

P1

Questões Geriatria 25

- 1- Efeitos colaterais inibitórios acetilcolina e efeitos anticorpos monoclonais (causa hemorragia e edema cerebral) e memantina não usa em fase leve
- 2- Sertralina para idoso com HAS
- 3- Falsa: melatonina é potente indutora do sono
- 4- Reduzir dose ou trocar por outro: senhora com alzheimer apresenta efeitos colaterais após 2 semanas (náusea, vômito e inapetência). Conduta? Tinha sobre reduzir dose e manter escalonando, tinha add antiemético
- 5- Demencia associada ao Parkinson: falsa: sintomas iniciados a menos de 1 ano
- 6- Demência vascular
- 7- Fratura de fêmur = delirium
- 8- Transtorno cognitivo leve = Moca não serve para diagnóstico
- 9- Distúrbio do sono = sd de pernas inquietas, falsa: movimento periódico de membros são movimentos complexos e paciente age tal qual no sono
- 10- PET Alzheimer
- 11- Falsa: diminui o hcl e pepsina, aumenta d dimero, joga mais água pra fora em sobrecarga, tinha mais uma opção mas não lembro
- 12- CAM é para triagem: os 4 criterios
- 13- Associar memantina (em depressão)
- 14- Variante semântica
- 15- Trocar nortriptilina por mirtazapina, tinha depressão com perda de peso
- 16- Falsa: não precisa fazer apgar familiar se tem boa condição financeira
- 17- Amantadina para discinesia
- 18- Falsa: fibra mesmo com baixa agua
- 19- Corpos de Lewy: no córtex e subcortex
- 20- Rasagilina não usa para discinesia

Paciente há 4 semanas com levodopa e amantadina, começou a ter delirium = resposta é fracionar dose de levodopa e suspender amantina

TNL/CCL amnésico é mais provável resultar em alzheimer

DCS DO AGA = ESCALAS

- sobre remédios de parkinson - CAMT, agonista dopaminergico etc

Distúrbio de sono REM: usa clonazepam se for jovem sem problema de cognição

Movimentos coreiformes = diminuir levodopa e adicionar amantadina NAOSEI

Levodopa sem alimento e fracionada

Fases avançadas da DA

Idosos tem menor área de troca gasosas, idosos eliminam agua mais facilmente

Prova 1 geriatria T24(2025.2)

Tratamento de delirium -> paciente estava orientado e lúcido, calmo no momento, não há necessidade de contenção química, apenas prevenção de novo episódio

Distúrbios do sono -> INCORRETA melatonina é um forte indutor do sono;

- certa – uso da doxepina é seguro
- certa – uso do BZD em paciente jovem é seguro a curto prazo

Alzheimer -> era o diagnóstico e os exames confirmavam o quadro;

Parkinson -> paciente a 4 semanas diagnosticado tratado com levodopa e amantadina, começou a ter delirium, resposta fracionar levodopa e suspender amantadina;

Distúrbios do sono -> resposta I e II corretas, a III falava sobre movimento periódico de membros ser movimentos complexos e como se o paciente agisse tal qual no sonho, incorreta. IV não lembro.

Delirium -> como diagnosticar(falava exatamente qual a frase que é) os critérios de CAM;

Alterações fisiológicas do coração -> Resposta era queda da função sistólica quando exercício;

AGA -> INCORRETA paciente com boa condição financeira veio sozinho a consulta, essa falava que por essa condição \$\$ dela não era necessário aplicar APGAR familiar

AGA tinham algumas repetidas do compilado

Discinesias em parkinson -> como tratar e diferença de flutuação(tinha alternativas sobre as duas) a correta dizia que era uma discinesia e deveríamos associar amantadina para tratar;

TNL/CCL amnésico é o mais provável de resultar em Alzheimer;

Paciente quadro depressivo com perda de peso etc, trocava o tricíclico por mirtazapina;

Assertiva sobre função renal no idoso -> monitorar pela TGF e não pela creatinina sérica;

DVa tratamento para sintomas de labilidade emocional com ISRS;

Depressão e DA(comparação de como o paciente age na consulta) -> depressão no idoso gera sintomas exagerados/desproporcionais enquanto um paciente com DA gera sintomas que ele prefere nem falar sobre;

Q1 (0.40 pts) Sobre a Avaliação Geriátrica Ampla (AGA), analise os itens a seguir:

I – A AGA é uma avaliação que complementa a anamnese tradicional, trazendo informações que muitas vezes não são aparentes ou não são queixas relatadas pelo paciente ou família;

II – A Escala de Depressão Geriátrica de Yesavage de 15 pontos, com uma pontuação maior que 5 pontos, confirma o diagnóstico de depressão no idoso;

III – O Miniexame do Estado Mental (mini-mental) é geralmente utilizado para pacientes com menor escolaridade já o Montreal Cognitive Assessment (MoCA) é mais indicado para pacientes com maior escolaridade;

IV – A medição da força de preensão palmar é uma boa forma de mensurar a força global do paciente e a velocidade de marcha $< 0,8$ m/s é indicativa de baixo desempenho muscular.

Assinale a alternativa correta:

- a) Somente I, II e IV estão corretas
- b) Somente II e III estão corretas
- c) Somente I, III e IV estão corretas**
- d) Somente I e IV estão corretas
- e) Todas estão corretas

Q2 (0.40 pts) Assinale a alternativa que contem alterações da farmacocinética presentes no processo de envelhecimento e medicações potencialmente inapropriadas para uso no paciente idoso:

- a) Redução do pH gástrico, menor concentração sérica de drogas hidrossolúveis; meloxicam e zolpidem.
- b) Aumento do pH gástrico, menor meia vida de drogas lipossolúveis; enalapril e prometazina.
- c) Aumento na produção de HCl pelo estômago, maior meia vida de drogas lipossolúveis; paroxetina e ciclobenzaprina.
- d) Aumento do pH gástrico, maior meia vida de drogas lipossolúveis; clonazepam e amitriptilina.**
- e) Atrofia da mucosa intestinal, maior concentração sérica de fármacos hidrossolúveis; atorvastatina e óleo mineral

Q3 (0.40 pts) O envelhecimento cardíaco é um processo lento e heterogêneo que afeta a integridade do sistema cardiovascular, tendo o coração uma incapacidade de responder de maneira adequada a uma carga de estresse. Diante disso é correto afirmar:

- a) Há uma redução da função sistólica ao repouso.
- b) Um aumento do AE e com isso um maior risco de fibrilação atrial.**
- c) Aumento da complacência do VE.
- d) Diminuição da contração atrial do AE.
- e) O VE se mantém inalterado com a idade.

Q4 (0.40 pts) Paciente do sexo feminino de 75 anos vem há 12 meses com queixas de

diminuição de memória recente, esquece fatos recentes, repete assuntos e onde guarda objetos. Nega outras alterações cognitivas. Nega atrapalho nas AVDS. Algumas vezes deixa a comida queimar. Veio com a filha na consulta. Tem como comorbidades DM II e HAS. Nega demências na família. Tem como escolaridade, faculdade de contabilidade. Fez o Moca Teste que deu alterado. Diante do caso, qual seria o mais provável diagnóstico e sua conduta para elucidação clínica:

- a) Quadro de demência de Alzheimer, onde seria pedido Ressonância magnética de encéfalo.
- b) Declínio subjetivo, com exames laboratoriais a serem pedidos.
- c) Declínio subjetivo, com pedido de dosagem de proteína beta amiloide e tau no liquor.
- d) Transtorno Neurocognitivo Leve, com pedido de Ressonância magnética de encéfalo.**
- e) Transtorno Neurocognitivo Leve, sendo pedido eletroencefalograma.

Q5 (0.40 pts) A doença de Alzheimer é uma doença degenerativa que acarreta declínio funcional progressivo e perda gradual da autonomia. O declínio cognitivo dessa patologia associado as alterações neuropsiquiátricas causam uma carga de sofrimento aos pacientes e familiares. Sendo assim é incorreto afirmar:

- a) Na doença de Alzheimer a proteína precursora amiloide é clivada de maneira anormal pelas alfa-secretases.**

b) O tabagismo, obesidade, depressão e diabetes são fatores de risco para pacientes desenvolverem a doença.

c) As medicações como donepezila, galantamina e rivastigmina lentificam a evolução da patologia.

d) O paciente apresenta declínio inicialmente de memória recente, agnosia, apraxia, desorientação no tempo e espaço.

e) Exames laboratoriais devem ser pedidos como vdrl, cálcio, b12, folato, transaminases, hemograma, glicemia.

Q6 (0.40 pts) Sobre a demência por corpos de Lewy, assinale a alternativa INCORRETA

- a) Faz parte de um grupo de doenças conhecidas como sinucleinopatias, em que ocorre a deposição de alfasinucleína (uma proteína presente no cérebro normal) na forma de corpos de Lewy em regiões como córtex, núcleos da base e lobos temporais.
- b) Os sintomas cognitivos característicos da doença são disfunção executiva, visuo espacial e de atenção. Déficits de memória e linguagem são menos frequentes e quando acontecem tendem a ser mais leves do que na Doença de Alzheimer
- c) Além de sintomas cognitivos, a doença é caracterizada por sintomas motores. O parkinsonismo é marcado principalmente por rigidez e bradicinesia, com tremores menos frequentes e com boa resposta ao tratamento com Levodopa.**
- d) O transtorno comportamental do sono REM e a hiposmia são sintomas comuns

e que podem estar presentes anos antes da disfunção cognitiva

- e) Flutuações cognitivas e no estado de alerta ao longo de horas, dias ou semanas, são muito comuns na doença e fazem parte dos critérios diagnósticos centrais.

Q7 (0.40 pts) Homem de 72 anos, empresário, cursou faculdade de contabilidade, vem em primeira consulta com geriatra, acompanhado pela esposa, por queixas de esquecimento de início há cerca de 2 meses, dificultando levemente alguns cálculos simples de matemática que realiza no dia a dia, esquece onde deixou a chave do carro, também relata estar sobrecarregado com o trabalho, relata apresentar insônia inicial ocasional já melhorada após iniciar prometazina e com discreta perda ponderal desde o início da metformina. De história pregressa, possui DM2, HAS e hipercolesterolemia, em uso contínuo de metformina, enalapril, sinvastatina, omeprazol, prometazina e suplemento alimentar manipulado indicado por amigo. Triagem com PA 125/72, frequência cardíaca de 68bpm, HGT 119 em jejum, SpO2 95% em ar ambiente, peso de 65kg e altura de 173cm, IMC 21,7. Exame físico não possui nenhum déficit motor ou alteração de pares cranianos, ausculta cardíaca e pulmonar sem alterações, sem lesões tróficas em membros inferiores. Testagem com Miniexame do Estado Mental (mini-mental) de 29 pontos. Com relação ao caso, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) O DM, o uso da metformina e o quadro de sobrecarga com o trabalho,

poderiam justificar a perda ponderal do paciente, mesmo assim, a aplicação da Mini Avaliação Nutricional deve ser realizada para melhor avaliação do estado nutricional do mesmo.

- b) A Escala de Depressão Geriátrica pode ser utilizada para rastrear possível quadro depressivo associado ao quadro de queixas cognitivas apresentado.
c) A utilização dos critérios de Beers poderia ser útil na avaliação do quadro cognitivo para identificar medicações que possam estar ocasionando ou piorando as queixas cognitivas.

d) A pontuação normal do mini-mental é suficiente para indicar que o paciente não possui declínio cognitivo e nem quadro demencial.

- e) A avaliação da funcionalidade, principalmente na avaliação das Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVDs), se alterada, poderia auxiliar no diagnóstico de Declínio Cognitivo ou Demência.

Q8 (0.40 pts) Observe as afirmativas a seguir sobre a terapêutica da DA:

I. Os efeitos colaterais mais comuns no uso dos inibidores da acetilcolinesterase são náuseas, vômitos e inapetência.

II. Donepezila é mais segura em pacientes com hepatopatia crônica.

III. É comum na DA que o indivíduo apresente alteração do comportamento no final da tarde, quando pode haver agitação e piora da confusão.

IV. O objetivo da terapêutica na DA é estabilizar os sintomas, lentificando a patologia.

Quais estão corretas:

- a) Apenas a I, a II e a III.
- b) Apenas a II, a III e a IV.
- c) Apenas I e a III
- d) Apenas a I, a III e a IV.**
- e) Todas estão corretas.

Q9 (0.40 pts) Sobre o Comprometimento Cognitivo Vascular (CCVa) e a Demência Vascular (DVa), assinale a alternativa correta:

- a) São ocasionados por eventos isquêmicos de grandes vasos apenas, sendo os AVC por evento embólico ou trombótico os únicos causadores;
- b) Na grande maioria dos casos, o paciente apresenta primeiro o comprometimento da memória, seguido por alterações comportamentais e por último disfunção na parte executiva.
- c) A escala de Hachinski é pouco útil para auxiliar na diferenciação entre Demência de Alzheimer e Demência Vascular.
- d) Se o paciente já apresentar quadro de DVa, não é indicado o tratamento dos fatores de risco como HAS por já haver dano ocasionado.
- e) A terapia para sintomas neuropsiquiátricos inclui, se indicado, o uso de inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRS) para melhorar quadros depressivos e labilidade emocional que são frequentes nessa população.**

Q10 (0.40 pts) Sobre Delirium, assinale a alternativa incorreta

- a) São fatores predisponentes para delirium: idade avançada, déficit cognitivo, polifarmácia, déficit sensorial.
- b) Aproximadamente metade dos pacientes idosos internados por fratura de fêmur apresentará delirium
- c) São fatores precipitantes de delirium: infecção, constipação, dor, presença de dispositivos invasivos, como sonda vesical de demora
- d) Algumas medicações estão associadas com um maior risco de precipitar delirium, entre elas: benzodiazepínicos, antihistamínicos, anticolinérgicos
- e) As ferramentas para rastreio de delirium são simples e devem ser utilizadas não somente pela equipe médica, mas também pela equipe multiprofissional. Caso o profissional aplique a ferramenta e o resultado seja negativo, está excluído delirium.

Q11 (0.40 pts) Sobre a Demência Frontotemporal é correto afirmar:

- a) A DFT variante comportamental se caracteriza com falta de empatia, desinibição, alterações das funções executivas e comportamentos estereotipados.**
- b) A DFT variante semântica se apresenta com dificuldade de encontrar palavras, mutismo e alucinações.
- c) A coleta de liquor é importante para o diagnóstico de certeza da patologia.
- d) O Spect cerebral mostra hipometabolismo em regiões fronto, temporo-parietais.
- e) A DFT não fluente agramática ou Afasia Progressiva Primária tem um prejuízo

na compreensão das palavras isoladas e preservação das complexas.

Q12 (0.40 pts) Sobre o caso abaixo, indique qual a melhor conduta a ser tomada:

Você está de plantão no Pronto Socorro e a equipe de enfermagem vem chamá-lo para avaliar um paciente que está agitado e agressivo. Quando você chega na sala de emergência, encontra o senhor João, de 82 anos, confuso, irritado, agressivo verbalmente com familiares e equipe. Filha relata que até 2 dias atrás paciente conversava normalmente, cuidava dos netos, fazia pequenos cuidados com a casa e eventualmente ajudava na empresa da família. Há 5 dias iniciou quadro de tosse produtiva e febre, tendo feito uso de xarope de loratadina, sem melhora. Qual a melhor conduta a ser adotada neste momento?

- a) Rx de tórax, exames laboratoriais, antibioticoterapia e contenção química com Haldol 1mg IM, podendo repetir a dose se necessário**
- b) Passagem de sonda naso gástrica para garantir via de alimentação e contenção mecânica no leito para evitar que paciente retire a sonda.
- c) Iniciar anticolinesterásico como Donepezila, por se tratar de paciente com quadro demencial.
- d) Contenção química com Diazepam 10mg, investigação e tratamento do quadro infeccioso.
- e) Realizar contenção mecânica e Prometazina 25mg IM, para controle de agitação e melhora da tosse.

Q13 (0.40 pts) Paciente de 65 anos, tem diagnóstico de doença de Parkinson, com tremor de repouso em mão direita intermitente, rigidez e bradicinesia em hemicorpo direito. Neste paciente, quanto ao início da farmacoterapia, é correto dizer:

- a) O biperideno é uma opção importante para aliviar o tremor.
- b) Iniciar com um agonista dopaminérgico como pramipexole.**
- c) Iniciar com levodopa associado com entacapone.
- d) Dar somente entacapone, pois está numa fase inicial.
- e) Iniciar somente com fisioterapia.

Q14 (0.40 pts) Sobre os distúrbios do sono no idoso, avalie as assertivas a seguir:

I – O sintoma que define a síndrome das pernas inquietas é a necessidade urgente de movimentar os membros – geralmente os pacientes apresentam sintomas de parestesias ou disestesias.

II – O Transtorno Comportamental do Sono REM (TCSR) é mais prevalente em portadores de Doença de Parkinson e seus sintomas incluem movimentos complexos e vocalização durante o sono.

III – Sintomas da Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono são dificuldade de concentração, cefaleia matinal, episódios de parada respiratória e a doença pode trazer piora da HAS e aumento do risco cardiovascular.

IV – A insônia em idosos é multifatorial devendo sempre ser orientada a higiene do sono, bem como avaliação de medicações

ou substâncias que possam estar afetando o sono e a primeira linha de tratamento é com medicações benzodiazepínicas.

Assinale a alternativa correta:

- a) Somente I, II e IV estão corretas
- b) Somente II e III estão corretas
- c) Somente I, III e IV estão corretas
- d) Somente I, II e III estão corretas**
- e) Todas estão corretas

Q15 (0.40 pts) Paciente de 68 anos, com DM, HAS, dislipidemia, Cirurgia de Revascularização do Miocárdio (CRM) há 2 anos, ex-tabagista há 2 anos com índice tabágico de 80 AM, vem em consulta por queixas de ter iniciado com quadro de dificuldade para encontrar palavras ao conversar, há cerca de 1 ano e 8 meses. Apresentou piora do quadro há cerca de 6 meses após quadro de AIT, em que iniciou com dificuldade para ir até o mercado fazer compras pois se perdia no caminho. Filha refere que o pai não esquece de fatos recentes, mas que apresenta evidente lentificação do pensamento e choros imotivados frequentes, com melhora após algum tempo e que o paciente volta a ficar alegre e sorridente. Sobre o caso, assinale a alternativa correta:

- a) O quadro do paciente pode ser considerado comprometimento cognitivo vascular por não apresentar esquecimentos e ter discreta alteração nas AIVDs.
- b) Por ter apresentado quadro de AIT com melhora total do déficit neurológico apresentado, o paciente provavelmente não possui lesões encefálicas que justifiquem o quadro cognitivo atual.

c) A ressonância magnética provavelmente mostraria lesões isquêmicas de pequenos vasos como infartos subcorticais e microangiopatia.

- d) Antipsicóticos (como a quetiapina) e estabilizadores de humor (como o valproato) são a primeira escolha para tratamento da labilidade emocional e sintomas comportamentais que possam surgir.
- e) O fato de os declínios cognitivos estarem temporalmente associados a eventos como a CRM com circulação extracorpórea e o AIT, não reforça o diagnóstico de Demência Vascular.

Q16 (0.40 pts) Sobre a Doença de Parkinson é incorreto afirmar:

- a) Existem casos da doença sem tremor, na qual chamamos de Doença de Parkinson rígido-acinética.
- b) A levodopa é a droga de escolha em idosos com idade mais avançada.
- c) Um dos sintomas pré-clínicos da doença é o distúrbio comportamental do sono REM.
- d) A rasagilina e o pramipexole podem ser usadas no tratamento das flutuações motoras.
- e) A presença de disfunção autonômica, com hipotensão ortostática e quedas frequentes, são comuns nas fases iniciais da doença.**

Q17 (0.40) Paciente sexo feminino, 75 anos, vem relatando tristeza, inapetência, emagrecimento de 6 kg em 90 dias, fraqueza geral, irritabilidade, ansiedade,

anedonia e sono com despertares frequentes. Teve uma queda há 7 dias sem traumas graves. Medicações: Venlafaxina e nortriptilina em uso há 6 meses. Paciente tem quadro depressivo há anos, com vários tratamentos, sem remissão total dos sintomas. Paciente relata obstipação intestinal crônica, com piora nos últimos meses. Sobre o caso acima, qual a conduta mais correta para este paciente?

- a) Suspender venlafaxina e introduzir duloxetina.
- b) Aumentar a dose da nortriptilina e manter venlafaxina.
- c) Trocar nortriptilina por mirtazapina, manter venlafaxina.**
- d) Trocar venlafaxina e nortriptilina por citalopram.
- e) Manter o esquema terapêutico e introduzir trazodona

Q18 (0.40 pts) Sobre a Osteoartrite no idoso é correto afirmar:

- a) O uso de AINH é mandatório no tratamento da doença, sendo a primeira opção.
- b) O joelho em valgo é o mais comum nos quadros de gonoartrose crônica.
- c) O uso da bengala sempre deve ser feita do mesmo lado da lesão e para dar instabilidade e diminuir a dor do paciente.
- d) Os nódulos de Heberden e os nódulos de Bouchard são mais comuns em homens.
- e) Medicações como curcuma longa e diacereina diminuem o processo**

inflamatório articular, diminuindo o uso de AINH.

Q19 (0.40 pts) Com relação à depressão no idoso, assinale V (verdadeiro) ou F (falso):

- 1. A condição apresenta maior comprometimento cognitivo e funcional, aumentando o risco de demência.
- 2. Hiponatremia e alterações do intervalo QT podem ser efeitos colaterais dos ISRS.
- 3. Na depressão resistente usamos antipsicóticos como o aripiprazol.
- 4. A paroxetina tem uma indicação reservada em casos de depressão com sintomas ansiosos, com pouca ação anticolinérgica.

- a) V-V-F-F
- b) V-V-V-F**
- c) F-V-V-V
- d) V-F-V-V
- e) Todas corretas

Q20 (0.40 pts) No processo de senescência é incorreto afirmar:

- a) Diminuição de produção de saliva, com mais queixas de xerostomia.
- b) Redução na absorção de vitamina b12.
- c) A creatinina é uma medida confiável para avaliação da função renal no idoso.**
- d) Os idosos tem maior tendencia devido ao envelhecimento a hipercalcemia.
- e) Ocorre um aumento de adenomas na tireoide e suprarrenais.

- 1) Paciente José, 88 anos, chega ao pronto socorro acompanhado de seus familiares, é prontamente atendido pelo médico plantonista. A queixa principal da família é que nos últimos 3 dias o senhor José vem apresentando alterações de comportamento, não falando coisa com coisa, agitação psicomotora, passou a dormir mais durante o dia, ficar acordado à noite e com alucinações visuais. Após avaliar o senhor José, colher sua história clínica, solicitar os exames complementares o médico poderia propor o seguinte a conduta:
- a) Internar o paciente, pois o seu quadro clínico sugere fortemente um quadro de acidente vascular encefálico e iniciar o devido tratamento.
 - b) Tranquilizar a família, pois os achados clínicos do seu José são muito comuns na sua idade, medicá-lo com um antipsicótico e encaminhá-lo para o ambulatório de geriatria.
 - c) Tranquilizar a família, ressaltando que o senhor José apresenta um quadro clínico que sugere a patologia delirium, que essa patologia tem causas multifatoriais, que seria necessário aguardar o resultado dos exames solicitados para definir conduta.**
 - d) Internar o paciente, pois o seu quadro sugere fortemente um quadro de demência de Alzheimer na fase inicial.
 - e) Fazer haloperidol endovenoso e encaminhar o paciente para tratamento ambulatorial, pois o paciente tem um quadro inicial de síndrome demencial, com seguimento na neurologia ou geriatria.
- 2) Com relação à DV ocasionada por hipoperfusão, analise as alternativas a seguir e marque V (verdadeiro) ou F (falso).
- Na DV por hipoperfusão, há a ocorrência de eventos sistêmicos que afetam a hemodinâmica cerebral.
 - Insuficiência cardíaca grave é exemplo de hipoperfusão aguda.
 - A hipotensão postural crônica é um exemplo de hipoperfusão crônica.
 - Apesar de a DV por hipoperfusão ocorrer em áreas de penumbra entre regiões irrigadas por grandes artérias, tal condição não afeta a substância branca.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- a) V, V, F, V
 - b) V, F, V, F**
 - c) F, V, F, V
 - d) F, F, V, F
 - e) V, V, V, F

3) Com relação ao diagnóstico diferencial de déficit cognitivo nas demências, correlacione a primeira e a segunda colunas.

1 DV cortical

2 DV subcortical

3 Doença de Alzheimer

4 Demência por Corpos de Lewy

Curso gradual e progressivo com memória episódica muito acometida.

Curso gradual e progressivo com flutuação da consciência.

Curso em degraus com disfunção executiva.

Curso gradual e progressivo com disfunção executiva, déficit de atenção e alteração da marcha.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

a) 2, 1, 4, 3

b) 3, 4, 1, 2

c) 1, 3, 2, 4

d) 4, 2, 3, 1

e) 4, 3, 1, 2

4) Sobre os critérios diagnósticos de Comprometimento Cognitivo Leve assinale a alternativa correta.

a) A memória é, necessariamente, afetada em casos de CCL.

b) As atividades instrumentais de vida diária nunca são afetadas no CCL.

c) O diagnóstico de CCL está confirmado quando há qualquer comprometimento das avds.

d) O desempenho nos testes cognitivos dos pacientes com CCL costuma ser muito comprometido.

e) O CCL não amnésico com um único domínio afetado pode envolver somente linguagem, função executiva ou habilidades visuoespaciais

5) Idosa de 76 anos vem ao consultório médico com obstipação crônica e delirium há 7 dias. Tem tremor em mão direita há 6 meses, que vem aumentando, associado a bradicinesia. Tem quadro depressivo com uso de escitalopram e recente prescrição de nortriptilina há 14 dias. Paciente tem diabetes mellitus com excelente controle, hipertensão arterial e labirintopatia. Medicamentos: metformina, enalapril, metoclopramida esporadicamente, cinarizina e nortriptilina.

Exame Físico: tremor parkinsoniano em mão direita, roda dentada positiva, fâcies de máscara.

Exames laboratoriais normais.

Descartado causa orgânica, e diante da anamnese referida, quais medicamentos poderiam levar a esses sinais e sintomas iatrogênicos?

- a) Metformina, nortriptilina e metoclopramida
- b) Metformina e cinarizina
- c) Cinarizina, metoclopramida e nortriptilina.**
- d) Cinarizina e nortriptilina
- e) Enalapril e metformina.

- 6) Uma senhora de 72 anos de idade apresenta 2 anos de progressiva alteração da memória e dificuldade em AVDs, como compras e perda de objetos. Ela recebeu o diagnóstico de provável DA. Foi sugerido o uso de galantamina em doses crescentes até 24mg/dia. Depois de 5 meses, retorna com a filha reclamando que o tratamento não fez efeito, porque está “do mesmo jeito”. A informação é de que continua com as mesmas limitações e fazendo as mesmas atividades, isto é, cuidando da casa, fazendo compras em lugares muito próximos e indo à igreja aos domingos. O escore no MEEM caiu 1 ponto.

Considerando as informações apresentadas, pode-se concluir que

- a) O diagnóstico não é DA, por isso, o tratamento fracassou.
- b) O diagnóstico é DA, mas essa medicação não funcionou e precisa ser substituída por outro inibidor da acetilcolinesterase.
- c) A medicação não obteve uma resposta plena e deve ser adicionada memantina.
- d) A resposta a medicação está correta, dentro das expectativas do tratamento.**
- e) Deve ser adicionar outro inibidor da acetilcolinesterase.

- 7) No passado, acreditava-se que, para o indivíduo ser classificado como portador de demência, ele deveria apresentar perda de memória. Hoje sabe-se que existem diversos tipos de demências com quadros clínicos iniciais distintos. Qual das alternativas a seguir é caracterizada pela abertura do quadro demencial com alucinações visuais, parkinsonismo e distúrbio do sono REM?

- a) Demência frontotemporal.
- b) Demência vascular.
- c) Demência por corpúsculos de Lewy.**
- d) Hidrocefalia de pressão normal.
- e) Demência na Doença de Parkinson

- 8) A Demência Fronto-Temporal é uma doença degenerativa que afeta faixa etárias mais jovens, entre 45 a 64 anos, sendo assim é correto dizer:
- a) Há inicialmente uma perda de memória seguida de alterações de comportamento, como impulsividade, hiperoralidade e risos inadequados.
 - b) A sobrevida é maior do que na doença de Alzheimer.
 - c) Alteração da personalidade como aparência desleixada, impaciência e irritabilidade, disputa argumentativa, comentários libidinosos e compulsões precedem o quadro de declínio da memória.**
 - d) Quadros alucinatórios e hipocondria são frequentes precedendo a perda de memória.
 - e) Geralmente acomete indivíduos acima de 70 anos, sendo a 2ª causa de demência não Alzheimer.

- 9) Sra. Balbina, 75 anos, autônoma e independente, comparece à consulta ambulatorial de rotina sem queixas espontâneas. Ao exame, observa-se perda ponderal de 5kg no último ano que, segundo a paciente, foi involuntária. Quando questionada sobre o hábito intestinal, ela relata que tem ficado até quatro dias sem evacuar e que o uso de laxativos orais não modifica muito esse quadro. Descreve certo tenesmo. Revisando o prontuário, percebe-se que, há um ano, a Sra. Balbina possuía ritmo intestinal diário, sem esforço evacuatório.

Com relação à conduta mais adequada para a paciente do caso clínico, assinale a alternativa correta.

- a) Trata-se, possivelmente, de quadro benigno, já que não há impacto significativo na funcionalidade e a paciente não apresenta queixa espontânea. Recomenda-se apenas acompanhamento.
 - b) São indicados ajuste na dieta e uso regular e combinado de laxativos orais com diferentes mecanismos de ação.
 - c) Deve-se realizar toque retal e solicitar pesquisa anual de sangue oculto nas fezes.
 - d) Deve-se solicitar colonoscopia, considerando a funcionalidade da paciente e a presença dos sinais de alerta.**
 - e) Prescrever fleet enema semanal para melhorar o funcionamento do intestino.
- 10) Sobre a Osteoartrite no idoso é correto afirmar:
- a) O uso do colágeno do tipo II tem como indicação na osteoartrite de quadril, com bons resultados a longo prazo, pois modifica a evolução da doença.
 - b) A dor não piora com a mudança atmosférica e sendo pior ao repouso.

c) A cúrcuma longa e a Boswellia serrata são fitoterápicos com ação anti-inflamatória e ação otimizada em 4 a 6 semanas, podendo ser tentados para melhora da dor e função em pacientes com osteoartrite de joelho.

d) O uso da bengala deve ser sempre do mesmo lado da articulação acometida com o cotovelo fletido a 30 graus.

e) O uso de AINH no tratamento é mandatório em todos os pacientes.

11) Na Avaliação Geriátrica Ampla (AGA) temos várias ferramentas para avaliação do idoso de maneira correta, melhorando a precisão diagnóstica. Sendo assim é incorreto afirmar:

a) O teste cronometrado de levantar e andar avalia a possibilidade de quedas e fragilidade, aonde um tempo maior que 20 segundos sugerem risco para quedas e fragilidade muscular.

b) O Moca-Teste tem uma boa aplicabilidade em pacientes com bons níveis educacionais e é usado em pacientes com suspeita de CCL e demência.

c) O 10-CS é usado para avaliar questões cognitivas em substituição ao Minimental.

d) O SARC-F é usado para avaliar o risco de fraturas em pacientes idosos.

e) O questionário de Yesavage avalia possível quadros depressivos, através de uma lista de perguntas.

12) No que se refere às manifestações clínicas da DP, analise as alternativas a seguir e marque V (verdadeiro) ou F (falso).

- Em indivíduos acometidos pela DP, o tremor de repouso ainda é o primeiro sintoma reconhecido pelo próprio paciente, por seus familiares e pelos médicos assistentes.
- A bradicinesia não é o principal sintoma cardinal na DP no idoso, e sim o tremor.
- A instabilidade postural em geral não ocorre nas formas iniciais e leves da DP.
- Dermatite seborreica, hipotensão ortostática e alterações do sono REM podem fazer parte da patologia.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

a) V, V, F, F

b) V, F, V, V

c) F, V, F, V

d) F, F, V, F

e) V, F, F, V

- 13) Paciente do sexo feminino, traz ao consultório exame de Densitometria Óssea mostrando os seguintes resultados: colo do fêmur -3,1/fêmur total -2,8. Coluna vertebral L1-L4 -1,2. Exames de sangue normais. Tem histórico de obstipação intestinal crônica. Qual seria o diagnóstico e tratamento:
- a) Osteopenia; usar Raloxifeno e Carbonato de Cálcio 500mg + Vitamina D 400UI 2X ao dia.
 - b) Osteoporose; usar alendronato sódico semanal e Carbonato de cálcio 500mg 2x ao dia.
 - c) Osteoporose; usar bifosfonato, calcio citrato malato associado a vitamina D.**
 - d) Osteopenia; usar bifosfonato, calcio citrato malato e denosumabe.
 - e) Osteopenia; usar calcio citrato malato e vitamina D.
- 14) Idosa com 74 anos, chega ao consultório geriátrico com sua filha, que relata que sua mãe há 6 meses, esquece fatos recentes, repetitividade, esquece palavras que vai falar e desorientação espacial. Tem queimado vários alimentos. Tem transtorno depressivo maior há 5 anos, diabetes mellitus e insônia em tratamento. Usa como medicações: Usa Losartana, escitalopram 10mg, clonazepam gotas (usa há 10 anos), metformina. Exame físico normal. 10 CS: 4, Teste com fluência verbal: 5. Diante do caso qual, assinale a resposta incorreta:
- a) Quadro característico de síndrome demencial, provável doença de Alzheimer, pois tem alterações de instrumentais de vida diária e testes cognitivos alterados.
 - b) A paciente tem em questão fatores de risco para ter uma demência, como o diabetes mellitus, uso crônico de benzodiazepínico e depressão na terceira idade.
 - c) Doença de Alzheimer fase inicial; aonde pediremos exames laboratoriais como TSH, vdrl, fta-abs, b12 e exame de imagem como a ressonância magnética de encéfalo.
 - d) Além do tratamento do quadro demencial, a retirada de maneira lenta do clonazepam, pode ajudar também no tratamento cognitivo.
 - e) Se a paciente em questão, tiver ressonância magnética de encéfalo normal e liquor com proteína beta amiloide diminuída e proteína TAU aumentada, devemos afastar doença de Alzheimer.**
- 15) Idosa, 73 anos refere diarreia e vômitos há 12 horas por quadro viral, além disso confusão mental aguda associada. Nega febre. No exame físico mostra-se desidratada +2/4, hipotensa 90/60 e confusa. Exames laboratoriais mostrou hiponatremia, creatina e ureia elevadas. Diante desse quadro clínico é incorreto afirmar:
- a) Como o idoso tem diminuição de aldosterona pelo próprio envelhecimento, teremos mais casos de hiponatremia e hipocalemia associada em situações de depleção.**

- b) Devido a menor água corporal, menos sensação de sede, o paciente pode rapidamente desidratar e levar piora da função renal.
- c) O quadro de delirium foi devido a desidratação com elevação dos níveis de ureia e a hiponatremia.
- d) A diminuição da renina plasmática devido a senescência pode aumentar a incidência de hiponatremia.
- e) Além da creatinina nesse caso, deve-se monitorar o clearance de creatinina, pois esse é mais fidedigno para avaliar a função renal no idoso.

16) Paciente com 68 com doença de Parkinson diagnosticada há 7 anos, usando levodopa em doses fracionadas e pramipexole. Nos últimos 30 dias vem tendo movimentos coreiformes em segmento cefálico. Diante do caso clínico, qual seria esta alteração e melhor conduta para este doente?

- a) Piora do quadro de parkinsonismo e aumentar a dose da levodopa.
- b) Fenômeno wearing-off e aumentar dose de pramipexole.
- c) Discinesia e aumentar a dose da levodopa.
- d) Agitação psicomotora e associar quetiapina.
- e) Discinesia continua e associar amantadina.**

17) Analise as afirmativas sobre a Osteoporose.

I – São fatores de risco para osteoporose a artrite reumatoide, uso crônico de corticoides e o tabagismo.

II – Homens não entram na investigação para osteoporose, pois a incidência é bem menor do que nas mulheres.

III – Os bifosfonatos tem como efeitos colaterais sintomas dispépticos, úlcera esofágica e osteonecrose de mandíbula.

IV – O cálcio de melhor absorção no idoso e com poucos efeitos colaterais é o carbonato de cálcio.

Quais estão corretas?

- a) I e III**
- b) I, II e III
- c) III e IV
- d) I, II e IV
- e) I e II

18) Sobre o escore isquêmico de Hachinski, assinale a alternativa correta.

a) Sua aplicação é recomendada na investigação de DV cortical.

- b) Deve ser utilizado na tentativa de diferenciar DV pura de demência mista.
- c) Quando apresenta pontuação superior a 4, indica maior probabilidade de etiologia neurodegenerativa.
- d) Não deve ser utilizado para estudo da contribuição vascular em um quadro demencial.
- e) Pode ser usada para aferir o grau de acometimento motor e cognitivo.

19) A desprescrição é uma ferramenta usada para evitar a polifarmácia, reduzindo dose de medicamentos e até interrompendo o consumo de medicamentos, aonde o potencial de dano é superior aos seus benefícios. Sendo assim é incorreto afirmar:

a) Os aminoglicosídeos é uma classe segura de antibióticos em idosos.

- b) Medicamentos como anticolinérgicos, benzodiazepínicos e antiinflamatórios devem ser evitados em pacientes idosos.
- c) O uso indevido e por tempo prolongado de AINH podem levar a insuficiência renal e descompensação de ICC.
- d) Retirar medicamentos prescritos por balconistas de farmácia, vizinhos ou familiares.
- e) A amiodarona pode levar a alterações da tireoide, como o hipotireoidismo.

20) J.S. é um homem de 75 anos portador de quadro demencial devido à doença de Alzheimer em fase moderada. Mora em sua residência com cuidadores 24 horas/dia. Apresenta continência urofecal e alimenta-se sozinho. Dormia bem até que há uma semana iniciou quadro de agitação, agressividade verbal e incontinência urinária. Mostra-se assustado, referindo presença de pessoas estranhas na residência. Houve uma tentativa de agressão física a uma das cuidadoras, fato até então nunca ocorrido.

O paciente apresenta como comorbidades hipertensão arterial e diabetes melito (DM) do tipo 2. Está acima do peso e reluta em fazer atividade física. Ele utiliza os seguintes fármacos: donepezila, enalapril, hidroclorotiazida, metformina, amitriptilina. Médico avaliou o paciente em sua residência, com o exame físico normal.

Diante do caso é verdadeiro afirmar:

- a) O paciente teve piora do quadro demencial, sendo necessário associar memantina para controle da agitação e melhora cognitiva.
- b) Deve ser medicado com antipsicótico como o haloperidol gotas e suspender amitriptilina devido ao seu efeito anticolinérgico.
- c) Pedir exames laboratoriais para afastar possível quadro infeccioso ou metabólico, suspender o tricíclico e medicar com quetiapina.**
- d) Suspender a donepezila e pedir exames laboratoriais.
- e) Introduzir a trazodona para o quadro de agitação e associar memantina.

- 1) Paciente José, 88 anos, chega ao pronto socorro acompanhado de seus familiares, é prontamente atendido pelo médico plantonista. A queixa principal da família é que nos últimos 3 dias o senhor José vem apresentando alterações de comportamento, não falando coisa com coisa, agitação psicomotora, passou a dormir mais durante o dia, ficar acordado à noite e com alucinações visuais. Após avaliar o senhor José, colher sua história clínica, solicitar os exames complementares o médico poderia propor o seguinte a conduta:
- a) Internar o paciente, pois o seu quadro clínico sugere fortemente um quadro de acidente vascular encefálico e iniciar o devido tratamento.
 - b) Tranquilizar a família, pois os achados clínicos do seu José são muito comuns na sua idade, medicá-lo com um antipsicótico e encaminhá-lo para o ambulatório de geriatria.
 - c) Tranquilizar a família, ressaltando que o senhor José apresenta um quadro clínico que sugere a patologia delirium, que essa patologia tem causas multifatoriais, que seria necessário aguardar o resultado dos exames solicitados para definir conduta.**
 - d) Internar o paciente, pois o seu quadro sugere fortemente um quadro de demência de Alzheimer na fase inicial.
 - e) Fazer haloperidol endovenoso e encaminhar o paciente para tratamento ambulatorial, pois o paciente tem um quadro inicial de síndrome demencial, com seguimento na neurologia ou geriatria.
- 2) Com relação à DV ocasionada por hipoperfusão, analise as alternativas a seguir e marque V (verdadeiro) ou F (falso).
- Na DV por hipoperfusão, há a ocorrência de eventos sistêmicos que afetam a hemodinâmica cerebral.
 - Insuficiência cardíaca grave é exemplo de hipoperfusão aguda.
 - A hipotensão postural crônica é um exemplo de hipoperfusão crônica.
 - Apesar de a DV por hipoperfusão ocorrer em áreas de penumbra entre regiões irrigadas por grandes artérias, tal condição não afeta a substância branca.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- a) V, V, F, V
 - b) V, F, V, F**
 - c) F, V, F, V
 - d) F, F, V, F
 - e) V, V, V, F
- 3) Com relação ao diagnóstico diferencial de déficit cognitivo nas demências, correlacione a primeira e a segunda colunas.
- 1 DV cortical
 - 2 DV subcortical
 - 3 Doença de Alzheimer
 - 4 Demência por Corpos de Lewy

Curso gradual e progressivo com memória episódica muito acometida.

Curso gradual e progressivo com flutuação da consciência.

Curso em degraus com disfunção executiva.

Curso gradual e progressivo com disfunção executiva, déficit de atenção e alteração da marcha.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- a) 2, 1, 4, 3
- b) 3, 4, 1, 2**
- c) 1, 3, 2, 4
- d) 4, 2, 3, 1
- e) 4, 3, 1, 2

4) Sobre os critérios diagnósticos de Comprometimento Cognitivo Leve assinale a alternativa correta.

- a) A memória é, necessariamente, afetada em casos de CCL.
- b) As atividades instrumentais de vida diária nunca são afetadas no CCL.
- c) O diagnóstico de CCL está confirmado quando há qualquer comprometimento das avds.
- d) O desempenho nos testes cognitivos dos pacientes com CCL costuma ser muito comprometido.
- e) O CCL não amnésico com um único domínio afetado pode envolver somente linguagem, função executiva ou habilidades visuoespaciais**

5) Idosa de 76 anos vem ao consultório médico com obstipação crônica e delirium há 7 dias. Tem tremor em mão direita há 6 meses, que vem aumentando, associado a bradicinesia. Tem quadro depressivo com uso de escitalopram e recente prescrição de nortriptilina há 14 dias. Paciente tem diabetes mellitus com excelente controle, hipertensão arterial e labirintopatia. Medicamentos: metformina, enalapril, metoclopramida esporadicamente, cinarizina e nortriptilina.

Exame Físico: tremor parkinsoniano em mão direita, roda dentada positiva, fácies de máscara.

Exames laboratoriais normais.

Descartado causa orgânica, e diante da anamnese referida, quais medicamentos poderiam levar a esses sinais e sintomas iatrogênicos?

- a) Metformina, nortriptilina e metoclopramida
- b) Metformina e cinarizina
- c) Cinarizina, metoclopramida e nortriptilina.**
- d) Cinarizina e nortriptilina
- e) Enalapril e metformina.

6) Uma senhora de 72 anos de idade apresenta 2 anos de progressiva alteração da memória e dificuldade em AVDs, como compras e perda de objetos. Ela recebeu o diagnóstico de provável DA. Foi sugerido o uso de galantamina em doses crescentes até 24mg/dia. Depois de 5 meses, retorna com a filha reclamando que o tratamento não fez efeito, porque está “do mesmo jeito”. A informação é de que continua com as mesmas limitações e fazendo as mesmas atividades, isto é, cuidando da casa, fazendo compras em lugares muito próximos e indo à igreja aos domingos. O escore no MEEM caiu 1 ponto.

Considerando as informações apresentadas, pode-se concluir que

- a) O diagnóstico não é DA, por isso, o tratamento fracassou.
- b) O diagnóstico é DA, mas essa medicação não funcionou e precisa ser substituída por outro inibidor da acetilcolinesterase.
- c) A medicação não obteve uma resposta plena e deve ser adicionada memantina.
- d) A reposta a medicação está correta, dentro das expectativas do tratamento.**
- e) Deve ser adicionar outro inibidor da acetilcolinesterase.

7) No passado, acreditava-se que, para o indivíduo ser classificado como portador de demência, ele deveria apresentar perda de memória. Hoje sabe-se que existem diversos tipos de demências com quadros clínicos iniciais distintos. Qual das alternativas a seguir é caracterizada pela abertura do quadro demencial com alucinações visuais, parkinsonismo e distúrbio do sono REM?

- a) Demência frontotemporal.
- b) Demência vascular.
- c) Demência por corpúsculos de Lewy.**
- d) Hidrocefalia de pressão normal.
- e) Demência na Doença de Parkinson

8) A Demência Fronto-Temporal é uma doença degenerativa que afeta faixa etárias mais jovens, entre 45 a 64 anos, sendo assim é correto dizer:

- a) Há inicialmente uma perda de memória seguida de alterações de comportamento, como impulsividade, hiperoralidade e risos inadequados.
- b) A sobrevida é maior do que na doença de Alzheimer.
- c) Alteração da personalidade como aparência desleixada, impaciência e irritabilidade, disputa argumentativa, comentários libidinosos e compulsões precedem o quadro de declínio da memória.**
- d) Quadros alucinatórios e hipocondria são frequentes precedendo a perda de memória.
- e) Geralmente acomete indivíduos acima de 70 anos, sendo a 2ª causa de demência não Alzheimer.

9) Sra. Balbina, 75 anos, autônoma e independente, comparece à consulta ambulatorial de rotina sem queixas espontâneas. Ao exame, observa-se perda ponderal de 5kg no último ano que, segundo a paciente, foi involuntária. Quando questionada sobre o hábito intestinal, ela relata que tem ficado até quatro dias sem evacuar e que o uso de laxativos orais não modifica muito esse quadro. Descreve certo tenesmo. Revisando o prontuário, percebe-se que, há um ano, a Sra. Balbina possuía ritmo intestinal diário, sem esforço evacuatório.

Com relação à conduta mais adequada para a paciente do caso clínico, assinale a alternativa correta.

- a) Trata-se, possivelmente, de quadro benigno, já que não há impacto significativo na funcionalidade e a paciente não apresenta queixa espontânea. Recomenda-se apenas acompanhamento.
- b) São indicados ajuste na dieta e uso regular e combinado de laxativos orais com diferentes mecanismos de ação.
- c) Deve-se realizar toque retal e solicitar pesquisa anual de sangue oculto nas fezes.

d) Deve-se solicitar colonoscopia, considerando a funcionalidade da paciente e a presença dos sinais de alerta.

e) Prescrever fleet enema semanal para melhorar o funcionamento do intestino.

10) Paciente de 69 anos, sexo feminino, sobrepeso, está em tratamento por Transtorno Depressivo, com melhora do quadro melancólico com sertralina. Entretanto, vem tendo insônia, com sono entrecortado nas últimas semanas, com cochilos frequentes durante o dia. Qual seria a medicação de primeira escolha para esse paciente?

a) Zolpidem

b) Diazepam

c) Amitriptilina

d) Lorazepam

e) Trazodona

11) Na Avaliação Geriátrica Ampla (AGA) temos várias ferramentas para avaliação do idoso de maneira correta, melhorando a precisão diagnóstica. Sendo assim é incorreto afirmar:

a) O teste cronometrado de levantar e andar avalia a possibilidade de quedas e fragilidade, aonde um tempo maior que 20 segundos sugerem risco para quedas e fragilidade muscular.

b) O Moca-Teste tem uma boa aplicabilidade em pacientes com bons níveis educacionais e é usado em pacientes com suspeita de CCL e demência.

c) O 10-CS é usado para avaliar questões cognitivas em substituição ao Minimental.

d) O SARC-F é usado para avaliar o risco de fraturas em pacientes idosos.

e) O questionário de Yesavage avalia possível quadros depressivos, através de uma lista de perguntas.

12) No que se refere às manifestações clínicas da DP, analise as alternativas a seguir e marque V (verdadeiro) ou F (falso).

- Em indivíduos acometidos pela DP, o tremor de repouso ainda é o primeiro sintoma reconhecido pelo próprio paciente, por seus familiares e pelos médicos assistentes.
- A bradicinesia não é o principal sintoma cardinal na DP no idoso, e sim o tremor.
- A instabilidade postural em geral não ocorre nas formas iniciais e leves da DP.
- Dermatite seborreica, hipotensão ortostática e alterações do sono REM podem fazer parte da patologia.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

a) V, V, F, F

b) V, F, V, V

c) F, V, F, V

d) F, F, V, F

e) V, F, F, V

13) Quanto à medicação considerada primeira opção no tratamento de pacientes com sintomas de Síndrome de Pernas Inquietas e exames a serem pedidos para investigação, assinale a alternativa correta.

a) Pramipexol, ferro, ferritina, creatinina.

- b) Clonazepam, ferro e ferritina.
- c) Ciclobenzaprina, hb glicosilada, glicemia jejum.
- d) Duloxetina, ureia, creatinina, ferro.
- e) Clonazepam, b12 e ferro.

14) Idosa com 74 anos, chega ao consultório geriátrico com sua filha, que relata que sua mãe há 6 meses, esquece fatos recentes, repetitividade, esquece palavras que vai falar e desorientação espacial. Tem queimado vários alimentos. Tem transtorno depressivo maior há 5 anos, diabetes mellitus e insônia em tratamento. Usa como medicações: Usa Losartana, escitalopram 10mg, clonazepam gotas (usa há 10 anos), metformina. Exame físico normal. 10 CS: 4, Teste com fluência verbal: 5. Diante do caso qual, assinale a resposta incorreta:

- a) Quadro característico de síndrome demencial, provável doença de Alzheimer, pois tem alterações de instrumentais de vida diária e testes cognitivos alterados.
- b) A paciente tem em questão fatores de risco para ter uma demência, como o diabetes mellitus, uso crônico de benzodiazepínico e depressão na terceira idade.
- c) Doença de Alzheimer fase inicial; aonde pediremos exames laboratoriais como TSH, vdrl, fta-abs, b12 e exame de imagem como a ressonância magnética de encéfalo.
- d) Além do tratamento do quadro demencial, a retirada de maneira lenta do clonazepam, pode ajudar também no tratamento cognitivo.
- e) Se a paciente em questão, tiver ressonância magnética de encéfalo normal e liquor com proteína beta amiloide diminuída e proteína TAU aumentada, devemos afastar doença de Alzheimer.**

15) Idosa, 73 anos refere diarreia e vômitos há 12 horas por quadro viral, além disso confusão mental aguda associada. Nega febre. No exame físico mostra-se desidratada +2/4, hipotensa 90/60 e confusa. Exames laboratoriais mostrou hiponatremia, creatina e ureia elevadas. Diante desse quadro clínico é incorreto afirmar:

- a) Como o idoso tem diminuição de aldosterona pelo próprio envelhecimento, teremos mais casos de hiponatremia e hipocalcemia associada em situações de depleção.**
- b) Devido a menor água corporal, menos sensação de sede, o paciente pode rapidamente desidratar e levar piora da função renal.
- c) O quadro de delirium foi devido a desidratação com elevação dos níveis de ureia e a hiponatremia.
- d) A diminuição da renina plasmática devido a senescência pode aumentar a incidência de hiponatremia.
- e) Além da creatinina nesse caso, deve-se monitorar o clearance de creatinina, pois esse é mais fidedigno para avaliar a função renal no idoso.

16) Paciente com 68 com doença de Parkinson diagnosticada há 7 anos, usando levodopa em doses fracionadas e pramipexole. Nos últimos 30 dias vem tendo movimentos coreiformes em segmento cefálico. Diante do caso clínico, qual seria esta alteração e melhor conduta para este doente?

- a) Piora do quadro de parkinsonismo e aumentar a dose da levodopa.

- b) Fenômeno wearing-off e aumentar dose de pramipexole.
- c) Discinesia e aumentar a dose da levodopa.
- d) Agitação psicomotora e associar quetiapina.

e) Discinesia continua e associar amantadina.

17) Uma paciente idosa é trazida por seus filhos por quadro de alucinações visuais mais proeminente a noite, com insônia e agitação psicomotora há 4 dias. Qual seria o medicamento mais apropriado para o seu caso até ficarem prontos seus exames investigatórios?

a) Clorpromazina

b) Risperidona

c) Lorazepam

d) Trazodona

e) Levomepromazina

18) Sobre o escore isquêmico de Hachinski, assinale a alternativa correta.

a) Sua aplicação é recomendada na investigação de DV cortical.

b) Deve ser utilizado na tentativa de diferenciar DV pura de demência mista.

c) Quando apresenta pontuação superior a 4, indica maior probabilidade de etiologia neurodegenerativa.

d) Não deve ser utilizado para estudo da contribuição vascular em um quadro demencial.

e) Pode ser usada para aferir o grau de acometimento motor e cognitivo.

19) A desprescrição é uma ferramenta usada para evitar a polifarmácia, reduzindo dose de medicamentos e até interrompendo o consumo de medicamentos, aonde o potencial de dano é superior aos seus benefícios. Sendo assim é incorreto afirmar:

a) Os aminoglicosídeos é uma classe segura de antibióticos em idosos.

b) Medicamentos como anticolinérgicos, benzodiazepínicos e antiinflamatórios devem ser evitados em pacientes idosos.

c) O uso indevido e por tempo prolongado de AINH podem levar a insuficiência renal e descompensação de ICC.

d) Retirar medicamentos prescritos por balconistas de farmácia, vizinhos ou familiares.

e) A amiodarona pode levar a alterações da tireoide, como o hipotireoidismo.

20) J.S. é um homem de 75 anos portador de quadro demencial devido à doença de Alzheimer em fase moderada. Mora em sua residência com cuidadores 24 horas/dia. Apresenta continência urofecal e alimenta-se sozinho. Dormia bem até que há uma semana iniciou quadro de agitação, agressividade verbal e incontinência urinária. Mostra-se assustado, referindo presença de pessoas estranhas na residência. Houve uma tentativa de agressão física a uma das cuidadoras, fato até então nunca ocorrido.

O paciente apresenta como comorbidades hipertensão arterial e diabetes melito (DM) do tipo 2. Está acima do peso e reluta em fazer atividade física. Ele utiliza os seguintes fármacos: donepezila, enalapril, hidroclorotiazida, metformina, amitriptilina. Médico avaliou o paciente em sua residência, com o exame físico normal.

Diante do caso é verdadeiro afirmar:

- a) O paciente teve piora do quadro demencial, sendo necessário associar memantina para controle da agitação e melhora cognitiva.
- b) Deve ser medicado com antipsicótico como o haloperidol gotas e suspender amitriptilina devido ao seu efeito anticolinérgico.
- c) Pedir exames laboratoriais para afastar possível quadro infeccioso ou metabólico, suspender o tricíclico e medicar com quetiapina.**
- d) Suspender a donepezila e pedir exames laboratoriais.
- e) Introduzir a trazodona para o quadro de agitação e associar memantina.

SENESCÊNCIA

Questões:

- 1) ## (P1: T20) 15) Idosa, 73 anos, refere a diarreia e vômitos a 12 horas, por quadro viral, além disso, confusão mental à dúvida associada, nega febre. No exame físico, mostra-se desidratada duas cruzes em quatro, hipotensa (9/6), e confusa. Exames laboratoriais mostraram **hiponatremia**, creatinina e ureia elevadas. Diante desse quadro clínico é INCORRETO afirmar:
 - a) Como ocorre diminuição da própria aldosterona pelo envelhecimento, teremos mais casos de hiponatremia e hipocalemia

- 2) ## (P1: T18) 16) M.A.N, 73 anos refere **diarreia, astenia, náuseas e vômitos há 8 horas**. Nega enterorragia e fezes com muco ou pus. No exame físico mostra-se **desidratada** +2/4, hipotensa 90/60 e confusa. Tirando o quadro patológico, a **fácil desidratação** dessa paciente pode ser explicada, devido a:
 - a) Aumento da massa gorda e diminuição da massa magra.
 - b) Diminuição de glândulas sudoríparas e setáceas.
 - c) Diminuição do fluxo sanguíneo renal.
 - d) Menor produção de renina.
 - e) Diminuição de água corpórea, devido a menor massa celular.

Questões comentadas:

- 3) ## (P1: T20) 15) Idosa, 73 anos, refere a diarreia e vômitos a 12 horas, por quadro viral, além disso, confusão mental à dúvida associada, nega febre. No exame físico, mostra-se desidratada duas cruzes em quatro, hipotensa (9/6), e confusa. Exames laboratoriais mostraram **hiponatremia**, creatinina e ureia elevadas. Diante desse quadro clínico é INCORRETO afirmar:
- a) Como ocorre diminuição da própria aldosterona pelo envelhecimento, teremos mais casos de hiponatremia e hipocalemia
- ↳ Hiponatremia → Correto
 - ↳ Hipocalemia → Errado
 - Correto seria **HIPERcalemia** (aumento do potássio)
 - ↳ **Senescência:**
 - Menor produção de renina e angiotensina II em idosos, **redução de aldosterona**.
 - Cuidar de **HIPERcalemia** (aumento do potássio) e **HIPONatremia** (redução sódio).
 - Se **Aldosterona** causa:
 - ↳ **Reabsorção** de Na^+ e Água
 - ↳ **Excreção** de K^+
 - Então, se ↓ **Aldosterona**
 - ↳ ↓ **Reabsorção** de Na^+ → **HIPONatremia**
 - ↳ ↓ **Excreção** de K^+ → **HIPERcalemia**
 - ↳ Medicamentos
 - Hiponatremia ou Hipercalcemia:
 - São eventos mais fáceis de ocorrer, principalmente por diuréticos de alça ou espironolactona, respectivamente.
- 4) ## (P1: T18) 16) M.A.N, 73 anos refere **diarreia, astenia, náuseas e vômitos há 8 horas**. Nega enterorragia e fezes com muco ou pus. No exame físico mostra-se **desidratada** +2/4, hipotensa 90/60 e confusa. Tirando o quadro patológico, a **fácil desidratação** dessa paciente pode ser explicada, devido a:
- a) Aumento da massa gorda e diminuição da massa magra.
- b) Diminuição de glândulas sudoríparas e setáceas.
- c) Diminuição do fluxo sanguíneo renal.
- d) Menor produção de renina.
- e) Diminuição de água corpórea, devido a menor massa celular.**
- ↳ Água:
 - A **quantia de células reduz**, e com isso há uma **diminuição da água corpórea**, se mantendo em 50%. Ainda há uma **menor capacidade de sentir sede**, e assim a **desidratação é um fenômeno mais comum**.

COMPROMETIMENTO COGNITIVO LEVE (CCL)

Questões:

- 25)## (P1: T18) 14) Sobre o Comprometimento Cognitivo leve, assinale a alternativa incorreta:
- a) A doença pode corresponder a uma fase prodrômica de uma demência de Alzheimer.
 - b) A avaliação de biomarcadores (amiloide e proteína tau) no líquido é indicada de rotina em pacientes com CCL amnésico.
 - c) O comprometimento Cognitivo Amnésico é o mais comum.
 - d) O paciente com CCL não apresenta alteração nas atividades de vida diária.
 - e) O CCL não amnésico com um único domínio afetado pode envolver somente linguagem, função executiva ou habilidades viso-espaciais.
- 26)## (P1: T20) 04) Sob os critérios de diagnósticos de comprometimento cognitivo leve, assinale a alternativa correta.
- a) A memória é necessariamente afetada no caso de CCL.
 - b) As atividades instrumentais de vida diária nunca são afetadas no CCL.
 - c) O diagnóstico de CCL está confirmado quando há qualquer comprometimento das AVDs.
 - d) O desempenho dos testes cognitivos dos pacientes com CCL costuma ser muito comprometido
 - e) O CCL não amnésico, com o único domínio afetado, pode incorporar somente linguagem, função executiva ou habilidades visuoespaciais.

Questões comentadas:

27) ## (P1: T18) 14) Sobre o Comprometimento Cognitivo leve, assinale a alternativa INCORRETA:

a) A doença pode corresponder a uma **fase prodrômica de uma demência de Alzheimer**.

→ **CCL Amnésico com um Único Domínio Afetado (memória):**

- **Somente a memória** é afetada
- É o subtipo **mais comum**
- Em grande parte dos casos, apresenta-se como **precursor da Doença de Alzheimer**

→ **Evolução dos tipos de CCL:**

- **COM alteração de memória (CCL amnésico)**

- Um **único domínio** alterado:
 - ↳ **Doença de Alzheimer**
- **Múltiplos domínios** alterados:
 - ↳ **Doença de Alzheimer**
 - ↳ **Demência Vascular**



- **SEM alteração de memória (CCL NÃO amnésico)** → Paciente que pode evoluir para outro tipo de demência, que **não seja Alzheimer**

- Um **único domínio** alterado:
 - ↳ Demência **Frontotemporal**
 - ↳ Demência de **Corpos de Lewy**
 - ↳ Paralisia Supranuclear Progressiva
 - ↳ Degeneração corticobasal
- **Múltiplos domínios** alterados:
 - ↳ Demência **Frontotemporal**
 - ↳ Demência de **Corpos de Lewy**

b) A avaliação de biomarcadores (amiloide e proteína tau) no líquido é indicada de rotina em pacientes com CCL amnésico.

- Não é rotina → É invasivo (geralmente não faz na geriatria), pede-se dúvida entre CCL ou DA
- Níveis **baixos de proteína Beta Amiloide** e **elevados de proteína Tau** = Maior risco de DA

c) O comprometimento **Cognitivo Amnésico** é o **mais comum**.

d) O paciente com CCL **não** apresenta alteração nas **atividades de vida diária**.

→ **CCL NÃO tem comprometimento de AVD**, mas pode ter comprometimento pequeno de **AIVD**

→ **Atividades de Vida Diária (AVD)**

- Avalia o desempenho do indivíduo na **execução de tarefas pessoais diárias**
 - Como por exemplo: banhar-se, vestir-se, cuidar da higiene pessoal, transferir-se do leito para uma cadeira, manter continência e alimentar-se

→ **Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD)**

- Verifica a **autonomia do indivíduo**, ou seja, sua capacidade para controlar, assumir e tomar decisões no dia a dia
 - Como por exemplo: capacidade de morar sozinho, ir ao banco, mexer no fogão

☆ **Demência** → Alteração de **AVD**

☆ **Comprometimento Cognitivo Leve** → **NÃO tem comprometimento de AVD**, mas pode ter comprometimento pequeno de **AIVD**

e) O CCL **Não Amnésico** com Um **Único Domínio Afetado** pode envolver **SOMENTE linguagem**, função **executiva** ou **habilidades viso-espaciais**.

28)## (P1: T20) 04) Sob os critérios de diagnósticos de comprometimento cognitivo leve, assinale a alternativa correta.

- a) A memória é necessariamente afetada no caso de CCL.
 - ↳ Nem sempre → Tem o CCL **NÃO amnésico** = SEM alteração de memória
- b) As atividades instrumentais de vida diária ~~nunca~~ são afetadas no CCL.
 - ↳ Muitas vezes são de maneira discreta.
 - ↳ **Demência** → Alteração de **Atividades de Vida Diária (AVD)**
 - ↳ **Comprometimento Cognitivo Leve** → **NÃO tem comprometimento de AVD**, mas pode ter comprometimento pequeno de **Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD)**
- c) O diagnóstico de ~~CCL~~ está confirmado quando há qualquer comprometimento das AVDs.
 - ↳ Quando tem o comprometimento das AVDs → Quadro de Demência
- d) O desempenho dos testes cognitivos dos pacientes com CCL costuma ser ~~muito~~ comprometido
 - ↳ Não, não é tão comprometido assim, ao contrário dos quadros demenciais
 - Testes de memória **levemente comprometidos**
 - ↳ O teste cognitivo com **melhor acurácia** no CCL foi o **MOCA** Teste
 - O MEEM tem uma sensibilidade baixa no diagnóstico de CCL, acontecendo também com o teste de fluência verbal e teste do relógio
- e) **O CCL não amnésico, com o único domínio afetado, pode incorporar somente linguagem, função executiva ou habilidades visuoespaciais.**

↳ **Tipos de CCL:**

- CCL amnésico (COM alteração de memória)
 - Um único domínio alterado:
 - ↳ Somente a memória é afetada
 - ↳ Subtipo mais comum
 - ↳ Pode evoluir para:
 - **Doença de Alzheimer**
 - Múltiplos domínios alterados:
 - ↳ Além da memória pode haver agnosia, apraxia e alterações visuoespaciais, de linguagem e de função executiva (memória motora)
 - ↳ Dificuldade mínima na realização de atividade instrumental da vida diária
 - ↳ Pode evoluir para:
 - Doença de Alzheimer ou **Demência Vascular**
- CCL NÃO amnésico (SEM alteração de memória) → Paciente que pode evoluir para outro tipo de demência, que **não seja Alzheimer**
 - Um único domínio alterado:
 - ↳ Uma única alteração dentre: linguagem, função executiva ou habilidades visuoespaciais
 - ↳ Pode evoluir para:
 - Demência **Frontotemporal**, Demência de **Corpos de Lewy**, Paralisia Supranuclear ou Progressiva Degeneração corticobasal
 - Múltiplos domínios alterados:
 - ↳ Pode haver agnosia, apraxia e alterações visuoespaciais, de linguagem e de função executiva
 - ↳ Pode evoluir para:
 - Demência **Frontotemporal** ou Demência de **Corpos de Lewy**

DOENÇA DE ALZHEIMER

Questões:

- 58)## (P1: T20) 06) Uma senhora de 72 anos de idade, apresenta dois anos de progressiva alteração de memória e dificuldades AVDs, com compras e perdas de objetos, ela recebeu o diagnóstico provável de DA, foi surgindo uso de galantamina em doses crescentes até 24 miligramas por dia. Depois de cinco meses, retorna com a filha reclamando que o tratamento não fez efeito, porque está do mesmo jeito. A informação é que continua com as mesmas limitações, fazendo as mesmas atividades, isto é, cuidando da casa, fazendo contas em lugares muito próximos e indo à igreja aos domingos. O score de minimental caiu um ponto. Considerando as informações apresentadas, pode-se concluir o quê?
- a) O diagnóstico não é de DA, pois o tratamento fracassou
 - b) O diagnóstico é de DA, mas essa medicação não funcionou e precisa ser substituída por outro inibidor da acetilcolinesterase.
 - c) A medicação obteve uma resposta bem e deve ser adicionado à memantina.
 - d) A resposta da medicação está correta, dentro das expectativas do tratamento.
 - e) Deve-se adicionar outro inibidor de acetilcolinesterase.
- 59)## (P1: T20) 14) Idosa com 74 anos, chegou ao consultório geriátrico com sua filha que relata que sua mãe há seis meses esquece fatos recentes, repetitividade, esquece palavras que vai falar de desorientação espacial. Tem queimado vários alimentos, tem transtorno depressivo maior a cinco anos. Diabetes mellitus insônia em tratamento. Usa como medicações, losartana, escitalopram, clonazepam (usa 10 anos), e metformina. Exame físico normal, 10 CS deu 4, o teste de fluência verbal deu 5. Dentro do caso assinala é a resposta INCORRETA:
- a) Quadro característico de síndrome demencial, provável doença de Alzheimer, pois tem alterações instrumentais de vida diária e testes cognitivos alterados.
 - b) O paciente tem questões de fatores de risco para ter uma demência, diabetes, uso crônico de medos de benzodiazepínico, e depressão na terceira idade
 - c) Doença de Alzheimer em fase inicial onde pediremos exames laboratoriais como TSH, VDRL, FTLS, B12 e exame de imagem com ressonância magnética incepta.
 - d) Além do tratamento do quadro demencial, retirado de uma maneira lenta do clonazepam, pode ajudar também no tratamento cognitivo,
 - e) Se a paciente em questão tiver ressonância magnética de encéfalo normal e liquor com proteína betaminóide diminuída e proteína tau aumentada, devemos afastar a doença.
- 60)## (P1: T20) Homem de 75 anos, portador de quadro demencial devido a doença de Alzheimer, em fase moderada, mora em sua residência com cuidadores 24h por dia. Apresenta continência urofecal e alimenta-se sozinho. Dormia bem até que há uma semana iniciou quadro de agitação, agressividade verbal e incontinência urinária. Mostra-se assustado, referindo a presença de pessoas estranhas. Houve uma tentativa de agressão física a uma das cuidadoras, fato até então nunca ocorrido. O paciente apresenta como comorbidades: hipertensão e DM2, está acima do peso e reluta em fazer atividade física. Ele utiliza: Donepezila, Enalapril, Hidroclorotiazida, Metformina e Amitriptilina. O médico avaliou o paciente em sua residência com exame físico normal. Qual a conduta correta:
- a) Pedir exames laboratoriais para afastar possível quadro infeccioso ou metabólico, suspender o tricíclico e medicar com Quetiapina
 - b) Introduzir a Trazodona para o quadro de agitação, e associar a Memantina

- c) Deve-se medicar com antipsicótico como Haloperidol em gotas
- d) Paciente teve piora do quadro demencial, sendo necessário associar a Memantina para controle da agitação e melhora do cognitivo

61)## (P1: T18) 10) Idosa com 74 anos, professora aposentada, chega ao consultório geriátrico com sua filha, que relata que sua mãe há 8 meses, esquece fatos recentes, repetitividade, esquece palavras que vai falar e teve um episódio desorientação espacial. Tem queimado vários alimentos. Tem transtorno depressivo maior há 20 anos e insônia em tratamento. Usa como medicações: Usa Losartana, escitalopram 10mg e clonazepam gotas. Exame físico normal. 10 CS: 4, Teste com fluência verbal: 7. Diante do caso qual o provável diagnóstico e exames a serem pedidos?

- a) Doença de Alzheimer fase inicial; aonde pediremos exames laboratoriais como cálcio sérico, tgo, tgp, glicemia jejum, tsh, creatinina e exame de imagem como a ressonância magnética de encéfalo.
- b) Comprometimento cognitivo leve amnésico; aonde pediremos exames laboratoriais como vdri, ftasbs, cálcio sérico, tgo, tgp e glicemia jejum e dosagem de proteína beta amiloide e proteína tau no liquor.
- c) Alteração cognitiva secundária a depressão e ao uso de benzodiazepínicos, aonde pediremos exames laboratoriais como B12, ácido fólico, vdrl, HIV, função renal e exame de imagem como a ressonância magnética de encéfalo.
- d) Doença de Alzheimer fase inicial; aonde pediremos exames laboratoriais como TSH, glicemia jejum, vitamina D, fosfatase alcalina e exame de imagem como a ressonância magnética de encéfalo.
- e) Comprometimento cognitivo leve amnésico; aonde pediremos exames laboratoriais e spect-cerebral.

62)## (P1: T18) 18) L.A.O de 69 anos é trazido ao consultório com queixas de memória recente diminuída há 6 meses, com agnosia, diminuição da atenção, agitação psicomotora, principalmente no período noturno e delírios de ciúme patológico. Diante do quadro clínico, poderemos afirmar:

- a) É um quadro de possível Demência de Alzheimer, com manifestações da Síndrome de Godot. Confirmado o diagnóstico entraremos com antidepressivos para tratar a doença e prescrever Memantina.
- b) O paciente apresenta Comprometimento Cognitivo Leve e necessita de investigação com exames laboratoriais e Ressonância Magnética, para excluir Demência.
- c) Quadro de Doença de Alzheimer, sem necessidade de pedir exames de imagem, somente os laboratoriais.
- d) Possível Doença de Alzheimer, com delírios da Síndrome de Othello, aonde após os exames confirmatórios e testes de cognitivos, entraremos com anticolinesterásicos como a Donepezila
- e) Possível Doença de Alzheimer, com delírios da Síndrome de Capgras, aonde pediremos dosagem líquórica de proteína beta-amilóide e proteína tau.

Questões comentadas:

63)## (P1: T20) 06) Uma senhora de 72 anos de idade, apresenta dois anos de progressiva **alteração de memória e dificuldades AVDs**, com compras e perdas de objetos, ela recebeu o diagnóstico provável de DA, foi surgindo uso de **galantamina** em doses crescentes até 24 miligramas por dia. Depois de cinco meses, retorna com a filha reclamando que o **tratamento não fez efeito**, porque está do mesmo jeito. A informação é que continua com as mesmas limitações, fazendo as mesmas atividades, isto é, cuidando da casa, fazendo contas em lugares muito próximos e indo à igreja aos domingos. O score de **minimental caiu um ponto**. Considerando as informações apresentadas, pode-se concluir o quê?

- a) O diagnóstico não é de DA, pois o tratamento fracassou
 - ↳ Não
- b) O diagnóstico é de DA, mas essa medicação não funcionou e precisa ser substituída por outro inibidor da acetilcolinesterase.
 - ↳ Medicamentos para **Alzheimer não vão melhorar o paciente** de uma maneira muito drástica (paciente não tem uma melhora importante com o uso da medicação). O que a gente percebe é que a **doença estabiliza por algum tempo e depois ela progride lentamente**.
 - Então, no caso aqui, como o paciente está do mesmo jeito, **não piorou, nem melhorou, e a doença está controlada**, é sinal de que o **medicamento está fazendo efeito**.
 - Se depois de cinco meses o paciente **tivesse piorando** trocaria por outro → Um **Anticolinesterásico**
- c) A medicação obteve uma resposta bem ... e deve ser adicionado à memantina.
 - ↳ Não é o caso, porque o paciente está em uma fase leve da doença não está numa fase grave. Ela está cuidando da casa, fazendo as compras, então ela está numa fase leve da doença
- d) A resposta da medicação está correta, dentro das expectativas do tratamento.**
- e) Deve-se adicionar outro inibidor de acetilcolinesterase.
 - ↳ Mesmo se o paciente estivesse piorando → **Não adiciona outro**, mas sim **troca a medicação**

64)## (P1: T20) 14) Idosa com 74 anos, chegou ao consultório geriátrico com sua filha que relata que sua mãe há seis meses **esquece fatos recentes**, repetitividade, **esquece palavras** que vai falar e **desorientação visuoespacial**. Tem **queimado vários alimentos**, tem **transtorno depressivo maior** a cinco anos. **Diabetes mellitus** e **insônia** em tratamento. Usa como medicações, *losartana*, *escitalopram*, *clonazepam* (usa 10 anos), e *metformina*. Exame físico normal, **10 CS deu 4**, o teste de fluência verbal deu 5 (então 2 deram baixos). Dentro do caso assinala é a resposta INCORRETA:

- a) Quadro característico de síndrome demencial, provável doença de Alzheimer, pois tem **alterações instrumentais de vida diária e testes cognitivos alterados**.
- b) O paciente tem questões de **fatores de risco** para ter uma **demência, diabetes, uso crônico de medos de benzodiazepínico, e depressão** na terceira idade
 - ↳ Fatores de risco para ter uma demência
 - Não é só questão genética (não modificáveis)
 - Tem outros fatores modificáveis: como diabetes, depressão, obesidade, hipoacusia (é importante e leva a demência - tem que corrigir déficit auditivo com aparelho)
- c) Doença de Alzheimer em fase inicial onde pediremos exames laboratoriais como **TSH, VDRL, FTLS, B12** e exame de imagem com **ressonância magnética**.

d) Além do tratamento do quadro demencial, retirado de uma maneira lenta do clonazepam, pode ajudar também no tratamento cognitivo

- **BDZ**

- Pioram a capacidade cognitiva (Distúrbio cognitivo)
- Confusão mental
- Queda, sonolência, fraqueza muscular e delírio
- Para paciente que já toma BDZ → Tenta RETIRAR

- ↳ O menos prejudicial seria o Clonazepam por não passar por oxidação hepática

e) Se a paciente em questão tiver ressonância magnética de encéfalo normal e liquor com proteína betaminóide diminuída e proteína tau aumentada, devemos afastar a doença.

↳ Duas coisas erradas:

- O paciente pode ter o quadro clínico de doença de Alzheimer, testes compatíveis, e numa **fase inicial a ressonância ou tomografia pode ser normal**, e o paciente **ter a doença**.
- Faz o diagnóstico clínico, pede o exame de imagem para afastar outras patologias e o liquor, por exemplo, vem com a proteína da betaminóide diminuída e proteína tau aumentada (na doença de **Alzheimer** a alteração vai ser essa → **Beta-amilóide diminuída e proteína tau aumentada**). Com isso, **comprova a doença**, não afasta a doença

65)## (P1: T18) 10) Idosa com 74 anos, professora aposentada, chega ao consultório geriátrico com sua filha, que relata que sua mãe há 8 meses, esquece fatos recentes, repetitividade, esquece palavras que vai falar e teve um episódio desorientação espacial. Tem queimado vários alimentos. Tem transtorno depressivo maior há 20 anos e insônia em tratamento. Usa como medicações: Usa Losartana, escitalopram 10mg e clonazepam gotas. Exame físico normal. **10 CS: 4**, Teste com fluência verbal: 7. Diante do caso qual o provável diagnóstico e exames a serem pedidos?

a) Doença de Alzheimer fase inicial; aonde pediremos exames laboratoriais como cálcio sérico, tgo, tgp, glicemia jejum, tsh, creatinina e exame de imagem como a ressonância magnética de encéfalo.

↳ Exames laboratoriais:

- HMG completo
- Ureia
- Creatinina
- Albumina
- Glicemia jejum
- TSH
- Dosagem de vitamina B12 e Ácido fólico
- TGO, TGP
- Cálcio sérico
- Sorologia para sífilis e HIV

b) Comprometimento cognitivo leve amnésico; aonde pediremos exames laboratoriais como vdri, ftasbs, cálcio sérico, tgo, tgp e glicemia jejum e dosagem de proteína beta amiloide e proteína tau no liquor.

↳ CCL → Testes de memória levemente comprometidos

- 10-CS → 6 a 7 = CCL

c) Alteração cognitiva secundária a depressão e ao uso de benzodiazepínicos, aonde pediremos exames laboratoriais como B12, ácido fólico, vdrl, HIV, função renal e exame de imagem como a ressonância magrética de encéfalo.

- d) Doença de Alzheimer fase inicial; aonde pediremos exames laboratoriais como TSH, glicemia jejum, vitamina D, ~~fosfatase alcalina~~ e exame de imagem como a ressonância magnética de encéfalo.
- ↳ Não pede fosfatase alcalina
 - **Fosfatase alcalina → OSTEOPOROSE**
- e) Comprometimento cognitivo leve amnésico; aonde pediremos exames laboratoriais e spect-cerebral.

66) ## (P1: T20) 20) Um homem de 75 anos, portador de **quadro demencial**, devido a doença de **Alzheimer e fase moderada**, mora em sua residência com cuidadores 24 horas por dia, apresenta **incontinência urofecal e alimenta-se sozinho**. Dormia bem, até que uma semana iniciou quadro de **agitação, agressividade verbal e incontinência urinária**. Mostra-se assustado e afirma a **presença de pessoas estranhas** (está tendo alucinações). Houve uma tentativa de **agressão física** a uma das cuidadoras, fato até então nunca corrido. O paciente apresenta como comorbidades, hipertensão e diabetes tipo 2, está acima do peso, reluta em fazer atividade física. Ele utiliza *donepezila, enalapril, hidroclorotiazida, metformina e amitriptilina*. O médico avaliou o paciente e sua residência com exame físico normal. O correto aqui:

a) Pedir exames laboratoriais para afastar possível quadro infeccioso ou metabólico (como ele está tendo incontinência urinária, pode ser uma infecção urinária) suspender o tricíclico (que amitriptilina piora o quadro demencial, que é o tricíclico) e medicar com quetiapina.

- ↳ Se o paciente deteriora rapidamente e de forma inesperada, mesmo recebendo tratamento, devemos procurar causas: Comorbidades, uso de medicações, delirium, causas comportamentais.
 - Verificar se alguma comorbidade, infecção, se medicação ou se o cuidador está interferindo
 - ↳ Pedir: Urina I sp → Sempre deve descartar infecção urinária em casos de delírio
- b) Trasdona para o quadro de agitação e associar a memantina
- ↳ Não é o caso de associar a memantina
 - ↳ Trazodona até poderia
 - Trazodona (antidepressivo) dá sono → É indica quando paciente não dorme a noite e tem **Síndrome do Sol Poente**, que vai perambular, quer sair de casa
- c) Deve ser medicado com antipsicótico haloperidol ~~gotas~~
- ↳ Haloperidol
 - Só endovenoso
 - Haloperidol gotas ou comprimido → Evitar usar em pacientes idosos, tem o efeito parkinsoniano
- d) O paciente teve piora do quadro demencial, sendo necessário associar a memantina para o controle da agitação e melhora a cognitiva
- ↳ Não, porque o paciente está tendo um **quadro de delírio** dentro da demência.
 - Então, **precisa medicar o quadro de delírio**
 - O paciente não teve uma piora na parte cognitiva, ele está tendo um quadro confusional, logo não adianta associar a memantina

67)## (P1: T18) 18) L.A.O de 69 anos é trazido ao consultório com queixas de **memória recente diminuída há 6 meses**, com **agnosia, diminuição da atenção, agitação psicomotora**, principalmente no período noturno e **delírios de ciúme patológico**. Diante do quadro clínico, poderemos afirmar:

a) É um quadro de possível Demência de Alzheimer, com manifestações da Síndrome de ~~Godot~~. Confirmado o diagnóstico entraremos com antidepressivos para tratar a doença e prescrever ~~Memantina~~.

↪ Não pode iniciar tratamento com Memantina

- Indicação na fase moderada e avançada
- Se os anticolinesterásicos não funcionarem, pode tratar só com memantina? Sim, o que **não pode é iniciar só com memantina** sem tentar os anticolinesterásicos

↪ Tem Síndrome de Othelo → Associada a ideia de traição, também conhecida como Síndrome do Delírio de Ciúme

↪ **Sintomas neuropsiquiátricos**

- **Síndrome do Sol Poente** → Inquietação, agitação, irritabilidade ou confusão que podem começar ou piorar à medida que a luz do dia começa a desaparecer.
- **Síndrome de Othelo** → Associada a ideia de traição, também conhecida como **Síndrome do Delírio de Ciúme**.
- **Síndrome de Godot** → Gera o pensamento de que houve a troca de uma pessoa por outra, como da esposa ou outra familiar.
- **Delírio de roubo** → De seus pertences por quem frequenta sua casa ou mesmo ambiente.
- **Sinal do espelho** → A pessoa é incapaz de se reconhecer.
- **Hóspedes fantasmas** → Com falecidos ou desconhecidos.
- **Síndrome de Diógenes** → Profunda pobreza mesmo com dinheiro que tem - começa a viver como mendigo.

b) O paciente apresenta Comprometimento Cognitivo Leve e necessita de investigação com exames laboratoriais e Ressonância Magnética, para excluir Demência.

c) Quadro de Doença de Alzheimer, sem necessidade de pedir exames de imagem, somente os laboratoriais.

d) Possível Doença de Alzheimer, com delírios da Síndrome de Othelo, aonde após os exames confirmatórios e testes de cognitivos, entraremos com anticolinesterásicos como a Donepezila

e) Possível Doença de Alzheimer, com delírios da Síndrome de Capgras, aonde pediremos dosagem líquórica de proteína beta-amilóide e proteína tau.

DEMÊNCIA FRONTOTEMPORAL

Questões:

- 46)## (P1: T20) 08) A demência frontotemporal é uma doença degenerativa que afeta faixas etárias mais jovens entre 45 a 64 anos, sendo assim é correto dizer:
- a) R: Alteração da personalidade com aparência desleixada, impaciência e irritabilidade, disputa argumentativa, comentários libidinosos e compulsões que precede o quadro de memória
- 47)## (P1: T18) 08) A Demência Fronto-Temporal é uma doença degenerativa que afeta faixa etárias mais jovens, entre 45 e 64 anos, sendo assim e correto dizer:
- a) Há um comprometimento da acetilcolina nesta doença, por isso o uso de anticolinesterásicos.
- b) Há inicialmente uma perda de memória seguida de alterações de comportamento, como impulsividade, hiperoratividade e risos inadequados.
- c) Uma maior impregnação por neurolépticos em relação a outras demências.
- d) A sobrevida é maior do que na doença de Alzheimer.
- e) O comportamento estereotipados e ritualizados são comuns, com mudança nos hábitos alimentares, com preferência por doces.

Questões comentadas:

48)## (P1: T20) 08) A demência frontotemporal é uma doença degenerativa que afeta faixas etárias mais jovens entre 45 a 64 anos, sendo assim é correto dizer:

↪ **Demência frontotemporal**

- **Jovens** entre 45 a 64 anos
- **Alteração da personalidade**
- **Aparência desleixada**
- **Impaciência e irritabilidade**
- **Disputa argumentativa** (aquele indivíduo que confronta todo o mundo)
- **Comentários libidinosos**
- **Compulsões que precedem o quadro de memória** (geralmente vem o quadro mais psiquiátrico e depois vem a alteração de memória)

49)## (P1: T18) 08) A Demência Fronto-Temporal é uma doença degenerativa que afeta faixa etárias mais jovens, entre 45 e 64 anos, sendo assim é correto dizer:

a) Há um comprometimento da acetilcolina nesta doença, por isso o uso de anticolinesterásicos.

↪ Os **anticolinesterásicos NÃO são usados** porque **não tem nenhum déficit de acetilcolina**

↪ **Tratamento Demência Fronto-Temporal**

- Não há tratamento que cure ou modifique a doença
- Os medicamentos são todos psiquiátricos, não tem um remédio específico
 - **ISRS** → Compulsões e impulsividade
 - **Trazodona** → Controle dos sintomas comportamentais, como agitação, desinibição, comportamentos perserverativos e insônia
 - **Neurolépticos** → Agitação e agressividade intensa
 - ↳ Neurolépticos aumentam a mortalidade!!! Pioram o parkinsonismo, disfagia, redução da atividade motora

b) Há inicialmente uma perda de memória seguida de alterações de comportamento, como impulsividade, hiperoratividade e risos inadequados.

↪ **Alterações de comportamento** é que **precedem o quadro de memória**

- Geralmente vem o **quadro psiquiátrico** e **depois vem a alteração de memória**

c) Uma maior impregnação por neurolépticos em relação a outras demências.

↪ **Hipersensibilidade a neurolépticos**

- Um dos critérios diagnóstico **sugestivos de Demência com Corpos de Lewy**
- Maior sensibilidade a neurolépticos
 - Paciente com alucinações → Médico passa Resperidona → Trava, fica rígido → Isso não é comum no DA e outras demências

d) A sobrevida é maior do que na doença de Alzheimer.

↪ Prognóstico

- Demência com Corpos de Lewy (DCL) e Demência Fronto-Temporal tem prognóstico **PIOR** que a Doença de Alzheimer → **MENOR sobrevida**

e) O comportamento estereotipados e ritualizados são comuns, com mudança nos hábitos alimentares, com preferência por doces.

DOENÇA DE PARKINSON

Questões:

- 50)## (P1: T20) 12) O que se refere às manifestações clínicas de doença de Parkinson, analisa as alternativas a seguir e marcar com V, verdadeiro F de falso.
- a) () Em indivíduos acometidos por doença de Parkinson, o tremor de repouso ainda é o primeiro sintoma reconhecido pelo próprio paciente, por seus familiares e pelos médicos assistentes
 - b) () A bradicinesia não é o principal sintoma cardinal na doença de Parkinson do idoso, e sim o tremor.
 - c) () A instabilidade postural, em geral, não ocorre nas formas iniciais e leves de doença de Parkinson
 - d) () Dermate seborreica e hipotensão ortostática e alterações do sono rem podem fazer parte da patologia.
- 51)## (P1: T20) 16) Paciente com 68 anos com doença de Parkinson, diagnosticada há 7 anos, usando levodopa em doses fracionadas e pramipexona. Nos últimos 30 dias, vem tendo movimentos coreiformes em segmento cefálico. Diante do caso clínico, qual seria esta alteração e a melhor conduta para esse doente?
- a) Piora do parkinsonismo, aumentar a dose de Levodopa
 - b) Fenômeno de on-off, aumentar a dose de Pramipexol
 - c) Discinesia, aumentar dose de Levodopa
 - d) Agitação psicomotora, associar Quetiapina
 - e) Discinesia contínua, associar Amantadina
- 52)## (P1: T18) 13) Com relação à doença de Parkinson é verdadeiro afirmar;
- I. Déficit olfativo, alterações comportamentais e perda ponderal constituem sinais/sintomas pré-motores
 - II. O tremor está presente em 70% dos pacientes e caracteriza se por diminui sua amplitude com o estresse ao realizar tarefas.
 - III. A rigidez pode estar presente com o fenômeno da roda dentada
 - IV. Hipomimia e hipofonia são sinais observados em pacientes com esta patologia.
 - V. O diagnostico é definido com base na presença de síndrome parkinsoniana com tremor, bradicinesia e rigidez muscula
- São afirmativas corretas:
- a) I e IV
 - b) II, III, IV e V
 - c) III, IV e V
 - d) I, III e IV
 - e) Todas corretas

53)## (P1: T18) 19) Sobre o tratamento da DP, assinale a alternativa incorreta:

- a) Os agonistas dopaminérgicos têm como benefícios melhorar os sintomas motores e as flutuações motoras pelo uso da levodopa?
- b) As discinesias podem ser tratadas com o uso da amantadina ou diminuição da dose da levodopa.
- c) A levodopa é a única droga que não causa delirium no paciente idoso
- d) Uma opção no tratamento inicial de um idoso abaixo de 70 anos é o uso da rasagilina ou agonista dopaminérgico
- e) O biperideno tem seu uso limitado no idoso, devido a sua ação anticolinérgica, causando transtornos neuropsiquiátricos.

Questões comentadas:

- 54)## (P1: T20) 12) O que se refere às manifestações clínicas de doença de Parkinson, analisa as alternativas a seguir e marcar com V, verdadeiro F de falso.
- a) (V) Em indivíduos acometidos por doença de Parkinson, o **tremor de repouso ainda é o primeiro sintoma reconhecido** pelo próprio paciente, por seus familiares e pelos médicos assistentes
- ↳ Geralmente quando o paciente tem doença de Parkinson, o sinal que eles mais relatam é o tremor, é mais vívido e o que mais incomoda
 - NÃO necessariamente precisa ter Tremor
 - Acinesia ou Bradicinesia → PRINCIPAL SINAL → TEM QUE TER
- b) (F) A bradicinesia ~~não~~ é o principal sintoma cardinal na doença de Parkinson do idoso, e sim o tremor.
- ↳ **Acinesia** ou **Bradicinesia** → **É o principal sinal**
 - Diagnóstico de doença de Parkinson → Precisa ter **Bradicinesia** + Pelo menos um dos três:
 - Tremor; Rigidez muscular; Instabilidade postural
- c) (V) A **instabilidade postural**, em geral, **não ocorre nas formas iniciais e leves** de doença de Parkinson
- ↳ **Instabilidade postural** → Ocorre nas formas TARDIAS
- d) (V) Dermatite seborreica e hipotensão ortostática e alterações do sono rem podem fazer parte da patologia.
- ↳ Sintomas não motores:
 - Constipação intestinal.
 - Dermatite seborreica em face → muito comum
 - **Hipotensão Postural**
 - Pode aparecer em fases moderadas, dificilmente na fase inicial
 - Na Atrofia de Múltiplos Sistemas → Começa na fase INICIAL.
 - Distúrbio comportamental do sono REM
- 55)## (P1: T20) 16) Paciente com 68 anos com **doença de Parkinson**, diagnosticada há **7 anos**, usando **levodopa** em doses fracionadas e **pramipexona**. Nos últimos 30 dias, vem tendo **movimentos coreiformes em segmento cefálico** (= Discinesia). Diante do caso clínico, qual seria esta alteração e a melhor conduta para esse doente?
- a) Piora do Parkinsonismo, aumentar a dose da levodopa
- ↳ Não está piorando o Parkinsonismo.
 - ↳ A **discinesia** é um **efeito a longo prazo da levodopa**.
 - A levodopa ela se liga através da dopamina a receptores dopaminérgicos e estimula muitos receptores e causando essas discinesias.
 - Se aumentar a levodopa, vai piorar mais ainda a discinesia.
- b) Fenômeno On-Off, aumento da dose do pramipexora
- ↳ O On-Off → Quando o indivíduo começa a **perder a eficácia da levodopa**.
 - Aparecem NO FINAL do efeito da levodopa
 - Então próximo a dosagem X ele começa a piorar os sintomas parkinsonianos
- c) Discinesia, aumentar a dose da levodopa.
- ↳ É discinesia, mas aumentar a dose da levodopa e vai piorar ela
- d) Agitação psicomotora, associar a quetiapina.
- e) **Discinesia continua, associar a amantadina**
- ↳ Amantadina e a Pramipexora são usados também nas discinesias

56)## (P1: T18) 13) Com relação à doença de Parkinson é verdadeiro afirmar;

I. Déficit olfativo, alterações comportamentais e perda ponderal constituem sinais/sintomas pré-motores

↪ **Sintomas pré-clínicos da doença de Parkinson**

- Constipação
- Déficits olfatórios (discriminação)
- Distúrbio comportamental do sono REM
- Depressão
- Perda de peso

II. O tremor está presente em 70% dos pacientes e caracteriza-se por ~~diminui~~ sua amplitude com o estresse ao realizar tarefas.

↪ **Sintomas Motores**

- **Bradicinesia ou acinesia**
 - Diminuir o balanço dos braços → anda como um robzinho
 - Redução da mímica facial → **Fácies de máscara**
 - Acúmulo de saliva → deglute menos saliva → **sialorreia**
- **Tremor de Repouso** – 4 a 6hz.
 - Tremor em **contar moeda** → Alta amplitude e baixa frequência
 - ↳ Diminui ou desaparece quando se inicia um movimento
 - ↳ Quando pega o objeto tremor desaparece ou diminui
 - ↳ Piora com ESTRESSE
- **Rigidez muscular**
 - Sinal da roda dentada.
 - Positiva → pega o braço e faz movimento de CATRACA

III. A rigidez pode estar presente com o fenômeno da roda dentada

IV. Hipomímia e hipofonia são sinais observados em pacientes com esta patologia.

↪ Sinais observados

- **Hipomímia facial** ou **Face em máscara** → Redução da mímica facial
- **Hipofonia** (diminuição do volume da voz), disartria, gagueira, jatos de palavras

V. O diagnóstico é definido com base na presença de síndrome parkinsoniana com tremor, bradicinesia e rigidez muscular

↪ Diagnóstico de doença de Parkinson

- Precisa ter Bradicinesia + Pelo menos um dos três:
 - Tremor
 - Rigidez muscular
 - Instabilidade postural

São afirmativas corretas:

- a) I e IV
- b) II, III, IV e V
- c) III, IV e V

↪ No gabarito da prova diz que tá errada essa

- d) I, III e IV
- e) Todas corretas

57)## (P1: T18) 19) Sobre o tratamento da DP, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Os agonistas dopaminérgicos têm como benefícios melhorar os **sintomas motores** e as **flutuações motoras** pelo uso da levodopa

↪ Agonistas dopaminérgicos → Pramipexole e Rotigotina (em adesivo).

b) As discinesias podem ser tratadas com o uso da Amantadina ou diminuição da dose da Levodopa.

↪ **Discinesias:**

- Ocorre no momento do pico de efeito da dose, por conta da estimulação por glutamato
- As discinesias são movimentos coreiformes, mioclonias, tiques e atetoses
- Em uma discinesia contínua os movimentos coreiformes passam a ser presentes durante todo o tempo de efeito da levodopa

• **Tratamento**

- **Amantadina** (Anticolinérgico) associado com agonista dopaminérgico
- **DIMINUIR A DOSE da Levodopa**

↳ Os pacientes que tem discinesias são pacientes que usam Levodopa há muito tempo

c) A levodopa é a única droga que não causa delirium no paciente idoso

↪ **Levodopa**

- Medicamento com a maior eficácia para o Parkinson.
- Possui efeitos colaterais que incluem náuseas, vômitos, discinesias e flutuações

d) Uma opção no tratamento inicial de um idoso abaixo de 70 anos é o uso da rasagilina ou agonista dopaminérgico

↪ 70 anos → ESCOLHA É LEVODOPA

↪ < 70 anos → Droga de eleição

- Amantadina
- Agonistas dopaminérgicos
- Inibidores de MAO-B (Rasagilina)
 - Confusão mental em idosos

e) O biperideno tem seu uso limitado no idoso, devido a sua ação anticolinérgica, causando transtornos neuropsiquiátricos.

• **Anticolinérgicos**

- Biperideno → mais usado para diminuir tremor e rigidez, mas pra idoso não
 - ↳ (Idoso usa → Triexifenidila)
- Risco de demência → NÃO SÃO INDICADOS PARA PACIENTES IDOSOS

DEPRESSÃO

Questões:

- 123) ## (P2: T20) Paciente 76 anos, sexo feminino, obesa, com queixas de anedonia, irritabilidade, mal-estar, tonturas, desanimo e ansiedade há 120 dias. Foi num médico generalista há 60 dias que passou dose máxima de escitalopram, com razoável melhora. Mantem ainda quadro de desanimo e tristeza em certos dias, querendo ficar somente em casa e não sair. Paciente tem como comorbidade Doença de Parkinson. Diante de tudo isso, qual seria a melhor conduta para a paciente:
- a) Associar outro ISRS.
 - b) Associar bupropiona.
 - c) Trocar por mirtazapina.
 - d) Trocar o escitalopram pela venlafaxina.
 - e) Associar quetiapina a noite para insônia.

RESUMO

Diagnóstico

- De acordo com DSM-5 são necessários:
 - Pelo menos **5 sintomas** por pelo menos **2 semanas**
 - +**
 - Presença de **humor depressivo** marcado pela **diminuição de interesse nas atividades de vida diária**.
 - Outros sintomas
 - Alteração de peso, alteração de apetite, insônia ou agitação psicomotora, fadiga, culpa excessiva, pensamentos de morte excessivo
 - Necessário que esses sintomas **não sejam decorrentes** de medicamentos, drogas ou alguma enfermidade

Tratamento

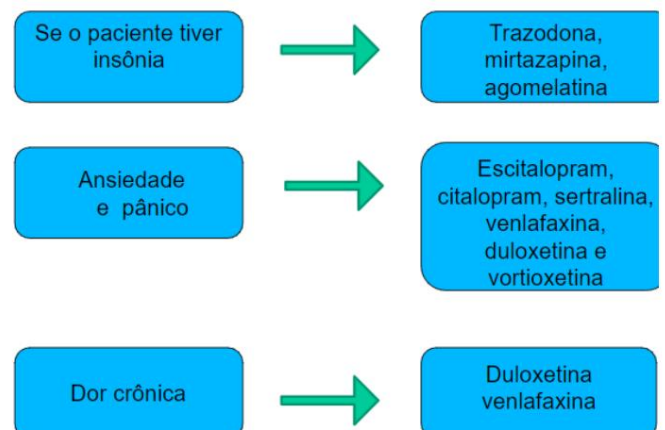
Abordagem ideal:

- Início com um **ISRS**
 - Falta de resposta ou Resposta parcial
 - Aumentar a dose do ISRS** ou **Trocar por outro ISRS**.
 - Ainda sem resposta pode ser feita:
 - Troca** para **ISRSN** ou **Associação** com Bupropiona, Lítio, Lamotrigina, Oxcarbamazepina e Quetiapina.
 - Troca para ISRSN**
 - Ausência de resposta pode:
 - Aumentada a dose do ISRSN**
 - Associar outro ISRSN** ou **Associação** com Bupropiona, Lamotrigina, oxcarbamazepina e Quetiapina.



Indicações:

- Insônia:**
 - Trazodona, Mirtazapina** (aumento de peso) e **Agomelatina**.
- Ansiedade e pânico:**
 - Escitalopram, Citalopram, Sertralina, Vortioxetina, Venlafaxina** e **Duloxetina**.
- Dor crônica:**
 - Venlafaxina** e **Duloxetina**



Questões comentadas:

124) ## (P2: T20) Paciente 76 anos, sexo **feminino** [*Fator de risco*], obesa, com queixas de **anedonia**, **irritabilidade**, **mal-estar**, **tonturas**, **desanimo** e **ansiedade** há 120 dias [*Depressão Tardia, início após 60 anos ... 6 sintomas por mais de 2 semanas*]. Foi num médico generalista há 60 dias que passou **dose máxima de escitalopram [ISRS]**, com **razoável melhora [resposta parcial]**. Mantém ainda quadro de **desanimo** e **tristeza** em certos dias, querendo ficar **somente em casa e não sair**. Paciente tem como **comorbidade** Doença de Parkinson. Diante de tudo isso, qual seria a melhor conduta para a paciente:

a) Associar outro ISRS.

↳ **NÃO ASSOCIAR dois ISRS**

- **Aumenta a dose do ISRS** ou **Troca** por outro **ISRS**.

↳ Dois **ISRSN** **podem ser associados**

b) Associar bupropiona

↳ Último passo, caso **ISRS** ou **ISRSN** falhem

- **Bupropiona** = ISR**DN**

c) Trocar por mirtazapina.

↳ **Mirtazapina**

- Antidepressivos noradrenérgicos e serotoninérgicos específicos
- Indicado para **INSÔNIA**
- Causa aumento de peso

d) Trocar o escitalopram pela venlafaxina

↳ Início com um **ISRS** (**escitalopram**)

- Falta de resposta ou **Resposta parcial**
 - **Aumentar a dose do ISRS** ou **Trocar** por outro **ISRS**.
 - ou
 - **Troca** para **ISRSN** (**venlafaxina**)

e) Associar quetiapina a noite para insônia.

↳ Último passo, caso **ISRS** ou **ISRSN** falhem

- **Quetiapina** = **Antipsicóticos**



OSTEOARTRITE

75) ## (P2: T20) Sobre a Osteoartrite no idoso é correto afirmar:

- a) O uso do colágeno do tipo II tem como indicação na osteoartrite de quadril, com bons resultados a longo prazo, pois modifica a evolução da doença.
- b) A dor não piora com a mudança atmosférica e sendo pior ao repouso.
- c) A cúrcuma longa e a Boswellia serrata são fitoterápicos com ação anti-inflamatória e ação otimizada em 6 semanas, podendo ser tentados para melhora da dor e função em pacientes com osteoartrite de joelho
- d) O uso da bengala deve ser sempre do mesmo lado da articulação acometida com o cotovelo fletido graus.
- e) O uso de AINH no tratamento é mandatório em todos os pacientes.

AVALIAÇÃO GERIÁTRICA AMPLA

Questões:

- 5) ## (P1: T20) 11) Na avaliação geriátrica ampla, temos várias ferramentas para avaliação do idoso de uma maneira correta, melhorando a precisão diagnóstica. Sendo assim, é INCORRETO afirmar:
- a) O teste de cronometrado de levantar e andar avalia a possibilidade de quedas e fragilidade, onde o tempo maior que 20 segundos sugere o risco de quedas e fragilidade
 - b) O MOCA teste tem uma boa probabilidade em pacientes com bons níveis educacionais e é usado em pacientes com suspeito de CCL e demência
 - c) O 10CS é usado para avaliar questões cognitivas em substituição ao mini mental
 - d) O SARC-F é usado o risco de fratura em pacientes idosos
 - e) O questionário de Yesavage avalia possíveis quadros depressivos através de uma lista de perguntas
- 6) ## (P1: T18) 05) Paciente de 81 anos, masculino, professor universitário aposentado, vem ao consultório para tratamento de queixas cognitivas, sem atrapalho nas suas atividades de vida diária. Qual o melhor teste para avaliar cognição neste paciente?
- a) Minimental
 - b) Fluência Verbal
 - c) Moca Teste
 - d) MAN
 - e) Teste com figuras
- 7) ## (P1: T18) 11) Na Avaliação Geriátrica Ampla (AGA) temos várias ferramentas para avaliação do idoso de maneira correta, melhorando a precisão diagnóstica. Sendo assim é verdadeiro afirmar:
- a) A escala de atividades de vida diária (AVDs) tem como prioridade avaliar atividades como lidar com finanças, dirigir, tomar seus remédios e arrumar casa, entre outras.
 - b) O teste cronometrado de levantar e andar avalia a possibilidade de quedas e fragilidade, aonde um tempo maior que 10 segundos é considerado positivo.
 - c) O SARC-F avalia é uma importante ferramenta para diagnóstico de sarcopenia e fragilidade
 - d) O Moca-Teste tem uma boa aplicabilidade em pacientes com grau de educação reduzido é usado em pacientes com suspeita de CCL e demência.
 - e) O Mini-mental tem uma acurácia superior ao 10-CS.

Questões comentadas:

- 8) ## (P1: T20) 11) Na avaliação geriátrica ampla, temos várias ferramentas para avaliação do idoso de uma maneira correta, melhorando a precisão diagnóstica. Sendo assim, é INCORRETO afirmar:
- a) O teste de cronometrado de levantar e andar avalia a possibilidade de quedas e fragilidade, onde o tempo maior que 20 segundos sugere o risco de quedas e fragilidade
- ↳ **Teste Cronometrado de Levantar e Andar (Timed get up and go)**
- Solicita ao paciente que se levante da cadeira sem apoiar os braços, deambule três metros, retornando ao assento
 - **> 20 segundos → FRAGILIDADE**
 - ↳ Demorou mais que 20 segundos é um paciente que tem fragilidade muscular → Maior risco de queda
 - 10 a 20 - RISCO DE FRAGILIDADE
 - ↳ Acima de 10 começar a se preocupar com risco de fragilidade
- b) O MOCA teste tem uma boa probabilidade em pacientes com bons níveis educacionais e é usado em pacientes com suspeito de CCL e demência
- ↳ **Moca Teste – Montreal Cognitive Assesment**
- Não expõe o paciente
 - Usado em pacientes com escolaridade bem alta
 - Teste para pacientes com comprometimento cognitivo leve
 - **O teste de melhor acurácia para o CCL é o MOCA test**
 - Ponto de corte = 26
 - ↳ Acima → Normal
 - ↳ Abaixo → Sugestivo de comprometimento cognitivo leve
- c) O 10CS é usado para avaliar questões cognitivas em substituição ao mini mental
- ↳ **10-CS Point Cognitive Screener**
- O teste mais utilizado, com maior especificidade e menor exposição do paciente
 - O MEEM, o teste de fluência verbal e o teste do relógio **possuem baixa sensibilidade para CCL**
 - MOCA possui a necessidade de ser aplicado para pessoas com boa escolaridade, perdendo sensibilidade em pacientes de baixa escolaridade
 - 10CS pode ser realizado para pacientes com baixa escolaridade ou analfabetos
 - 8 pontos → Normal
 - 6 a 7 → Comprometimento Cognitivo Possível
 - 0 a 5 → Comprometimento Cognitivo Provável
- d) O SARC-F é usado o risco de fratura em pacientes idosos**
- ↳ Errado → SARC-F não avalia o risco de fratura, ele avalia o **risco de sarcopenia e de queda**
- ↳ SARC-F:
- Um questionário mais preciso, que somado à circunferência da panturrilha permite avaliar a sarcopenia, indicada quando avaliado com 11 pts ou mais
- e) O questionário de Yesavage avalia possíveis quadros depressivos através de uma lista de perguntas
- ↳ **Escala de Yesavage**
- Ferramenta mais usada para avaliar depressão é a Escala de Yesavage
 - Score acima de 5 → Suspeita a depressão

9) ## (P1: T18) 05) Paciente de **81 anos**, masculino, **professor universitário** aposentado, vem ao consultório para tratamento de **queixas cognitivas, sem atrapalho nas suas atividades de vida diária**. Qual o melhor teste para avaliar cognição neste paciente?

a) Minimental

↳ **Mini exame do estado mental (MEEM):**

- Avalia de maneira insuficiente a memória episódica e funções executivas
- Baixa acurácia para casos leves
 - **O MEEM, o teste de fluência verbal e o teste do relógio possuem baixa sensibilidade para CCL**
- Possui limitações quanto a escolaridade e cultura
 - Escolaridade inferior acaba sendo limitado → Expõe o paciente, fica constrangido por não saber fazer conta de cabeça, então não tem utilizado
 - Paciente tem demência leve e excelente escolaridade → Pode não conseguir fazer diagnóstico
- Escores sugestivos de demência
 - Menor 18 (Analfabeto)
 - Menor 24 (1 a 4 anos)
 - Menor 26 (8 anos ou mais)

b) Fluência Verbal

↳ **Teste de fluência verbal:**

- O paciente pronuncia uma lista com itens que incluem animais, frutas, vegetais, lista de supermercado ou fonêmica, com palavras iniciadas por uma determinada letra.
- O ponto de corte:
 - 9 palavras para analfabetos
 - 12 palavras em 1 a 7 anos de estudo
 - 13 palavras em mais de 8 anos de estudo
- **O MEEM, o Teste de fluência verbal e o Teste do relógio possuem baixa sensibilidade para CCL**

c) Moca Teste

- ↳ Professor universitário aposentado → Boa escolaridade
- ↳ Queixas cognitivas, sem atrapalho nas suas atividades de vida diária → CCL
- ↳ **Moca Teste – Montreal Cognitive Assessment**
 - Não expõe o paciente
 - Usado em pacientes com **boa escolaridade**
 - Teste para pacientes com comprometimento cognitivo leve
 - **O teste de melhor acurácia para o CCL é o MOCA test**
 - Ponto de corte = 26
 - ↳ Acima → Normal
 - ↳ Abaixo → Sugestivo de comprometimento cognitivo leve

d) MAN

↳ Mini Avaliação Nutricional - MAN

e) Teste com figuras

↳ Teste de memória com figuras (Brief Cognitive Screening Battery):

- 10 figuras são postas para avaliação da percepção visual, nomeação e memória (incidental, imediata e tardia).

10)## (P1: T18) 11) **Na Avaliação Geriátrica Ampla (AGA)** temos várias ferramentas para **avaliação do idoso** de maneira correta, melhorando a precisão diagnóstica. Sendo assim é VERDADEIRO afirmar:

a) A ~~escala de atividades de vida diária (AVDs)~~ tem como prioridade avaliar atividades como lidar com finanças, dirigir, tomar seus remédios e arrumar casa, entre outras.

↳ Finanças, dirigir → **AIVD - Atividades Instrumentais de Vida Diária**

↳ Atividades de Vida Diária (AVD)

- Índice de Katz
- Avalia o desempenho do indivíduo na **execução de tarefas pessoais diárias**
 - Como por exemplo: banhar-se, vestir-se, cuidar da higiene pessoal, transferir-se do leito para uma cadeira, manter continência e alimentar-se

↳ Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD)

- Verifica a **autonomia do indivíduo**, ou seja, sua capacidade para controlar, assumir e tomar decisões no dia a dia
 - Como por exemplo: capacidade de morar sozinho, ir no banco, mexer no fogão

☆ **Demência** → Alteração de **AVD**

☆ **Comprometimento Cognitivo Leve** → **NÃO tem comprometimento de AVD**, mas pode ter comprometimento pequeno de **AIVD**

b) O **teste cronometrado de levantar e andar** avalia a possibilidade de **quedas e fragilidade**, aonde um tempo maior que ~~10 segundos~~ é considerado positivo.

↳ Tempo maior que **20 segundos** é considerado positivo.

↳ **Teste Cronometrado de Levantar e Andar (Timed get up and go)**

- Solicita ao paciente que se levante da cadeira sem apoiar os braços, deambule três metros, retornando ao assento
 - **> 20 segundos** → **FRAGILIDADE**
 - ↳ Demorou mais que 20 segundos é um paciente que tem fragilidade muscular → Maior risco de queda
 - **10 a 20 - RISCO DE FRAGILIDADE**
 - ↳ Acima de 10 começar a se preocupar com risco de fragilidade

c) O SARC-F avalia é uma importante ferramenta para diagnóstico de sarcopenia e fragilidade

↳ SARC-F:

- Avalia o **risco de sarcopenia e de queda**
- Um questionário mais preciso, que somado à circunferência da panturrilha permite avaliar a sarcopenia, indicada quando avaliado com 11 pts ou mais

d) O Moca-Teste tem uma boa aplicabilidade em pacientes com grau de educação ~~reduzido~~ é usado em pacientes com suspeita de CCL e demência.

↳ Moca-Teste tem uma boa aplicabilidade em pacientes com ALTO grau de educação é usado em pacientes com suspeita de CCL e demência

↳ **Moca Teste – Montreal Cognitive Assessment**

- Não expõe o paciente
- Usado em pacientes com **boa escolaridade**
- Teste para pacientes com comprometimento cognitivo leve
 - **O teste de melhor acurácia para o CCL** é o MOCA test
 - Ponto de corte = 26

- └ Acima → Normal
- └ Abaixo → Sugestivo de comprometimento cognitivo leve

e) O Mini-mental tem uma acurácia ~~superior~~ ao 10-CS

↳ **O MEEM, o Teste de fluência verbal e o Teste do relógio possuem baixa sensibilidade para CCL**

- O 10CS é usado para avaliar questões cognitivas em substituição ao mini mental

↳ **10-CS Point Cognitive Screener**

- O teste mais utilizado, com maior especificidade e menor exposição do paciente
 - O MEEM, o teste de fluência verbal e o teste do relógio **possuem baixa sensibilidade para CCL**
 - MOCA possui a necessidade de ser aplicado para pessoas com boa escolaridade, perdendo sensibilidade em pacientes de baixa escolaridade
 - 10CS pode ser realizado para pacientes com baixa escolaridade ou analfabetos
- 8 pontos → Normal
- 6 a 7 → Comprometimento Cognitivo Possível
- 0 a 5 → Comprometimento Cognitivo Provável

DEMÊNCIAS

33) ## (P1: T20) 03) Com relação ao diagnóstico diferencial de déficit cognitivo nas demências, correlacione a primeira e a segunda coluna:

a) Demência cortical = Demência vascular de grandes artérias → **Curso integral**, com **disfunção executiva** (múltiplos infartos, paciente teve AVC)

↳ **Demência vascular cortical**

- Demência vascular que pega **grandes artérias**
 - (Aquele que tem múltiplos infartos ou que pega artéria cerebral média)
- **Progressão em degraus = Curso integral**, com **disfunção executiva**
 - Ex.: O paciente tem um AVC, ele teve uma queda da parte cognitiva, depois fica um tempo na mesma situação. Depois ele tem um outro AVC e piora

b) Demência subcortical = Demência vascular de pequenos vasos → Curso gradual e progressivo, com disfunção executiva, déficit de atenção e alteração da marcha

↳ **Demência vascular subcortical**

- Demência de pequenos vasos (demência subcortical)
- **Progressiva** (não é em degraus) = **Curso gradual e progressivo**, com disfunção executiva, déficit de atenção e alteração da marcha
 - Paciente tem a marcha de “Petit Pas”, tem alterações motoras, então há um comprometimento da parte motoras, **sem lesões hemiplégicas ou em paréticas**

c) Doença de Alzheimer → Curso gradual e progressivo, com memória episódica muito acometida

d) Demência por corpos de lewy → curso gradual e progressivo, com flutuação da consciência

- ↳ Lembra que demência por corpos de lewy tem parkinsonismo, tem a flutuação da consciência, tem as alucinações

DEMÊNCIA VASCULAR

Questões:

- 34) ## (P1: T20) 02) Com relação à demência vascular ocasionada por hipoperfusão, analise as alternativas a seguir e marque um verdadeiro ou falso:
- a) () Na demência vascular por hipoperfusão, há ocorrência de eventos sistêmicos que afetam a hemodinâmica cerebral
 - b) () A insuficiência cardíaca grave é exemplo de hipoperfusão aguda
 - c) () A hipotensão postural crônica é um exemplo de hipoperfusão crônica
 - d) () Apesar da demência vascular por hipoperfusão ocorrida em áreas de penumbra entre regiões irrigadas por grandes artérias, tal condição não afeta a substância branca
- 35) ## (P1: T20) 18) Sobre o score isquêmico de Hachinski, assinale, eu tenho a alternativa correta.
- a) Sua aplicação é recomendada na investigação de demência vascular cortical.
 - b) Deve ser utilizada na tentativa de diferenciar a demência vascular pura de demência mista
 - c) Quanto apresentar pontuação superior a 4 indica maior probabilidade de etiologia neurodegenerativa
 - d) Não deve ser utilizada para estudo e contribuição vascular no quadro demencial
 - e) Pode ser usada para definir o grau de acometimento motor e cognitivo
- 36) ## (P1: T18) 15) Na demência vascular temos uma doença cerebrovascular, tendo como causas quadros hemorrágicos, embólicos e isquêmicos. Sobre essa patologia é incorreto dizer:
- a) A escala isquêmica de hachinski é usada como auxílio ao diagnóstico, sendo um escore maior que 7 positivo para a doença.
 - b) Alguns fatores de risco: sedentarismo, doença coronariana, níveis aumentados de homocisteína e diabetes
 - c) Demência por múltiplos infartos é decorrente de infartos grandes, corticais e subcorticais, de grandes artéria
 - d) A demência vascular por doença de pequenos vasos leva alteração das funções executivas, déficit de memória, com atrapalho nas atividades ocupacionais e distúrbios da marcha.
 - e) A doença de Binswanger não apresenta sintomas comportamentais e de marcha, relacionada com a hipertensão arterial.

Questões comentadas:

37) ## (P1: T20) 02) Com relação à demência vascular ocasionada por **hipoperfusão**, analise as alternativas a seguir e marque um verdadeiro ou falso:

- a) (V) Na demência vascular por **hipoperfusão**, há ocorrência de **eventos sistêmicos** que afetam a **hemodinâmica cerebral**
- ↳ ↓ PA → Hipoperfusão cerebral → ↓ Oxigenação cerebral → Demência vascular
 - Por isso pressão baixa em idoso é ruim, pode fazer pequenas isquemias, e aí paciente começa a ter problemas cognitivos
- b) (F) A insuficiência cardíaca grave é exemplo de hipoperfusão ~~aguda~~
- ↳ Insuficiência cardíaca grave → Hipoperfusão CRÔNICA
 - Paciente não tem uma insuficiência cardíaca inicial, já tem de longa data. Se é grave, já vem de há muito tempo
 - ↳ **Hipoperfusão**
 - **Aguda** → Tem-se a **Encefalopatia Anóxica** pós-parada cardiorrespiratória
 - **Crônica** → Casos de relacionados a **Insuficiência Cardíaca Grave** e **Hipotensão postural crônica**
- c) (V) A hipotensão postural crônica é um exemplo de hipoperfusão crônica
- ↳ **Hipoperfusão**
 - **Aguda** → **Encefalopatia Anóxica** pós-parada cardiorrespiratória
 - **Crônica** → **Insuficiência Cardíaca Grave** e **Hipotensão postural crônica**
- d) (F) Apesar da demência vascular por hipoperfusão ocorrida em áreas de penumbra entre regiões irrigadas por grandes artérias, tal condição não afeta a substância branca
- ↳ Afeta, porque quando o paciente tem uma **hipoperfusão cerebral**, ou com uma **parada cardiorrespiratória**, uma hipotensão importante, ou várias hipotensões, ou baixa oxigenação, isso **vai causar lesões em substância branca**.
 - Isso vai levar tipo uma **demência subcortical** também
 - Demência subcortical: Com o comprometimento de pequenas artérias após infartos lacunares

38) ## (P1: T20) 18) Sobre o score isquêmico de Hachinski, assinale, eu tenho a alternativa correta.

a) Sua aplicação é recomendada na investigação de demência vascular cortical.

- ↳ A escala de Hachinski é usada para diferenciar **Demência de múltiplos infartos** ou **Demência vascular cortical** de **Doença de Alzheimer**
 - ↳ Sua aplicação é recomendada na investigação de demência vascular cortical, porque conforme a pontuação ela vai determinar: Demência de múltiplos infartos ou Doença de Alzheimer
 - ↳ **Escore de Hachinski:**
 - ↳ Permite diferenciar **Doença de Alzheimer** e **Demência vascular de multi-infartos**.
 - Pontuação **maior que 7** indica maior probabilidade de etiologia **vascular**.
 - Pontuação **menor que 4** aponta para maior probabilidade de etiologia **neurodegenerativa**.
- b) Deve ser utilizada na tentativa de diferenciar a demência vascular pura de demência mista
- ↳ Não é utilizada para isso
- c) Quanto apresentar pontuação superior a 4 indica maior probabilidade de etiologia neurodegenerativa
- ↳ Quanto menor a pontuação, maior a chance de ser uma doença de Alzheimer.
 - **Menor que 4** aponta para maior probabilidade de etiologia **neurodegenerativa**
 - ↳ Quanto maior a pontuação, maior o risco de ter demência vascular
 - **Maior que 7** indica maior probabilidade de etiologia **vascular**

- d) Não deve ser utilizada para estudo e contribuição vascular no quadro demencial
- e) Pode ser usada para definir o grau de acometimento motor e cognitivo
 - ↳ Finalidade dela não é ver se o paciente tem lesões motoras

39)## (P1: T18) 15) Na demência vascular temos uma doença cerebrovascular, tendo como causas quadros **hemorrágicos, embólicos e isquêmicos**. Sobre essa patologia é INCORRETO dizer:

- a) A **escala isquêmica de Hachinski** é usada como auxílio ao diagnóstico, sendo um **escore maior que 7 positivo para a doença**.
 - ↳ Quanto menor a pontuação, maior a chance de ser uma doença de Alzheimer.
 - **Menor que 4** aponta para maior probabilidade de etiologia **neurodegenerativa**
 - ↳ Quanto maior a pontuação, maior o risco de ter demência vascular
 - **Maior que 7** indica maior probabilidade de etiologia **vascular**
- b) Alguns **fatores de risco**: sedentarismo, doença coronariana, níveis aumentados de homocisteína e diabetes
 - ↳ Geralmente pacientes com DV, tem comprometimento cardiovascular também, pois são os mesmos fatores de risco
- c) Demência por múltiplos infartos é decorrente de infartos grandes, corticais e subcorticais, de grandes artérias
- d) A demência vascular por doença de pequenos vasos leva alteração das funções executivas, déficit de memória, com atrapalho nas atividades ocupacionais e distúrbios da marcha.
 - ↳ **Demência Vascular Subcortical**
 - Doença de **Pequenos Vasos (DPV)**
 - Comprometimento de pequenas artérias após infartos lacunares
 - Na DPV há infartos isquêmicos, lacunares ou microinfartos e pequenas hemorragias, localizadas principalmente na substância branca, na substância cinzenta cortical e no tronco encefálico
 - Clínica:
 - Início insidioso
 - Lentificação motora
 - Prejuízo da memória em **caráter progressivo (não é em degraus é progressiva)**
 - Alterações fala e comportamento.
 - Há ainda parkinsonismo, ataxia e incontinência urinária, aumento do risco de quedas e prejuízo na atenção e funções executivas
 - **Não terá pacientes com hemiplegia**
 - Geralmente ocorre em Hipertensos, DM
 - ↳ **Demência Vascular Cortical ou Demência pós-AVC**
 - Doença de **Grandes Vasos (DGV)**
 - Quando paciente tem AVC propriamente dito
 - Comprometimento cognitivo próximo a lesão focal, tendo também lesão motora (hemiparético e hemiplégico)
 - **Progressão em degraus**
 - Afetado por disfagia, disartria, afasia e choro patológico. Sofre com flutuações cognitivas e confusão noturna, tendo momentos de melhora e de piora, podendo se tornar ainda mais agitados que doentes de Alzheimer
 - As alterações esfinterianas e de marcha por vezes precedem as cognitivas

e) A doença de Binswanger não apresenta sintomas comportamentais e de marcha, relacionada com a hipertensão arterial.

↳ **Doença de Binswanger**

- Marcada por infartos lacunares na substância branca.
- Mais de 95% são hipertensos.
 - Casos graves de HAS → Geralmente associada a quadros de Hipertensão de difícil controle
- Comprometimento das artérias medulares longas.
- Incontinência urinária, distúrbios da marcha e rigidez de membro

DISTÚRBIOS DO SONO

Questões:

- 84)## (P1: T20) 10) Paciente de 69 anos, sexo feminino, sobrepeso, está em tratamento por depressão, com melhora do quadro melancólico com sertralina. Entretanto, vem tendo insônia, com o sono entrecortado nas últimas semanas, com cochilos frequentes durante o dia. Qual seria a medicação de escolha para esse paciente?
- a) R: Trazodona
- 85)## (P1: T18) 09) Paciente de 70 anos, sexo feminino, sobrepeso, está em tratamento por Transtorno Depressivo, com melhora do quadro melancólico com escitalopram. Entretanto, vem tendo insônia, com sono entrecortado nas últimas semanas, com cochilos frequentes durante o dia. Qual seria a medicação de primeira escolha para esse paciente?
- a) Zelpiclona
b) Diazepam
c) Amitriptilina
d) Trazodona
e) Lorazepam
- 86)## (P1: T20) 13) Quanto à medicação considerada a primeira opção no tratamento de pacientes com os sintomas de síndrome das pernas inquietas e exames assim repetidos para a investigação, assinale é a alternativa correta.
- a) R: Pramipexole, pode pedir ferro, ferritina e creatinina.
 ↳ Lembrar que a anemia ferropriva e a insuficiência renal podem piorar ou podem desencadear a síndrome das pernas inquietas
- 87)## (P1: T18) 03) Analise as afirmativas sobre a Síndrome das Pernas Inquietas no idoso:
- I. As drogas de primeira escolha na SPI são os anticonvulsivantes, sendo que um quadro de anemia ferropriva pode piorar o quadro.
- II. Os pacientes com SPI tem necessidade de movimentar as pernas, com sensação desconfortável que geralmente piora nos períodos de repouso ou no período noturno e que não melhora com a movimentação dos membros.
- III. Insuficiência renal crônica, uso de inibidores da recaptação da serotonina, doença de Parkinson e síndromes demenciais são condições clínicas associadas a SPI.
- IV. Qual (is) está (ão) correta (s)
- a) Apenas a I
b) Apenas a II
c) Apenas a II e a III
d) Apenas I e II
e) Todas corretas

Questões comentadas:

88)## (P1: T20) 10) Paciente de 69 anos, sexo **feminino**, **sobrepeso**, está em tratamento por **depressão**, com **melhora** do quadro melancólico com **sertralina**. Entretanto, vem tendo **insônia**, com o **sono entrecortado** nas últimas semanas, com **cochilos frequentes durante o dia**. Qual seria a medicação de escolha para esse paciente?

a) R: Trazodona

↳ **Trazodona**

- Trazodona para controle dos sintomas comportamentais, como agitação, desinibição, comportamentos preservativos e **insônia**
- **Primeira indicação para dormir** para o Idoso é a TRAZODONA
 - Em últimos casos Zolpidem, antes tentar antidepressivos
- Quadro de demência, agitado, confuso, inquieto → tentar medidas não farmacológicas, não é agitação tão grave, tenta medidas não farmacológicas, ou uma Trazodona

89)## (P1: T18) 09) Paciente de 70 anos, sexo feminino, **sobrepeso**, está em tratamento por **Transtorno Depressivo**, com melhora do quadro melancólico com **escitalopram**. Entretanto, vem tendo **insônia**, com sono entrecortado nas últimas semanas, com cochilos frequentes durante o dia. Qual seria a medicação de **primeira escolha** para esse paciente?

a) Zelpiclona

b) Diazepam

c) Amitriptilina

d) Trazodona

↳ **Primeira opção** é a Trazodona

↳ **Insônia – Tratamento**

- **Não farmacológico**
 - Evitar o álcool, nicotina, cafeína.
 - Rotina para dormir.
 - Reduzir o tempo na cama.
 - Atividade física 6 horas antes de adormecer.
 - Evitar cochilos ao entardecer ou início da noite.
 - Limitar a ingestão de líquidos a noite.
 - Utilizar o quarto e cama somente para dormir.
- **Farmacológico**
 - Iniciar com doses pequenas e manter menor dose possível.
 - Evitar uso de hipnóticos.
 - ↳ Cuidado em pacientes com apnéia do sono e insônia de rebote ao suspender o hipnótico
 - Abordagem:
 - ↳ **Melatonina** é a **opção de escolha** para **casos iniciais e leves**.
 - ↳ **Primeira opção** é a Trazodona
 - Partindo para **Mirtazapina** ou **Agomelatina** em casos de **depressão associada** a insônia
 - **Por último** utilizando **Zolpidem** ou **Zopiclona**.
 - ↳ **Antipsicóticos** (**Quetiapina** e **Olanzapina**) são utilizados **exclusivamente** na insônia de pacientes com **delírios** e **alucinações**

e) Lorazepam

90) ## (P1: T20) 13) Quanto à **medicação** considerada a **primeira opção** no tratamento de pacientes com os sintomas de **síndrome das pernas inquietas** e exames assim repetidos para a investigação, assinala a alternativa correta.

a) R: **Pramipexole**, pode pedir ferro, ferritina e creatinina.

- ↳ Lembrar que a **anemia ferropriva** e a **insuficiência renal** podem **piorar** ou **podem desencadear** a **síndrome das pernas inquietas**
- ↳ **Parassonias com Síndrome das Pernas Inquietas**
 - Ocorrendo **intenso desconforto nas pernas** ao **sentar-se** ou se **deitar**, de maneira **incapacitante**, que se **assemelha a formigamento**.
 - A inquietação **MELHORA** com movimentação das pernas ou deambulação.
 - **Trazodona** **piora** a síndrome das pernas inquietas
 - Associado a mioclonias em 70-80% dos casos.
 - Possui padrão genético familiar ou pode ser secundária: a **anemia**, **IR**, DM, uremia, insuficiência vascular periférica, neuropatias, fibromialgia, DPOC, Parkinson ou medicações (ISRS).
 - Exames:
 - Hemograma, **ferro**, **ferritina**, ácido fólico, ENMG e polissonografia.
 - Tratamento:
 - Evitar álcool e cafeína
 - Repor ferro
 - Framcos:
 - ↳ **Pramipexole**
 - **Primeira opção**
 - Agonista dopaminérgico (também utilizado no Parkinson)
 - ↳ Clonazepam
 - ↳ Levodopa
 - ↳ Rotigotina e patch

91) ## (P1: T18) 03) Analise as afirmativas sobre a Síndrome das Pernas Inquietas no idoso:

I. (??) As **drogas de primeira escolha** na SPI são os **anticonvulsivantes**, sendo que um quadro de **anemia ferropriva** **pode piorar o quadro**.

↳ **Pramipexol**

- **Primeira opção**
- **Agonista dopaminérgico** (também utilizado no Parkinson)
 - É Anticonvulsivantes ????? (Anticonvulsivantes = Carbamazepina, Topiramato, Lamotrigina)

II. (F) Os pacientes com SPI tem **necessidade de movimentar as pernas**, com sensação desconfortável que geralmente **piora nos períodos de repouso** ou no **período noturno** e que **não melhora com a movimentação dos membros**.

↳ Ocorrendo **intenso desconforto nas pernas** ao **sentar-se** ou se **deitar**, de maneira **incapacitante**, que se **assemelha a formigamento**.

- A inquietação **MELHORA** com movimentação das pernas ou deambulação.
- **Trazodona** **piora** a síndrome das pernas inquietas

III. (V) Insuficiência renal crônica, uso de inibidores da recaptação da serotonina, doença de Parkinson e síndromes demenciais são **condições clínicas associadas a SPI**.

↳ Possui padrão genético familiar ou pode ser secundária: a **anemia**, **IR**, DM, uremia, insuficiência vascular periférica, neuropatias, fibromialgia, DPOC, **Parkinson** ou **medicações** (ISRS).

Qual (is) está (ão) correta (s)

- a) Apenas a I
- b) Apenas a II
- c) Apenas a II e a III
- d) Apenas I e II
- e) Todas corretas

USO SEGURO DE MEDICAMENTOS EM IDOSOS

Questões:

- 11)## (P1: T20) Idosa de 76 anos vem ao consultório médico com obstipação crônica e delirium há 7 dias. Tem tremor em mão direita há 6 meses que vem aumentando, associado à bradicinesia. Tem quadro depressivo com uso de Escitalopram, e recentemente prescrição de Nortriptilina 14 dias. Paciente tem diabetes com excelente controle, hipertensão arterial e labirintopatia. Medicamentos: Metformina, Enalapril, Metoclopramida esporadicamente, Cinarizina e Nortriptilina. Ao exame físico tinha tremor em mão direita, roda denteadada positiva, fácies de máscara. Exames laboratoriais normais. Descartada a causa orgânica diante da anamnese definida, quais os medicamentos poderiam levar a esses sinais e sintomas iatrogênicos
- a) Cinarizina está levando a um quadro de parkinsonismo. Metoclopramida pode pior ou levar ao parkinsonismo. Nortriptilina está causando a obstipação crônica como o tremor
- 12)## (P1: T20) 19) A desprescrição é uma ferramenta utilizada para evitar a polifarmácia, reduzindo doses de medicamentos e até interrompendo o consumo de medicamentos, onde o potencial de dano é superior aos seus benefícios. Sendo assim, é incorreto afirmar:
- a) Os aminoglicosídeos são uma classe segura de antibióticos em idosos
 - b) Anticolinérgicos, benzodiazepínicos e anti-inflamatórios não devem ser evitados em pacientes idosos
 - c) O uso indevido por tempo prolongado de anti-inflamatório pode levar a insuficiência renal e a descompensação de ICC
 - d) Retirar medicamentos prescritos por atendentes de farmácia, vizinhos e familiares
 - e) A Amiodarona pode levar a alterações da tireoide, como hipotireoidismo
- 13)## (P1: T18) 02) A palavra iatrogenia, derivada do grego iatrikós, relativo ao médico e a medicina, refere-se a to... malefício provocado ao paciente, decorrente do seu tratamento, seja ele medicamentos ou no âmbito relações humanas. Sobre isso, assinale a alternativa errada:
- a) Um dos efeitos adversos mais comuns são os distúrbios da cognição, geralmente causados tricíclicos, benzodiazepínicos e anticolinérgicos.
 - b) Os inibidores de bomba de prótons podem diminuir ainda a mais acidez gástrica e causar prejuízo na absorção de medicamentos como o ferro, carbonato de cálcio e digoxina.
 - c) As alterações a nível de barorreceptor no idoso, somado ao uso de vasodilatadores e antihipertensivos, a quadro de hipotensão ortostática e síncope
 - d) Medicamentos com características ácidas como a fenitoína se ligam fortemente a albumina, sendo assim, seus efeitos são potencializados no caso de uma depleção de albumina
 - e) O aumento de massa gorda com o envelhecimento leva diminuição da meia vida de fármacos como a morfina e amiodarona.
- 14)## (P1: T18) 06) Idosa de 72 anos vem ao consultório médico referindo inapetência há 40 dias. Diz que perdeu 5 kg n período. Relata associado náuseas e diarreia intermitente. Tem tremor em mão direita há 6 meses, que vem aumentando, associado a bradicinesia. Nega sintomas depressivos ou qualquer outro sintoma associado. Paciente tem diabetes mellitus com excelente controle, hipertensão arterial e labirintopatia. Usa como medicamentos: metformina, enalapril, metoclopramida, cinarizina, AAS infantil. Exame Físico: tremor parkinsoniano em mão direita, roda denteadada positiva, fácies de máscara. Exames laboratoriais normais.

Descartado causa orgânica, e diante da anamnese referida, quais medicamentos poderiam levar a esses sintomas iatrogênicos?

- a) Metformina, Enalapril e Metoclopramida
- b) Metformina e Cinarizina
- c) Enalapril, AAS e Metformina.
- d) Cinarizina, Metoclopramida e Metformina
- e) AAS, Enalapril

15) ## (P1: T20) 10) Paciente de 69 anos, sexo feminino, sobrepeso, está em tratamento por depressão, com melhora do quadro melancólico com sertralina. Entretanto, vem tendo insônia, com o sono entrecortado nas últimas semanas, com cochilos frequentes durante o dia. Qual seria a medicação de escolha para esse paciente?

- a) R:Trasodon.

16) ## (P1: T18) 09) Paciente de 70 anos, sexo feminino, sobrepeso, está em tratamento por Transtorno Depressivo, com melhora do quadro melancólico com escitalopram. Entretanto, vem tendo insônia, com sono entrecortado nas últimas semanas, com cochilos frequentes durante o dia. Qual seria a medicação de primeira escolha para esse paciente?

- a) Zelpiclona
- b) Diazepam
- c) Amitriptilina
- d) Trazodona
- e) Lorazepam

17) ## (P1: T18) 07) A desprescrição é uma ferramenta usada para evitar a polifarmácia, reduzindo dose de medicamentos e até interrompendo o consumo de medicamentos, aonde o potencial de dano é superior aos seus benefícios. Sendo assim é incorreto afirmar:

- a) Tomar cuidados adicionais em idosos acima de 80 anos, frágeis e com várias comorbidades.
- b) Medicamentos como anticolinérgicos, benzodiazepínicos e antiinflamatórios devem ser evitados em pacientes idosos.
- c) uso indevido e por tempo prolongado de AINH podem levar a insuficiência renal descompensação de ICC
- d) Retirar medicamentos prescritos por balconistas de farmácia, vizinhos ou familiares.
- e) A amiodarona tem como eventos adversos as alterações gastrointestinais

Questões comentadas:

18)## (P1: T20) 05) Idosa de 76 anos, vem ao consultório médico, com **obstipação crônica** e **delírio** há sete dias. Tem **tremor na mão direita** há seis meses que vem aumentando associado à **bradicinesia**. [Sugere-se aqui um quadro de **parkinsonismo, bradicinesia e tremor**]. Tem quadro **depressivo** com uso de **citalopram** e, recentemente, prescrição de **nortriptilina** a 14 dias. O paciente tem **diabetes**, com excelente controle, **hipertensão** e **labirintopatia**. Medicamentos: usa metformina, enalapril, metoclopramida, esporadicamente, cinarizina e nortriptilina. O exame físico tinha um tremor na mão direita, **roda dentada positiva**, faces de **máscara**. Exames laboratoriais normais. **Descartada a causa orgânica** e diante da anamnese referida, quais os medicamentos podiam levar esses sinais e sintomas iatrogênicos?

a) R: Cinarizina, Metoclopramida e Nortriptilina

↳ Sinais e sintomas iatrogênicos

- **Parkinsonismo**

- Perda de neurônios dopaminérgicos, facilita a sensibilidade a medicamentos que causam parkinsonismo → **Cinarizina, Metoclopramida e Neurolépticos**
- Por isso que uso de antipsicóticos nos idosos (**Haloperidol**, Aripiprazol, **Quetiapina**, Respiridona, Levopromazina, Clorpromazina) podem causar Parkinsonismo, principalmente se usar por longa data.
 - ↳ Nos mais antigos como **Haloperidol**, ainda mais
- Quadro de demência, agitado, confuso, inquieto → Tentar medidas não farmacológicas, não é agitação tão grave, tenta medidas não farmacológicas, ou uma **Trazodona**
- **Parkinsonismo Secundário Medicamentos:**
 - ↳ Cinarizina, Flunarizina, Haloperidol, Lítio, Fluoxetina, Metildopa, Clorpromazina, Levomepromazina e Metoclopramida

- Delirium

↳ **Cinarizina**

- Leva um quadro de **Parkinsonismo**

↳ **Metoclopramida**

- Leva a um quadro de **Parkinsonismo, Delirium e Efeitos Extrapiramidais**
 - Lembrar que a metoclopramida é a piora quadro de parkinsonismo ou pode levar, mesmo ela usando esporadicamente (ela tinha quadros de parkinsonismo)

↳ **Nortriptilina**

- **Tricíclicos** causam: **Obstipação crônica, Delirium, Sedação, Hipotensão ortostática** e retardam o **Esvaziamento gástrico**
 - Lembrar que os **tricíclicos têm contraindicação em pacientes idosos**
 - ↳ Dos Tricíclicos, a Nortriptilina é a que tem mais perfil um pouquinho melhor de segurança, entretanto tem casos que os pacientes envolvem **confusão mental**.

19)## (P1: T18) 06) Idosa de 72 anos vem ao consultório médico referindo **inapetência** há 40 dias. Diz que perdeu 5 kg no período. Relata associado **náuseas** e **diarreia intermitente**. Tem **tremor em mão direita** há 6 meses, que vem aumentando, associado a **bradicinesia**. Nega sintomas depressivos ou qualquer outro sintoma associado. Paciente tem **diabetes mellitus** com excelente controle, **hipertensão arterial** e **labirintopatia**. Usa como medicamentos: *metformina, enalapril, metoclopramida, cinarizina, AAS infantil*. Exame Físico: **tremor parkinsoniano em mão direita, roda denteada positiva**, fâcies de máscara. Exames laboratoriais normais.

Descartado causa orgânica, e diante da anamnese referida, quais medicamentos poderiam levar a esses **sintomas iatrogênicos**?

- a) Metformina, Enalapril e Metoclopramida
 - ↳ Metformina → Pioram função renal, dor, diarreia
 - ↳ Metoclopramida → Parkinsonismo
- b) Metformina e Cinarizina
 - ↳ Metformina → Pioram função renal, dor, diarreia
 - ↳ Cinarizina → Parkinsonismo
- c) Enalapril, AAS e Metformina.

d) Cinarizina, Metoclopramida e Metformina

- ↳ **Cinarizina**
 - Leva um quadro de **Parkinsonismo**
 - ↳ **Metoclopramida**
 - Leva a um quadro de **Parkinsonismo, Delirium e Efeitos Extrapiramidais**
 - Lembrar que a metoclopramida é a piora quadro de parkinsonismo ou pode levar, mesmo ela usando esporadicamente (ela tinha quadros de parkinsonismo)
 - ↳ **Metformina**
 - Pioram função renal, dor, diarreia
 - ↳ **Nortriptilina**
 - **Tricíclicos** causam: **Obstipação crônica, Delirium, Sedação, Hipotensão ortostática** e retardam o **Esvaziamento gástrico**
 - Lembrar que os **tricíclicos têm contraindicação em pacientes idosos**
- e) AAS, Enalapril

20)## (P1: T20) 10) Paciente de 69 anos, sexo **feminino, sobrepeso**, está em tratamento por **depressão**, com **melhora** do quadro melancólico com **sertralina**. Entretanto, vem tendo **insônia**, com o **sono entrecortado** nas últimas semanas, com cochilos frequentes durante o dia. Qual seria a medicação de escolha para esse paciente?

- a) R: Trazodona
 - ↳ **Trazodona**
 - Trazodona para controle dos sintomas comportamentais, como agitação, desinibição, comportamentos preservativos e **insônia**
 - **Primeira indicação para dormir** para o Idoso é a TRAZODONA
 - Em últimos casos Zolpidem, antes tentar antidepressivos
 - Quadro de demência, agitado, confuso, inquieto → tentar medidas não farmacológicas, não é agitação tão grave, tenta medidas não farmacológicas, ou uma Trazodona

21)## (P1: T18) 09) Paciente de 70 anos, sexo feminino, **sobrepeso**, está em tratamento por **Transtorno Depressivo**, com melhora do quadro melancólico com **escitalopram**. Entretanto, vem tendo **insônia**, com sono entrecortado nas últimas semanas, com cochilos frequentes durante o dia. Qual seria a medicação de primeira escolha para esse paciente?

- a) Zelpiclona
- b) Diazepam
- c) Amitriptilina
- d) Trazodona**
- e) Lorazepam

22) ## (P1: T20) 19) A **desprescrição** é uma ferramenta usada para **evitar a polifarmácia**, reduzindo a dose de medicamentos e até interrompendo o consumo de medicamentos, aonde o potencial de dano é superior aos seus benefícios. Sendo assim, é INCORRETO afirmar:

a) Os aminoglicosídeos é uma classe segura de antibiótico imunológico

↳ **Aminoglicosídeos**

- **São nefrotóxicos**

- Gentamicina, Amicacina → Evita o em paciente idoso (pneumonia)

↳ Medicamentos pioram a função renal → AINEs, metformina, digoxina, sulfonilureias e aminoglicosídeos

b) Anticolinérgico, benzodiazepínico e o anti-inflamatório NÃO devem ser evitados em paciente idoso

↳ **NÃO** devem ser evitados ??? → Devem sim

↳ **Critério de Beers** → Lista de medicamentos contra-indicados para idosos

- **BDZ**

- Pioram a capacidade cognitiva (Distúrbio cognitivo)
- Confusão mental
- Queda, sonolência, fraqueza muscular e delírio
- Para paciente que já toma BDZ → Tenta RETIRAR
 - ↳ O menos prejudicial seria o Clonazepam por não passar por oxidação hepática

- **Anticolinérgico**

- Distúrbio cognitivo
- Interferem no esvaziamento gástrico,

- **AINES**

- Insuficiência renal aguda

c) O uso indevido, por tempo prolongado do **anti-inflamatório**, pode levar à **insuficiência renal** e à **descompensação excessiva**.

d) Retirar medicamentos prescritos por atendentes de farmácia e vizinhos ou familiares

e) A **amiodarona** pode levar a **alterações** da **tireoide** com **hipotireoidismo**.

↳ **Amiodarona**

- Medicamentos antiarrítmicos
- Tem efeito endocrinológico → **Iodo** na composição → **Hipo/Hipertireoidismo**, Fibrose pulmonar, neuropatia periférica.

23) ## (P1: T18) 07) A **desprescrição** é uma ferramenta usada para evitar a polifarmácia, reduzindo dose de medicamentos e até interrompendo o consumo de medicamentos, aonde o potencial de dano é superior aos seus benefícios. Sendo assim é INCORRETO afirmar:

a) Tomar cuidados adicionais em idosos acima de 80 anos, frágeis e com várias comorbidades.

b) Medicamentos como anticolinérgicos, benzodiazepínicos e anti-inflamatórios devem ser evitados em pacientes idosos.

c) O uso indevido e por tempo prolongado de AINH podem levar a insuficiência renal e descompensação de ICC

d) Retirar medicamentos prescritos por balconistas de farmácia, vizinhos ou familiares.

e) A amiodarona tem como eventos adversos as alterações gastrointestinais

Questão sem gabarito no arquivo, não achei a resposta

24)## (P1: T18) 02) A palavra iatrogenia, derivada do grego iatrikós, relativo ao médico e a medicina, refere-se a to... malefício provocado ao paciente, decorrente do seu tratamento, seja ele medicamentos ou no âmbito relações humanas. Sobre isso, assinale a alternativa ERRADA:

a) Um dos efeitos adversos mais comuns são os **distúrbios da cognição**, geralmente causados **tricíclicos, benzodiazepínicos e anticolinérgicos**.

↪ **Distúrbios da cognição** → **Tricíclicos, Benzodiazepínicos e Anticolinérgicos**

b) Os **inibidores de bomba de prótons** podem **diminuir ainda a mais acidez gástrica** e causar **prejuízo na absorção de medicamentos** como o **ferro, carbonato de cálcio e digoxina**.

↪ **Inibidor de bomba sem indicação**

- Vai diminuir a absorção de medicamentos que necessitam de meio ácido, como salicilatos, ferro, cálcio, vitamina B12

- Critério de Beers

c) As **alterações a nível de barorreceptor no idoso**, somado ao uso de **vasodilatadores e antihipertensivos**, a quadro de **hipotensão ortostática e síncope**

↪ **Hipotensão Ortostática** → Anti-hipertensivo + Vasodilatador + Diurético + Tadanafila → Faz hipotensão

d) Medicamentos com características ácidas como a **fenitoína** se ligam fortemente a albumina, sendo assim, seus **efeitos são potencializados** no caso de uma **depleção de albumina**

↪ **Albumina**

- No idoso em sua síntese reduzida em 15 a 20%, além do aumento do metabolismo
- **Hipoalbuminemia** → **Potencializa a ação de certos medicamentos**, causando **toxemia**, como é o caso da Varfarina, Fenitoína, Furosemida, Salicilatos, Digoxina, Levotiroxina e Sulfonilureias

e) O aumento de massa gorda com o envelhecimento leva diminuição da meia vida de fármacos como a morfina e amiodarona.

↪ **Senescência** → **Aumento de massa gorda** e diminuição de massa magra com o envelhecimento.

- **AUMENTO** da meia vida de fármacos lipofílicos → Drogas lipofílicas ficam mais tempo no organismo
- **Maior chance de intoxicação** por drogas lipofílicas, como a Digoxina, Clonazepam, Bromazepam e Diazepam

DELIRIUM

Questões:

- 29)## (P1: T20) 01) Três dias, o Sr. José vem apresentando alterações de comportamento, não falando coisa com coisa, agitação psicomotora, passou a dormir mais durante o dia, ficar acordado à noite e com alucinações visuais. Após avaliar o Sr. José e colher sua história clínica, solicitar os exames complementares, o médico poderia propor a seguinte conduta:
- a) Internar o paciente por seu quadro clínico sugere fortemente um quadro de acidente vascular encefálico inicial devido ao tratamento.
 - b) Tranquilizar a família com os achados clínicos de Sr. José são muito comuns na sua idade, medicá-lo com antipsicótico e encaminhá-lo para um ambulatório de geriatria.
 - c) Tranquilizar a família, ressaltando que o Sr. José apresenta um quadro que sugere patologia de delírio, e que essa patologia tem causas multifatoriais, que seria necessário aguardar o resultado dos exames solicitados para definir conduta
 - d) Internar o paciente, porque o seu quadro sugere fortemente um quadro de demência de Alzheimer
 - e) Fazer haloperidol endovenoso e encaminhar o paciente para o tratamento ambulatorial. Pois o paciente tem um quadro inicial de síndrome demencial, consequentemente na Hidrologia ou Geriatria
- 30)## (P1: T18) 01) Paciente José 88 anos, chega ao pronto socorro acompanhado de seus familiares, é prontamente atendido pelo médico plantonista. A queixa principal da família é que nos últimos 3 dias o senhor José vem apresentando alterações de comportamento, não falando coisa com coisa, está com lentidão, passou a dormir mais durante o dia, ficar acordado à noite e com alucinações visuais. Após avaliar o senhor José, colher sua história clínica, solicitar os exames complementares o médico plantonista poderia propor o seguinte tratamento:
- a) Internar o paciente, pois o seu quadro clínico sugere fortemente um quadro de acidente vascular encefálico e iniciar o devido tratamento.
 - b) Tranquilizar a família, pois os achados clínicos do seu José são muito comuns na sua idade, medicá-lo com um antipsicótico e encaminhá-lo para o ambulatório de geriatria.
 - c) Tranquilizar a família, ressaltando que o senhor José apresenta um quadro clínico que sugere a patologia delirium, que essa patologia tem causas multifatoriais, que seria necessário aguardar o resultado dos exames solicitados para definir conduta.
 - d) Internar o paciente, pois o seu quadro sugere fortemente um quadro de demência de Alzheimer na fase inicial, e solicitaria uma avaliação no dia seguinte do neurologista para orientar o devido tratamento.
 - e) Internar o paciente, pois o paciente tem um quadro psicótico, fazendo como medicação de escolha Haloperidol.

Questões comentadas:

31)## (P1: T20) 01) Três dias, o Sr. José vem apresentando **alterações de comportamento**, não falando coisa com coisa, **agitação psicomotora**, passou a **dormir mais durante o dia**, ficar **acordado à noite** e com **alucinações visuais**. Após avaliar o Sr. José e colher sua história clínica, solicitar os exames complementares, o médico poderia propor a seguinte conduta:

a) Internar o paciente por seu quadro clínico sugere fortemente um quadro de acidente vascular encefálico inicial devido ao tratamento.

↳ Não dá para saber se é AVC, o quadro é de delírio. Poderia ser um AVC causando o delírio, mas não pode afirmar com certeza que é um AVC

b) Tranquilizar a família com os achados clínicos de Sr. José são muito comuns na sua idade, medicá-lo com antipsicótico e encaminhá-lo para um ambulatório de geriatria.

↳ Quadro confusional → Não faz parte do envelhecimento normal (não é comum na idade).

c) Tranquilizar a família, ressaltando que o Sr. José apresenta um quadro que sugere patologia de delírio, e que essa patologia tem causas multifatoriais, que seria necessário aguardar o resultado dos exames solicitados para definir conduta

↳ É um quadro de delírio, certo é realmente **internar** esse paciente para ver a causa desse delírio. Se é causa infecciosa, metabólica, acidente vascular encefálico ou uso de alguma medicação

d) Internar o paciente, porque o seu quadro sugere fortemente um quadro de demência de Alzheimer

↳ É um quadro de poucos dias, DA é um quadro de meses

↳ **Delirium**

- Confusão mental **AGUDA** ou Insuficiência cerebral **AGUDA**, com déficit cognitivo **transitório** de início agudo, caracterizado por **desorientação, distúrbios de atenção, julgamento, percepção e alterações de comportamento** e do ciclo sono-vigília

- **Delirium** é Confusão mental **AGUDA** diferente da **DEMÊNCIA** que é **CRÔNICA**

e) Fazer haloperidol endovenoso e encaminhar o paciente para o tratamento ambulatorial. Pois o paciente tem um quadro inicial de síndrome demencial, seguimento na Neurologia ou Geriatria

↳ Não vai fazer só a medicação endovenosa nesse paciente, você vai fazer a medicação para controlar a agitação psicomotora, o quadro confusional e investigar

↳ Não mandar para casa, porque o paciente pode, por exemplo, estar infartando e ter um quadro confusional agudo

↳ Não é uma síndrome demencial = **Delirium** → **AGUDA** | **Demência** → **CRÔNICA**

↳ **Tratamento para Delirium**

- **Haloperidol**

- O tratamento de **escolha** no delirium agudo

↳ É para **tirar a crise** → Quadro agudo que coloca em risco paciente e familiar

- Menores efeitos sobre o intervalo QT

- Efeitos colaterais → Sedação, parkinsonismo, hipotensão, retenção urinária e distonia aguda (discinesia)

- **Não recomendamos uso contínuo** pelo **efeito parkinsoniano** e **piora cognitiva**

↳ **Uso contínuo** preferencialmente os outros como Quetiapina

- **Quetiapina**

- Efeito sedativo e sobre o ciclo sono-vigília.

- Somente oral

- Prolongamento do intervalo Q-T

- Ex.: Paciente apenas delirando, não precisa dar Haloperidol, pode ser Quetiapina.

↳ Haloperidol é casos mais graves de psicose

32)## (P1: T18) 01) Paciente José 88 anos, chega ao pronto socorro acompanhado de seus familiares, é prontamente atendido pelo médico plantonista. A queixa principal da família é que nos últimos 3 dias o senhor José vem apresentando alterações de comportamento, não falando coisa com coisa, está com lentidão, passou a dormir mais durante o dia, ficar acordado à noite e com alucinações visuais. Após avaliar o senhor José, colher sua história clínica, solicitar os exames complementares o médico plantonista poderia propor o seguinte tratamento:

- a) Internar o paciente, pois o seu quadro clínico sugere fortemente um quadro de acidente vascular encefálico e iniciar o devido tratamento.
- b) Tranquilizar a família, pois os achados clínicos do seu José são muito comuns na sua idade, medicá-lo com um antipsicótico e encaminhá-lo para o ambulatório de geriatria.
- c) Tranquilizar a família, ressaltando que o senhor José apresenta um quadro clínico que sugere a patologia delirium, que essa patologia tem causas multifatoriais, que seria necessário aguardar o resultado dos exames solicitados para definir conduta.**
- d) Internar o paciente, pois o seu quadro sugere fortemente um quadro de demência de Alzheimer na fase inicial, e solicitaria uma avaliação no dia seguinte do neurologista para orientar o devido tratamento.
- e) Internar o paciente, pois o paciente tem um quadro psicótico, fazendo como medicação de escolha Haloperidol.

CORPOS DE LEWY

Questões:

- 40)## (P1: T20) 07) No passado, acreditava-se que, para o indivíduo ser classificado como portador de demência, ele deveria apresentar perda de memória. Hoje, se sabe que existem diversos tipos de demência, com quadros clínicos iniciais e distintos, qual das alternativas a seguir é caracterizada pela abertura do quadro demencial com alucinações visuais, parkinsonismo eruim?
- 41)## (P1: T18) 12) Paciente de 83 anos, encaminhada para centro multidisciplinar de reabilitação cognitiva com história de, há 5 anos ter iniciado com quadro de confusão mental, declínio cognitivo, alucinações visuais (via objetos inexistentes, pessoas no quarto...) e depressão de difícil controle. Além disso, apresentava também alterações de marcha e rigidez simétrica axial, quedas repetidas, desmaios, delírios (acreditar em coisas que não existem). Teve uma progressão rápida da doença, sendo, atualmente, totalmente dependente para atividades básicas da vida diária. Qual tipo de demência mais provável?
- a) Demência vascular
 - b) Demência fronto-temporal
 - c) Doença de Alzheimer
 - d) Demência de corpos de Lewy
 - e) Demência mista
- 42)## (P1: T18) 20) A demência por corpos de lewy é uma sinucleinopatia, aonde a evolução é mais rápida do que outras demências. Assim é correto afirmar:
- a) Mais comum em homens e tem a presença de dos corpúsculos de lewy que é patognômico dessa doença.
 - b) Apresenta com manifestações clínicas o quadro de parkinsonismo, disfunção autonômica, apatia, alucinações visuais e déficits de memória menos marcantes
 - c) A impregnação por neurolépticos não é tão evidente como na doença de Alzheimer.
 - d) O tremor parkinsoniano é muito comum nestes pacientes, sendo a rigidez menos frequente.
 - e) Geralmente o déficit cognitivo aparece depois de muitos anos do quadro de parkinsonismo.

Questões comentadas:

43)## (P1: T20) 07) No passado, acreditava-se que, para o indivíduo ser classificado como portador de demência, ele deveria apresentar perda de memória. Hoje, se sabe que existem diversos tipos de demência, com quadros clínicos iniciais e distintos, qual das alternativas a seguir é caracterizada pela **abertura do quadro demencial com alucinações visuais, parkinsonismo eruim?**

a) R: Doença por Corpos de Lewy

↳ **Diagnóstico**

- Evolução é mais rápida do que outras demências
- **Quadro demencial (cognitivo) + Parkinsonismo**
 - Sintomas cognitivos começam **ANTES ou JUNTO** ou sintomas motores
 - ↳ **Parkinsonismo espontâneo: A Síndrome Demencial deve ocorrer ao máximo 12 meses após o início de Parkinsonismo**
- **Crítérios Centrais:**
 - Flutuação, **alucinação precoce** (imagens coloridas, tridimensionais, animais, objetos)
 - **Parkinsonismo precoce** (geralmente com **rigidez** e **bradicinesia** sendo o **tremor menos frequente**)
- **Sugestivos:**
 - Alteração do sono REM
 - Hipersensibilidade a neurolépticos
 - Baixa captação dopaminérgica no spect ou pet.
- **DCL provável:** 2 centrais ou 1 central e 1 sugestivo.
- **DCL possível:** 1 central ou 1 ou mais sugestivos

44)## (P1: T18) 20) A demência por corpos de lewy é uma sinucleinopatia, aonde a evolução é mais rápida do que outras demências. Assim é correto afirmar:

a) Mais comum em homens e tem a presença dos corpúsculos de lewy que é patognômico dessa doença.

↳ É comum em homens

↳ Presença dos Corpúsculos de Lewy **NÃO é patognômico** de DCL

- **Parkinson** → Presença dos **Corpos de Lewy**, Sinucleína e Parkina → Destruição neuronal

b) Apresenta com manifestações clínicas o quadro de parkinsonismo, disfunção autonômica, apatia, alucinações visuais e déficits de memória menos marcantes

c) A impregnação por neurolépticos ~~não é tão evidente~~ como na doença de Alzheimer.

↳ **Hipersensibilidade a neurolépticos**

- Um dos critérios diagnóstico sugestivos de DCL
- Maior sensibilidade a neurolépticos
 - Pct com alucinações → Médico passa Resperidona → Trava, fica rígido → Isso não é comum no DA e outras demências

d) O tremor parkinsoniano é muito comum nestes pacientes, sendo a rigidez menos frequente.

↳ **Parkinsonismo precoce**

- Um dos critérios diagnóstico centrais de DCL
- **Rigidez** e **Bradicinesia** → **MAIS COMUM**
- **Tremor** → **Menos frequente**

e) Geralmente o déficit cognitivo aparece depois de muitos anos do quadro de parkinsonismo.

↳ DCL → Sintomas cognitivos começam **ANTES ou JUNTO** ou sintomas motores

- Parkinsonismo espontâneo: A síndrome demencial deve ocorrer ao máximo 12 meses após o início de parkinsonismo

45)## (P1: T18) 12) Paciente de 83 anos, encaminhada para centro multidisciplinar de reabilitação cognitiva com história de, há 5 anos, ter iniciado com **quadro de confusão mental, declínio cognitivo, alucinações visuais** (via objetos inexistentes, pessoas no quarto...) e **depressão** de difícil controle. Além disso, apresentava também **alterações de marcha e rigidez simétrica axial, quedas** repetidas, **desmaios, delírios** (acreditar em coisas que não existem). Teve uma progressão rápida da doença, sendo, atualmente, totalmente **dependente para atividades básicas da vida diária**. Qual tipo de demência mais provável?

a) Demência Vascular

↳ **Demência Vascular**

- Tem histórico de AVC

b) Demência Fronto-Temporal

↳ **Demência Fronto-Temporal**

- Paciente **Jovem**
 - A partir de 45 anos
 - < 65 anos
- Alterações de personalidade e comportamento
 - Mudança de comportamento muito significativas, fica desinibido, faz coisas as quais não fazia antes
- SEM parkinsonismo

c) Doença de Alzheimer

↳ **Doença de Alzheimer**

- Insidioso e progressivo
- Parkinsonismo ocorre em fase mais finais da doença sendo leves a moderados.

d) Demência de corpos de Lewy

↳ **Demência de corpos de Lewy**

- Sinucleinopatia
- Início **Súbito**
 - Evolução é mais rápida do que outras demências
- Mais comum em **homens**
- **Quadro demencial (cognitivo) + Parkinsonismo**
 - Sintomas cognitivos começam **ANTES ou JUNTO** ou sintomas motores
 - ↳ **Demência de Parkinson** → Sintomas cognitivos começam **DEPOIS** ou sintomas motores
- Diagnostico precisa ter pelo menos 2 dos seguintes critérios
 - **Parkinsonismo atípico (não responde a Levopoda)**
 - **Alucinações** visuais recorrentes
 - **Flutuações cognitivas**
 - **Alterações psiquiátricas** (já no início do quadro)
- Apresenta **Parkinsonismo** → Bradicinesia, Instabilidade postural, Tremor, Rigidez extrapiramidal

e) Demência Mista

f) Demência da doença de Parkinson

Corpos de Lewy X Alzheimer:

	DCL	DA
Início	60 anos	60 anos
Exames de imagem	Preservação	Acometimento
Progressão	Rápida	Insidiosa
Cognição	Flutuante	Piora gradual
Parkinsonismo	Ao início	Estágios terminais
Alucinações	Presentes	Ausentes
Antipsicóticos	Mais sensível	Inalterado
Delirium	Sem causa aparente	Causa definida
Sobrevida	6 anos	2 a 20 anos

↳ **Demência da doença de Parkinson**

- Sintomas cognitivos começam **DEPOIS** dos sintomas motores
 - Pcte já deveria ter a doença de Parkinson, de anos, para depois iniciar o quadro cognitivo
- **Quando vai ser Doença de Parkinson?**
 - Quando tiver **pelo menos 1 ano de sintomas de Parkinson.**
 - Para ser demência da doença de Parkinson tem que ter diagnóstico da doença de Parkinson por pelo menos 1 ano ANTES.

g) Hidrocefalia de pressão normal

↳ **Tríade da HPN:**

- Marcha Parkinsoniana
- Quadro de demência rápida
- Incontinência urinária.



COMPILADO DE PROVAS – PI

GERIATRIA

QUESTÕES

- 1) Paciente José, 88 anos, chega ao pronto socorro acompanhado de seus familiares, é prontamente atendido pelo médico plantonista. A queixa principal da família é que nos últimos 3 dias o senhor José vem apresentando alterações de comportamento, não falando coisa com coisa, agitação psicomotora, passou a dormir mais durante o dia, ficar acordado à noite e com alucinações visuais. Após avaliar o senhor José, colher sua história clínica, solicitar os exames complementares o médico poderia propor o seguinte a conduta:
- a) Internar o paciente, pois o seu quadro clínico sugere fortemente um quadro de acidente vascular encefálico e iniciar o devido tratamento.
 - b) Tranquilizar a família, pois os achados clínicos do seu José são muito comuns na sua idade, medicá-lo com um antipsicótico e encaminhá-lo para o ambulatório de geriatria.
 - c) Tranquilizar a família, ressaltando que o senhor José apresenta um quadro clínico que sugere a patologia delirium, que essa patologia tem causas multifatoriais, que seria necessário aguardar o resultado dos exames solicitados para definir conduta.**
 - d) Internar o paciente, pois o seu quadro sugere fortemente um quadro de demência de Alzheimer na fase inicial.
 - e) Fazer haloperidol endovenoso e encaminhar o paciente para tratamento ambulatorial, pois o paciente tem um quadro inicial de síndrome demencial, com seguimento na neurologia ou geriatria.
- 2) A palavra iatrogenia, derivada do grego iatrikós, relativo ao médico e a medicina, refere-se a todo malefício provocado ao paciente, decorrente do seu tratamento, seja ele medicamentoso ou no âmbito das relações humanas. Sobre isso, assinale a alternativa errada:
- a) Um dos efeitos adversos mais comuns são os distúrbios da cognição, geralmente causados por tricíclicos, benzodiazepínicos e anticolinérgicos.
 - b) Os inibidores de bomba de prótons podem diminuir ainda a mais acidez gástrica e causar prejuízo na absorção de medicamentos como o ferro, carbonato de cálcio e digoxina.

- c) As alterações a nível de barorreceptor no idoso, somado ao uso de vasodilatadores e anti-hipertensivos, a quadro de hipotensão ortostática e síncope.
- d) Medicamentos com características ácidas como a fenitoína se ligam fortemente a albumina, sendo assim, seus efeitos são potencializados no caso de uma depleção de albumina.
- e) O aumento de massa gorda com o envelhecimento leva diminuição da meia vida de fármacos como a morfina e amiodarona.**
- 3) Analise as afirmativas sobre a Síndrome das Pernas Inquietas no idoso:
- I – As drogas de primeira escolha na SPI são os anticonvulsivantes.
- II – Os pacientes com SPI tem necessidade de movimentar as pernas, com sensação desconfortável que geralmente piora nos períodos de repouso ou no período noturno e que melhora com a movimentação dos membros.
- III – Insuficiência renal crônica, uso de inibidores da recaptação da serotonina, doença de Parkinson e neuropatias são condições clínicas associadas a SPI.
- Qual (is) está (ão) correta (s)
- a) Apenas a I
- b) Apenas a II
- c) Apenas a II e a III.**
- d) Apenas I e a II
- e) Todas corretas.
- 4) Paciente de 81 anos, masculino, professor universitário aposentado, vem ao consultório para tratamento de queixas cognitivas, sem atrapalho nas suas atividades de vida diária. Qual o melhor

teste para avaliar cognição neste paciente?

- a) Minimental
- b) Fluência Verbal
- c) Moca Teste**
- d) MAN
- e) Teste com figuras

- 5) Idosa de 82 anos vem ao consultório médico com obstipação crônica, com piora nos últimos meses. Tem tremor em mão direita há 6 meses, que vem aumentando, associado a bradicinesia. Tem quadro depressivo com uso de amitriptilina há 8 meses. Paciente tem diabetes mellitus com excelente controle, hipertensão arterial e labirintopatia. Medicamentos: metformina, enalapril, metoclopramida, cinarizina.
- Exame Físico: tremor parkinsoniano em mão direita, roda dentada positiva, fácies de máscara.
- Exames laboratoriais normais.
- Descartado causa orgânica, e diante da anamnese referida, quais medicamentos poderiam levar a esses sintomas iatrogênicos?
- a) Metformina, amitriptilina e metoclopramida
- b) Metformina e cinarizina
- c) Cinarizina e amitriptilina
- d) Enalapril, Aas e metformina.
- e) Amitriptilina, Cinarizina e metoclopramida.**
- 6) A desprescrição é uma ferramenta usada para evitar a polifarmácia, reduzindo dose de medicamentos e até interrompendo o consumo de medicamentos, aonde o potencial de dano é superior aos seus

benefícios. Sendo assim é incorreto afirmar:

a) Os aminoglicosídeos é uma classe segura de antibióticos em idosos.

b) Medicamentos como anticolinérgicos, benzodiazepínicos e antiinflamatórios devem ser evitados em pacientes idosos.

c) O uso indevido e por tempo prolongado de AINH podem levar a insuficiência renal e descompensação de ICC.

d) Retirar medicamentos prescritos por balconistas de farmácia, vizinhos ou familiares.

e) A amiodarona pode levar a alterações da tireoide, como o hipotireoidismo.

7) A Demência Fronto-Temporal é uma doença degenerativa que afeta faixa etárias mais jovens, entre 45 a 64 anos, sendo assim é correto dizer:

a) Há um comprometimento da acetilcolina nesta doença, por isso o uso de anticolinesterásicos.

b) Há inicialmente uma perda de memória seguida de alterações de comportamento, como impulsividade, hiperoralidade e risos inadequados.

c) Uma maior impregnação por neurolépticos em relação a outras demências.

d) A sobrevida é maior do que na doença de Alzheimer.

e) O comportamento estereotipados e ritualizados são comuns, com mudança nos hábitos alimentares, com preferência por doces.

8) Paciente de 70 anos, sexo feminino, sobrepeso, está em tratamento por Transtorno Depressivo, com melhora do

quadro melancólico com escitalopram. Entretanto, vem tendo insônia, com sono entrecortado nas últimas semanas, com cochilos frequentes durante o dia. Qual seria a medicação de primeira escolha para esse paciente?

a) Zolpiclona

b) Diazepam

c) Amitriptilina

d) Trazodona

e) Lorazepam

9) Idosa com 74 anos, professora aposentada, chega ao consultório geriátrico com sua filha, que relata que sua mãe há 8 meses, esquece fatos recentes, repetitividade, esquece palavras que vai falar e teve um episódio desorientação espacial. Tem queimado vários alimentos. Tem transtorno depressivo maior há 20 anos e insônia em tratamento. Usa como medicações: Usa Losartana, escitalopram 10mg e clonazepam gotas. Exame físico normal. 10 CS: 4, Teste com fluência verbal: 7. Diante do caso qual o provável diagnóstico e exames a serem pedidos?

a) Comprometimento cognitivo leve amnésico; aonde pediremos exames laboratoriais como vdrl, ftasbs, cálcio sérico, tgo, tgp e glicemia jejum e dosagem de proteína beta amiloide e proteína tau no líquor.

b) Alteração cognitiva secundária a depressão e ao uso de benzodiazepínicos, aonde pediremos exames laboratoriais como B12, ácido fólico, vdrl, HIV, função renal e exame de imagem como a ressonância magnética de encéfalo.

c) Doença de Alzheimer fase inicial; aonde pediremos exames laboratoriais

como TSH, glicemia jejum, vitamina D, fosfatase alcalina e exame de imagem como a ressonância magnética de encéfalo.

d) Doença de Alzheimer fase inicial; aonde pediremos exames laboratoriais como cálcio sérico, tgo, tgp, glicemia jejum, tsh, creatinina e exame de imagem como a ressonância magnética de encéfalo.

e) Comprometimento cognitivo leve amnésico; aonde pediremos exames laboratoriais e spect cerebral.

10) Na Avaliação Geriátrica Ampla (AGA) temos várias ferramentas para avaliação do idoso de maneira correta, melhorando a precisão diagnóstica. Sendo assim é verdadeiro afirmar:

a) A escala de atividades de vida diária (AVDs) não são importantes na avaliação de um paciente com demência, somente nos casos de delirium.

b) b) O SARC-F avalia é uma importante ferramenta para diagnóstico de sarcopenia e fragilidade, tendo com importância a medida da panturrilha.

c) c) O teste cronometrado de levantar e andar avalia a possibilidade de quedas e fragilidade, aonde um tempo maior que 10 segundos é considerado positivo.

d) d) O Moca-Teste tem uma boa aplicabilidade em pacientes com grau de educação reduzido é usado em pacientes com suspeita de CCL e demência.

e) e) O Mini-mental tem uma acurácia superior ao 10-CS.

11) Paciente de 83 anos, encaminhada para centro multidisciplinar de reabilitação cognitiva com história de, há 2 anos, ter iniciado com quadro de confusão mental, declínio cognitivo, alucinações visuais (via objetos inexistentes, pessoas no quarto...) e depressão de difícil controle. Além disso, apresentava também alterações de marcha e rigidez simétrica axial, quedas repetidas, desmaios, delírios (acreditar em coisas que não existem). Teve uma progressão rápida da doença, sendo, atualmente, totalmente dependente para atividades básicas da vida diária. Qual tipo de demência mais provável?

a) Demência vascular

b) Demência fronto-temporal

c) Doença de Alzheimer

d) Demência Mista

e) Demência de corpos de Lewy

12) Com relação à doença de Parkinson é verdadeiro afirmar:

I – A rigidez pode estar presente com o fenômeno da roda denteada.

II – Déficit olfativo, quedas frequentes e perda ponderal constituem sinais/sintomas pré motores.

III – O tremor está presente em 70% dos pacientes e caracteriza-se por diminuir sua amplitude com o estresse e ao repouso.

IV – Hipomimia e hipofonia são sinais observados em pacientes com esta patologia.

V – O diagnóstico é definido com base na presença de síndrome parkinsoniana com tremor, bradicinesia, instabilidade postural e rigidez muscular.

São afirmativas corretas:

a) I, II e V

b) I, IV e V

c) III, IV e V

d) I, III e IV

e) Todas corretas.

13) Sobre o Comprometimento Cognitivo leve, assinale a alternativa incorreta:

a) A doença pode corresponder a uma fase prodrômica de uma demência de Alzheimer.

b) A avaliação de biomarcadores (amiloide e proteína tau) no líquido é indicada para descartar possível doença de Alzheimer.

c) O comprometimento Cognitivo Amnésico é o mais comum.

d) O CCL não amnésico com um único domínio afetado é que tem mais propensão a evolução para Alzheimer.

e) O paciente com CCL não apresenta alteração nas atividades de vida diária.

14) Na demência vascular temos uma doença cerebrovascular, tendo como causas quadros hemorrágicos, embólicos e isquêmicos. Sobre essa patologia é incorreto dizer:

a) A escala isquêmica de hachinski é usada como auxílio ao diagnóstico, sendo um escore maior que 7 positivo para a doença.

b) Alguns fatores de risco: sedentarismo, doença coronariana, níveis aumentados de homocisteína e diabetes.

c) Demência por múltiplos infartos é decorrente de infartos grandes, corticais e subcorticais, de grandes artérias.

d) A demência vascular por doença de pequenos vasos leva alteração das

funções executivas, déficit de memória, com atrapalho nas atividades ocupacionais e distúrbios da marcha.

e) A doença de Binswanger não apresenta sintomas comportamentais e de marcha, sendo relacionada com a hipertensão arterial.

15) M.A.N, 73 anos refere diarreia, astenia, náuseas e vômitos há 8 horas. Nega enterorragia e fezes com muco ou pus. No exame físico mostra-se desidratada +2/4, hipotensa 90/60 e confusa. Tirando o quadro patológico, a fácil desidratação dessa paciente pode ser explicada, devido a:

a) Aumento da massa gorda e diminuição da massa magra.

b) Diminuição de glândulas sudoríparas e sebáceas.

c) Diminuição do fluxo sanguíneo renal.

d) Menor produção de renina.

e) Diminuição de água corpórea, devido a menor massa celular.

16) Paciente 70 anos, sexo feminino, com queixas de melancolia, irritabilidade, mal estar, tonturas, desânimo e diminuição do vocabulário há 90 dias. Foi num médico generalista há 60 dias que passou dose máxima de citalopram, com razoável melhora. Mantém ainda quadro de desânimo e tristeza em certos dias, querendo ficar somente em casa e não sair. Paciente tem como comorbidades HAS, Obesidade, DM II e Neuropatia Diabética. Diante de tudo isso, qual seria a melhor conduta para a paciente:

a) Associar outro ISRS.

b) Trocar o citalopram pelo escitalopram.

- c) Associar mirtazapina.
d) Trocar o citalopram pela duloxetine.
e) Trocar o citalopram pela bupropiona.
- 17) Paciente com 77 anos, com depressão grave há 2 anos, vem usando venlafaxina e mirtazapina em doses máximas, com razoável melhora. Vem mantendo quadro de anedonia, tristeza, apatia e ansiedade, com medo de sair de casa. Diante desse quadro, qual seria a próxima conduta para esse paciente?
a) Trocar a mirtazapina pela duloxetine.
b) Associar lítio ou valproato de sódio.
c) Passar um ansiolítico como o bromazepam.
d) Trocar a venlafaxina pela sertralina.
e) Indicar um antipsicótico como a levomepromazina.
- 18) A Osteoartrite é um transtorno articular multifatorial que pode acometer uma ou várias articulações, de tendo a dor como a principal queixa no consultório médico. Além disso, a limitação funcional e prejuízo nas atividades de vida diária tem grande impacto na vida dos pacientes. Com isso é correto afirmar:
a) O uso do colágeno e da glicosamina muda a evolução da doença e diminui o grau de dor do paciente.
b) A dor não piora com a mudança atmosférica e sendo pior ao repouso.
c) O uso de anticonvulsivantes como a gabapentina e a pregabalina pode ser indicada em certos casos, devido à amplificação central da dor.
d) O uso da bengala deve ser sempre do mesmo lado da articulação acometida com o cotovelo fletido a 20 a 30 graus.

- e) As alterações radiográficas se caracterizam somente por degradação da cartilagem e pinçamento articular.
- 19) Com relação à DV ocasionada por hipoperfusão, analise as alternativas a seguir e marque V (verdadeiro) ou F (falso).
- Na DV por hipoperfusão, há a ocorrência de eventos sistêmicos que afetam a hemodinâmica cerebral.
- Insuficiência cardíaca grave é exemplo de hipoperfusão aguda.
- A hipotensão postural crônica é um exemplo de hipoperfusão crônica.
- Apesar de a DV por hipoperfusão ocorrer em áreas de penumbra entre regiões irrigadas por grandes artérias, tal condição não afeta a substância branca.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
a) V, V, F, V
b) V, F, V, F
c) F, V, F, V
d) F, F, V, F
e) V, V, V, F
- 20) Com relação ao diagnóstico diferencial de déficit cognitivo nas demências, correlacione a primeira e a segunda colunas.
1 DV cortical
2 DV subcortical
3 Doença de Alzheimer
4 Demência por Corpos de Lewy
() Curso gradual e progressivo com memória episódica muito acometida.
() Curso gradual e progressivo com flutuação da consciência.
() Curso em degraus com disfunção executiva.

() Curso gradual e progressivo com disfunção executiva, déficit de atenção e alteração da marcha.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- a) 2, 1, 4, 3
- b) 3, 4, 1, 2**
- c) 1, 3, 2, 4
- d) 4, 2, 3, 1
- e) 4, 3, 1, 2

21) Sobre os critérios diagnósticos de Comprometimento Cognitivo Leve assinale a alternativa correta.

- a) A memória é, necessariamente, afetada em casos de CCL.
- b) As atividades instrumentais de vida diária nunca são afetadas no CCL.
- c) O diagnóstico de CCL está confirmado quando há qualquer comprometimento das avds.
- d) O desempenho nos testes cognitivos dos pacientes com CCL costuma ser muito comprometido.

e) O CCL não amnésico com um único domínio afetado pode envolver somente linguagem, função executiva ou habilidades visuoespaciais

22) Idosa de 76 anos vem ao consultório médico com obstipação crônica e delirium há 7 dias. Tem tremor em mão direita há 6 meses, que vem aumentando, associado a bradicinesia. Tem quadro depressivo com uso de escitalopram e recente prescrição de nortriptilina há 14 dias. Paciente tem diabetes mellitus com excelente controle, hipertensão arterial e labirintopatia. Medicamentos: metformina, enalapril,

metoclopramida esporadicamente, cinarizina e nortriptilina.

Exame Físico: tremor parkinsoniano em mão direita, roda dentada positiva, fácies de máscara.

Exames laboratoriais normais.

Descartado causa orgânica, e diante da anamnese referida, quais medicamentos poderiam levar a esses sinais e sintomas iatrogênicos?

- a) Metformina, nortriptilina e metoclopramida
- b) Metformina e cinarizina
- c) Cinarizina, metoclopramida e nortriptilina.**
- d) Cinarizina e nortriptilina
- e) Enalapril e metformina.

23) Uma senhora de 72 anos de idade apresenta 2 anos de progressiva alteração da memória e dificuldade em AVDs, como compras e perda de objetos. Ela recebeu o diagnóstico de provável DA. Foi sugerido o uso de galantamina em doses crescentes até 24mg/dia. Depois de 5 meses, retorna com a filha reclamando que o tratamento não fez efeito, porque está “do mesmo jeito”. A informação é de que continua com as mesmas limitações e fazendo as mesmas atividades, isto é, cuidando da casa, fazendo compras em lugares muito próximos e indo à igreja aos domingos. O escore no MEEM caiu 1 ponto.

Considerando as informações apresentadas, pode-se concluir que

- a) O diagnóstico não é DA, por isso, o tratamento fracassou.
- b) O diagnóstico é DA, mas essa medicação não funcionou e precisa ser substituída por outro inibidor da acetilcolinesterase.

- c) A medicação não obteve uma resposta plena e deve ser adicionada memantina.
- d) A resposta a medicação está correta, dentro das expectativas do tratamento.**
- e) Deve ser adicionar outro inibidor da acetilcolinesterase.
- 24) No passado, acreditava-se que, para o indivíduo ser classificado como portador de demência, ele deveria apresentar perda de memória. Hoje sabe-se que existem diversos tipos de demências com quadros clínicos iniciais distintos. Qual das alternativas a seguir é caracterizada pela abertura do quadro demencial com alucinações visuais, parkinsonismo e distúrbio do sono REM?
- a) Demência frontotemporal.
- b) Demência vascular.
- c) Demência por corpúsculos de Lewy.**
- d) Hidrocefalia de pressão normal.
- e) Demência na Doença de Parkinson
- 25) A Demência Fronto-Temporal é uma doença degenerativa que afeta faixa etárias mais jovens, entre 45 a 64 anos, sendo assim é correto dizer:
- a) Há inicialmente uma perda de memória seguida de alterações de comportamento, como impulsividade, hiperoralidade e risos inadequados.
- b) A sobrevida é maior do que na doença de Alzheimer.
- c) Alteração da personalidade como aparência desleixada, impaciência e irritabilidade, disputa argumentativa, comentários libidinosos e compulsões precedem o quadro de declínio da memória.**
- d) Quadros alucinatórios e hipocondria são frequentes precedendo a perda de memória.
- e) Geralmente acomete indivíduos acima de 70 anos, sendo a 2ª causa de demência não Alzheimer.
- 26) Paciente de 69 anos, sexo feminino, sobrepeso, está em tratamento por Transtorno Depressivo, com melhora do quadro melancólico com sertralina. Entretanto, vem tendo insônia, com sono entrecortado nas últimas semanas, com cochilos frequentes durante o dia. Qual seria a medicação de primeira escolha para esse paciente?
- a) Zolpidem
- b) Diazepam
- c) Amitriptilina
- d) Lorazepam
- e) Trazodona**
- 27) Na Avaliação Geriátrica Ampla (AGA) temos várias ferramentas para avaliação do idoso de maneira correta, melhorando a precisão diagnóstica. Sendo assim é incorreto afirmar:
- a) O teste cronometrado de levantar e andar avalia a possibilidade de quedas e fragilidade, aonde um tempo maior que 20 segundos sugerem risco para quedas e fragilidade muscular.
- b) O Moca-Teste tem uma boa aplicabilidade em pacientes com bons níveis educacionais e é usado em pacientes com suspeita de CCL e demência.
- c) O 10-CS é usado para avaliar questões cognitivas em substituição ao Minimental.

d) O SARC-F é usado para avaliar o risco de fraturas em pacientes idosos.

e) O questionário de Yesavage avalia possível quadros depressivos, através de uma lista de perguntas.

28) No que se refere às manifestações clínicas da DP, analise as alternativas a seguir e marque V (verdadeiro) ou F (falso).

- Em indivíduos acometidos pela DP, o tremor de repouso ainda é o primeiro sintoma reconhecido pelo próprio paciente, por seus familiares e pelos médicos assistentes.
- A bradicinesia não é o principal sintoma cardinal na DP no idoso, e sim o tremor.
- A instabilidade postural em geral não ocorre nas formas iniciais e leves da DP.
- Dermatite seborreica, hipotensão ortostática e alterações do sono REM podem fazer parte da patologia.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

a) V, V, F, F

b) V, F, V, V

c) F, V, F, V

d) F, F, V, F

e) V, F, F, V

29) Quanto à medicação considerada primeira opção no tratamento de pacientes com sintomas de Síndrome de Pernas Inquietas e exames a serem pedidos para

investigação, assinale a alternativa correta.

a) Pramipexol, ferro, ferritina, creatinina.

b) Clonazepam, ferro e ferritina.

c) Ciclobenzaprina, hb glicosilada, glicemia jejum.

d) Duloxetine, ureia, creatinina, ferro.

e) Clonazepam, b12 e ferro.

30) Idosa com 74 anos, chega ao consultório geriátrico com sua filha, que relata que sua mãe há 6 meses, esquece fatos recentes, repetitividade, esquece palavras que vai falar e desorientação espacial. Tem queimado vários alimentos. Tem transtorno depressivo maior há 5 anos, diabetes mellitus e insônia em tratamento. Usa como medicações: Usa Losartana, escitalopram 10mg, clonazepam gotas (usa há 10 anos), metformina. Exame físico normal. 10 CS: 4, Teste com fluência verbal: 5. Diante do caso qual, assinale a resposta incorreta:

a) Quadro característico de síndrome demencial, provável doença de Alzheimer, pois tem alterações de instrumentais de vida diária e testes cognitivos alterados.

b) A paciente tem em questão fatores de risco para ter uma demência, como o diabetes mellitus, uso crônico de benzodiazepínico e depressão na terceira idade.

c) Doença de Alzheimer fase inicial; aonde pediremos exames laboratoriais como TSH, vdril, fta-abs, b12 e exame de imagem como a ressonância magnética de encéfalo.

d) Além do tratamento do quadro demencial, a retirada de maneira lenta

do clonazepam, pode ajudar também no tratamento cognitivo.

e) Se a paciente em questão, tiver ressonância magnética de encéfalo normal e liquor com proteína beta amiloide diminuída e proteína TAU aumentada, devemos afastar doença de Alzheimer.

31) Idosa, 73 anos refere diarreia e vômitos há 12 horas por quadro viral, além disso confusão mental aguda associada. Nega febre. No exame físico mostra-se desidratada +2/4, hipotensa 90/60 e confusa. Exames laboratoriais mostrou hiponatremia, creatina e ureia elevadas. Diante desse quadro clínico é incorreto afirmar:

a) Como o idoso tem diminuição de aldosterona pelo próprio envelhecimento, teremos mais casos de hiponatremia e hipocalemia associada em situações de depleção.

b) Devido a menor água corporal, menos sensação de sede, o paciente pode rapidamente desidratar e levar piora da função renal.

c) O quadro de delirium foi devido a desidratação com elevação dos níveis de ureia e a hiponatremia.

d) A diminuição da renina plasmática devido a senescência pode aumentar a incidência de hiponatremia.

e) Além da creatinina nesse caso, deve-se monitorar o clearance de creatinina, pois esse é mais fidedigno para avaliar a função renal no idoso.

32) Paciente com 68 com doença de Parkinson diagnosticada há 7 anos,

usando levodopa em doses fracionadas e pramipexole. Nos últimos 30 dias vem tendo movimentos coreiformes em segmento cefálico. Diante do caso clínico, qual seria esta alteração e melhor conduta para este doente?

a) Piora do quadro de parkinsonismo e aumentar a dose da levodopa.

b) Fenômeno wearing-off e aumentar dose de pramipexole.

c) Discinesia e aumentar a dose da levodopa.

d) Agitação psicomotora e associar quetiapina.

e) Discinesia continua e associar amantadina.

33) Uma paciente idosa é trazida por seus filhos por quadro de alucinações visuais mais proeminente a noite, com insônia e agitação psicomotora há 4 dias. Qual seria o medicamento mais apropriado para o seu caso até ficarem prontos seus exames investigatórios?

a) Clorpromazina

b) Risperidona

c) Lorazepam

d) Trazodona

e) Levomepromazina

34) Sobre o escore isquêmico de Hachinski, assinale a alternativa correta.

a) Sua aplicação é recomendada na investigação de DV cortical.

b) Deve ser utilizado na tentativa de diferenciar DV pura de demência mista.

c) Quando apresenta pontuação superior a 4, indica maior probabilidade de etiologia neurodegenerativa.

- d) Não deve ser utilizado para estudo da contribuição vascular em um quadro demencial.
- e) Pode ser usada para aferir o grau de acometimento motor e cognitivo.

35) J.S. é um homem de 75 anos portador de quadro demencial devido à doença de Alzheimer em fase moderada. Mora em sua residência com cuidadores 24 horas/dia. Apresenta continência urofecal e alimenta-se sozinho. Dormia bem até que há uma semana iniciou quadro de agitação, agressividade verbal e incontinência urinária. Mostra-se assustado, referindo presença de pessoas estranhas na residência. Houve uma tentativa de agressão física a uma das cuidadoras, fato até então nunca ocorrido. O paciente apresenta como comorbidades hipertensão arterial e diabetes melito (DM) do tipo 2. Está acima do peso e reluta em fazer atividade física. Ele utiliza os seguintes fármacos: donepezila, enalapril, hidroclorotiazida, metformina, amitriptilina. Médico avaliou o paciente em sua residência, com o exame físico normal.

Diante do caso é verdadeiro afirmar:

- a) O paciente teve piora do quadro demencial, sendo necessário associar memantina para controle da agitação e melhora cognitiva.
- b) Deve ser medicado com antipsicótico como o haloperidol gotas e suspender amitriptilina devido ao seu efeito anticolinérgico.
- c) Pedir exames laboratoriais para afastar possível quadro infeccioso ou metabólico, suspender o tricíclico e medicar com quetiapina.**

- d) Suspender a donepezila e pedir exames laboratoriais.
- e) Introduzir a trazodona para o quadro de agitação e associar memantina.

36) Sobre a Osteoartrite no idoso é correto afirmar:

- a) O uso do colágeno do tipo II tem como indicação na osteoartrite de quadril, com bons resultados a longo prazo, pois modifica a evolução da doença.
- b) A dor não piora com a mudança atmosférica e sendo pior ao repouso.
- c) A cúrcuma longa e a Boswellia serrata são fitoterápicos com ação anti-inflamatória e ação otimizada em 4 a 6 semanas, podendo ser tentados para melhora da dor e função em pacientes com osteoartrite de joelho.**
- d) O uso da bengala deve ser sempre do mesmo lado da articulação acometida com o cotovelo fletido a 30 graus.
- e) O uso de AINH no tratamento é mandatório em todos os pacientes.

37) Paciente de 78 anos é trazido pelos filhos com sintomas de alucinações, confusão mental, agitação psicomotora há 4 dias. Família relata urina com odor fétido, sem disúria, mas com incontinência urinária associada neste período. Conforme o caso relatado é verdadeiro dizer:

- a) Trata-se de um quadro de Demência por Corpos de Lewy.
- b) As hipóteses diagnósticas seriam Demência de Alzheimer com infecção urinária.
- c) O diagnóstico mais provável seria de Demência Vascular por acidente vascular cerebral.

d) As hipóteses diagnósticas seriam delirium com infecção do trato urinário.

e) O uso da rivastigmina traria benefícios a este paciente, devido a melhora cognitiva.

38) Paciente feminina, 78 anos, portadora de HAS, DMII e osteoporose, sofreu duas quedas da própria altura no último ano, sendo a última há 1 mês, em casa, após tropeçar no tapete levando a trauma em região frontal. Na avaliação geriátrica ampla apresenta Teste get up and go de 30 seg, escala yesavage 9, MEEM=25. Nesse caso, o fator que é o maior PREDITOR de futuras quedas para essa idosa é:

- a) Osteoporose
- b) Minimental
- c) A hipertensão
- d) A idade

e) O teste get up and go

39) Uma paciente idosa é trazida por seus filhos por quadro de alucinações visuais mais proeminente a noite, com insônia e agitação psicomotora. Qual seria o medicamento mais apropriado para o seu caso?

- a) Quetiapina**
- b) Melatonina
- c) Lorazepam
- d) Trazodona
- e) Zolpidem

40) Paciente com 78 com doença de Parkinson diagnosticada há 7 anos, usando levodopa em doses fracionadas e pramipexole. Nos últimos 30 dias vem

tendo movimentos coreiformes em segmento cefálico. Diante do caso clínico, qual seria esta alteração e melhor conduta para este doente?

- a) Piora do quadro de parkinsonismo e aumentar a dose da levodopa.
- b) Fenômeno wearing-off e aumentar dose de pramipexole.
- c) Fenômeno coreico e associar outro agonista dopaminérgico.

d) Discinesia continua e associar amantadina.

e) Agitação psicomotora e associar quetiapina.

41) Paciente com 80 anos, com diagnóstico de Depressão Maior, pela escala de Yesavage, relata que tem gonoartrose bilateral com dor em ambos os joelhos. Está em uso de glicosamina e condroitina com razoável melhora do quadro algico. Diante do caso depressivo e de artrose, qual seria o melhor medicamento em questão:

- a) Diazepam
- b) Fluoxetina
- c) Duloxetina**
- d) Trazodona
- e) Sertralina

42) Na doença de Alzheimer tem uma doença degenerativa, sem tratamento curativo e sim sintomático. É a demência mais comum em nosso meio. Assim podemos afirmar:

a) Existe uma hiperfosforilação da proteína tau, levando ao aparecimento dos emaranhados neurofibrilares.

b) Doenças metabólicas e cardiovasculares não estão

relacionadas com o aparecimento da doença, e sim de causa genética na maioria dos casos.

- c) A memantina está indicada a partir das fases leves da doença.
- d) A proteína beta amiloide é uma lesão intracelular.
- e) A disfagia aparece em fase precoce da patologia, necessitando o uso de sonda.

43) Pacientes idosos com depressão podem ter alterações do sono, como insônia ou sonolência. Dentre estes antidepressivos a abaixo, qual o único que não ajudaria na insônia de um paciente idoso com depressão?

- a) Doxepine
- b) Mirtazapina
- c) Sertralina**
- d) Trazodona
- e) Agomelatina

44) Paciente 70 anos, teve AVC isquêmico há 90 dias, aonde desde o internamento vem tendo quadro de confusão mental, choro fácil, repete assuntos, desorientação no tempo e espaço, não reconhece sua casa e sua esposa em certos momentos. Nega queixas cognitivas anteriormente. Qual possível hipótese diagnóstica para esse quadro?

- a) Doença de Alzheimer
- b) Demência Vascular**
- c) Comprometimento cognitivo leve
- d) Transtorno depressivo maior
- e) Demência por Corps de Lewy

45) O transtorno depressivo no idoso causa um impacto significativo na vida do paciente, sendo que o seu diagnóstico muitas vezes é negligenciado e subtratado. Sendo assim é correto dizer:

- a) Sentimentos de culpa e menos valia são menos comuns em depressão de início tardio.**
- b) A escolaridade e a doença cerebrovascular não são fatores de risco para depressão no idoso.
- c) Os homens são os que tem mais sintomas e maior possibilidade de apresentação atípica.
- d) A depressão subsindromica não preenche os critérios para depressão maior e não causa o mesmo tipo de incapacidade.
- e) Na depressão de início tardio, o fator genético é de suma importância, e por isso deve ser investigado.

Provas de Geriatria

1º BIMESTRE

PROVA 01 - TXXI

1- Paciente José, 88 anos, chega ao pronto socorro acompanhado de seus familiares, é prontamente atendido pelo médico plantonista. A queixa principal da família é que nos últimos 3 dias o senhor José vem apresentando alterações de comportamento, não falando coisa com coisa, agitação psicomotora, passou a dormir mais durante o dia, ficar acordado à noite e com alucinações visuais. Após avaliar o senhor José, colher sua história clínica, solicitar os exames complementares o médico poderia propor o seguinte a conduta:

- a) Internar o paciente, pois o seu quadro clínico sugere fortemente um quadro de acidente vascular encefálico e iniciar o devido tratamento.
- b) Tranquilizar a família, pois os achados clínicos do seu José são muito comuns na sua idade, medicá-lo com um antipsicótico e encaminhá-lo para o ambulatório de geriatria.
- c) Tranquilizar a família, ressaltando que o senhor José apresenta um quadro clínico que sugere a patologia delirium, que essa patologia tem causas multifatoriais, que seria necessário aguardar o resultado dos exames solicitados para definir conduta.
- d) Internar o paciente, pois o seu quadro sugere fortemente um quadro de demência de Alzheimer na fase inicial.
- e) Fazer haloperidol endovenoso e encaminhar o paciente para tratamento ambulatorial, pois o paciente tem um quadro inicial de síndrome demencial, com seguimento na neurologia ou geriatria.

- 2- Com relação à DV ocasionada por hipoperfusão, analise as alternativas a seguir e marque V (verdadeiro) ou F (falso).
- I. Na DV por hipoperfusão, há a ocorrência de eventos sistêmicos que afetam a hemodinâmica cerebral.
 - II. Insuficiência cardíaca grave é exemplo de hipoperfusão aguda.
 - III. A hipotensão postural crônica é um exemplo de hipoperfusão crônica.
 - IV. Apesar de a DV por hipoperfusão ocorrer em áreas de penumbra entre regiões irrigadas por grandes artérias, tal condição não afeta a substância branca.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- a) V, V, F, V
- b) V, F, V, F
- c) F, V, F, V
- d) F, F, V, F
- e) V, V, V, F

- 3- Com relação ao diagnóstico diferencial de déficit cognitivo nas demências, correlacione a primeira e a segunda colunas.

- 1. DV cortical
- 2. DV subcortical
- 3. Doença de Alzheimer
- 4. Demência por Corpos de Lewy

- () Curso gradual e progressivo com memória episódica muito acometida.
- () Curso gradual e progressivo com flutuação da consciência.
- () Curso em degraus com disfunção executiva.
- () Curso gradual e progressivo com disfunção executiva, déficit de atenção e alteração da marcha.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- a) 2, 1, 4, 3
- b) 3, 4, 1, 2**
- c) 1, 3, 2, 4
- d) 4, 2, 3, 1
- e) 4, 3, 1, 2

4- Sobre os critérios diagnósticos de Comprometimento Cognitivo Leve assinale a alternativa correta.

- a) A memória é, necessariamente, afetada em casos de CCL.
- b) As atividades instrumentais de vida diária nunca são afetadas no CCL.
- c) O diagnóstico de CCL está confirmado quando há qualquer comprometimento das avds.
- d) O desempenho nos testes cognitivos dos pacientes com CCL costuma ser muito comprometido.

e) O CCL não amnésico com um único domínio afetado pode envolver somente linguagem, função executiva ou habilidades visuoespaciais

5- Idosa de 76 anos vem ao consultório médico com obstipação crônica e delirium há 7 dias. Tem tremor em mão direita há 6 meses, que vem aumentando, associado a bradicinesia. Tem quadro depressivo com uso de escitalopram e recente prescrição de nortriptilina há 14 dias. Paciente tem diabetes mellitus com excelente controle, hipertensão arterial e labirintopatia. Medicamentos: metformina, enalapril, metoclopramida esporadicamente, cinarizina e nortriptilina. Exame Físico: tremor parkinsoniano em mão direita, roda dentada positiva, fâcies de máscara. Exames laboratoriais normais. Descartado causa orgânica, e diante da anamnese referida, quais medicamentos poderiam levar a esses sinais e sintomas iatrogênicos?

- a) Metformina, nortriptilina e metoclopramida
- b) Metformina e cinarizina
- c) Cinarizina, metoclopramida e nortriptilina.**
- d) Cinarizina e nortriptilina
- e) Enalapril e metformina

6- Uma senhora de 72 anos de idade apresenta 2 anos de progressiva alteração da memória e dificuldade em AVDs, como compras e perda de objetos. Ela recebeu o diagnóstico de provável DA. Foi sugerido o uso de galantamina em doses crescentes até 24mg/dia. Depois de 5 meses, retorna com a filha reclamando que o tratamento não fez efeito, porque está “do mesmo jeito”. A informação é de que continua com as mesmas limitações e fazendo as mesmas atividades, isto é, cuidando da casa, fazendo compras em lugares muito próximos e indo à igreja aos domingos. O escore no MEEM caiu 1 ponto.

Considerando as informações apresentadas, pode-se concluir que

- a) O diagnóstico não é DA, por isso, o tratamento fracassou.
- b) O diagnóstico é DA, mas essa medicação não funcionou e precisa ser substituída por outro inibidor da acetilcolinesterase.
- c) A medicação não obteve uma resposta plena e deve ser adicionada memantina.
- d) A resposta a medicação está correta, dentro das expectativas do tratamento.**
- e) Deve ser adicionar outro inibidor da acetilcolinesterase.

7- No passado, acreditava-se que, para o indivíduo ser classificado como portador de demência, ele deveria apresentar perda de memória. Hoje sabe-se que existem diversos tipos de demências com quadros clínicos iniciais distintos. Qual das alternativas a seguir é caracterizada pela abertura do quadro demencial com alucinações visuais, parkinsonismo e distúrbio do sono REM?

- a) Demência frontotemporal.

- b) Demência vascular.
 - c) Demência por corpúsculos de Lewy.
 - d) Hidrocefalia de pressão normal.
 - e) Demência na Doença de Parkinson
- 8- A Demência Fronto-Temporal é uma doença degenerativa que afeta faixa etárias mais jovens, entre 45 e 64 anos, sendo assim é correto dizer:
- a) Há inicialmente uma perda de memória seguida de alterações de comportamento, como impulsividade, hiperoralidade e risos inadequados.
 - b) A sobrevida é maior do que na doença de Alzheimer.
 - c) Alteração da personalidade como aparência desleixada, impaciência e irritabilidade, disputa argumentativa, comentários libidinosos e compulsões precedem o quadro de declínio da memória.
 - d) Quadros alucinatórios e hipocondria são frequentes precedendo a perda de memória.
 - e) Geralmente acomete indivíduos acima de 70 anos, sendo a 2ª causa de demência não Alzheimer.
- 9- Sra. Balbina, 75 anos, autônoma e independente, comparece à consulta ambulatorial de rotina sem queixas espontâneas. Ao exame, observa-se perda ponderal de 5kg no último ano que, segundo a paciente, foi involuntária. Quando questionada sobre o hábito intestinal, ela relata que tem ficado até quatro dias sem evacuar e que o uso de laxativos orais não modifica muito esse quadro. Descreve certo tenesmo. Revisando o prontuário, percebe-se que, há um ano, a Sra. Balbina possuía ritmo intestinal diário, sem esforço evacuatório. Com relação à conduta mais adequada para a paciente do caso clínico, assinale a alternativa correta.
- a) Trata-se, possivelmente, de quadro benigno, já que não há impacto

significativo na funcionalidade e a paciente não apresenta queixa espontânea. Recomenda-se apenas acompanhamento.

- b) São indicados ajuste na dieta e uso regular e combinado de laxativos orais com diferentes mecanismos de ação.
- c) Deve-se realizar toque retal e solicitar pesquisa anual de sangue oculto nas fezes.
- d) Deve-se solicitar colonoscopia, considerando a funcionalidade da paciente e a presença dos sinais de alerta.
- e) Prescrever fleet enema semanal para melhorar o funcionamento do intestino.

10- Sobre a Osteoartrite no idoso é correto afirmar:

- a) O uso do colágeno do tipo II tem como indicação na osteoartrite de quadril, com bons resultados a longo prazo, pois modifica a evolução da doença.
- b) A dor não piora com a mudança atmosférica e sendo pior ao repouso.
- c) A cúrcuma longa e a Boswellia serrata são fitoterápicos com ação anti-inflamatória e ação otimizada em 4 a 6 semanas, podendo ser tentados para melhora da dor e função em pacientes com osteoartrite de joelho.
- d) O uso da bengala deve ser sempre do mesmo lado da articulação acometida com o cotovelo fletido a 30 graus.
- e) O uso de AINH no tratamento é mandatório em todos os pacientes.

11- Na Avaliação Geriátrica Ampla (AGA) temos várias ferramentas para avaliação do idoso de maneira correta, melhorando a precisão diagnóstica. Sendo assim é incorreto afirmar:

- a) O teste cronometrado de levantar e andar avalia a possibilidade de quedas e fragilidade, aonde um tempo maior que 20 segundos sugerem risco para quedas e fragilidade muscular.

- b) O Moca-Teste tem uma boa aplicabilidade em pacientes com bons níveis educacionais e é usado em pacientes com suspeita de CCL e demência.
- c) O 10-CS é usado para avaliar questões cognitivas em substituição ao Minimental.
- d) O SARC-F é usado para avaliar o risco de fraturas em pacientes idosos.
- e) O questionário de Yesavage avalia possível quadros depressivos, através de uma lista de perguntas.

12- No que se refere às manifestações clínicas da DP, analise as alternativas a seguir e marque V (verdadeiro) ou F (falso).

- I. Em indivíduos acometidos pela DP, o tremor de repouso ainda é o primeiro sintoma reconhecido pelo próprio paciente, por seus familiares e pelos médicos assistentes.
- II. A bradicinesia não é o principal sintoma cardinal na DP no idoso, e sim o tremor.
- III. A instabilidade postural em geral não ocorre nas formas iniciais e leves da DP.
- IV. Dermatite seborreica, hipotensão ortostática e alterações do sono REM podem fazer parte da patologia.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- a) V, V, F, F
- b) V, F, V, V
- c) F, V, F, V
- d) F, F, V, F
- e) V, F, F, V

13- Paciente do sexo feminino, traz ao consultório exame de Densitometria Óssea mostrando os seguintes resultados: colo do fêmur -3,1/fêmur total -2,8. Coluna vertebral L1-L4 -1,2. Exames de sangue normais. Tem histórico de obstipação intestinal crônica. Qual seria o diagnóstico e tratamento:

- a) Osteopenia; usar Raloxifeno e Carbonato de Cálcio 500mg + Vitamina D 400UI 2X ao dia.

- b) Osteoporose; usar alendronato sódico semanal e Carbonato de cálcio 500mg 2x ao dia.
- c) Osteoporose; usar bifosfonato, cálcio citrato malato associado a vitamina D.
- d) Osteopenia; usar bifosfonato, cálcio citrato malato e denosumabe.
- e) Osteopenia; usar cálcio citrato malato e vitamina D.

14- Idosa com 74 anos, chega ao consultório geriátrico com sua filha, que relata que sua mãe há 6 meses, esquece fatos recentes, repetividade, esquece palavras que vai falar e desorientação espacial. Tem queimado vários alimentos. Tem transtorno depressivo maior há 5 anos, diabetes mellitus e insônia em tratamento. Usa como medicações: Usa Losartana, escitalopram 10mg, clonazepam gotas (usa há 10 anos), metformina. Exame físico normal. 10 CS: 4, Teste com fluência verbal: 5. Diante do caso qual, assinale a resposta incorreta:

- a) Quadro característico de síndrome demencial, provável doença de Alzheimer, pois tem alterações de instrumentais de vida diária e testes cognitivos alterados.
- b) A paciente tem em questão fatores de risco para ter uma demência, como o diabetes mellitus, uso crônico de benzodiazepínico e depressão na terceira idade.
- c) Doença de Alzheimer fase inicial; onde pediremos exames laboratoriais como TSH, vdrl, fta-abs, b12 e exame de imagem como a ressonância magnética de encéfalo.
- d) Além do tratamento do quadro demencial, a retirada de maneira lenta do clonazepam, pode ajudar também no tratamento cognitivo.
- e) Se a paciente em questão, tiver ressonância magnética de encéfalo normal e líquido com proteína beta amiloide diminuída e proteína TAU

aumentada, devemos afastar doença de Alzheimer.

15- Idosa, 73 anos refere diarreia e vômitos há 12 horas por quadro viral, além disso confusão mental aguda associada. Nega febre. No exame físico mostra-se desidratada +2/4, hipotensão 90/60 e confusa. Exames laboratoriais mostraram hiponatremia, creatina e ureia elevadas. Diante desse quadro clínico é incorreto afirmar:

a) Como o idoso tem diminuição de aldosterona pelo próprio envelhecimento, teremos mais casos de hiponatremia e hipocalemia associada em situações de depleção.

- b) Devido a menor água corporal, menos sensação de sede, o paciente pode rapidamente desidratar e levar piora da função renal.
- c) O quadro de delirium foi devido a desidratação com elevação dos níveis de ureia e a hiponatremia.
- d) A diminuição da renina plasmática devido a senescência pode aumentar a incidência de hiponatremia.
- e) Além da creatinina nesse caso, deve-se monitorar o clearance de creatinina, pois esse é mais fidedigno para avaliar a função renal no idoso.

16- Paciente com 68 com doença de Parkinson diagnosticada há 7 anos, usando levodopa em doses fracionadas e pramipexole. Nos últimos 30 dias vem tendo movimentos coreiformes em segmento cefálico. Diante do caso clínico, qual seria esta alteração e melhor conduta para este doente?

- a) Piora do quadro de parkinsonismo e aumentar a dose da levodopa.
- b) Fenômeno wearing-off e aumentar dose de pramipexole.
- c) Discinesia e aumentar a dose da levodopa.

d) Agitação psicomotora e associar quetiapina.

e) Discinesia contínua e associar amantadina.

17- Analise as afirmativas sobre a Osteoporose.

- I. São fatores de risco para osteoporose a artrite reumatoide, uso crônico de corticoides e o tabagismo.
- II. Homens não entram na investigação para osteoporose, pois a incidência é bem menor do que nas mulheres.
- III. Os bifosfonatos tem como efeitos colaterais sintomas dispépticos, úlcera esofágica e osteonecrose de mandíbula.
- IV. O cálcio de melhor absorção no idoso e com poucos efeitos colaterais é o carbonato de cálcio.

Quais estão corretas?

- a) I e III
- b) I, II e III
- c) III e IV
- d) I, II e IV
- e) I e II

18- Sobre o escore isquêmico de Hachinski, assinale a alternativa correta.

a) Sua aplicação é recomendada na investigação de DV cortical.

- b) Deve ser utilizado na tentativa de diferenciar DV pura de demência mista.
- c) Quando apresenta pontuação superior a 4, indica maior probabilidade de etiologia neurodegenerativa.
- d) Não deve ser utilizado para estudo da contribuição vascular em um quadro demencial.
- e) Pode ser usada para aferir o grau de acometimento motor e cognitivo.

19- A desprescrição é uma ferramenta usada para evitar a polifarmácia, reduzindo dose de medicamentos e até interrompendo o consumo de medicamentos, aonde o potencial de dano é superior aos seus

benefícios. Sendo assim é incorreto afirmar:

- a) Os aminoglicosídeos é uma classe segura de antibióticos em idosos.
- b) Medicamentos como anticolinérgicos, benzodiazepínicos e antiinflamatórios devem ser evitados em pacientes idosos.
- c) O uso indevido e por tempo prolongado de AINH podem levar a insuficiência renal e descompensação de ICC.
- d) Retirar medicamentos prescritos por balconistas de farmácia, vizinhos ou familiares.
- e) A amiodarona pode levar a alterações da tireoide, como o hipotireoidismo.

20- J.S. é um homem de 75 anos portador de quadro demencial devido à doença de Alzheimer em fase moderada. Mora em sua residência com cuidadores 24 horas/dia. Apresenta continência urofecal e alimenta-se sozinho. Dormia bem até que há uma semana iniciou quadro de agitação, agressividade verbal e incontinência urinária. Mostra-se assustado, referindo presença de pessoas estranhas na residência. Houve uma tentativa de agressão física a uma das cuidadoras, fato até então nunca ocorrido. O paciente apresenta como comorbidades hipertensão arterial e diabetes melito (DM) do tipo 2. Está acima do peso e reluta em fazer atividade física. Ele utiliza os seguintes fármacos: donepezila, enalapril, hidroclorotiazida, metformina, amitriptilina. Médico avaliou o paciente em sua residência, com o exame físico normal. Diante do caso é verdadeiro afirmar:

- a) O paciente teve piora do quadro demencial, sendo necessário associar memantina para controle da agitação e melhora cognitiva.
- b) Deve ser medicado com antipsicótico como o haloperidol gotas e suspender amitriptilina devido ao seu efeito anticolinérgico.

- c) Pedir exames laboratoriais para afastar possível quadro infeccioso ou metabólico, suspender o tricíclico e medicar com quetiapina.
- d) Suspender a donepezila e pedir exames laboratoriais.
- e) Introduzir a trazodona para o quadro de agitação e associar memantina

PROVA 01 - TXX

21- Paciente José, 88 anos, chega ao pronto socorro acompanhado de seus familiares, é prontamente atendido pelo médico plantonista. A queixa principal da família é que nos últimos 3 dias o senhor José vem apresentando alterações de comportamento, não falando coisa com coisa, agitação psicomotora, passou a dormir mais durante o dia, ficar acordado à noite e com alucinações visuais. Após avaliar o senhor José, colher sua história clínica, solicitar os exames complementares o médico poderia propor o seguinte a conduta:

- a) Internar o paciente, pois o seu quadro clínico sugere fortemente um quadro de acidente vascular encefálico e iniciar o devido tratamento.
- b) Tranquilizar a família, pois os achados clínicos do seu José são muito comuns na sua idade, medicá-lo com um antipsicótico e encaminhá-lo para o ambulatório de geriatria.
- c) Tranquilizar a família, ressaltando que o senhor José apresenta um quadro clínico que sugere a patologia delirium, que essa patologia tem causas multifatoriais, que seria necessário aguardar o resultado dos exames solicitados para definir conduta.
- d) Internar o paciente, pois o seu quadro sugere fortemente um quadro de demência de Alzheimer na fase inicial.
- e) Fazer haloperidol endovenoso e encaminhar o paciente para tratamento ambulatorial, pois o paciente tem um quadro inicial de síndrome demencial,

com seguimento na neurologia ou geriatria.

22- Com relação à DV ocasionada por hipoperfusão, analise as alternativas a seguir e marque V (verdadeiro) ou F (falso).

- I. Na DV por hipoperfusão, há a ocorrência de eventos sistêmicos que afetam a hemodinâmica cerebral.
- II. Insuficiência cardíaca grave é exemplo de hipoperfusão aguda.
- III. A hipotensão postural crônica é um exemplo de hipoperfusão crônica.
- IV. Apesar de a DV por hipoperfusão ocorrer em áreas de penumbra entre regiões irrigadas por grandes artérias, tal condição não afeta a substância branca.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- a) V, V, F, V
- b) V, F, V, F
- c) F, V, F, V
- d) F, F, V, F
- e) V, V, V, F

23- Com relação ao diagnóstico diferencial de déficit cognitivo nas demências, correlacione a primeira e a segunda colunas.

- 1. DV cortical
- 2. DV subcortical
- 3. Doença de Alzheimer
- 4. Demência por Corpos de Lewy

() Curso gradual e progressivo com memória episódica muito acometida.

() Curso gradual e progressivo com flutuação da consciência.

() Curso em degraus com disfunção executiva.

() Curso gradual e progressivo com disfunção executiva, déficit de atenção e alteração da marcha.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- a) 2, 1, 4, 3
- b) 3, 4, 1, 2
- c) 1, 3, 2, 4

d) 4, 2, 3, 1

e) 4, 3, 1, 2

24- Sobre os critérios diagnósticos de Comprometimento Cognitivo Leve assinale a alternativa correta.

- a) A memória é, necessariamente, afetada em casos de CCL.
- b) As atividades instrumentais de vida diária nunca são afetadas no CCL.
- c) O diagnóstico de CCL está confirmado quando há qualquer comprometimento das avds.
- d) O desempenho nos testes cognitivos dos pacientes com CCL costuma ser muito comprometido.

e) O CCL não amnésico com um único domínio afetado pode envolver somente linguagem, função executiva ou habilidades visuoespaciais

25- Idosa de 76 anos vem ao consultório médico com obstipação crônica e delirium há 7 dias. Tem tremor em mão direita há 6 meses, que vem aumentando, associado a bradicinesia. Tem quadro depressivo com uso de escitalopram e recente prescrição de nortriptilina há 14 dias. Paciente tem diabetes mellitus com excelente controle, hipertensão arterial e labirintopatia.

- Medicamentos: metformina, enalapril, metoclopramida esporadicamente, cinarizina e nortriptilina.

- Exame Físico: tremor parkinsoniano em mão direita, roda dentada positiva, fácies de máscara.

- Exames laboratoriais normais.

- Descartado causa orgânica, e diante da anamnese referida, quais medicamentos poderiam levar a esses sinais e sintomas iatrogênicos?

- a) Metformina, nortriptilina e metoclopramida
- b) Metformina e cinarizina
- c) Cinarizina, metoclopramida e nortriptilina.

- d) Cinarizina e nortriptilina
- e) Enalapril e metformina.

26- Uma senhora de 72 anos de idade apresenta 2 anos de progressiva alteração da memória e dificuldade em AVDs, como compras e perda de objetos. Ela recebeu o diagnóstico de provável DA. Foi sugerido o uso de galantamina em doses crescentes até 24mg/dia. Depois de 5 meses, retorna com a filha reclamando que o tratamento não fez efeito, porque está “do mesmo jeito”. A informação é de que continua com as mesmas limitações e fazendo as mesmas atividades, isto é, cuidando da casa, fazendo compras em lugares muito próximos e indo à igreja aos domingos. O escore no MEEM caiu 1 ponto.

Considerando as informações apresentadas, pode-se concluir que

- a) O diagnóstico não é DA, por isso, o tratamento fracassou.
- b) O diagnóstico é DA, mas essa medicação não funcionou e precisa ser substituída por outro inibidor da acetilcolinesterase.
- c) A medicação não obteve uma resposta plena e deve ser adicionada memantina.
- d) A resposta a medicação está correta, dentro das expectativas do tratamento.
- e) Deve ser adicionar outro inibidor da acetilcolinesterase.

27- No passado, acreditava-se que, para o indivíduo ser classificado como portador de demência, ele deveria apresentar perda de memória. Hoje sabe-se que existem diversos tipos de demências com quadros clínicos iniciais distintos. Qual das alternativas a seguir é caracterizada pela abertura do quadro demencial com alucinações visuais, parkinsonismo e distúrbio do sono REM?

- a) Demência frontotemporal.
- b) Demência vascular.
- c) Demência por corpúsculos de Lewy.
- d) Hidrocefalia de pressão normal.
- e) Demência na Doença de Parkinson

28- A Demência Fronto-Temporal é uma doença degenerativa que afeta faixa etária mais jovens, entre 45 a 64 anos, sendo assim é correto dizer:

- a) Há inicialmente uma perda de memória seguida de alterações de comportamento, como impulsividade, hiperoralidade e risos inadequados.
- b) A sobrevida é maior do que na doença de Alzheimer.
- c) Alteração da personalidade como aparência desleixada, impaciência e irritabilidade, disputa argumentativa, comentários libidinosos e compulsões precedem o quadro de declínio da memória.
- d) Quadros alucinatorios e hipocondria são frequentes precedendo a perda de memória.
- e) Geralmente acomete indivíduos acima de 70 anos, sendo a 2ª causa de demência não Alzheimer.

29- Sra. Balbina, 75 anos, autônoma e independente, comparece à consulta ambulatorial de rotina sem queixas espontâneas. Ao exame, observa-se perda ponderal de 5kg no último ano que, segundo a paciente, foi involuntária. Quando questionada sobre o hábito intestinal, ela relata que tem ficado até quatro dias sem evacuar e que o uso de laxativos orais não modifica muito esse quadro. Descreve certo tenesmo. Revisando o prontuário, percebe-se que, há um ano, a Sra. Balbina possuía ritmo intestinal diário, sem esforço evacuatório. Com relação à conduta mais adequada para a paciente do caso clínico, assinale a alternativa correta.

- a) Trata-se, possivelmente, de quadro benigno, já que não há impacto significativo na funcionalidade e a paciente não apresenta queixa espontânea. Recomenda-se apenas acompanhamento.

- b) São indicados ajuste na dieta e uso regular e combinado de laxativos orais com diferentes mecanismos de ação.
- c) Deve-se realizar toque retal e solicitar pesquisa anual de sangue oculto nas fezes.

d) Deve-se solicitar colonoscopia, considerando a funcionalidade da paciente e a presença dos sinais de alerta.

- e) Prescrever fleet enema semanal para melhorar o funcionamento do intestino.

30- Paciente de 69 anos, sexo feminino, sobrepeso, está em tratamento por Transtorno Depressivo, com melhora do quadro melancólico com sertralina. Entretanto, vem tendo insônia, com sono entrecortado nas últimas semanas, com cochilos frequentes durante o dia. Qual seria a medicação de primeira escolha para esse paciente?

- a) Zolpidem
- b) Diazepam
- c) Amitriptilina
- d) Lorazepam
- e) Trazodona

31- Na Avaliação Geriátrica Ampla (AGA) temos várias ferramentas para avaliação do idoso de maneira correta, melhorando a precisão diagnóstica. Sendo assim é incorreto afirmar:

- a) O teste cronometrado de levantar e andar avalia a possibilidade de quedas e fragilidade, aonde um tempo maior que 20 segundos sugerem risco para quedas e fragilidade muscular.
- b) O Moca-Teste tem uma boa aplicabilidade em pacientes com bons níveis educacionais e é usado em pacientes com suspeita de CCL e demência.
- c) O 10-CS é usado para avaliar questões cognitivas em substituição ao Minimental.
- d) O SARC-F é usado para avaliar o risco de fraturas em pacientes idosos.

- e) O questionário de Yesavage avalia possível quadros depressivos, através de uma lista de perguntas.

32- No que se refere às manifestações clínicas da DP, analise as alternativas a seguir e marque V (verdadeiro) ou F (falso).

- I. Em indivíduos acometidos pela DP, o tremor de repouso ainda é o primeiro sintoma reconhecido pelo próprio paciente, por seus familiares e pelos médicos assistentes.
- II. A bradicinesia não é o principal sintoma cardinal na DP no idoso, e sim o tremor.
- III. A instabilidade postural em geral não ocorre nas formas iniciais e leves da DP.
- IV. Dermatite seborreica, hipotensão ortostática e alterações do sono REM podem fazer parte da patologia.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- a) V, V, F, F
- b) V, F, V, V
- c) F, V, F, V
- d) F, F, V, F
- e) V, F, F, V

33- Quanto à medicação considerada primeira opção no tratamento de pacientes com sintomas de Síndrome de Pernas Inquietas e exames a serem pedidos para investigação, assinale a alternativa correta.

- a) Pramipexol, ferro, ferritina, creatinina.
- b) Clonazepam, ferro e ferritina.
- c) Ciclobenzaprina, hb glicosilada, glicemia jejum.
- d) Duloxetine, ureia, creatinina, ferro.
- e) Clonazepam, b12 e ferro.

34- Idosa com 74 anos, chega ao consultório geriátrico com sua filha, que relata que sua mãe há 6 meses, esquece fatos recentes, repetitividade, esquece palavras que vai falar e desorientação espacial. Tem queimado vários alimentos. Tem transtorno depressivo maior há 5 anos,

diabetes mellitus e insônia em tratamento. Usa como medicações: Usa Losartana, escitalopram 10mg, clonazepam gotas (usa há 10 anos), metformina. Exame físico normal. 10 CS: 4, Teste com fluência verbal: 5. Diante do caso qual, assinale a resposta incorreta:

- a) Quadro característico de síndrome demencial, provável doença de Alzheimer, pois tem alterações de instrumentais de vida diária e testes cognitivos alterados.
- b) A paciente tem em questão fatores de risco para ter uma demência, como o diabetes mellitus, uso crônico de benzodiazepínico e depressão na terceira idade.
- c) Doença de Alzheimer fase inicial; onde pediremos exames laboratoriais como TSH, vdrl, fta-abs, b12 e exame de imagem como a ressonância magnética de encéfalo.
- d) Além do tratamento do quadro demencial, a retirada de maneira lenta do clonazepam, pode ajudar também no tratamento cognitivo.

e) Se a paciente em questão, tiver ressonância magnética de encéfalo normal e liquor com proteína beta amiloide diminuída e proteína TAU aumentada, devemos afastar doença de Alzheimer.

35- Idosa, 73 anos refere diarreia e vômitos há 12 horas por quadro viral, além disso confusão mental aguda associada. Nega febre. No exame físico mostra-se desidratada +2/4, hipotensão 90/60 e confusa. Exames laboratoriais mostrou hiponatremia, creatina e ureia elevadas. Diante desse quadro clínico é incorreto afirmar:

- a) Como o idoso tem diminuição de aldosterona pelo próprio envelhecimento, teremos mais casos de hiponatremia e hipocalemia associada em situações de depleção.

- b) Devido a menor água corporal, menos sensação de sede, o paciente pode rapidamente desidratar e levar piora da função renal.
- c) O quadro de delirium foi devido a desidratação com elevação dos níveis de ureia e a hiponatremia.
- d) A diminuição da renina plasmática devido a senescência pode aumentar a incidência de hiponatremia. Além da creatinina nesse caso, deve-se monitorar o clearance de creatinina, pois esse é mais fidedigno para avaliar a função renal no idoso.

36- Paciente com 68 com doença de Parkinson diagnosticada há 7 anos, usando levodopa em doses fracionadas e pramipexole. Nos últimos 30 dias vem tendo movimentos coreiformes em segmento cefálico. Diante do caso clínico, qual seria esta alteração e melhor conduta para este doente?

- a) Piora do quadro de parkinsonismo e aumentar a dose da levodopa.
- b) Fenômeno wearing-off e aumentar dose de pramipexole.
- c) Discinesia e aumentar a dose da levodopa.
- d) Agitação psicomotora e associar quetiapina.
- e) Discinesia contínua e associar amantadina.

37- Uma paciente idosa é trazida por seus filhos por quadro de alucinações visuais mais proeminente a noite, com insônia e agitação psicomotora há 4 dias. Qual seria o medicamento mais apropriado para o seu caso até ficarem prontos seus exames investigatórios?

- a) Clorpromazina
- b) Risperidona
- c) Lorazepam
- d) Trazodona
- e) Levomepromazina

38- Sobre o escore isquêmico de Hachinski, assinale a alternativa correta.

- a) Sua aplicação é recomendada na investigação de DV cortical.
- b) Deve ser utilizado na tentativa de diferenciar DV pura de demência mista.
- c) Quando apresenta pontuação superior a 4, indica maior probabilidade de etiologia neurodegenerativa.
- d) Não deve ser utilizado para estudo da contribuição vascular em um quadro demencial.
- e) Pode ser usada para aferir o grau de acometimento motor e cognitivo.

39- A desprescrição é uma ferramenta usada para evitar a polifarmácia, reduzindo dose de medicamentos e até interrompendo o consumo de medicamentos, aonde o potencial de dano é superior aos seus benefícios. Sendo assim é incorreto afirmar:

- a) Os aminoglicosídeos é uma classe segura de antibióticos em idosos.
- b) Medicamentos como anticolinérgicos, benzodiazepínicos e anti-inflamatórios devem ser evitados em pacientes idosos.
- c) O uso indevido e por tempo prolongado de AINH podem levar a insuficiência renal e descompensação de ICC.
- d) Retirar medicamentos prescritos por balconistas de farmácia, vizinhos ou familiares.
- e) A amiodarona pode levar a alterações da tireoide, como o hipotireoidismo.

40- J.S. é um homem de 75 anos portador de quadro demencial devido à doença de Alzheimer em fase moderada. Mora em sua residência com cuidadores 24 horas/dia. Apresenta continência urofecal e alimenta-se sozinho. Dormia bem até que há uma semana iniciou quadro de agitação, agressividade verbal e incontinência urinária. Mostra-se assustado, referindo presença de pessoas estranhas na residência. Houve uma

tentativa de agressão física a uma das cuidadoras, fato até então nunca ocorrido. O paciente apresenta como comorbidades hipertensão arterial e diabetes melito (DM) do tipo 2. Está acima do peso e reluta em fazer atividade física. Ele utiliza os seguintes fármacos: donepezila, enalapril, hidroclorotiazida, metformina, amitriptilina. Médico avaliou o paciente em sua residência, com o exame físico normal. Diante do caso é verdadeiro afirmar:

- a) O paciente teve piora do quadro demencial, sendo necessário associar memantina para controle da agitação e melhora cognitiva.
- b) Deve ser medicado com antipsicótico como o haloperidol gotas e suspender amitriptilina devido ao seu efeito anticolinérgico.
- c) Pedir exames laboratoriais para afastar possível quadro infeccioso ou metabólico, suspender o tricíclico e medicar com quetiapina.
- d) Suspender a donepezila e pedir exames laboratoriais.
- e) Introduzir a trazodona para o quadro de agitação e associar memantina

OUTRAS QUESTÕES

41- Com o envelhecimento temos um processo de perda de massa magra e aumento de massa gorda. Assim, é incorreto afirmar:

- a) Há uma maior perda de fibras do tipo I, de contração rápida
- b) A diminuição de massa muscular é chamada de sarcopenia.
- c) A sarcopenia pode levar a quedas no paciente idoso.
- d) O sistema muscular é o que mais sofre com o processo de envelhecimento. Músculo - rins - fígado
- e) O aumento do tecido gorduroso pode interferir no processo farmacodinâmico de certas drogas.

- 42- Em relação a senilidade, é possível considerar que:
- a) É caracterizada pela redução da homeostase do indivíduo idoso, levando à maior vulnerabilidade a eventos estressores
 - b) Diferente da Doença de Alzheimer, é caracterizada pela deterioração da cognição levando à perda funcional
 - c) É sinônimo de síndrome demencial, relacionada ao declínio cognitivo no idoso de idade muito avançada
 - d) Diferencia do envelhecimento fisiológico, é caracterizada por modificações determinadas por afecções que frequentemente acometem a pessoa idosa.
 - e) Resulta do somatório de alterações orgânicas, funcionais e psicológicas próprias do envelhecimento normal

- 43- Segundo a pato biologia do envelhecimento, várias teorias podem justificar a senescência. Analise as afirmativas abaixo:
- 1. O envelhecimento resulta da interferência genética na capacidade das células para se reproduzirem.
 - 2. O relógio biológico altera a secreção de hormônios, resultando em alterações nos tecidos.
 - 3. A função celular diminui, aumentando as chances de desenvolvimento de infecções e câncer.
 - 4. O encurtamento dos telômeros em células somáticas diminui a capacidade das células para se dividirem.
 - 5. Quanto maior a taxa metabólica basal (a taxa em que o corpo, em repouso, usa a energia), menor a expectativa de vida.
 - 6. Mutações em genes ocorrem com o envelhecimento, eventualmente fazendo com que as células parem de funcionar.
 - 7. A lesão tecidual é causada pelos radicais livres, como os radicais superóxido ou hidroxila.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a) São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
- b) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 7.
- c) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 6.
- d) São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4, 5 e 7.
- e) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

44- No exame físico do idoso, considera-se como senescência a presença de

- a) Tremor fino e rápido nas mãos.
- b) Quarta bulha na ausculta cardíaca.
- c) Nódulos nas interfalangianas distais.
- d) Hiper-reflexia de tendão patelar.
- e) Edema leve nos membros inferiores

45- Entre as alterações farmacocinéticas próprias do envelhecimento, assinale a alternativa que apresenta a modificação mais relevante para que os benzodiazepínicos permaneçam mais tempo no organismo quando ingeridos por idosos.

- a) Aumento da massa gordurosa
- b) Aumento da α_1 glicoproteína.
- c) Diminuição da água corporal.
- d) Diminuição da massa magra.
- e) Diminuição da albumina.

46- Quanto às teorias do envelhecimento, analise as seguintes assertivas:

- I. Teorias estocásticas do envelhecimento humano têm como base as teorias que postulam sobre os danos moleculares que ocorrem ao acaso.
- II. A teoria do dano oxidativo postula que todas as deficiências fisiológicas características relacionadas com a idade podem ser atribuídas aos danos intracelulares produzidos pelos radicais livres. E atribui ao emprego de vitaminas a prevenção e a correção de tais danos.

- III. A teoria da Taxa de Vida estabelece que a longevidade é inversamente proporcional à taxa metabólica.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e III.**
- e) Apenas II e III.

47- A marcha é dependente da capacidade de vários órgãos, especificamente dos sistemas neurológico, musculoesquelético e cardiovascular. O envelhecimento provoca alterações no padrão de marcha, sendo considerada como alteração fisiológica “normal” do envelhecimento (alteração eugérica) a marcha que apresente:

- a) aumento do período de apoio bipedal.**
- b) base de suporte alargada com postura fletida.
- c) redução dos passos com leve semiflexão dos braços.
- d) aumento dos passos com leve semiflexão dos braços.
- e) redução do período de apoio bipedal.

48- Com relação ao envelhecimento renal, é correto afirmar que ocorre:

- a) diminuição do limiar de excreção renal de glicose.
- b) aumento da concentração plasmática de aldosterona.
- c) aumento da capacidade tubular distal de reabsorver sódio.
- d) aumento da síntese de 1,25(OH)₂ vitamina D.
- e) diminuição da atividade da renina plasmática.**

49- A causa mais comum de perda auditiva neurosensorial no idoso é

- a) o uso de medicamento ototóxico.
- b) o neurinoma do acústico.
- c) a presbiacusia.**
- d) a impactação por cerume.

- e) a exposição à ruído.

50- Em relação às alterações que ocorrem no envelhecimento do aparelho digestivo, não faz parte do estômago senil:

- a) aumento do tempo de esvaziamento gástrico.
- b) aumento da capacidade proliferativa da mucosa.**
- c) diminuição da secreção basal de pepsina.
- d) diminuição das prostaglandinas na mucosa gástrica.
- e) diminuição da produção de fator intrínseco.

51- Um homem de 76 anos de idade, geralmente com boa saúde, começou a notar problemas há cinco meses os quais estão piorando. Apresenta dificuldade para levantar-se de poltronas baixas e dos vasos sanitários. O que mais provavelmente apresenta esse paciente?

- a) Fraqueza muscular proximal.**
- b) Disautonomia.
- c) Disdiadococinesia.
- d) Fraqueza muscular distal.
- e) Apraxia de marcha.

52- Sobre o processo de senescência, que são as mudanças fisiológicas que ocorrem no transcorrer da vida, é correto afirmar:

- a) Há um aumento de massa magra e diminuição da massa adiposa
- b) Os órgãos que mais sofrem perda ponderal são o pâncreas, fígado e rins
- c) Há uma diminuição de condrócitos na cartilagem articular**
- d) Diminuição do paladar para alimentos doces - salgado
- e) Diminuição da função sistólica no repouso

53- Devemos ficar atentos as principais alterações farmacológicas e farmacodinâmicas das drogas do Idoso,

pois com isso evitaremos possíveis iatrogenias, sendo com isso correto dizer:

- a) No geronte temos maior intoxicação por drogas hidrofílicas, como o fenobarbital.
- b) Temos um prejuízo na absorção de certos medicamentos no idoso devido a sua hipocloridria (diminuição de ácido clorídrico), sendo um dos exemplos o ferro e salicilato.
- c) A digoxina é um dos medicamentos que não sofre alteração na absorção devido ao Ph mais alto no geronte. (intoxicação)
- d) Tanto o processo de oxidação como conjugação hepática estão reduzidos no paciente idoso.
- e) A creatinina é fidedigna na avaliação renal do idoso. (clearance é o usado).

54- Qual o grupo de medicamentos que não causa hipotensão ortostática e tonturas no idoso?

- a) Antidepressivos tricíclicos.
- b) Antidepressivos inibidores da recaptação da serotonina.
- c) Diuréticos tiazídicos.
- d) Bloqueadores dos canais de cálcio derivados da diidropiridina.
- e) Nitratos.

55- Entre os inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS) listados a seguir, aquele que deve ser evitado em idosos devido à sua meia vida longa e pelo seu maior potencial causador de efeitos adversos, como hiponatremia, é:

- a) Citalopram
- b) Escitalopram
- c) Sertralina
- d) paroxetina
- e) fluoxetina

56- Em idosos, é fundamental prevenir a iatrogenia, uma vez que, nessa faixa etária, há uma vulnerabilidade aumentada quanto às reações adversas às drogas e a determinadas situações. Nessa fase da vida, é comum a

a) iatrofarmacogenia, decorrente de polifarmácia, da interação medicamentosa e do desconhecimento das alterações farmacocinéticas associadas ao envelhecimento.

- b) iatrogenia do silêncio, associada ao desconhecimento de técnicas de comunicação de más notícias.
- c) iatrogenia da palavra, que decorre da dificuldade de ouvir adequadamente o paciente e sua família.
- d) iatrogenia do excesso de intervenções reabilitadoras na qual o déficit de "equipe interdisciplinar" pode trazer consequências desfavoráveis ao paciente.

57- Quase todas as classes de drogas têm o potencial de causar delirium em pacientes idosos, mas drogas específicas têm sido mais comumente implicadas. Assinale qual droga está mais corretamente indicada para diminuir esse efeito indesejado em idosos.

- a) Diazepam
- b) Ranitidina
- c) Meperidina
- d) Lorazepam
- e) Flurazepam

58- Quanto aos fatores que resultam em alterações na farmacocinética e farmacodinâmica das drogas na pessoa idosa, observe as assertivas a seguir:

- I. A pessoa idosa apresenta um aumento na proporção de gordura em relação ao peso corporal, promovendo uma diminuição no tempo total de eliminação de drogas lipossolúveis.
- II. A diminuição de proteínas plasmáticas, como a albumina, leva a um aumento da fração livre das drogas.
- III. A diminuição da água corporal no envelhecimento promove um menor nível sérico da droga hidrofílica.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.

- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.
- e) Apenas II e III.

59- Qual dos anti-inflamatórios abaixo é considerado impróprio para idosos por causar efeitos adversos sobre o sistema nervoso central?

- a) Ibuprofeno
- b) Nimesulide
- c) Ácido acetilsalicílico
- d) Indometacina**
- e) Diclofenaco

60- Devemos ficar atentos as principais alterações farmacológicas e farmacodinâmicas das drogas do idoso, pois com isso evitaremos possíveis iatrogenias, sendo com isso correto dizer:

- a) No geronte temos maior intoxicação por drogas hidrofílicas, como fenobarbital
- b) Devido a diminuição de albumina, devemos ter cuidado em administrar drogas como anti-inflamatório, salicatos e fenobarbital, pelo maior risco de intoxicação
- c) Maior sensibilidade a opiáceos e medicações anestésicas**
- d) O processo de conjugação está alterado, no metabolismo hepático
- e) Maior resposta aos agonistas beta-adrenérgicos

61- Qual o grupo de medicamentos que não causa hipotensão em idosos?

- a) Diuréticos tiazídicos
- b) Antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina**
- c) Nitratos
- d) Bloqueadores dos canais de cálcio derivados da dihidropiridina

62- A avaliação geriátrica é dificultada por diversas questões, como sintomas indefinidos, múltiplas queixas e dificuldade de comunicação, entre outros.

Uma avaliação geriátrica de qualidade requer que o médico geriatra

- a) Adote perspectivas de avaliação semelhantes às usadas na avaliação de adultos em geral.
- b) Evite a repetição de informações para não confundir o idoso.
- c) Focalize no sintoma relatado pelo paciente, evitando contextualizações.
- d) Utilize medicação específica para cada problema detectado.
- e) Domine o conhecimento relativo aos problemas exclusivos dos idosos.**

63- Um número significativo de idosos é vítima de síndromes semelhantes, independentemente de doenças específicas, denominadas os 5 "Is" ou gigantes da geriatria. Descritas inicialmente por Isaac, os 5 "Is" foram acrescidos de duas novas síndromes que atuam diretamente na saúde do idoso, totalizando, agora, os 7 "Is" da geriatria. As duas novas entidades são:

- a) incapacidade comunicativa e iatrogenia.
- b) incapacidade comunicativa e insuficiência familiar.**
- c) insuficiência familiar e imobilidade.
- d) iatrogenia e imobilidade.

64- No estudo da geriatria, são considerados os gigantes da geriatria ou grandes "I". Essas situações devem obrigatoriamente ser pesquisadas na abordagem geriátrica. Quais das situações clínicas correspondem a dois desses grandes "I"?

- a) Imobilidade e incompetência istmo-cervical
- b) Insuficiência cardíaca e iatrogenia
- c) Insuficiência renal e insuficiência cerebral
- d) Incontinência fecal e infarto do miocárdio
- e) Incontinência urinária e instabilidade postural**

65- O teste recomendado pelo Ministério da Saúde, a ser aplicado pela Atenção Básica, para avaliação do desempenho do

idoso na realização das atividades básicas de vida diária é:

- a) escala de Barthel
- b) escala de Katz**
- c) MiniCog
- d) minixame do estado mental
- e) escala de Lawton

66- O Minixame do Estado Mental é um dos testes mais utilizados no mundo para avaliação de pacientes com queixa de esquecimento. Uma grande vantagem da aplicação desse teste nos pacientes com declínio cognitivo é:

- a) Fecha o diagnóstico de Alzheimer, sem a necessidade de outros testes
- b) Permite a avaliação do insight, que não é avaliado em outros testes
- c) Não sofre interferência da escolaridade
- d) Permite o acompanhamento evolutivo do quadro cognitivo**
- e) Permite a diferenciação da doença de Alzheimer para demência fronto temporal

67- A avaliação da cognição do paciente idoso é muito importante no contato com o doente geriátrico, com isso é incorreto dizer:

- a) Um Teste de Mini-Mental menor que 25 para pacientes analfabetos é sugestivo para Demência**
- b) O Teste do Relógio avalia habilidades visuoespaciais, sofrendo alteração com a escolaridade.
- c) O Teste de Fluência Verbal se baseia em pedir ao paciente um número máximo de palavras, como animais, que possa lembrar em 1 minuto.
- d) O Teste de Memória com Figuras avalia entre outras coisas a memória tardia e imediata.
- e) O Teste de Palavras do Cerad, avalia através de uma lista de palavras a memória verbal de longo prazo.

68- Paciente de 82 anos, chega ao ambulatório para sua primeira consulta.

Suas queixas são diminuição de memória recente, tristeza, melancolia e quedas frequentes. Diante disso, quais seriam os testes a serem feitos conforme a suas queixas:

- a) Mini-mental, Cartilha de Snellen e Teste Cronometrado de Levantar e Andar.
- b) Mini-Mental, Escala de Yesavage e Teste Cronometrado de Levantar e Andar.**
- c) Escala de Yesavage, Teste do relógio e Fluência verbal.
- d) Teste do Relógio, Escala de Yesavage e Cartilha de Snellene. Fluência verbal e. Teste de Romberg.

69- Mulher, 72 anos, com escolaridade equivalente ao ensino fundamental, é avaliada pelo minixame do estado mental com pontuação de 23. Qual a interpretação deste resultado e a conduta correta, respectivamente?

- a) Sugere perda cognitiva. Dosar vitamina D.
- b) Sugere perda cognitiva. Dosar hormônio estimulante da tireoide.**
- c) Afasta perda cognitiva. Dosar vitamina B12.
- d) Afasta perda cognitiva. Tomografia de crânio.
- e) O minixame do estado mental não determina avaliação cognitiva.

70- Um paciente com 74 anos chega ao pronto atendimento com febre, confusão mental, agitação e taquicardia. O quadro clínico é compatível com:

1. alucinação.
2. demência.
3. delirium.
4. pneumonia aguda.

Estão corretos os itens:

- a) 1 e 2 apenas.
- b) 2 e 3 apenas.
- c) 1, 3 e 4 apenas.
- d) 1 e 2 apenas.
- e) 1, 2, 3 e 4**

71- Paciente de 87 anos procura emergência com quadro de desorientação de início agudo, estando sonolento, com dificuldade de focar atenção, com sintomas que flutuam ao longo do dia, passando a não reconhecer familiares. A família nega alterações de memória previamente e informam que o idoso era independente para atividades instrumentais de vida diária. Ao exame físico paciente apresentava PA: 160x90mmHg; FC: 108 bpm; FR: 15 irpm; TAX: 37,9 °C; ACV: RCR em 2 T; pulmões limpos, abdome sem alterações. Exame neurológico sem sinais focais. Laboratório com leucocitose e desvio para esquerda. A conduta mais correta a ser seguida pelo médico da emergência é:

- a) realização de ressonância magnética de crânio para melhor investigação da desorientação de início súbito.
- b) a realização de punção lombar é mandatória para investigação deste caso, visto que há desorientação aguda e estado febril.
- c) prescrever haloperidol endovenoso para tratamento do e prosseguir investigação do fator desencadeante.
- d) incluir paciente no protocolo de AVC e avaliar realização de trombólise.
- e) seguir investigação de causa clínica desencadeante de hipotivo

72- Na avaliação da capacidade funcional do idoso, são consideradas atividades instrumentais de vida diária:

- a) fazer compras, vestir-se, realizar serviços domésticos.
- b) usar telefone, cuidar das finanças e preparar refeições.
- c) tomar medicamentos, cuidar do jardim e tomar banho.
- d) dirigir carro, realizar higiene pessoal e lavar roupa.
- e) escovar os dentes, alimentar-se, cortar as unhas.

73- O teste do levantar e caminhar cronometrado (Timed Up and Go) identifica idoso com alto risco para quedas, quando o tempo para execução do teste for superior a:

- a) 10 segundos.
- b) 12 segundos.
- c) 15 segundos.
- d) 18 segundos.
- e) 20 segundos.

74- Quais desses abaixo fazem parte dos critérios que levam ao diagnóstico de fragilidade no idoso:

- a) Emagrecimento de 10kg ou mais nos últimos 12 meses.
- b) Quedas frequentes e fadiga referida.
- c) Tonturas, quedas e lentificação da marcha.
- d) Força de preensão palmar diminuída e diminuição da testosterona.
- e) Emagrecimento, exaustão física e lentificação da marcha.

75- No Comprometimento Cognitivo leve é falso afirmar:

- a) É considerado em alguns casos como uma fase pré-demencial.
- b) Existe sempre tratamento para a doença, onde usamos um anticolinesterásico.
- c) Uma das características primordiais é a não mudança das atividades de vida diária.
- d) A presença de baixa proteína beta-amiloide e aumento de proteína tau nesses pacientes, coloca os mesmos em risco para Doença de Alzheimer.
- e) O CCL amnésico pode evoluir para Doença de Alzheimer.

76- Sra. H.E. 66 anos, chega ao consultório geriátrico com sua filha, que relata que sua mãe há 9 meses, esquece fatos recentes, como dar recados, esquece onde guarda objetos, esquece palavras que vai falar e piora nos últimos 3 meses. Nega desorientação temporo-espacial.

Nega alterações importantes das atividades de vida diária como ir ao banco ou fazer trabalhos domésticos. Relata que sua mãe estudou até 8ª série. Usa como medicações: Usa um AAS infantil, Metformina 850mg/dia, Sinvastatina 20mg/dia. Exame físico normal. Mini-mental de 25. Relógio: normal. Teste de Fluência Verbal lembrou 14 animais. Exames laboratoriais todos normais, exceto glicemia de jejum 221 e hb glicada de 8,0. Ressonância Magnética de Encéfalo: normal. Assim, podemos afirmar:

- a) É uma Demência de Alzheimer, onde devemos aumentar a dose da Metformina para melhor controle glicêmico, pois o Diabetes é fator de piora cognitiva.
- b) É um quadro de Demência Reversível por medicamentos, devido ao uso da sinvastatina.
- c) A queixa de memória relatada é próprio do envelhecimento, onde deve enfatizar o controle alimentar e exercícios diários sem mexer na dose da metformina.
- d) É um Comprometimento Cognitivo Leve de Múltiplos Domínios, onde devemos aumentar a dose da metformina para melhor controle glicêmico, pois Diabetes Mellitus é um fator de piora da cognição.
- e) É um Comprometimento Cognitivo Leve do tipo Amnésico, onde devemos aumentar a dose da metformina para melhor controle glicêmico, pois o Diabetes Mellitus é um fator de piora da cognição.

77- Na investigação da incapacidade cognitiva, a realização de, pelo menos, um exame de neuroimagem é importante porque:

- a) A presença de redução volumétrica do hipocampo é critério para o diagnóstico de Doença de Alzheimer pelo DSM-5
- b) A presença de atrofia do córtex pré-frontal sugere a doença de Creutzfeldt-Jakob

c) Serve para afastar diagnósticos diferenciais na demência, como hematoma subdural crônico e neoplasias intracerebrais

- d) A presença de gliose microangiopática sugere o diagnóstico de Alzheimer
- e) É possível verificar sinal do pinguim ou do beija-flor na ressonância magnética, na demência dos corpúsculos de Lewy.

78- Paciente de 67 anos de idade, com escolaridade > 7 anos, apresenta queixa de esquecimento. A avaliação neuropsicológica mostra prejuízo da memória, funções gnósticas e linguagem, abaixo do esperado para sua escolaridade. O paciente mantém sua capacidade funcional intacta para atividades básicas e instrumentais de vida diária. Este paciente apresenta critérios diagnósticos de:

- a) Transtorno neurocognitivo leve
- b) Transtorno neurocognitivo maior do tipo Alzheimer
- c) Transtorno neurocognitivo maior do tipo FrontoTemporal
- d) Depressão
- e) Transtorno de ansiedade generalizada

79- Sobre os critérios para o diagnóstico de Comprometimento Cognitivo Leve (Petersen et al, 1997), analise as afirmativas abaixo, assinalando V, se verdadeiro, ou F, se falso.

- () Presença de déficit de memória comparado com idosos normais.
- () Funcionamento emocional e intelectual com transtornos leves.
- () Ausência de dificuldades com atividades de vida diária básicas e instrumentais.
- () Funcionamento intelectual geral normal.
- () Apresenta-se com baixo risco de desenvolver demência.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) V – V – V – F – V.
- b) F – V – F – V – F.

c) V – F – V – V – F.

d) F – F – V – F – V.

e) V – V – F – F – V.

80- Uma variedade de distúrbios metabólicos pode contribuir para o delírio, exceto:

a) Hipocalcemia.

b) Hipercalcemia.

c) Hipernatremia.

d) Hiponatremia.

e) Distúrbio ácido-base.

81- Mudança aguda do estado mental com flutuação do nível de consciência, além de dificuldade em manter atenção, pensamento desorganizado e alucinações são características de idoso que apresenta

a) Demência.

b) Esquizofrenia.

c) Depressão.

d) Delirium.

e) Parafrenia.

82- Delirium é uma síndrome cerebral orgânica sem etiologia específica, que aumenta a mortalidade e apresenta alta prevalência em unidade de urgência. O quadro clínico do delirium é composto por

a) início insidioso, curso flutuante, orientação seletivamente prejudicada, linguagem incoerente.

b) curso flutuante, início súbito, redução do nível de consciência, prejuízos da cognição e orientação, linguagem incoerente.

c) ausência de ideias delirantes, curso flutuante, início insidioso, linguagem clara, prejuízo global da orientação.

d) prejuízo da cognição e da orientação, curso sem flutuação, linguagem prejudicada por dificuldade em encontrar palavras e perseveração, início insidioso.

e) curso nas 24 horas sem flutuação, início súbito, orientação seletivamente prejudicada, linguagem incoerente.

83- A conduta mais adequada para paciente idosa internada com diagnóstico de delirium hiperativo secundário à infecção urinária, além da terapia antimicrobiana, é a prescrição de

a) anticonvulsivante.

b) antipsicótico.

c) benzodiazepínico.

d) antidepressivo atípico.

e) anticolinesterásico.

84- No quadro de delirium no idoso, qual seriam as drogas efetivas no tratamento agudo do paciente?

a) Haloperidol e Quetiapina

b) Clonazepam e Olanzapina

c) Clonazepam e Olanzapina

d) Clorpromazina e Trazodona

85- A Sra. M. T. G., 83 anos, é trazido ao PS com quadro de há 2 dias, desorientação no tempo e espaço, agressividade, ilusões que a família a estar prendendo em uma cadeia e alteração do ciclo sono-vigília. Diante do caso, qual seria o diagnóstico e que exames poderiam ser pedidos para melhor avaliação diagnósticas.

a) Demência de Alzheimer e Parcial de urina, urocultura, TGO e TGP

b) Delirium e TSH, sódio, potássio, hemograma e cálcio

c) Delirium e vitamina D, PTH, fosfatase alcalina

d) Demência de Alzheimer e hemograma, ácido fólico e microalbuminúria isolada

e) Demência de Alzheimer e ureia, creatinina, sódio, potássio, VDRL, FTAabs, glicemia jejum

86- Paciente de 89 anos, pós-operatório imediato de artroplastia total de quadril. A prescrição continha analgesia com dipirona somente quando necessário, protetor gástrico e profilaxia para trombose venosa profunda com enoxaparina subcutânea. Encontrava-se hipertenso, sonolento, flutuando nível de

consciência, com CAM (Confusion Assessment Method) positivo. Diante do quadro clínico, qual a conduta mais correta a ser seguida?

- a) Iniciar haloperidol 0,5 a 1mg IM.
- b) Iniciar quetiapina 12,5 a 25 mg 2x dia VO.
- c) Tentar medidas visando corrigir causas de delirium como analgesia adequada, estado de hidratação, necessidade de manter cateteres e medidas não farmacológicas de tratamento.
- d) Transferir paciente para unidade intensiva visando estabilização do quadro clínico.
- e) Realizar RNM de crânio e eletroencefalograma para complementação diagnóstica.

87- Assinale a alternativa que apresenta causas de demência potencialmente reversível.

- a) Doença de Parkinson e hipotireoidismo.
- b) Deficiência de vitamina B12 e doença de Pick.
- c) Hidrocefalia de pressão normal e doença de Wilson.
- d) Hematoma subdural crônico e doença de Lewy.
- e) Neuro sífilis e acidente vascular encefálico

88- Assinale a alternativa que NÃO constitui uma indicação de realização do exame do líquido Cefalorraquidiano em pacientes com demência.

- a) Pacientes com história familiar positiva e com alto risco de desenvolver demência
- b) Idade inferior a 65 anos
- c) Demência com apresentação atípica
- d) Hidrocefalia comunicante
- e) Suspeita de doença infecciosa ou inflamatória do SNC

89- Sobre a avaliação inicial da demência, considere as seguintes afirmativas:

- 1. A história é de pouca importância, porque o doente não sabe informar.

- 2. A suspensão do uso de medicamentos deve ser levada em conta.
- 3. Exames laboratoriais, como hemograma, TSH, creatinina, sódio e potássio são pouco elucidativos, por serem muito gerais.
- 4. A tomografia computadorizada é fundamental para investigar processos expansivos.
- 5. Aplicar testes breves é prático, pois não cansam o doente e por isso não há risco de falso negativo.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 1, 3 e 5 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 3, 4 e 5 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2 e 5 são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.

90- No diagnóstico diferencial entre o declínio cognitivo apresentado pelo idoso com depressão e o declínio cognitivo apresentado pelo idoso com demência, assinale a alternativa que contém a característica clínica que sugere o diagnóstico de demência.

- a) Data do início dos sintomas identificada com precisão.
- b) Queixa da perda cognitiva enfatizada pelo paciente.
- c) Deterioração precoce da capacidade para atividades sociais.
- d) Presença do sinal do “virar a cabeça” durante a anamnese.
- e) Pouco esforço para executar tarefas solicitadas.

91- Idosa de 82 anos, professora aposentada, procura atendimento ambulatorial de geriatria. Filha informa que a mãe vem apresentando “lapsos” de memória (esquece onde guarda objetos e já

esqueceu a panela no fogo). Apesar das queixas da acompanhante, a paciente reside sozinha, joga cartas com as amigas. Na avaliação geriátrica inicial apresentou MEEM (Miniexame do Estado Mental) de 25, teste do relógio normal, escala de atividades instrumentais de vida diária (Lawton) de 20. Laboratório: hemograma normal; TSH: 2,0; ácido fólico, vitamina B12 e eletrólitos dentro dos valores de referência. A tomografia de crânio mostra atrofia do lobo temporal. O exame físico foi sem alterações, Qual melhor conduta a ser iniciada?

- a) Solicitar tomografia computadorizada por emissão de fóton único (SPECT) para complementação da investigação de demência.
- b) Iniciar terapia com anticolinesterásico isoladamente.
- c) Iniciar terapia com anticolinesterásico e memantina.
- d) Iniciar terapia com memantina isoladamente.
- e) Acompanhar ambulatorialmente e ponderar a solicitação de testagem neuropsicológica.

92- Paciente de 60 anos chega ao ambulatório de geriatria trazido por sua filha. Ela relata que há 1 ano notou que o pai apresentava dificuldades para manejar suas finanças e já não conseguia trabalhar. Havia ainda dificuldade em se comunicar, pois “não achava as palavras” e notava frequentes parafasias fonêmicas. O comportamento tornou-se, por vezes, inapropriado e realizava inúmeros gestos e movimentos sem qualquer propósito. Tornou-se totalmente dependente para atividades básicas de vida diária. Ao exame físico, notava-se além do déficit cognitivo evidente (MEEM: 0), rigidez para tônica e mioclonias. Pensando na principal hipótese diagnóstica para o quadro, o exame solicitado e seu resultado provável, assinale a opção correta.

- a) Eletroencefalograma com padrão deprimido difuso, sem paroxismos.
- b) RNM de encéfalo com imagem lacunar subinsular bilateral.
- c) Líquor com elevação da proteína 14-3-3.
- d) Dosagem de anti-Hu elevada no soro.
- e) PET scan com hipocaptção parietal.

93- Sr. Cláudio, 69 anos, é trazido pela filha que refere há 3 meses, episódios de diminuição de memória recente, alucinações visuais como ratos passando pela sala, quedas frequentes e no exame físico apresentava um Parkinsonismo com rigidez de membros e bradicinesia, sem tremores. Essas alterações motoras apareceram há 6 meses. Familiar relata que paciente apresenta flutuações no nível de consciência, dando exemplo; que em alguns dias ele está meio alerta e atento, e que alguns dias depois está desatento. Podemos pensar em:

- a) Demência Frontotemporal
- b) Demência de Corpos de Lewy
- c) Demência Vascular
- d) Doença de Alzheimer
- e) Doença de Parkinson

94- Filho traz pai de 76 anos para consulta de retorno ao geriatra e relata que o paciente não melhorou da sintomatologia, mantendo quadro de rigidez muscular e movimentos lentos. Segundo o filho, o idoso diz que é chamado por uma senhora todo dia, pela manhã, para ir ao mercado, porém ele, o filho diz não ouvir nada. A tentativa de uso de risperidona 1 mg ao dia não melhorou o quadro e o paciente passou a cair, motivo pelo qual suspendeu o medicamento após 2 semanas de uso. O diagnóstico é demência

- a) Por corpos de Lewy.
- b) Tipo Alzheimer.
- c) Micro angiopática.
- d) Reversível.

95- Paciente de 83 anos, encaminhada para centro multidisciplinar de reabilitação cognitiva com história de, há 5 anos, ter iniciado com quadro de confusão mental, declínio cognitivo, alucinações visuais (via objetos inexistentes, pessoas no quarto...) e depressão de difícil controle. Além disso, apresentava também alterações de marcha e rigidez simétrica axial. Teve uma progressão rápida da doença, sendo, atualmente, totalmente dependente para atividades básicas da vida diária. A família informa piora dos sintomas com o uso de haloperidol. Qual o diagnóstico mais provável?

- a) Demência associada à doença de Parkinson
- b) Degeneração lobar fronto temporal
- c) Demência de Alzheimer
- d) Demência de corpos de Lewy.
- e) Paralisia supra nuclear progressiva

96- Mulher branca de 64 anos de idade, viúva, é levada ao geriatra pela sua cuidadora, que é enfermeira, por estar apresentando déficits na função executiva, na solução de problemas, no desempenho audiovisual e na fluência verbal, porém mantém memória preservada. Relata flutuações dos déficits, algumas vezes de minutos ou horas, com alucinações visuais detalhadas e sintomas parkinsonianos. Qual é o provável diagnóstico clínico e qual é a medicação utilizada nesse quadro que desencadeia piora dos sintomas comportamentais?

- a) Demência por Corpúsculos de Lewy; Neurolépticos.
- b) Demência da doença de Parkinson; Analgésicos.
- c) Doença de Creutzfeld-Jakob; Anticonvulsivantes.
- d) Demência vascular; Inibidores da receptação da serotonina.
- e) Hidrocefalia de pressão normal; Antagonista seletivo das monoaminas cerebrais.

97- A Demência por Corpúsculos de Lewy (DCL), que acomete cerca de 20% dos pacientes com síndrome demencial, tem o diagnóstico clínico quando ocorre(m)

- a) alucinações (especialmente visuais), menor sensibilidade aos antipsicóticos convencionais, declínio cognitivo progressivo, quedas frequentes, sinais extrapiramidais espontâneos, períodos de confusão.

- b) demência de, pelo menos, 02 (dois) anos com declínio cognitivo progressivo, períodos de confusão, quedas frequentes, sinais extrapiramidais espontâneos, alucinações (especialmente visuais), menor sensibilidade aos antipsicóticos convencionais.

c) demência de, pelo menos, 06 (seis) meses de duração com declínio cognitivo flutuante, períodos de confusão, quedas frequentes, maior sensibilidade aos antipsicóticos convencionais, sinais extrapiramidais espontâneos, alucinações (especialmente visuais).

- d) sinais extrapiramidais espontâneos, menor sensibilidade aos antipsicóticos convencionais, demência de, pelo menos, 02 (dois) anos com declínio cognitivo progressivo, quedas frequentes, períodos de confusão.
- e) quedas frequentes, demência de, pelo menos, 02 (dois) anos com declínio cognitivo progressivo, menor sensibilidade aos antipsicóticos convencionais, períodos de confusão, alucinações (especialmente visuais).

98- A doença cujos critérios diagnósticos incluem o declínio cognitivo progressivo suficiente para interferir nas atividades de vida diária, quadro de parkinsonismo espontâneo, flutuação da cognição e alucinações visuais recorrentes é:

- a) Delirium
- b) Parafrenia tardia
- c) Demência por mal de Parkinson

- d) Doença de Alzheimer
- e) Demência dos corpúsculos de Lewy

99- L.A.O de 69 anos é trazido ao consultório com queixas de memória recente diminuída há 6 meses, com agnosia, apraxia, diminuição da atenção, agitação psicomotora, principalmente no período noturno. Diante do quadro clínico, poderemos afirmar:

- a) É um quadro de possível Demência de Alzheimer, com manifestações da Síndrome de Godot. Confirmado o diagnóstico entraremos com antidepressivos para tratar a doença e associar Memantina.
- b) O paciente apresenta Comprometimento Cognitivo Leve e necessita de investigação com exames laboratoriais e Ressonância Magnética, para excluir Demência.
- c) Quadro de Doença de Alzheimer, sem necessidade de pedir exames de imagem, somente os laboratoriais.
- d) Possível Doença de Alzheimer, com Síndrome do Sol Poente, onde após os exames confirmatórios e testes de cognitivos, entraremos com anticolinesterásicos como a Donepezila.
- e) Possível Doença de Alzheimer, com delírios da Síndrome de Capgras, onde pediremos dosagem líquórica de proteína beta-amiloide e proteína tau.

100- Paciente de 85 anos de idade, portadora de demência na doença de Alzheimer em estágio moderado, em tratamento com rivastigmina 4,5 mg duas vezes ao dia; iniciou há 3 dias piora da cognição com quadro de flutuação do nível de consciência, alternância do ciclo sono-vigília e agitação noturna com períodos de alucinações visuais, gritos, piora da atenção e agitação motora. A melhor conduta diante desse quadro recente é:

- a) Prescrever haloperidol 5 mg 2 x dia e prometazina 25 mg à noite

- b) Aumentar a rivastigmina e prescrever memantina

c) Pesquisar e tratar a causa do delirium (quadro de delirium)

- d) Tratar a agitação com clonazepam 2,5 mg/ml - 5 gotas à noite
- e) Pesquisar a causa e conter ao leito para prevenção de quedas 25.

101- Mulher, 75 anos, portadora de demência tipo Alzheimer em uso de donepezila 5 mg, diabética em uso de insulina NPH e vildagliptina 100 mg/dia, cardiopata em uso de carvedilol 12,5 mg/dia e hipertensa em uso de losartana 100 mg/dia, é admitida com icterícia e colúria. USG abdominal mostra aumento do volume hepático sem dilatação de vias biliares e com presença de ascite. A conduta imediata é a suspensão de

- a) Losartana.
- b) Carvedilol.
- c) Vildagliptina.
- d) Donepezila.

102- Em relação aos sintomas psicológicos e comportamentais das demências, qual o distúrbio de comportamento mais comum da Demência de Alzheimer?

- a) Depressão
- b) Perambulação
- c) Agitação
- d) Apatia
- e) Delírios

103- Os critérios para o diagnóstico clínico de provável Doença de Alzheimer incluem:

- I. Demência estabelecida pelo exame clínico por testes como o Miniexame do Estado Mental, escala de Blessed ou similares, confirmada por testes neuropsicológicos.
- II. Déficit em duas ou mais áreas da cognição.

- III. Piora progressiva da memória e outras funções cognitivas.
 - IV. Ausência de distúrbio da consciência.
 - V. Início entre os 40 e 90 anos, em geral após os 65 anos.
 - VI. Ausência de doenças sistêmicas ou cerebrais que por si possam explicar os déficits progressivos da memória e cognição.
- a) Apenas I, III e VI estão corretas.
 - b) Apenas II, IV, V e VI estão corretas.
 - c) Apenas II, IV e V estão corretas.
 - d) Todas estão corretas.**
 - e) Apenas I, II e IV estão corretas.

- 104- A Doença de Alzheimer (DA) é um transtorno neurodegenerativo, progressivo e fatal que se manifesta por deterioração cognitiva e da memória, comprometimento progressivo das atividades de vida diária e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais. Assinale a alternativa INCORRETA acerca da DA.
- a) Os fatores de risco bem estabelecidos para DA são idade e história familiar da doença (o risco aumenta com o número crescente de familiares de primeiro grau afetados).
 - b) O diagnóstico da DA é de exclusão. O rastreamento inicial deve incluir avaliação de depressão e exames de laboratório com ênfase especial na função da tireoide e níveis séricos de vitamina B12.
 - c) O objetivo do tratamento medicamentoso é propiciar a estabilização do comprometimento cognitivo, do comportamento e da realização das atividades da vida diária (ou modificar as manifestações da doença), com um mínimo de efeito adverso.

d) O diagnóstico definitivo de DA só pode ser realizado por necropsia (ou biópsia) com identificação do número apropriado de placas e enovelados em regiões específicas do cérebro, na presença de história clínica consistente com

demência. Assim, a biópsia é fundamental para o diagnóstico.

- 105- Os antagonistas de receptores NMDA são usados no tratamento da Doença de Alzheimer e tem como principais efeitos colaterais:

- a) Náuseas e vômitos.
- b) Quadros confusionais e alucinações.**
- c) Cefaleia e astenia.
- d) Parestesia de membros inferiores e flacidez muscular.
- e) Afasia e flacidez de musculatura respiratória

- 106- Quanto aos critérios diagnósticos do DSM-IV para demência do tipo Alzheimer, analise as seguintes assertivas:

- I. Ter a presença de, ao menos, um dos seguintes transtornos: afasia, apraxia, agnosia e transtorno de funções executivas.
- II. O curso é caracterizado por início gradual e declínio cognitivo flutuante.
- III. A fase inicial da demência é a de maior duração.
- IV. A Ressonância Magnética Cerebral é o método diagnóstico mais preciso para o diagnóstico.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.**
- b) Apenas II.
- c) Apenas II e III.
- d) Apenas III e IV.
- e) Apenas II, III e IV

- 107- Em paciente com diagnóstico de demência da doença de Alzheimer estágio leve, a conduta mais efetiva seria:

- a) Orientar reabilitação cognitiva.
- b) Iniciar com antagonista de receptor NMDA.
- c) Orientar atividade física regular.
- d) Iniciar com inibidor de acetilcolinesterase.**
- e) Iniciar com composto nutricional.

108- Os tipos de incontinência urinária que, mais frequentemente, acometem pacientes com demência da doença de Alzheimer estágio grave são:

- a) **Urgência e funcional.**
- b) Transbordamento e esforço.
- c) Esforço e funcional.
- d) Urgência e transbordamento.
- e) Esforço e urgência.

109- Em relação às drogas abaixo, qual é mais indicada nas fases mais avançadas da Doença de Alzheimer, podendo ser utilizada em associação com inibidores da acetilcolinesterase:

- a) Donepezil.
- b) Rivastigmina.
- c) Galantamina.
- d) Selegilina.
- e) **Memantina**

110- Qual das opções abaixo representa fator de risco de doença de Alzheimer de início tardio?

- a) Mutação do gene da proteína precursora amiloide.
- b) Mutação do gene da presenilina 1.
- c) Mutação do gene da presenilina 2.
- d) **AleloApo E4.**
- e) AleloApo E2.

111- Na demência de Alzheimer, encontramos:

- a) perda da memória semântica.
- b) **perda da memória recente.**
- c) perda da memória episódica.
- d) perda de interesse, choro, apatia e sonolência
- e) perda de memória remota.

112- Na investigação da doença de Alzheimer, no exame de ressonância magnética podemos encontrar:

- a) **atrofia do córtex parietal.**
- b) atrofia do córtex fronto temporal.
- c) atrofia da substância negra.
- d) hipotrofia do lobo temporo medial.

e) hipertrofia dos ventrículos.

113- Na atualidade, o tratamento farmacológico preconizado para a demência de Alzheimer são as substâncias:

- a) hipnóticas.
- b) fitoterápicas.
- c) Anticolinérgicas
- d) **Anticolinesterásicas.**
- e) neurolépticas.

114- M,E.R, de 73 anos, é trazido ao consultório com história de dificuldade para realizar suas atividades de vida diária há 4 meses, como se vestir e higiene pessoal. O cuidador refere que a memória episódica está diminuída, onde esquece fatos recentes. Além disso, está tendo quadro de melancolia, tristeza e choro sem motivo. Tem ficado agitado e agressivo por alguns períodos, com quedas frequentes e lentificação motora nesse período. Tem como comorbidades: has, dm II em tratamento. Paciente teve AVC há 6 meses somente com desvio de rima bucal como sequela. Minimal: 16. Teste do Relógio: não fez. Baseado nesses dados, qual seria provável diagnóstico:

- a) Hidrocefalia de Pressão Normal
- b) Doença de Alzheimer
- c) Depressão Maior
- d) **Demência Vascular**
- e) Hematoma subdural

115- Paciente de 82 anos de idade, hipertensa e diabética, viúva há 5 anos, vem à consulta trazida por sua filha, que relata que a mãe vem apresentando há 3 anos quadro progressivo de perda de memória e agressividade com os filhos. Até 1 mês atrás, morava sozinha em outra cidade, mas teve que se mudar para a casa da filha após quase ter incendiado a casa ao deixar a panela no fogo e ter ido dormir. Em relação a esse caso clínico, é possível afirmar:

a) A hipótese de demência vascular deve ser considerada, mesmo na ausência de história de acidente vascular cerebral

b) O miniexame do estado mental, o teste do relógio e testes de fluência verbal são úteis para rastreamento, mas têm valor limitado na avaliação e no acompanhamento clínico de pacientes com demência

c) Benzodiazepínicos devem ser usados para conter a agressividade, de preferência o diazepam

d) O diagnóstico de depressão é improvável, pois geralmente não cursa com perda de memória

116- Na demência vascular por múltiplos infartos é incorreto dizer:

a) A progressão é em graus

b) Há presença de depressão, melancolia e irritabilidade

c) As alterações da marcha podem preceder as alterações de memória - alterações esfinterianas e de marcha as vezes precedem as alterações cognitivas.

d) Geralmente há hemiplegia ou hemiparesia com alteração da fala.

e) As artérias mais acometidas são as pequenas, levando a leucoarrose de substância branca

117- Na Demência Fronto-Temporal é correto dizer:

a) Há um comprometimento da acetilcolina nesta doença, por isso o uso de anticolinesterásicos.

b) Há inicialmente uma perda de memória seguida de alterações de comportamento, como impulsividade, hiperoralidade e risos inadequados.

c) Uma maior impregnação por neurolépticos em relação a outras demências.

d) A atrofia cerebral, pela morte neuronal, compromete as regiões, frontais, temporais e occipitais.

e) Para tratamento pode usar neurolépticos atípicos, como a quetiapina nos distúrbios de comportamento.

118- Filha traz mãe de 68 anos para primeira consulta ao geriatra e mostra uma carta que relata os sintomas da paciente: mudanças no comportamento (desinibição, comportamento exaltado, risos e comentários sexuais inadequados e alterações importantes do hábito alimentar com preferência por doces) com discreta alteração de memória de início há 6 meses. A paciente diz se sentir bem e não sabe por que a filha marcou a consulta. O diagnóstico é demência:

a) Por corpos de Lewy.

b) Vascular.

c) Tipo Alzheimer.

d) Fronto temporal.

119- Paciente de 80 anos trazido pela filha que queixa que o pai vem apresentando mudanças gradativas no comportamento e personalidade, como por exemplo, perda do pudor, bate palmas repetidas vezes ao dia. Além disso, vem apresentando declínio na higiene pessoal e hipersexualidade. O SPECT mostra hipoperfusão dos lobos frontais e de áreas temporais anteriores. Diante do diagnóstico mais provável, qual o tratamento medicamentoso mais indicado?

a) Rivastigmina

b) Donepezil

c) Galantamina

d) Sertralina

e) Memantina

120- Paciente de 59 anos, trazido por seus familiares por apresentar mudanças na personalidade e no comportamento. Familiares notaram mais agressividade, mudança de hábitos alimentares, declínio dos cuidados de higiene pessoal e de vestir-se, além de conduta social

inadequada. A avaliação neuropsicológica revela sinais de disfunção executiva e mau desempenho em testes de julgamento crítico e social. O desempenho dos testes de nomeação de figuras, significado de palavras e de habilidades visuoespaciais estava intacto. Diante do diagnóstico mais provável de demência, o tratamento mais indicado é:

- a) Donepezila
- b) Rivastigmina.
- c) Memantina
- d) Galantamina
- e) **Sertralina**

121- Um senhor de 85 anos é levado ao ambulatório pela família com queixas de aumento do tempo da realização das atividades da vida diária, acúmulo de saliva e déficit cognitivo. A observação mostra micrografia, rigidez e bradicinesia. A hipótese diagnóstica é:

- a) Doença de Alzheimer.
- b) Doença de Lyme.
- c) **Doença de Parkinson.**
- d) Demência vascular.
- e) Demência do hematoma subdural.

122- Paralisia agitante, conhecida como doença de parkinson, em homenagem a James Parkinson em 1817, é marcada por:

- a) Perda acentuada e progressiva de células no hipocampo, levando a diminuição de dopamina e acetilcolina.
- b) Sinais pré-clínicos como constipação, psicose, instabilidade postural e insônia
- c) O tremor parkinsoniano é de repouso, de 4 a 6 Hz, que perde ao pegar objetos e somente acomete membros superiores
- d) **Marcha pit-pass, festinação, freezing e micrografia são alterações clínicas nestes pacientes**
- e) Flutuações motoras com uso de levodopa, tendo como exemplo a discinesia pico dose e período off

123- E.D, 72 anos, com Doença de Parkinson há 5 anos, em uso de Levodopa, onde há 30 dias vem apresentando movimentos involuntários do segmento cefálico com aspecto coreiforme. Diante disso, assinale o provável diagnóstico e tratamento para esta alteração:

- a) Discinesia, aumentar a dose da levodopa.
- b) Tremor senil, suspender a levodopa.
- c) Fenômeno wearing-off, associar pramipexole.
- d) Período off, associar entacapone.
- e) **Discinesia, associar pramipexole.**

124- Paciente de 78 anos, sexo feminino, obesa, está em tratamento por Transtorno Depressivo, com melhora do quadro melancólico com sertralina. Entretanto, vem tendo insônia, com sono entrecortado e sonolência diurna. Qual seria a medicação de escolha para esse paciente?

- a) Diazepam
- b) **Trazodona**
- c) Amitriptilina
- d) Alprazolam

125- Homem, 65 anos, metalúrgico aposentado apresenta, há 3 meses, dificuldade para iniciar o sono, melancolia, perda de peso e do interesse para atividades sociais. A opção terapêutica para esse paciente é

- a) bupropiona.
- b) fluoxetina.
- c) **mirtazapina.**
- d) sibutramina.

126- O envelhecimento biológico humano altera o padrão de sono, sendo características principais do sono no idoso:

- a) tempo de latência menor, ausência de estágios mais profundos e aumento do número de acordares noturnos.

- b) presença de estágios mais profundos, aumento do número de acordares noturnos e tempo de latência menor.
- c) presença de estágios mais profundos, aumento do número de acordares noturnos e redução do número de acordares noturnos.

d) aumento do número de acordares noturnos, tempo de latência maior e ausência de estágios mais profundos na fase NREM do sono.

- e) redução do número de acordares noturnos, presença de estágios mais profundos e tempo de latência maior.

127- Paciente idoso de 82 anos apresenta quadro de lapsos de memória, sonolência diurna e cansaço sete dias após iniciar uso de diazepam, prescrito na unidade básica de saúde, devido à queixa de insônia. A alteração farmacocinética responsável por esse quadro é o

- a) aumento da atividade em receptores GABA.
- b) a diminuição da atividade do sistema de isoenzimas P450.
- c) a diminuição da água intracelular.
- d) a diminuição da atividade em receptores colinérgicos.

e) o aumento da gordura corporal total.

128- Em um paciente com insônia, que já tentou as medidas não farmacológicas, é INCORRETO:

- a) Passar um BDZ de meia vida longa como o Diazepam
- b) Prescrever não BDZ como o zolpidem
- c) Se o paciente tiver quadro de depressão associado, associar tricíclico como à amitriptilina
- d) Trazodona seria uma opção para tratamento
- e) Mirtazapina seria opção para idosos desnutridos e de baixo peso.

129- Em relação à insônia no idoso, assinale a alternativa correta:

a) Dentre as medicações que podem causar insônia incluem-se: corticoides, beta2-agonistas, paroxetina e bupropiona.

- b) Fototerapia e exercícios noturnos são recomendações para reduzir a ocorrência de insônia.
- c) Os benzodiazepínicos são bem tolerados por não possuírem ação hipnótica nem causar dependência.
- d) A exposição à luz solar ao fim da tarde compromete a síndrome do avanço de fase do sono (ASPC).
- e) O zolpidem deve ser evitado em virtude de sua meia-vida longa com efeito acumulativo

130- Na Síndrome das Pernas Inquietas é correto afirmar:

a) Anemia ferropriva e as medicações antidepressivas são causas da doença.

- b) O tratamento de primeira escolha no idoso é o clonazepam.
- c) Não existe participação genética na doença.
- d) Os sintomas são de inquietação em pernas ou de dor, que não melhoram quando o indivíduo levanta e deambula.
- e) As mioclonias não são muito prevalentes como doença associada.

131- Cerca de 34% de indivíduos com mais de 60 anos apresentam Síndrome das Pernas Inquietas (SPI), que se manifesta clinicamente por sensação desagradável de desconforto nos membros, notadamente nos inferiores, sendo essa sensação aliviada pela movimentação das pernas. O tratamento medicamentoso dessa síndrome tem como drogas de escolha:

- a) antipsicóticos, opioides, anticonvulsivantes e hipnóticos indutores do sono.
- b) benzodiazepínicos, antidepressivos, compostos de Fe⁺ e miorelaxantes.
- c) anticonvulsivantes, benzodiazepínicos, agentes dopaminérgicos e opioides.

- d) antidepressivos, agentes dopaminérgicos, miorrelaxantes e anticonvulsivantes.
- e) opioides, hipnóticos indutores do sono, antidepressivos e compostos de Fe⁺.

132- Paciente de 82 anos é trazido ao ambulatório de geriatria pela sua filha com quadro de confusão mental há 10 dias, insônia sem agressividade e com alucinações visuais constantes como animais e que não está em sua casa. Depois de pedir os exames, qual seria o melhor medicamento para ser usado para esse paciente até o retorno da consulta?

- a) Haloperidol
- b) Prometazina
- c) Alprazolam
- d) Clorpromazina
- e) Quetiapina

133- Idosa com dor em joelho esquerdo, com crepitação e discreto edema. Fez Rx do joelho que mostrou Osteoartrite. Paciente refere também instabilidade na articulação com algumas quedas. Quais as condutas que seriam mais adequadas a essa paciente?

- a) Fisioterapia e joelheira
- b) Artroplastia total e fisioterapia
- c) Hidroxicloroquina, Ácido Hialurônico e fisioterapia
- d) Ácido hialurônico, joelheira e fisioterapia motora
- e) Glicosamina + Condroitina e fisioterapia.

134- Em relação a osteoartrite (OA) marque a incorreta:

- a) Algumas características desta patologia são dor articular, crepitação, rigidez protocinética (no início do movimento), instabilidade articular, atrofia da musculatura periarticular, piora da dor com atividade, melhora com repouso.
- b) As articulações mais acometidas são: IFD das mãos, IFP das mãos, primeira carpo metacarpeana (rizartrose), articulação acrômio-clavicular, quadris, joelhos,

primeira metatarso falangeana dos pés, articulações zigoapofisárias da coluna cervical e lombar.

- c) Em relação aos achados laboratoriais da AO temos: são inespecíficos. Não correm alterações das provas inflamatórias, nem surgem autoanticorpos. O líquido sinovial apresenta alta viscosidade, sendo amarelo claro, com poucos leucócitos, ausência de cristais e cultura negativa.
- d) Os principais achados radiológicos são: diminuição da interlinha articular decorrentes do afilamento da cartilagem, esclerose subcondral, osteofitose, cistos subcondriais grandes

e) São nódulos articulares ósseos (osteófitos), chamados de nódulos de Heberden quando localizados nas IFP e de Bouchard quando localizados nas IFD. Podem ocorrer desvios as falanges. São mais frequentes em mulheres e tem caráter familiar.

135- Idoso com dor em joelho esquerdo, com crepitação e discreto edema. Fez raio-X de joelho que mostrou Osteoartrite. Paciente (acho que está escrito “nega quedas”) Quais as condutas que seriam mais adequadas a esse paciente?

- a) Fisioterapia e joelheira
- b) Hidroxicloroquina, ácido hialurônico e fisioterapia
- c) Artroplastia total e fisioterapia
- d) Ácido hialurônico, joelheira e fisioterapia motora
- e) Glicosamina + Condroitina e fisioterapia

136- Paciente sexo feminino, 73 anos, refere obstipação intestinal há mais de 10 anos, sem outras queixas clínicas, como emagrecimento, enterorragia ou dor abdominal. Como comorbidades tem HAS, DM II, Obesidade leve e Osteoartrite de Coluna Lombar. Usando como medicações: enalapril 10mg, Metformina 850mg, Tramadol 50mg e Amitriptilina

25mg. Diante do quadro, qual seria a melhor conduta:

- a) Trocar o enalapril por outro anti-hipertensivo, devido a ser obstipante; atividade física regular e bisacodil dose única a noite.
- b) Suspender somente o tramadol, atividade física regular, orientação nutricional quanto a fibras e fenofibrato como laxante.
- c) Atividade física regular, orientação nutricional quanto a fibras, suspender tramadol e amitriptilina e usar o plantago ovata.
- d) Atividade física regular, orientação nutricional quanto a fibras, suspender a amitriptilina e prescrever Cáscara Sagrada.
- e) Orientação nutricional quanto a fibras e prescrever lactulose.

137- No tratamento medicamentoso da constipação intestinal crônica do idoso, na suspeita de obstrução intestinal, são formalmente contraindicados:

- a) laxantes e sais osmóticos.
- b) lubrificantes.
- c) laxantes formadores de massa.
- d) laxantes emolientes ou amolecedores de fezes.
- e) laxante estimulante ou de contato

138- Paciente de 62 anos de idade, vem ao ambulatório com queixa de constipação presente há vários anos. Tem evacuado apenas uma ou duas vezes por semana, quase sempre com muito esforço, e, de vez em quando, fica com a sensação de que não conseguiu evacuar tudo. Ocasionalmente usa laxantes, que aliviam um pouco os sintomas, mas deixam as fezes amolecidas, o que também a incomoda. Não tem história familiar de problemas semelhantes. Nega sangramento nas fezes e perda de peso. Fora a constipação, tem boa saúde: tem HAS controlada, faz caminhadas diárias e

tem uma dieta rica em verduras, frutas, pães e carne (branca e vermelha). Fez alguns exames laboratoriais 6 meses atrás, incluindo uma pesquisa de sangue oculto nas fezes, com resultado negativo. O exame do abdome é normal e o toque retal não encontra alterações. Diante do quadro, a conduta mais adequada é:

- a) solicitar colonoscopia
- b) contraindicar as caminhadas
- c) prescrever supositórios de glicerina
- d) orientar o aumento da ingestão de líquidos

139- Paciente de 60 anos de idade procura seu geriatra queixando-se de que está sem evacuar há 3 dias. Iniciou sintomas há 2 anos, sendo que, nos últimos 3 meses, está evacuando duas vezes por semana. Relata eliminação de gases, e que, na maioria das vezes, faz esforço para evacuar e apresenta sensação de esvaziamento incompleto. Nega alteração na cor ou consistência das fezes, nega dor abdominal ou mudança da forma ou frequência das evacuações. É hipertensa há 10 anos e faz uso de atenolol 100 mg e enalapril 20 mg. Sem alterações no exame físico. O diagnóstico, mais provável, e o plano terapêutico mais adequado são, respectivamente:

- a) constipação intestinal primária; orientar a paciente sobre as variações individuais do trânsito intestinal, prescrever dieta rica em fibra e líquidos, atividade física e reeducação intestinal
- b) constipação intestinal secundária ao uso de medicação; trocar anti-hipertensivo e prescrever um laxante emoliente e dieta rica em fibras e líquidos
- c) síndrome do cólon irritable; detectar eventos de vida que estão associados com os momentos de constipação
- d) constipação intestinal crônica; solicitar colonoscopia para exclusão de doenças anorretais e do cólon

140- Paciente de 74 anos de idade foi diagnosticado, há 1 ano, com um câncer de pulmão metastático, cujas possibilidades terapêuticas foram esgotadas há 3 meses. Em consulta domiciliar apresenta-se restrito ao leito devido à caquexia, com baixa ingesta hídrica, mas usando fraldas descartáveis e urinando normalmente. Está sem defecar regularmente há alguns dias. Sua prescrição inclui metoclopramida 10 mg 8/8 horas, codeína + paracetamol 30 + 500 mg 8/8 horas, omeprazol 40 mg pela manhã em jejum e clonazepam 2 mg as 22 horas. Está consciente, e, perguntado sobre como se pode ajudá-lo, responde que a dor está bem controlada, mas as náuseas persistem, que a barriga está muito inchada por não defecar e que isso o tem incomodado bastante, especialmente porque tem a sensação de que há ocupação retal mesmo após defecar. A melhor medida a ser tomada, considerando o desejo do paciente e seu manejo adequado, é:

- a) suspender a codeína+paracetamol e iniciar metadona
- b) manter a codeína+paracetamol e introduzir o óleo mineral
- c) suspender a codeína+paracetamol e prescrever naltrexona.
- d) manter a codeína+paracetamol e realizar toque retal para investigar a presença de fecaloma.

141- A.T., 72 anos, queixa-se de obstipação intestinal há 40 dias, com fezes em cíbalos, esforço evacuatório, ficando até 4 dias sem evacuar, onde usa laxante receitado pelo balconista de farmácia, com melhora parcial. Paciente nega dor abdominal, enterorragia ou febre. Não relata perda de peso. Paciente foi tabagista crônico por 30 anos, nega etilismo. Nega diabetes. Como comorbidades é depressivo e usa nortriptilina 50mg/dia. Tem HAS, com bom

controle em uso de enalapril 10mg/dia. Exame físico normal. Qual é a melhor conduta sobre esse paciente?

- a) pedir exames laboratoriais como TSH, cálcio, urina I. Não pedir colonoscopia ainda, pois vamos esperar os exames laboratoriais. Manter a nortriptilina.
- b) Pedir exames laboratoriais como hemograma, TSH, cálcio, pesquisa de sangue oculto nas fezes e Rx simples de abdome. Suspende nortriptilina e passar ISRS.
- c) Pedir colonoscopia e Rx simples de abdome.
- d) Solicitar hemograma, ureia, creatinina, cálcio, TSH, colonoscopia. Suspende nortriptilina e usar um ISRS.
- e) Pedir hemograma, ureia, creatinina, cálcio, glicemia de jejum, TSH e colonoscopia. Trocar a nortriptilina e enalapril, por ISRS e losartana.

142- A obstipação intestinal é um sintoma de incidência de 50% em casas de repouso, podendo ter causas orgânicas ou funcionais. Sendo assim é falso afirmar:

- a) o uso de anticolinérgicos e anti-inflamatórios são causas de obstipação.
- b) O fecaloma é uma complicação da obstipação intestinal, podendo ter o paciente a diarreia paradoxal.

c) Sais de magnésio é uma opção boa em pacientes idosos, sendo isento de efeitos colaterais.

- d) As antraquinonas como o Sene, podem causar Melanosis coli.
- e) O domperidone e a bromoprida são adjuvantes no tratamento da obstipação.

143- Obstipação intestinal é uma das queixas mais frequentes em Geriatria, com uso inapropriados de laxantes por essa faixa etária. Com isso podemos afirmar:

- a) Os laxativos osmóticos como sais de magnésio e sódio são os de primeira escolha para o idoso.
- b) As antraquinonas com Sene e Cáscara Sagrada, por serem fitoterápicos, praticamente são isentos de efeitos colaterais.
- c) O hipertireoidismo é um exemplo de causa de obstipação intestinal
- d) O fecaloma é uma complicação da obstipação intestinal, sendo caracterizado por fezes em cíbalos e enterorragia.

e) Os laxativos formadores de bolo fecal, como Psílio, devem ser evitados em pacientes acamados e com Mega cólon.

144- Paciente de 73 anos, com obstipação intestinal há 7 dias, com dor em hipogástrio tipo cólica, fraca intensidade e sem irradiação. À dor melhora com antiespasmódico e sem fator de piora. Nega outros sintomas associados. Comorbidades: DM, artrose de joelhos e doença de parkinson. Exame físico: crepitação de joelhos, joelhos em varo, parkinsonismo. Medicações: levodopa, metformina e codeína. Diante do caso é ERRADO AFIRMAR:

- a) A codeína e a doença de Parkinson são fatores para obstipação neste paciente
- b) Pouca mobilidade desse paciente devido à sua artrose e levodopa são causas de obstipação
- c) Como conduta o mais acertado seria dieta rica em fibras, hidratação e um laxante como antraquinona
- d) Um toque retal seria de fundamental importância
- e) Uma colonoscopia ou um enema opaco seriam exames de imagem a serem pedidos

145- Sr. 80 anos, com diagnóstico de Depressão Maior, pela escala de Yesavage, relata que tem Diabetes Mellitus Tipo II, em uso de Metformina

850mg 2x ao dia, com razoável controle. Relata dor em queimação em membros inferiores, mais precisamente em pés de maneira simétrica. No exame de Eletroneuromiografia mostrou Polineuropatia Diabética. Diante do caso depressivo e de dor, qual seria o melhor medicamento em questão:

- a) Diazepam
- b) Fluoxetina
- c) Duloxetina
- d) Trazodona
- e) Sertralina.

146- M.P.S, 67 anos, refere quadro de apatia, insônia, fraqueza geral, desânimo, ansiedade principalmente no período da manhã há 6 meses. Foi diagnosticado Depressão Maior e iniciado com Mirtazapina 30mg, sendo que após 40 dias, teve melhora parcial dos sintomas. Aumentado dose da medicação para 45mg e pedido para retornar em 40 dias. Paciente volta, com melhora da insônia, mas ainda com alguns sintomas depressivos e de ansiedade. Diante do quadro, poderemos seguir qual conduta:

- a) Associar Lítio
- b) Eletroconvulsoterapia
- c) Associar um ISRS
- d) Introduzir um benzodiazepínico
- e) Trocar a medicação por um ISRS

147- Paciente idoso de 80 anos, institucionalizado, com demência de Alzheimer em uso de donepezil. Vem apresentando tristeza, insônia, perda de apetite e irritabilidade. Diante do diagnóstico de depressão, qual dos antidepressivos abaixo está mais indicado para controle dos sintomas?

- a) Fluoxetina
- b) Amitríptilina
- c) Nortríptilina
- d) Duloxetina
- e) Mirtazapina

148- O uso de antidepressivo em idosos difere substancialmente do uso em pacientes jovens apresentando, nos idosos, altas taxas de recaída da depressão. Quanto aos antidepressivos, é correto afirmar que:

- a) dentre os inibidores de recaptção da serotonina a Paroxetina é a que tem a meia-vida mais longa devendo ser descontinuada abruptamente.
- b) entre os tricíclicos, a Nortriptilina é o antidepressivo mais indicado para os idosos por apresentar menos efeitos colaterais.
- c) Mirtazapina é um antidepressivo noradrenérgico e serotoninérgico específico útil no tratamento de idosos em que se deseja ganho de peso.
- d) a Bupropiona é um antidepressivo noradrenérgico e dopaminérgico que tem como efeito a indução do sono em idosos.
- e) os inibidores de recaptção de serotonina são drogas de escolha em pacientes com síndrome de secreção inapropriada do ADH.

149- Mulher, 76 anos, cardiopata isquêmica, hipertensa e diabética, há 4 meses apresentou AVEI, com sequela motora em dimídio direito, permanecendo cadeirante. Evoluiu há 2 meses com alteração do humor, chorosa, irritada, desejando morrer, alegando não servir para mais nada. Sente muita dor nas pernas e na coluna. A opção terapêutica para essa paciente é

- a) Clomipramina.
- b) Fluoxetina.
- c) Duloxetina.
- d) Trazodona

150- Paciente vem apresentando há 2 horas quadro súbito de vertigens de forte intensidade, com quedas, náuseas, vômitos e zumbido. Nega diminuição de força muscular ou parestesias. Qual seria o provável diagnóstico?

- a) Vertigem Posicional Paroxística Aguda
- b) Vertigem associada a Depressão
- c) Insuficiência Vertebrobasilar
- d) Vertigem de origem metabólica
- e) Doença de Menière

151- Na Vertigem Posicional Paroxística Benigna temos um tipo de tontura muito incapacitante no idoso, podendo levar a quedas e fraturas. Sobre essa patologia é incorreto dizer:

- a) Vertigem posicional associada a diplopia e fraqueza muscular.
- b) O tratamento se baseia na Manobra de Epley e/ou Betaistina.
- c) O paciente tem tonturas que duram segundos a minutos e é a tontura mais frequente no idoso.
- d) A cinarizina e flunarizina podem ser usadas como arsenal terapêutico.
- e) Pode haver náuseas associado ao quadro.

152- A manobra que, quando positiva, confirma o diagnóstico de vertigem posicional paroxística benigna (VPPB) é:

- a) manobra de Romberg
- b) tilt test
- c) manobra posicional de Dix-Hallpike
- d) teste get up and go
- e) escala de mobilidade e equilíbrio Tinetti

153- A vertigem é a sensação que o paciente tem de estar girando em torno do ambiente ou vice-versa. Mais raramente, há a sensação de movimento em báscula no plano horizontal, de movimento ascendente e descendente ou ilusão de rotação horária ou anti-horária no plano frontal. Assinale a alternativa INCORRETA acerca da vertigem.

- a) Pode ser acompanhada de outros sintomas, como náuseas, vômitos, tinnitus e hipoacusia.
- b) Na vertigem periférica, a lesão se encontra no labirinto e/ou nervo vestibular, até sua entrada no núcleo vestibular.

c) A vertigem é provocada por disfunção do aparelho vestibular e se manifesta como uma ilusão de movimento, geralmente do tipo rotatório.

d) A vertigem periférica pode estar associada a tinnitus e hipoacusia e o corpo costuma pender para o lado contralateral da lesão vestibular durante a queda.

154- São considerados critérios diagnósticos para Diabetes Melito (valores em m/dL):

a) glicemia > 140 e < 200 após teste de tolerância à glicose.

b) glicemia em jejum > 100 e < 126

c) glicemia em jejum > ou igual a 126.

d) glicemia casual >140.

e) glicemia >140 após 75 g de glicose.

155- O manejo da dor crônica com antidepressivos tricíclicos é muito comum. Qual das condições dolorosas abaixo demonstrou benefício no uso do antidepressivo tricíclico, porém não comprovado efeito analgésico?

a) Neuralgia pós-herpética.

b) Neuropatia diabética.

c) Cefaleia tensional.

d) Enxaqueca.

e) Dor lombar crônica.

156- Sobre a vacinação de idosos, é correto afirmar:

a) Os indivíduos imunodeprimidos, esplenectomizados e asilados devem tomar a vacina antipneumocócica a cada 10 anos.

b) O idoso que apresentar reações adversas à vacina da gripe após 7 dias deve ser internado.

c) Os doentes pulmonares não devem ser vacinados, porque pode haver o agravamento da doença básica.

d) A vacina dupla contra difteria e tétano deve ser tomada em dose única.

e) A vacina contra influenza é anual, segura e deve ser adiada se o idoso mostra uma síndrome gripal em curso.

157- A dor é uma experiência sensorial desagradável, multicausal, de intensidade variável, que requer diagnóstico e tratamento. Sobre a dor, assinale a alternativa correta.

a) A analgesia nunca deve ser feita com opioides associados a anti-inflamatórios não hormonais.

b) Os idosos não respondem a medidas não farmacológicas para alívio da dor.

c) Antidepressivos tricíclicos, neurolépticos e anti-histamínicos são medicações coadjuvantes no tratamento da dor.

d) A persistência da dor requer o aumento progressivo da dosagem do anti-inflamatório.

e) A potência analgésica e a tóxica de cada anti-inflamatório caminham paralelas; melhor intercalar diferentes tipos de AINES.

158- No exame físico do idoso, considera-se como senescência a presença de

a) tremor fino e rápido nas mãos.

b) quarta bulha na ausculta cardíaca.

c) nódulos nas interfalangianas distais.

d) hiper-reflexia de tendão patelar.

e) edema leve nos membros inferiores.

159- Assinale a alternativa que apresenta corretamente opioides para tratamento de dor de intensidade leve a moderada no indivíduo idoso.

a) Morfina e nalbufina.

b) Cetorolaco e fentanila.

c) Tramadol e codeína.

d) Oxycodona e metadona.

e) Meperidina e dipirona.

160- As opções terapêuticas mais efetivas para o tratamento de idoso de 72 anos com quadro de tremor de ação

postural fino e simétrico de mãos, que interfere nas atividades de vida diária, são:

- a) topiramato e alprazolam.
- b) levodopa e pramipexol.
- c) selegilina e biperideno.
- d) **propranolol e primidona.**
- e) oxcarbazepina e ácido valproico.

161- A tontura é uma queixa comum entre idosos e tem etiologia multifatorial. Sobre a tontura, assinale a alternativa correta.

- a) A farmacocinética das drogas sistêmicas não interfere no curso das tonturas a causa é primariamente funcional otológica.
- b) neurite vestibular raramente causa sintomas de tontura em idosos.
- c) tontura no idoso deve ser investigada com tomografia de crânio porque tem comprometimento do sistema nervoso central.
- d) a síndrome de Ménière está diretamente relacionada a posições e movimentos do pescoço.
- e) **A vertigem posicional paroxística benigna é autolimitada e a manobra de Epley é eficaz para a recuperação do paciente.**

162- Qual a arritmia cardíaca mais frequente em pacientes idosos admitidos em serviços de emergência?

- a) Taquicardia sinusal
- b) Bloqueio atrioventricular de primeiro grau
- c) **Fibrilação atrial**
- d) Bradicardia sinusal

163- Paciente de 77 anos de idade vem à consulta, por apresentar quadro de tontura e algumas quedas, há 6 meses. Ela descreve que o sintoma aparece quando ela está caminhando e, às vezes sentada. Nega hipoacusia, zumbidos, disartria ou disfagia. Ao exame físico, PA = 130 x 70 mmHg, sentada e em pé, ausência de diplopia e ataxia. Exame cardiovascular: ausência de sopros

carotídeos, bulhas cardíacas rítmicas e normofonéticas, sem sopros. A causa mais provável da tontura é:

- a) o uso de betabloqueadores, metildopa ou nifedipina
- b) pré-síncope secundária a um quadro de estenose aórtica
- c) **o comprometimento da propriocepção e visão, secundários à idade**
- d) síndrome de Ménière, se a paciente apresentar plenitude aural associada

164- Paciente de 67 anos de idade faz uso regular de hidroclorotiazida 25 mg pela manhã, para controle de hipertensão arterial. É portadora de asma, mas não apresenta sintomas, desde que mantenha o uso regular de budesonida/ formoterol inalatório (200/6 mcg duas vezes por dia). Há cerca de 3 meses, em função de um quadro depressivo, foi-lhe prescrito amitriptilina 25 mg à noite. Nesse período, houve uma melhora notável dos sintomas depressivos já ao final do primeiro mês de tratamento. No entanto, no último mês tem sentido “tonteira” quando se levanta da cama ou do sofá, o que motivou sua vinda à consulta atual. Tem usado com frequência um medicamento que a vizinha lhe receitou para a dor relacionada à osteoartrose dos joelhos e, além disso, como tem notado constipação intestinal, tem usado, diariamente, um laxativo. Sobre esse caso, é possível afirmar que:

- a) a prescrição de um anti-histamínico não sedativo seria uma boa opção para o tratamento da vertigem dessa paciente
- b) a dose de amitriptilina pode ser aumentada para 50 mg por dia, uma vez que o quadro depressivo ainda não está plenamente controlado
- c) a “tonteira” pode ser a interpretação da paciente de algum sintoma relacionado à asma, devendo ser aumentada a dose dos medicamentos inalatórios
- d) **a paciente pode estar apresentando hipotensão postural; nesse caso, o**

médico deve observar a associação do diurético tiazídico com o antidepressivo tricíclico

- 165- Num paciente idoso, com quadro infeccioso de qualquer natureza, temos que ficar atentos para não ter atraso no diagnóstico. Sendo assim, o que é verdadeiro afirmar:
- a) A febre e os sintomas de septicemia estão presentes na maioria dos casos
 - b) A ausência de febre em certos casos, devido a imuno senescência
 - c) A ausência de febre, devido a diminuição da água corporal
 - d) Sintomas atípicos, como confusão mental
 - e) As questões B e D estão corretas

- 166- As quedas são a terceira causa de morte em idosos. Sobre esse assunto analise os itens abaixo
- I. Idosos caem mais por causa dos déficits visuais e auditivos
 - II. Pisos escorregadios e tapetes são armadilhas arquitetônicas para quedas
 - III. Podem levar a fraturas, hospitalização e imobilidade
 - IV. Idosos da comunidade caem mais que idosos em ILPL
 - V. Com a queda pode haver repercussão na parte cognitiva do paciente

Estão incorretas:

- a) I e IV

- 167- Paciente idoso com fibrilação atrial, facilmente pode evoluir para quadro de edema agudo de pulmão, em comparação ao jovem, devido à:
- a) deposição de gordura e colágeno no nó sinusal
 - b) devido ao aumento da espessura do VE
 - c) devido à maior participação da contração atrial com a idade e diminuição da complacência do VE
 - d) Diminuição da função sistólica no repouso
 - e) calcificação das valvas mitral e aórtica

- 168- A.T.R, 78 anos, sexo masculino, em tratamento com sertralina para Depressão maior há 60 dias, com melhora importante dos sintomas de anedonia, desânimo, ansiedade. Entretanto, refere dificuldades para iniciar o sono e sono entrecortado. Apresenta muitos cochilos durante o dia. Tem como comorbidades HPB, obesidade, HAS e dislipidemia. Analisando o caso, qual seria a melhor medicação para esse paciente?
- a) benzodiazepínico como o Lexotam
 - b) amitriptilina ao deitar-se
 - c) mirtazapina associada ao deitar-se
 - d) trazodona ao deitar-se
 - e) zolpidem em dose baixa.

- 169- Paciente com depressão grave vem ao consultório geriátrico com queixas de anedonia, melancolia, fraqueza geral, desânimo e vontade de ficar somente na cama. Está em uso de venlafaxina e mirtazapina em doses máximas há 6 meses, com pouca melhora. Frente ao caso qual seria a sua conduta mais provável?
- a) eletroconvulsoterapia
 - b) Trocar a venlafaxina e colocar um tricíclico como a Nortriptilina
 - c) Associar a lamotrigina
 - d) Associar ISRS
 - e) Trocar a venlafaxina por um antipsicótico atípico como a quetiapina.

- 170- Paciente de 89 anos refere obstipação intestinal crônica há 10 anos, já usou lactopurga com melhora, mas tem reclamado de cólicas que o remédio causa. Tem como comorbidades Hipotireoidismo, Diabetes Mellitus e Depressão Maior. Trouxe exames para consulta que fez há 30 dias. TSH: 9,8; ureia 32; Cr 1,4; Sódio 136; potássio 4,6; glicemia jejum 78; HbA1c 5,6%; glicemia pós 90. Medicações em uso: Vildagliptina 100mg/dia, Glicazida 60mg/dia, AAS

100mg/dia, Enalapril 10mg 2x dia,
Nortriptilina 50mg dia, Levotiroxina
75mcg.

- a) Diante do caso o que você faria para a
Obstipação desse paciente?

R → Correção do hipotireoidismo, suspender
lactopurga, usar laxante formador de bolo
fecal muvinlax.

- b) As medicações estão corretas? Você faria
alguma correção ou não?

R → Aumentaria a Levotiroxina 125mcg +
Suspenderia glicazida, tricíclico (escitalopram).

- c) Quais seriam as possíveis causas de
obstipação intestinal nesse paciente?

R → Hipotireoidismo, DM, tricíclico

171- Quanto ao Transtorno Depressivo
na pessoa idosa, avalie as assertivas a
seguir:

- I. As doenças crônicas na pessoa idosa não
estabelecem, por si só, risco para a
doença depressiva no idoso, devido à
capacidade adaptativa e à diminuição do
metabolismo neuroendócrino na velhice.
- II. A história familiar de doença depressiva
apresenta menor influência nos casos de
depressão iniciada somente na velhice.
- III. Teste de supressão da dexametasona é
um método com sensibilidade e
especificidade para o diagnóstico da
depressão em pessoas idosas.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.
- e) Apenas II e III.

172- Analise as seguintes drogas:

- I. Propranolol
- II. Nifedipina.
- III. Digoxina.
- IV. Indometacina.

Quais estão relacionadas ao desencadeamento
de depressão na pessoa idosa?

MARIA EDUARDA BONIATTI - TXXII

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e III.
- d) Apenas II e IV.
- e) Apenas I, II, III e IV.

173- Embora não sejam a terapêutica
de primeira escolha para a depressão no
paciente idoso, são indicados para os
casos mais graves que não responderam a
outros antidepressivos, por melhorarem o
humor e agirem sobre a apatia, a fadiga e
a lentificação psicomotora, os

- a) antidepressivos tricíclicos.
- b) inibidores da monoaminaoxidase (IMAO).
- c) inibidores seletivos da recaptação de
serotonina.
- d) inibidores seletivos da recaptação de
noradrenalina e dopamina.
- e) inibidores seletivos da recaptação de
noradrenalina.

174- O antidepressivo mais adequado
para iniciar tratamento de depressão em
paciente idoso obeso, diabético,
hipertenso, cardiopata e usuário de
polifarmácia é:

- a) o citalopram.
- b) a trazodona.
- c) a venlafaxina.
- d) a mirtazapina.
- e) a nortriptilina.

175- Filha traz para a consulta seu pai
de 72 anos de idade, referindo que, na
última semana, ele reclamou de um
quadro de insônia que está presente há 5
meses. Ele não apresenta outros
problemas de saúde, sempre foi bastante
saudável, nega quadro de tristeza,
angústia ou ansiedade nesse período. O
geriatra deve, nesse caso:

- a) iniciar amitriptilina 25 mg à noite para
ajudar o paciente a iniciar e manter o sono
- b) solicitar polissonografia para investigação
de síndrome da apneia obstrutiva do sono

c) pedir que o paciente faça um diário do sono por 10 dias e retorne para nova avaliação

d) prescrever lorazepam 2 mg por 90 dias e pedir que marque consulta de retorno, após esse período

176- Paciente masculino de 80 anos de idade, portador de demência vascular, crises epiléticas secundárias ao acidente vascular cerebral, hipertensão arterial e diabetes mellitus, residente de Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Foi encaminhado à unidade de urgência com quadro de redução do nível de consciência, hipotensão, taquicardia e piora das escórias renais. Exame de sangue mostra leucocitose com desvio para a esquerda e aumento do lactato. Vinha evoluindo há 4 dias com períodos de desorientação e agitação, queixa de disúria e urina fétida. Cuidador nega febre. Possui história prévia de crise convulsiva com uso de quinolonas. O EAS (Elementos e sedimentos anormais ou Exame de Urina Tipo I) solicitado mostra nitrito positivo, leucócitos aumentados e presença de numerosas bactérias. Entre os antibióticos apresentados abaixo, aquele mais indicado para esse paciente, incluindo a forma de administração, é:

- a) ciprofloxacino intravenoso até resultado do antibiograma
- b) levofloxacino via oral 1 x dia por 7 dias
- c) sulfametoxazol/trimetoprima intravenoso até resultado do antibiograma
- d) ceftazidima intravenosa até resultado do antibiograma
- e) amoxicilina + ácido clavulânico via oral por 7 dias

177- A tontura é uma queixa comum entre idosos e tem etiologia multifatorial. Sobre a tontura, assinale a alternativa correta.

a) A farmacocinética das drogas sistêmicas não interfere no curso das tonturas que têm causa otológica.

b) A vertigem posicional paroxística benigna é autolimitada, dura três meses e a manobra de Epley é eficaz para a recuperação.

- c) Qualquer tontura do idoso deve ser investigada com TAC e RNM, porque tem componente central.
- d) Os antivertiginosos devem ser usados continuamente, por serem vasodilatadores cerebrais e evitarem a esclerose cerebral.
- e) Tanto a vertigem central quanto a periférica são acompanhadas de intensos sintomas neurológicos.

178- Assinale a alternativa correta em relação ao envelhecimento e a sua relação com o Diabetes Mellitus.

- a) Quando iniciam com Diabetes Mellitus os idosos necessitam de terapia com insulina.
- b) Em situações de stress, os idosos desencadeiam quadro de diabetes que não reverte quando a situação estressante desaparece.
- c) A capacidade de a insulina estimular a captação de glicose diminui com a idade e geralmente se manifesta como hipoglicemia pós-prandial, mas com níveis de glicose e insulina de jejum normal.
- d) Algumas alterações fisiológicas imitam doenças quando podem ser uma parte normal do envelhecimento; assim, a Diabetes mellitus pode “aparecer” e “desaparecer” em idosos.
- e) A perda de reserva fisiológica de glicogênio hepático é o fator determinante para o aumento da prevalência de diabetes com o avançar da idade

179- Quanto à doença de Diabetes Mellitus na pessoa idosa, considere as seguintes assertivas:

- I. Os sintomas neuroglicopênicos não são mais relevantes nas pessoas idosas do que nos jovens.
- II. Na pessoa idosa, a glicosúria ocorre com valores mais elevados que em indivíduos jovens, exceto quando o idoso está em uso de diurético. I
- III. Na pessoa idosa, os sintomas adrenérgicos muitas vezes não são percebidos e podem ser mascarados por drogas.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.**
- d) Apenas I e II.
- e) Apenas II e III.

180- Paciente idoso, de 68 anos de idade, informa que está com dificuldade para ter o orgasmo. Analise as seguintes medicações:

- I. Fluoxetina.
- II. Citalopram.
- III. Imipramina.
- IV. Bupropiona.
- V. Bupiriona.

Quais das medicações podem ser a causa da queixa referida?

- a) Apenas I e III.
- b) Apenas II e IV.
- c) Apenas I, II e III.**
- d) Apenas II, III e V.
- e) I, II, III, IV e V.

181- A metformina é contraindicada nos pacientes idosos diabéticos que apresentem:

- a) baixo peso corporal, depressão e insuficiência cardíaca.
- b) tendência ao desenvolvimento de acidose láctica, portadores de insuficiências cardíaca, renal, respiratória e hepática.**
- c) obesidade, estresse cirúrgico, sepse.
- d) infecções graves de repetição, baixo peso corporal, tendência ao desenvolvimento de acidose láctica.

- e) infecções graves, baixo peso corporal, insuficiência renal

182- A hidrocefalia de pressão normal (HPN) é responsável por aproximadamente 2% de todos os casos de demência, cujo quadro pode ser revertido, se diagnosticado e tratado precocemente. O quadro clínico é representado pela seguinte tríade:

- a) dificuldade à marcha, distúrbios comportamentais e incontinência urinária.
- b) incontinência urinária, reflexos primitivos (grasping e snouting) e distúrbios comportamentais.
- c) demência, dificuldade à marcha (marcha apráxica) e incontinência urinária.**
- d) distúrbios comportamentais, demência e incontinência fecal.
- e) reflexos primitivos (grasping e snouting), distúrbios comportamentais e incontinência urinária.

183- A diabetes mellitus tipo 2 está presente em cerca de 15-20% nos indivíduos maiores de 60 anos, e, entre medicamentos orais, utilizados no tratamento de tal doença, encontram-se as sulfonilureias, que podem apresentar como efeitos colaterais:

- a) cefaleia, redução do peso corporal, hipoglicemia, fotossensibilidade, anemia transitória.
- b) distúrbios gastrointestinais, aumento do peso corporal, fotos sensibilidade, hipoglicemia, púrpura.**
- c) aumento do peso corporal, derrame pleural, alteração nas transaminases, distúrbios gastrointestinais.
- d) anemia transitória, fotossensibilidade, hipoglicemia, aumento do peso corporal, alterações nas transaminases.
- e) edema, derrame pleural, anemia transitória, hipoglicemia, aumento do peso corporal.

184- Entre as várias situações clínicas causadoras de demência potencialmente reversível, encontram-se:

- a) distúrbios eletrolíticos, deficiência de vitamina C, hipertrofia prostática.
- b) doença de Wilson, uso imoderado de analgésico narcótico, DPOC.
- c) **encefalopatia hepática, insulinoma, deficiência de folato.**
- d) hipotireoidismo, deficiência de vitamina E, osteoporose.
- e) meningite crônica, uso inadequado de lítio, deficiência de vitamina D.

185- A meta terapêutica da hemoglobina glicada para idoso diabético com expectativa de vida menor que cinco anos, segundo novo posicionamento publicado pela Sociedade Brasileira de Diabetes, em 2014, deve situar-se entre

- a) 6,0% e 7,0%
- b) 6,5% e 7,5%
- c) 7,0% e 8,0%
- d) **7,5% e 8,5%**
- e) 8,0% e 9,0%

186- São sintomas/sinais do idoso com insuficiência cardíaca, EXCETO:

- a) Síncope
- b) Alterações do sono
- c) **Tremores**
- d) Confusão mental
- e) Tosse

187- São causas reversíveis ou potencialmente reversíveis de demência, exceto:

- a) Tumores cerebrais
- b) Hidrocefalia de pressão normal
- c) Neurocisticercose
- d) Hematoma subdural
- e) **Doença de Creutzfeldt-Jacob**

188- Paciente de 63 anos de idade tem diabetes há cerca de 20 anos e há 8 anos, aproximadamente, está em insulinoterapia. Atualmente, faz uso de

insulina NPH humana, aplicando 28 U por volta das 8 horas e 20 U por volta das 22 horas. Ele faz automonitoramento com a dosagem de glicemia capilar duas vezes por dia, sempre antes de utilizar a insulina. Tem notado que a glicemia capilar da noite tem ficado em torno de 130 mg/dL, mas a glicemia capilar da manhã quase sempre está acima de 250 mg/dL. Além disso, frequentemente, ele tem acordado durante a madrugada com tremores, sudorese e fome. A melhor conduta para esse paciente é:

- a) visando evitar a hipoglicemia de rebote, deve ser iniciada uma dose de insulina regular de 0,1 U/Kg antes do jantar
- b) a dose da insulina da noite pode ser aumentada em 4 U, uma vez que a glicemia capilar da manhã está acima do desejável
- c) orientar o paciente a manter a dose de insulina e colocar o despertador para as 2 horas da madrugada para se alimentar, visando evitar os picos de hipoglicemia
- d) **a dose de insulina da noite pode ser reduzida, uma vez que é provável que esteja havendo hipoglicemia durante a madrugada, com hiperglicemia reacional em seguida**

189- A palavra iatrogenia, derivada do grego iatrikós, relativo ao médico e a medicina, refere-se a todo malefício provocado ao paciente, decorrente do seu tratamento, seja ele medicamentoso ou no âmbito das relações humanas. Sobre isso, assinale a alternativa errada:

- a) Um dos efeitos adversos mais comuns são os distúrbios de cognição, geralmente causados por tricíclicos, benzodiazepínicos e anticolinérgicos
- b) Os inibidores de bomba de prótons podem diminuir ainda mais a acidez gástrica e causar prejuízo na absorção de medicamentos como o ferro, carbonato de cálcio e digoxina

- c) As alterações a nível de barorreceptor no idoso, somado ao uso de vasodilatadores e anti-hipertensivos, a quadro de hipotensão ortostática e síncope
- d) Medicamentos com características ácidas como a fenitoína se ligam a fortemente a albumina, sendo assim, seus efeitos são potencializados no caso de uma depleção de albumina
- e) O aumento da massa gorda com o envelhecimento leva a diminuição da meia vida de fármacos como a morfina e amiodarona

- 190- Analise as afirmativas sobre a Síndrome das Pernas Inquietas no idoso:
- I. As drogas de primeira escolha na SPI são os anticonvulsivantes, sendo que um quadro de anemia ferropriva pode piorar o quadro
 - II. Os pacientes com SPI tem necessidade de movimentar as pernas, com sensação desconfortável que geralmente piora nos períodos de repouso ou no período noturno e que não melhora com a movimentação dos membros
 - III. Insuficiência renal crônica, uso de inibidores da recaptação da serotonina, doença de Parkinson e síndromes demenciais são condições clínicas associadas a SPI

Qual (is) está (ão) correta (s)

- a) Apenas a I
- b) Apenas a II
- c) Apenas a II e a III
- d) Todas corretas
- e) Todas incorretas

- 191- Assinale a alternativa que apresenta exames laboratoriais indicados para investigação da constipação crônica no idoso:
- a) Hemograma, glicemia, creatinina, cálcio séricos
 - b) Ácido úrico, ácido fólico, hemograma e TSH

- c) Vitamina D, PTH, Cloretos, Fósforo e glicemia
- d) Osmolaridade, cálcio, ureia, lítio e TGO
- e) Ferro sérico, hemograma, pesquisa de sangue oculto nas fezes, fosfatase alcalina

192- Paciente de 81 anos, masculino, professor universitário aposentado, vem ao consultório para tratamento de queixas cognitivas, sem atrapalho nas suas atividades de vida diária. Qual o melhor teste para avaliar cognição neste paciente?

- a) Minimental
- b) Fluência Verbal
- c) Moca Teste
- d) MAN
- e) Teste com figuras

193- Idosa de 72 anos vem ao consultório médico referindo inapetência há 40 dias. Diz que perdeu 5kg no período. Relato associado náuseas e diarreia intermitente. Tem tremor em mão direita há 6 meses, que vem aumentando, associado a bradicinesia. Nega sintomas depressivos ou qualquer outro sintoma associado. Paciente tem diabetes mellitus com excelente controle, hipertensão arterial e labirintopatia. Usa como medicamentos: metformina, enalapril, metoclopramida, cinarizina, AAS infantil.

- Exame físico: tremor parkinsoniano em mão direita, roda dentada positiva, fácies de máscara
 - Exames laboratoriais normais
 - Descarta causa orgânica, e diante da anamnese referida, quais medicamentos poderiam levar a esses sintomas iatrogênicos?

- a) Metformina, enalapril e metoclopramida
- b) Metformina e cinarizina
- c) Enalapril, AAS e metformina
- d) Cinarizina, metoclopramida e Metformina
- e) AAS, enalapril

194- A desprescrição é uma ferramenta usada para evitar a polifarmácia,

reduzindo dose de medicamentos e até interrompendo o consumo de medicamentos, aonde o potencial de dano é superior aos seus benefícios. Sendo assim é incorreto afirmar:

- a) Tomar cuidados adicionais em idosos acima de 80 anos, frágeis e com várias comorbidades
- b) Medicamentos como anticolinérgicos, benzodiazepínicos e anti-inflamatórios devem ser evitados em pacientes idosos.
- c) O uso indevido e por tempo prolongado de AINH podem levar a insuficiência renal e descompensação de ICC.
- d) Retirar medicamentos prescritos por balconistas de farmácia, vizinhos ou familiares.
- e) A amiodarona tem como eventos adversos as alterações gastrointestinais

195- A Demência Fronto-Temporal é uma doença degenerativa que afeta faixa etárias mais jovens, entre 45 a 64 anos, sendo assim é correto dizer:

- a) Há um comprometimento da acetilcolina nesta doença, por isso o uso de anticolinesterásicos
- b) Há inicialmente uma perda de memória seguida de alterações de comportamento, como impulsividade, hiperoralidade e risos inadequados
- c) Uma maior impregnação por neurolépticos em relação a outras demências
- d) A sobrevida é maior do que na doença de Alzheimer
- e) O comportamento estereotipados e ritualizados são comuns, com mudança de hábitos alimentares, com preferência por doces

196- Paciente de 70 anos, sexo feminino, sobrepeso, está em tratamento por Transtorno Depressivo, com melhora do quadro melancólico com escitalopram. Entretanto, vem tendo insônia, com sono entrecortado nas últimas semanas, com

cochilos frequentes durante o dia. Qual seria a medicação de primeira escolha para esse paciente?

- a) Zolpidona
- b) Diazepam
- c) Amitriptilina
- d) Lorazepam
- e) Trazodona

197- Idosa com 74 anos, professora aposentada, chega ao consultório geriátrico com sua filha, que relata que sua mãe há 8 meses, esquece fatos recentes, repetitividade, esquece palavras que vai falar e teve um episódio de desorientação espacial. Tem queimado vários alimentos. Tem transtorno depressivo maior há 20 anos e insônia em tratamento. Usa como medicações: Usa Losartana, escitalopram 10mg e Clonazepam gotas. Exame físico normal. 10 CS: 4; Teste com fluência verbal: 7. Diante do caso qual o provável diagnóstico e exames a serem pedidos?

- a) Doença de Alzheimer fase inicial; onde pediremos exames laboratoriais como cálcio sérico, TGO, TGP, glicemia de jejum, TSH, creatinina e exame de imagem como a ressonância magnética de encéfalo
- b) Comprometimento cognitivo leve amnésico; onde pediremos exames laboratoriais como VDRL, FTAsbs, cálcio sérico, TGO, TGP e glicemia de jejum e dosagem de proteína beta amiloide e proteína TAU no líquido
- c) Alteração cognitiva secundária a depressão e ao uso de benzodiazepínicos, onde pediremos exames laboratoriais como B12, ácido fólico, VDRL, HIV, função renal e exame de imagem como ressonância magnética de encéfalo
- d) Doença de Alzheimer fase inicial; onde pediremos exames laboratoriais como TSH, glicemia de jejum, vitamina D, fosfatase alcalina e exame de imagem como a ressonância magnética do encéfalo

- e) Comprometimento cognitivo leve amnésico; onde pediremos exames laboratoriais e spect cerebral

198- Na Avaliação Geriátrica Ampla (AGA) temos várias ferramentas para avaliação do idoso de maneira correta, melhorando a precisão diagnóstica.

Sendo assim é verdadeiro afirmar:

- a) A escala de atividades de vida diária (AVDs) tem como prioridade avaliar atividades como lidar com finanças, dirigir, tomar seus remédios e arrumar a casa, entre outras
- b) O teste cronometrado de levantar e andar avalia a possibilidade de quedas e fragilidade, aonde um tempo maior que 10 segundos é considerado positivo
- c) O SARC-F avalia é uma importante ferramenta para diagnóstico de sarcopenia e fragilidade
- d) O Moca-Teste tem uma boa aplicabilidade em pacientes com grau de educação reduzido é usado em pacientes com suspeita de CCL e demência.
- e) O Mini-mental tem uma acurácia superior ao 10- CS

199- Com relação a doença de Parkinson é verdadeiro afirmar:

- I. Déficit olfativo, alterações comportamentais e perda ponderal constituem sinais/ sintomas pré-motores
- II. O tremor está presente em 70% dos pacientes e caracteriza-se por diminuir sua amplitude com o estresse e ao realizar tarefas
- III. A rigidez pode estar presente com o fenômeno da roda dentada
- IV. Hipomimia e hipofonia são sinais observados em pacientes com esta patologia
- V. O diagnóstico é definido com base na presença de síndrome parkinsoniana com tremor, bradicinesia e rigidez muscular

São afirmativas corretas:

- a) I e IV
- b) II, III, IV e V
- c) III, IV e V
- d) I, III e IV
- e) Todas corretas

200- Sobre o comprometimento cognitivo leve, assinale a alternativa incorreta:

- a) A doença pode corresponder a uma fase prodrômica de uma demência de Alzheimer
- b) A avaliação de biomarcadores (amiloide e proteína TAU) no líquido é indicada de rotina em pacientes com CCL amnésico
- c) O comprometimento cognitivo amnésico o mais comum
- d) O paciente com CCL não apresenta alteração nas atividades de vida diária
- e) O CCL não amnésico com um único domínio afetado pode envolver somente linguagem, função executiva ou habilidades visuoespaciais

201- Na demência vascular temos uma doença cerebrovascular, tendo como causas quadros hemorrágicos, embólicos e isquêmicos. Sobre essa patologia é incorreto dizer:

- a) A escala isquêmica de hachinski é usada como auxílio diagnóstico, sendo um escore maior que 7 positivo para a doença
- b) Alguns fatores de risco: sedentarismo, doença coronariana, níveis aumentados de homocisteína e diabetes
- c) Demência por múltiplos infartos é decorrente de infartos grandes, corticais e subcorticais, de grandes artérias
- d) A demência vascular por doença de pequenos vasos leva alteração das funções executivas, déficit de memória, com atrapalho das atividades ocupacionais e distúrbios da marcha
- e) A doença de Binswanger não apresenta sintomas comportamentais e de marcha, sendo relacionada a hipertensão arterial

202- M.A.N, 73 anos refere diarreia, astenia, náuseas e vômitos há 8 horas. Nega esterorragia e fezes com muco ou pus. No exame físico mostra-se desidratada +2/4, hipotensa 90/60 e confusa. Tirando o quadro patológico, a fácil desidratação dessa paciente pode ser explicada, devido a:

- a) Aumento da massa gorda e diminuição da massa magra
- b) Diminuição de glândulas sudoríparas e sebáceas
- c) Diminuição do fluxo sanguíneo renal
- d) Menor produção de renina
- e) Diminuição de água corpórea, devido a menor massa celular

203- Idosa, 75 anos, independente, comparece a consulta ambulatorial de rotina, com queixas de emagrecimento de 5kg nos últimos 3 meses, sem alteração do apetite. Questionado sobre o hábito intestinal relata constipação intestinal nos últimos meses, ficando até 5 dias sem evacuar, aonde tem desconforto abdominal. Usa sene sem melhora até agora. Nega outros sintomas. Exame físico normal. Qual seria a conduta mais adequada a essa paciente:

- a) É uma queixa benigna, pois altera sua funcionalidade e a paciente não relata queixa espontânea. Somente mudança na dieta e exercício já são suficientes
- b) Trocar o laxante sene por um formador de bolo fecal como psyllium
- c) Pedir colonoscopia para averiguar melhor o quadro
- d) Solicitar pesquisa de sangue oculto nas fezes anual
- e) Associar o sene, um laxante osmótico como a lactulose

204- Sobre o tratamento da DP, assinale a alternativa incorreta:

- a) Os agonistas dopaminérgicos têm como benefício melhorar os sintomas motores e

as flutuações motoras pelo uso da levodopa

- b) As discinesias podem ser tratadas com o uso da amantadina ou diminuição da dose da levodopa
- c) A levodopa é a única droga que não causa delirium no paciente idoso
- d) Uma opção no tratamento inicial de um idoso abaixo de 70 anos é o uso da rasagilina ou agonista dopaminérgico
- e) O biperideno tem seu uso limitado no idoso, devido a sua ação anticolinérgica, causando transtornos neuropsiquiátricos

205- A demência por corpos de lewy é uma sinucleinopatia, aonde a evolução é mais rápida do que outras demências. Assim é correto afirmar:

- a) Mais comum em homens e tem a presença dos corpúsculos de lewy que é patognomônico dessa doença
- b) Apresenta como manifestações clínicas o quadro de parkinsonismo, disfunção autonômica, apatia, alucinações visuais e déficits de memória menos marcantes
- c) A impregnação por neurolépticos não é tão evidente como na doença de Alzheimer
- d) O tremor parkinsoniano é muito comum nestes pacientes, sendo a rigidez menos frequente
- e) Geralmente o déficit cognitivo aparece depois de muitos anos do quadro de parkinsonismo

206- Paciente 70 anos, sexo feminino, com queixas de melancolia, irritabilidade, mal-estar, tonturas, desanimo e diminuição do vocabulário há 90 dias. Foi num médico generalista há 60 dias que passou dose máxima de citalopram, com razoável melhora. Mantém ainda quadro de desanimo e tristeza em certos dias, querendo ficar somente em casa e não sair. Paciente tem como comorbidades HAS, Obesidade, DM II e Neuropatia

Diabética. Diante de tudo isso, qual seria a melhor conduta para a paciente:

- a) **Associar outro ISRS.**
- b) Trocar o citalopram pelo escitalopram.
- c) Associar mirtazapina.
- d) Trocar o citalopram pela duloxetina.
- e) Trocar o citalopram pela bupropiona.

207- Paciente com 77 anos, com depressão grave há 2 anos, vem usando venlafaxina e mirtazapina em doses máximas, com razoável melhora. Vem mantendo quadro de anedonia, tristeza, apatia e ansiedade, com medo de sair de casa. Diante desse quadro, qual seria a próxima conduta para esse paciente?

- a) **Trocar a mirtazapina pela duloxetina.**
- b) Associar lítio ou valproato de sódio.
- c) Passar um ansiolítico como o bromazepam.
- d) Trocar a venlafaxina pela sertralina.
- e) Indicar um antipsicótico como a levomepromazina.

208- A Osteoartrite é um transtorno articular multifatorial que pode acometer uma ou várias articulações, de tendo a dor como a principal queixa no consultório médico. Além disso, a limitação funcional e prejuízo nas atividades de vida diária tem grande impacto na vida dos pacientes. Com isso é correto afirmar:

- a) O uso do colágeno e da glicosamina muda a evolução da doença e diminui o grau de dor do paciente.
- b) A dor não piora com a mudança atmosférica e sendo pior ao repouso.
- c) O uso de anticonvulsivantes como a gabapentina e a pregabalina pode ser indicada em certos casos, devido à amplificação central da dor.
- d) O uso da bengala deve ser sempre do mesmo lado da articulação acometida com o cotovelo fletido a 20 a 30 graus.
- e) **As alterações radiográficas se caracterizam somente por degradação da cartilagem e pinçamento articular.**

209- Paciente feminina, 78 anos, portadora de HAS, DMII e osteoporose, sofreu duas quedas da própria altura no último ano, sendo a última há 1 mês, em casa, após tropeçar no tapete levando a trauma em região frontal. Na avaliação geriátrica ampla apresenta Teste get up and go de 30 seg, escala yesavage 9, MEEM=25. Nesse caso, o fator que é o maior PREDITOR de futuras quedas para essa idosa é:

- a) Osteoporose
- b) Minimental
- c) A hipertensão
- d) A idade
- e) **O teste get up and go**

210- Na doença de Alzheimer tem uma doença degenerativa, sem tratamento curativo e sim sintomático. É a demência mais comum em nosso meio. Assim podemos afirmar:

- a) **Existe uma hiperfosforilação da proteína tau, levando ao aparecimento dos emaranhados neurofibrilares.**
- b) Doenças metabólicas e cardiovasculares não estão relacionadas com o aparecimento da doença, e sim de causa genética na maioria dos casos.
- c) A memantina está indicada a partir das fases leves da doença.
- d) A proteína beta amiloide é uma lesão intracelular.
- e) A disfagia aparece em fase precoce da patologia, necessitando o uso de sonda.

211- Pacientes idosos com depressão podem ter alterações do sono, como insônia ou sonolência. Dentre estes antidepressivos a abaixo, qual o único que não ajudaria na insônia de um paciente idoso com depressão?

- a) Doxepine
- b) Mirtazapina
- c) **Sertralina**
- d) Trazodona

e) Agomelatina

212- Paciente 70 anos, teve AVC isquêmico há 90 dias, aonde desde o internamento vem tendo quadro de confusão mental, choro fácil, repete assuntos, desorientação no tempo e espaço, não reconhece sua casa e sua esposa em certos momentos. Nega queixas cognitivas anteriormente. Qual possível hipótese diagnóstica para esse quadro?

- a) Doença de Alzheimer
- b) Demência Vascular**
- c) Comprometimento cognitivo leve
- d) Transtorno depressivo maior
- e) Demência por Corpos de Lewy

213- O transtorno depressivo no idoso causa um impacto significativo na vida do paciente, sendo que o seu diagnóstico muitas vezes é negligenciado e subtratado. Sendo assim é correto dizer:

- a) Sentimento de culpa e menos valia são menos comuns em depressão de início tardio.**
- b) A escolaridade e a doença cerebrovascular não são fatores de risco para depressão no idoso.
- c) Os homens são os que tem mais sintomas e maior possibilidade de apresentação atípica.
- d) A depressão sub sindrômica não preenche os critérios para depressão maior e não causa o mesmo tipo de incapacidade.
- e) Na depressão de início tardio, o fator genético é de suma importância, e por isso deve ser investigado.

EXAME

E

2^a CHAMADA

PROVA DE EXAME – GERIATRIA – TXXII

1) Sobre a Doença de Alzheimer é correto afirmar:

I — Os achados neuropatológicos definidores da DA são as placas neuríticas, resultantes de acúmulo e agregação do peptídeo beta-amiloide, e os emaranhados neurofibrilares, compostos da p-tau hiperfosforilada.

II — A hipótese da “cascata amiloide” postula que a formação e a agregação do peptídeo beta-amiloide são os eventos mais precoces e os desencadeadores da patogênese da DA.

III — A diminuição da audição e visão são fatores de risco para a doença.

IV - A memantina tem como ação o aumento de acetilcolina na fenda sináptica.

Quais estão corretas?

- a) I, III, IV
- b) I e II
- c) II, III e IV
- d) I, II e III**
- e) III e IV

2) No subtipo de DFT chamada de Afasia progressiva não fluente é incorreto dizer:

- a) O paciente tem anomia, que é a dificuldade em encontrar palavras, com redução da fluência verbal.
- b) A compreensão das palavras desde o início da doença está comprometida.**
- c) Os pacientes relatam intolerância a ruídos e mutismo na fase final.
- d) A memória recente é boa, mantendo as atividades de vida diária por um longo período.
- e) O agramatismo é frequente nesses pacientes.

3) Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) sobre o tratamento da Doença de Parkinson:

I – Os agonistas dopaminérgicos tem uma boa indicação em pacientes em idosos mais jovens, tendo como um dos efeitos colaterais a psicose.

II – A amantadina é uma boa opção de tratamento devido ao seu efeito anticolinérgico na pessoa idosa.

III – A levodopa não deve ser administrada junto com as refeições, devendo seu uso diário ser fracionado.

IV – Os inibidores da COMT têm indicação de uso somente em pacientes em fases iniciais da doença.

Assinale a correta:

- a) I e III**
- b) II, III, IV
- c) I e IV
- d) II e III
- e) I e IV.

4) O quadro depressivo deve ser sempre investigado em pacientes idosos, sendo assim é verdadeiro afirmar:

- a) Os tricíclicos são a primeira indicação de tratamento devido aos poucos efeitos colaterais.
- b) Sintomas somáticos e cognitivos são menos comuns nessa faixa etária.
- c) A depressão vascular se caracteriza por retardo psicomotor, redução do interesse e anomia.**
- d) A depressão psicótica é menos comum em idosos.
- e) Distúrbios hidroeletrólíticos como a hiponatremia não ocorrem com os inibidores seletivos da recaptação de serotonina.

5) Paciente idosa com gonoartrose em joelho esquerdo, com dor e instabilidade articular levando a algumas quedas, sem deformidades e edema no exame físico. Qual seria a conduta correta para essa paciente?

a) Uso de AINH por 30 dias, bengala contralateral e fisioterapia.

b) Uso de ácido hialurônico intrarticular, uso de joelheira e fisioterapia para reforço muscular.

c) Uso de colágeno não hidrolisado e joelheira.

d) Prescrição de paracetamol e fisioterapia para reforço muscular.

e) Bengala ipsilateral e corticoide via oral.

6) O médico Willian Osler comentou que a pneumonia era a maior inimiga do idoso, e em outros, como sua companheira. Sua prevalência é elevada nessa faixa etária, onde devemos estar sempre atentos para o diagnóstico precoce, pois a mortalidade é elevada. Assim é incorreto afirmar:

a) Os germes mais frequentes em pacientes com DPOC são *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* e *Moraxella catarrhalis*.

b) Fatores predisponentes para pneumonia como alcoolismo, tubos de alimentação, diabetes e prejuízo nas avds são alguns dos exemplos.

c) O quadro clínico muitas vezes é atípico com confusão mental, quedas, inapetência e declínio funcional.

d) O rx de tórax com imagem de consolidação é menos frequente.

e) Leucocitose com desvio a esquerda na fase inicial da doença está sempre presente em todos os casos, sendo um marcador de infecção bacteriana.

7) Paciente idoso com Doença de Alzheimer tem diabetes mellitus em

tratamento com endocrinologista, usando Metformina 850mg 3x dia e Sitagliptina 100mg 1x dia. Filha relata fraqueza geral, inapetência e apatia. Ela vem trazendo os exames que mostram glicemia jejum 162 hb glicada 6,0 creatinina 1,0 ureia 51 e demais exames de laboratório normais. Diante do quadro exposto qual seria a sua conduta?

a) Suspenderia a sitagliptina.

b) Como a glicemia de jejum está alterada associa uma glitazona.

c) Associa uma sulfoniuréia como a glicazida.

d) Suspendo somente a metformina.

e) Troco a metformina pela glitazona.

8) Analise as afirmativas sobre a avaliação da PA no idoso:

I — A pseudo-hipertensão, diagnosticada por meio da manobra de Osler, está relacionada com aterosclerose.

II — A hipotensão ortostática (HO) é definida como uma variação maior que 20mmHg na PAS ou maior que 10mmHg na PAD da posição supina para a ortostática.

III — A classificação de um paciente com nível de PAS de 170mmHg e PAD menor que 90mmHg é Hipertensão arterial estágio 3.

IV — O uso de anti-hipertensivos evita a hipotensão ortostática.

Assinale a alternativa correta:

a) I, II e III.

b) II, III, IV

c) I, II

d) I, II, IV

e) II, IV

9) Observe as afirmativas sobre a abordagem do paciente idoso que sofreu queda:

I — A abordagem do paciente que apresenta um único episódio de queda é

igual àquela do paciente que cai repetidamente.

II — Parte essencial da avaliação do idoso que cai é compreender as circunstâncias pertinentes associadas ao evento.

III — Como, onde e quando a queda ocorreu são perguntas essenciais para direcionar a investigação dos fatores envolvidos e/ou desencadeantes da queda.

Assinale a correta:

- a) Apenas a I
- b) II e III
- c) I e II
- d) I e III

e) Todas estão corretas.

10) Sobre o principal binômio terapêutico da síndrome de fragilidade, o exercício físico e a nutrição, analise as alternativas a seguir:

I. A abordagem multiprofissional é parte essencial do tratamento.

II. Os exercícios físicos devem ser estimulados em todas as consultas médicas e multiprofissionais e podem ser de natureza aeróbica, multidimensional ou resistida.

III. A prescrição de alimentação rica em aminoácidos e proteínas são um dos pilares do tratamento.

IV. O uso de suplementos pode ser necessário em muitas situações no tratamento da fragilidade e deve ser considerado individualmente.

Quais são as corretas:

- a) Apenas I e II.
- b) I, II, III, IV
- c) I, II e IV
- d) III, IV

e) I, III e IV.

11) Sobre a avaliação geriátrica ampla (AGA), assina a alternativa correta:

- a) A escala de Yesavage ou de depressão geriatria de 15 pontos (GDS15) com

uma pontuação maior que 6 pontos confirma o diagnóstico de depressão

- b) A força de preensão palmar é uma boa forma de medir a quantidade de massa muscular

- c) Uma avaliação do mini exame do estado mental com pontuação abaixo do esperado é diagnóstica de demência

d) A avaliação do estado funcional do paciente com a escala de Katz ou ABVD nos ajuda a prever a mortalidade e ajuda a guiar nossas condutas

- e) A AGA nos auxilia a diagnosticar doenças ou fatores que podem estar relacionados a piora da qualidade de vida, porém não existem muitas condutas que podem melhorar isso.

12) Sobre a demência vascular (DVa) e o comprometimento cognitivo vascular (CCVa), assinale a alternativa correta:

- a) Os fatores de risco para desenvolver a demência de Alzheimer são muito diferentes dos fatores de risco para DVa, por isso essas doenças na maioria dos casos acontecem isoladas

- b) Na DVa temos sintomas clássicos como alucinações, alteração do comportamento, alterações motoras como tremor

- c) Tanto a DVa quanto o CCVa se caracterizam por ser insidiosos, de lenta progressão, com alteração da personalidade, raramente apresentando depressão

- d) A escala de Hachinski não nos auxilia na diferenciação entre Alzheimer e DVa, pois em pontuações intermediárias não podemos classificar como demência mista

e) Devido a toda patologia da DVa, é muito comum que esses pacientes apresentem labilidade emocional e depressão, o tratamento de escolha é

com os inibidores da recaptação de serotonina.

13) Mulher, 71 anos, com diagnóstico recente de câncer de mama, iniciou quimioterapia há pouco tempo. Vem em consulta com queixa de insônia, tristeza, perda ponderal e discreta perda de memória. Sobre o caso, assinale a alternativa correta:

a) Caso depressão seja um diagnóstico da consulta, devemos considerar utilizar uma medicação para essa patologia, que contenha efeitos colaterais que são desejáveis no momento, como a mirtazapina

b) Muito provavelmente a paciente apresente um quadro de ansiedade e está em “luto” pelo diagnóstico. Nessa paciente devemos utilizar como primeira escolha um benzodiazepínico por ser uma medicação segura nessa população

c) Devido a paciente apresentar problemas psiquiátricos associados possivelmente, não necessitamos orientar a higiene do sono pois a mesma não surtirá efeito, devendo apenas prescrever a medicação para tratar insônia

d) O quadro de insônia da paciente deve estar causando os outros sintomas como perda cognitiva e tristeza, por isso, devemos iniciar uma medicação que trate somente a insônia inicialmente, como a ramelteona.

e) Podemos utilizar medicações como a prometazina, um anti-histamínico que induz sono e aumenta o apetite, tratando dois problemas com segurança com apenas uma medicação.

14) Sobre as tonturas no paciente idoso, assinale a alternativa correta:

a) Em todo tipo de tontura, devemos sempre tratar o sintoma para melhorar a qualidade de vida, por isso, para todos os pacientes prescreveremos betaistina, flunarizina ou dimenidrato e depois seguiremos investigação.

b) Doenças cardíacas são as principais causadoras de pré-síncope. Nesses casos, não adianta prescrevermos dimenidrato, flunarizina ou betaistina pois os mesmos não surtirão efeito. Devemos otimizar o tratamento da doença de base

c) Na hipotensão postural devemos sempre suspender as medicações diuréticas, pois são medicações inadequadas para os idosos e sempre devemos suspendê-los

d) A tontura de origem vestibular apresenta reflexo vestibulo-ocular sem alterações, ajudando a diferenciar da de origem central justamente por esse ponto

e) A fisioterapia de reabilitação vestibular apresenta pouco benefício nos pacientes, não sendo necessária prescrever sempre ela, podendo manter as medicações como alternativa no lugar da fisioterapia.

15) Sobre a incontinência urinária no paciente idoso, assinale a alternativa correta:

a) A incontinência urinária por esforço é mais comum nos homens do que nas mulheres, sendo os maiores beneficiados das terapias não farmacológicas

b) Um paciente que tenha artrose, sarcopenia e que perca a urina ao se deslocar para o banheiro urinar, tem incontinência urinária de esforço por definição

c) As medicações utilizadas no tratamento da incontinência urinária de urgência

são muito seguras, por isso, medicações como a oxibutinina são a primeira escolha nos pacientes com demência

d) A primeira escolha no tratamento de todos os tipos de incontinência, é a terapia não farmacológica, como a fisioterapia de reforço do assoalho pélvico e treinamento vesical, sendo a efetividade semelhante ao tratamento farmacológico

e) A maioria dos casos de incontinência urinária possuem resolução completa dos sintomas, por isso, sempre devemos informar os pacientes do bom prognóstico dessa morbidade.

16) Em relação à insuficiência cardíaca, assinale a alternativa correta:

a) A retenção de sódio e água é um mecanismo compensatório que ocorre de forma adaptativa, reduzindo sobrecarga ventricular.

b) Presença de hipertrofia ventricular esquerda no ecocardiograma e escore elevado no H2FPEF, são sugestivos de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (ICFep).

c) A hipertrofia ventricular leva a uma melhora contínua e duradoura da função cardíaca.

d) O tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFeR) sempre envolve uso contínuo de Furosemida, independente de sinais de congestão.

e) Em relação ao tratamento da ICFep, não existe nenhuma droga com evidência de benefício.

17) Um paciente idoso apresenta dor crônica mista (neuropática + nociceptiva) refratária ao tratamento inicial com Dipirona e AINEs. Qual seria a melhor abordagem medicamentosa para manejo da dor?

a) Suspender AINEs e associar um adjuvante como a pregabalina para atuar na componente neuropática e reavaliar a analgesia.

b) Iniciar um opióide forte, como Fentanil, para controle rápido da dor e alívio do sofrimento.

c) Suspender a Dipirona e iniciar antidepressivos tricíclicos, como amitriptilina, em dose máxima.

d) Suspender Dipirona e AINEs e iniciar Metadona para melhor controle do componente neuropático da dor.

e) Não utilizar Tramadol ou Codeína para este paciente, por se tratar de dor crônica.

18) Em um paciente idoso hospitalizado por Pneumonia, qual alternativa contém a abordagem correta em relação ao Delirium?

a) Administração de antipsicóticos como Haldol e Quetiapina precocemente na internação, em doses profiláticas, para evitar que paciente apresente delirium.

b) Contenção mecânica para todos os pacientes com delirium hiperativo, uma vez que podem colocar a si mesmos e a equipe em risco.

c) Uso de benzodiazepínicos como primeira linha de tratamento para pacientes com delirium hiperativo.

d) Passagem de sonda nasoenteral em caso de delirium hipoativo, a fim de garantir via de alimentação para estes pacientes e evitar broncoaspiração.

e) Tratar o quadro infeccioso, evitar/tratar dor, constipação e distúrbios hidroeletrólíticos são as medidas mais eficazes para evitar que este paciente apresente delirium, seja ele hiper ou hipoativo.

19) Em relação a demência por corpos de Lewy (DCL), assinale a alternativa correta.

- a) Alucinações visuais detalhadas são mais comuns na DCL do que na Doença de Alzheimer e quando estão associadas a agitação psicomotora, podemos lançar mão de medicações sedativas, como Diazepam.
- b) O déficit de dopamina é mais pronunciado na Doença de Alzheimer do que na DCL, o que justifica uma pior resposta aos anticolinesterásicos na DCL.
- c) A disfunção autonômica pode ocorrer de maneira precoce na doença e levar a instabilidade postural, quedas de repetição e hipotensão ortostática.**
- d) Levodopa é a terapia de escolha para os sintomas motores, dada a resposta significativa à medicação.
- e) Sintomas depressivos associados à DCL são frequentes e os antidepressivos tricíclicos estão indicados para o tratamento.

20) Um homem de 80 anos com histórico de hipertensão arterial, dor neuropática e insônia crônica está em uso regular de

anlodipino, hidroclorotiazida, pregabalina e lorazepam para dormir. Ele relata episódios de tontura ao se levantar, quedas recentes e dificuldade para se concentrar durante o dia, além de esquecimentos. Qual é a melhor estratégia inicial para manejo deste caso?

- a) Desmame e suspensão de lorazepam com introdução de um antidepressivo tricíclico com Amitriptilina para insônia.
- b) Solicitar medida residencial da pressão arterial e considerar introdução um terceiro antihipertensivo pois os sintomas que o paciente relata são sugestivos e hipertensão arterial mal controlada.
- c) Avaliar interações medicamentosas, suspensão de lorazepam e introdução de medidas não farmacológicas para tratar a insônia.**
- d) Introduzir medicação para proteção gástrica, como Omeprazol, uma vez que paciente apresenta polifarmácia.
- e) Manter o esquema terapêutico uma vez que paciente necessita de todas as medicações e investigar possível quadro demencial.

PROVA DE GERIATRIA – SEGUNDA CHAMADA - TXXII

Q.1 (0.80) - Qual das alternativas abaixo melhor descreve a definição de insuficiência cardíaca?

a) Qualquer alteração estrutural cardíaca detectada ao ecocardiograma, mesmo sem sintomas.

b) Presença de sinais e/ou sintomas de insuficiência cardíaca associados a anormalidades cardíacas estruturais/funcionais, com elevação de peptídeos natriuréticos ou evidência de congestão

c) Alterações estruturais ou funcionais do coração sem relação com sintomas.

d) Redução obrigatória da fração de ejeção ventricular esquerda (FEVE < 40%).

e) Síndrome clínica que exige elevação isolada de peptídeos natriuréticos para diagnóstico

Q.2 (0.80) - A fragilidade aumenta o risco de complicações aguda e crônicas, aumentando a prevalência de mortalidade do paciente idoso. Assim é de suma importância agirmos precocemente nos seu tratamento que se baseia:

a) Em acompanhamento interdisciplinar, com prescrição de suplementos como a creatina e indicação de hidroginástica.

b) Reposição de testosterona intramuscular, exercícios físicos resistidos e de equilíbrio.

c) Promover mudança ambiental para evitar quedas, reposição de vitamina D e cálcio e testosterona gel.

d) Atuar na polifarmácia e estimular exercícios aeróbicos.

e) Uso de dieta mais rica em aminoácidos e proteínas, exercícios resistidos e multicomponentes, diminuir a polifarmácia.

Q.3 (0.80) - Em relação à dor no idoso, qual afirmação é verdadeira?

a) Medicamentos adjuvantes com Duloxetina e Pregabalina tem papel apenas no tratamento da dor aguda.

b) O uso de adjuvantes no manejo farmacológico da dor permite uso de doses menores de opióides e potencializa a analgesia.

c) Escalas de avaliação de dor não são úteis para pacientes com demência.

d) Idosos apresentam maior sensibilidade a estímulos dolorosos viscerais

e) A experiência da dor no idoso está dissociada de fatores emocionais.

Q.4 (0.80) - Sobre a osteoporose no paciente idoso, assinale a alternativa correta:

a) O FRAX score não deve ser realizado em pacientes com densitometrias normais ou com osteopenia, pois a densitometria é o padrão-ouro no diagnóstico de osteoporose e o FRAX mesmo com elevado risco de fratura, não muda a conduta de não tratar osteoporose nesses casos

b) As terapias anabólicas ósseas (p. ex. Romosozumabe) podem auxiliar o tratamento de pacientes com alto risco de fraturas ou naqueles que já possuem fraturas, sendo obrigatório realizar terapia antirreabsortiva (p. ex. Ácido Zoledrônico) após o uso das medicações anabólicas

c) A indicação do Ministério da Saúde é de que a densitometria óssea (DMO) seja realizada em mulheres acima de 65 anos e homens acima de 70 anos, não sendo indicada realizar em idades menores quando presentes fatores de risco para osteoporose, como menopausa precoce;

d) O diagnóstico da osteoporose densitométrica, se baseia nos valores de Z escore, esse escore é a comparação do paciente com pessoas de mesma idade e características, sendo o Z escore menor que -2,5 diagnóstico de osteoporose;

e) A suplementação com Vitamina D e Cálcio deve ser realizada apenas nos pacientes com baixo nível socioeconômico, pois são eles que não conseguem atingir a ingesta adequada desses elementos com a alimentação

Q.5 (0.80) - Sra. de 74 anos, tem doença de Alzheimer há 7 anos, com períodos de disfagia para líquidos nas últimas semanas. Teve um engasgo importante com chá há 3 dias. Há 1 dia vem tendo quadro de tosse produtiva, sem expectoração, agitação psicomotora com insônia, sem febre e com dispneia associado. Exames físico: PA 115/80, FR 30, confusa. Tórax: mv crepitantes em base de pulmão direito. Diante do caso é verdadeiro afirmar:

a) Paciente será internado, com uso de oxigênio e antibioticoterapia com uso de amoxicilina + clavulanato.

b) Os principais germes envolvido neste caso seriam o S.Pneumoniae e Hemophilus influenzae.

c) Paciente precisa ser internado em ambiente hospitalar, onde usaremos uma quinolona respiratória.

d) Este paciente deverá se submeter a sonda nasoenteral para alimentação, oxigênio e uso de ceftriaxona + clindamicina.

e) O tratamento deverá ocorrer em ambiente domiciliar, com aporte de oxigênio e prescrição de ceftriaxona + macrolídeo.

Q.6 (0.80) - Hipertensão arterial no idoso é muito frequente, com características próprias dessa faixa etária:

I - Nos idosos, há especial preocupação com a aferição da PA, pois o envelhecimento está frequentemente associado à disfunção barorreflexa e, consequentemente, à maior possibilidade de hipotensão postural e pós-prandial, o que acontece em razão do inadequado aumento da FC com a queda do débito cardíaco.

II – Nos pacientes idosos, a medida da PA deve ser sempre realizada com o paciente de pé, em todas as consultas, para avaliar a presença de hipotensão ortostática, que, quando presente, determina que se considere a PA aferida com o paciente sentado como a medida padrão.

III – A manobra de Osler deve ser utilizada quando há suspeita de pseudo-hipertensão e consiste na palpação da artéria radial enquanto o cuff está sendo insuflado para assegurar que a onda de pulso realmente desapareça.

IV - Pacientes com idade avançada, acima de 80 anos, devem ter o tratamento criterioso, não seguindo as metas exigidas pelas diretrizes.

Assinale a correta:

a) Apenas I e III

b) Todas estão corretas.

c) Apenas II e III

d) Apenas I e II

e) Apenas I, II e IV

Q.7 (0.80) - Sobre os cuidados paliativos no paciente idoso, assinale a alternativa correta:

a) Caso a família solicite que seja realizada reanimação cardiopulmonar em um paciente terminal e em cuidados paliativos que evolua para parada cardiorrespiratória durante internação por progressão da doença de base, devemos imediatamente realizá-la para conforto da família

b) Pacientes com insuficiência cardíaca não se beneficiam de cuidados paliativos, pois sempre podemos realizar ajustes terapêuticos e novas intervenções, incluindo transplante cardíaco, para melhorar o quadro dos pacientes.

c) Em pacientes com demência em estágios avançados, já sem comunicação e acamados, quando apresentarem

dificuldade em se alimentar, devemos sempre indicar uma via de alimentação alternativa como Sonda Nasoenterica ou Gastrostomia para garantir adequado aporte nutricional.

d) Um dos objetivos dos cuidados paliativos é proporcionar uma “boa morte”, trazendo mais conforto para o paciente e família, por isso, em pacientes que apresentem sintomas refratários à múltiplas terapias e que tragam sofrimento ao mesmo e a família, podemos iniciar a sedação paliativa com objetivo de somente melhorar os sintomas, sem acelerar o processo de óbito.

e) Quando diagnosticamos um paciente com uma doença grave, intratável e que incorra em risco para saúde do paciente, devemos omitir o prognóstico até que chegue na fase terminal, para que o paciente não sofra com ansiedade e outros transtornos psíquicos que podem ocorrer por conta da comunicação do diagnóstico.

Q.8 (0.80) - Em relação ao tratamento da constipação

intestinal, qual é a abordagem inicial recomendada?

a) Terapia combinada de laxantes estimulantes e emolientes desde o início.

b) Indicação imediata de antagonistas opioides para constipação por opioides.

c) Medidas não farmacológicas, incluindo dieta rica em fibras, hidratação adequada e atividade física.

d) Uso de laxantes osmóticos para todos os pacientes.

e) Uso de enemas frequentes para prevenir fecalomas.

Q.9 (0.80) - Sobre as quedas no paciente idoso, é incorreto dizer:

a) Como, onde e quando a queda ocorreu são perguntas essenciais para direcionar a investigação dos fatores envolvidos e/ou desencadeantes da queda.

b) A mensuração da pressão deitado e depois em pé é de grande utilidade na investigação de quedas.

c) As medicações com maior potencial de risco para quedas são os hipnóticos sedativos.

d) A ptofobia é o medo de cair novamente, onde faz com que o paciente se movimente cada vez menos, aumentando o risco de quedas.

e) A maioria das quedas no idoso ocorrem fora do domicílio devido a calçadas mal adaptadas e irregulares, e sem histórico de quedas anteriores.

Q.10 (0.80) - Sobre a incontinência urinária no paciente idoso, assinale a alternativa correta:

a) Terapias não farmacológicas são sempre a primeira escolha,

independentemente do tipo de incontinência, pois possuem benefício maior ou semelhante aos tratamentos farmacológicos e quase não possuem efeitos colaterais;

b) A incontinência urinária de esforço é mais prevalente em homens, devido a doenças da próstata acometerem a inervação do esfíncter e isso ocasionar disfunção no controle involuntário da micção.

c) No tratamento dos pacientes com incontinência urinária, sempre devemos tranquilizar os pacientes quanto ao prognóstico, pois na quase totalidade dos casos obteremos resolução completa dos sintomas, com os pacientes atingindo continência completa.

d) No tratamento da incontinência urinária de urgência, podemos fazer uso de medicações que atuem diminuindo o tônus simpático, como os beta- antagonistas como a Mirabegrona e medicações que aumentam o tônus parassimpático como os agonistas muscarínicos como a Oxibutinina, Tróspio e Solifenacina.

e) Um paciente que apresente com vontade de urinar, mas que durante o deslocamento para o banheiro não consiga reter a urinar e acabe tendo escape antes de chegar ao mictório, por definição possui uma incontinência urinária por extravasamento.

PROVA DE EXAME – GERIATRIA – TXX

- 1) A Obstipação Intestinal é um sintoma de incidência de 50% em casas de repouso, podendo ter causas orgânicas ou funcionais. Sendo assim é falso afirmar:
 - a) O uso de anticolinérgicos e antiinflamatórios são causas de obstipação.
 - b) O Fecaloma é uma complicação da obstipação intestinal, podendo ter o paciente a diarreia paradoxal.
 - c) Os critérios de Roma para obstipação intestinal evidencia que o paciente precisa de um quadro de evolução de há 30 dias nos últimos 6 meses.**
 - d) As antraquinonas como o Sene, podem causar Melanosis coli.
 - e) O domperidone e a bromoprida são adjuvantes no tratamento da obstipação.

- 2) Paciente de 78 anos é trazido pelos filhos com sintomas de alucinações, confusão mental, agitação psicomotora há 4 dias. Família relata urina com odor fétido, sem disúria, mas com incontinência urinária associada neste período. Conforme o caso relatado é verdadeiro dizer:
 - a) Trata-se de um quadro de Demência por Corpus de Lewy.
 - b) As hipóteses diagnósticas seriam Demência de Alzheimer com infecção urinária.
 - c) O diagnóstico mais provável seria de Demência Vascular por acidente vascular cerebral.
 - d) As hipóteses diagnósticas seriam delirium com infecção do trato urinário.**
 - e) O uso da rivastigmina traria benefícios a este paciente, devido a melhora cognitiva.

- 3) Sobre a Hipertensão Arterial no Idoso é incorreto afirmar:
 - a) Para afastar a Hipertensão do Jaleco Branco, devemos pedir ao paciente um MAPA ou uma Medida Residencial da Pressão Arterial.
 - b) Paciente com 68 anos, obesa, com intolerância a glicose; as medicações mais adequadas seriam um tiazídico, um betabloqueador ou IECA.**
 - c) Na Hipertensão Renovascular poderemos ter um sopro abdominal em lojas renais e resistência a terapia medicamentosa.
 - d) Pacientes com HAS e com disfunção ventricular de origem diastólica, podem ter a indicação de Betabloqueadores.
 - e) Os betabloqueadores teriam uma boa indicação em pacientes coronariopatas.

- 4) P.S., 86 anos, chega ao PS com tosse com catarro amarelo, dispnéia ao repouso, sem febre há 2 dias. Paciente é acamado em uso de sonda nasoenteral, que segundo a família relata que o paciente teve regurgitação de dieta com engasgos e tosse, antes de começar o quadro pulmonar. No exame físico apresentava dispneico, sat O2 88%, afebril. Roncos difusos e estertores em base pulmonar direita. Com isso qual seria o

melhor tratamento para este paciente?

- a) Tratar em casa e usar Amoxicilina + Clavulanico.
- b) Tratar em casa usando ceftriaxona intramuscular.
- c) Internar e usar Ceftriaxona + clindamicina**
- d) Internar e usar Levofloxacino.
- e) Internar e usar cefalosporina de 1ª geração.

5) Paciente do sexo feminino, 69 anos, traz ao consultório exame de Densitometria Óssea mostrando resultado de Osteoporose. Exames de sangue normais. Paciente sem queixa clínica. Nega fraturas anteriores. Qual seria o seu tratamento:

- a) Raloxifeno e Carbonato de Cálcio 500mg
- b) Bifosfonato
- c) Teriparatida
- d) Bifosfonato e Colecalciferol 50.000ui 1x semana por 60 dias
- e) Bifosfonato e Cálcio Citrato Malato 500mg 2x ao dia.**

6) Paciente feminina, 78 anos, portadora de HAS, DMII e osteoporose, sofreu duas quedas da própria altura no último ano, sendo a última há 1 mês, em casa, após tropeçar no tapete levando a trauma em região frontal. Na avaliação geriátrica ampla apresenta Teste *get up and go* de 30 seg, escala yesavage 9, MEEM=25. Nesse caso, o fator que é o maior PREDITOR de futuras quedas para essa idosa é:

- a) Osteoporose
- b) Minimental
- c) A hipertensão
- d) A idade
- e) O teste get up and go**

7) Uma paciente idosa é trazida por seus filhos por quadro de alucinações visuais mais proeminente a noite, com insônia e agitação psicomotora. Qual seria o medicamento mais apropriado para o seu caso?

- a) Quetiapina**
- b) Melatonina
- c) Lorazepam
- d) Trazodona
- e) Zolpidem

8) A patologia tireoidiana mais comum no idoso é o hipotireoidismo, sendo a causa mais comum a Tireoidite de Hashimoto. Assim, é incorreto afirmar:

- a) A principal manifestação neuropática é a síndrome do túnel do carpo.
 - b) A alteração da glicose é a principal alteração metabólica.**
 - c) O tabagismo pode ser um fator desencadeador de Tireoidite de Hashimoto.
 - d) Pode haver alteração cardíaca como a insuficiência cardíaca e o derrame pericárdico.
 - e) A levotiroxina deve ser usada sempre em jejum, começando com doses pequenas.
- 9) Paciente com 78 com doença de Parkinson diagnosticada há 7 anos, usando levodopa em doses fracionadas e pramipexole. Nos últimos 30 dias vem tendo movimentos coreiformes em segmento cefálico. Diante do caso clínico, qual seria esta alteração e melhor conduta para este doente?
- a) Piora do quadro de parkinsonismo e aumentar a dose da levodopa.
 - b) Fenômeno wearing-off e aumentar dose de pramipexole.
 - c) Fenômeno coreico e associar outro agonista dopaminérgico.
 - d) Discinesia contínua e associar amantadina.**
 - e) Agitação psicomotora e associar quetiapina.
- 10) Paciente com 80 anos, com diagnóstico de Depressão Maior, pela escala de Yesavage, relata que tem gonartrose bilateral com dor em ambos os joelhos. Está em uso de glicosamina e condroitina com razoável melhora do quadro algico. Diante do caso depressivo e de artrose, qual seria o melhor medicamento em questão:
- a) Diazepam
 - b) Fluoxetina
 - c) Duloxetina**
 - d) Trazodona
 - e) Sertralina
- 11) Na doença de Alzheimer tem uma doença degenerativa, sem tratamento curativo e sim sintomático. É a demência mais comum em nosso meio. Assim podemos afirmar:
- a) Existe uma hiperfosforilação da proteína tau, levando ao aparecimento dos emaranhados neurofibrilares.**
 - b) Doenças metabólicas e cardiovasculares não estão relacionadas com o aparecimento da doença, e sim de causa genética na maioria dos casos.
 - c) A memantina está indicada a partir das fases leves da doença.
 - d) A proteína beta amiloide é uma lesão intracelular.
 - e) A disfagia aparece em fase precoce da patologia, necessitando o uso de sonda.
- 12) O idoso com diabetes mellitus e incontinência urinária de urgência, qual a droga devemos evitar para o tratamento do quadro glicêmico e não piora da incontinência urinária?

- a) Biguanidas
- b) Glitazonas
- c) Sulfoniuréias
- d) Inibidores da DPP4
- e) Inibidores da SGLT2**

13) Sra de 76 anos refere há meses polaciúria, nictúria e dizendo que quando sente vontade de urinar, não consegue chegar a tempo ao banheiro, tendo assim perdas de urina. Paciente tem como comorbidades DM II e DPOC. Qual seria o tratamento de escolha para essa paciente e que tipo de alteração urinária pode apresentar?

- a) Duloxetina e infecção urinária.
- b) Tolterodina e bexiga hiperativa.**
- c) Fisioterapia uroginecológica e incontinência urinária mista.
- d) Solifenacina e prolapso vesical
- e) Cirurgia tipo Sling e hiperreflexia do detrusor.

14) Pacientes idosos com depressão podem ter alterações do sono, como insônia ou sonolência. Dentre estes antidepressivos a abaixo, qual o único que não ajudaria na insônia de um paciente idoso com depressão?

- a) Doxepine
- b) Mirtazapina
- c) Sertralina**
- d) Trazodona
- e) Agomelatina

15) Idoso de 68 anos, comparece ao ambulatório de geriatria com queixas de tonturas tipo vertigem há 2 dias, que duram algumas horas, acompanhado de hipoacusia e zumbido bilateral. Nega vômitos. Antes desse quadro relata que tinha tonturas ao levantar da cama e da cadeira, com sensação de fraqueza geral há meses. Paciente tem como comorbidades DM II e HAS, usando medicações com bom controle. Baseado nessas queixas, quais os possíveis diagnósticos de paciente?

- a) Hipotensão Ortostática e Vertigem Posicional Paroxística Benigna.
- b) Doença de Menière e Neurite Vestibular
- c) Insuficiência Vertebro Basilar e Vertigem Paroxística Benigna
- d) Doença de Menière e Hipotensão Ortostática**
- e) Neurite Vestibular e Hipotensão Ortostática

16) Paciente com 77 anos, com crises hipertensivas frequentes nos últimos meses,

chegando a PA 220/110mmhg. Foi atendido no PS de sua cidade, aonde foi aumentado a dose máxima de anlodipino. Além disso, usa olmersartana, hidroclorotiazida e espirolactona. Paciente já teve IAM há 2 anos. Nega DM. Hoje vem ao consultório com PA de 170.90 e com várias medidas residências de PA alteradas. Diante do caso, qual seria a próxima droga a ser escolhida para a associação?

- a) Clonidina
- b) Furosemida
- c) IECA
- d) Metildopa
- e) Anlodipino**

17) No passado, acreditava-se que, para o indivíduo ser classificado como portador de demência, ele deveria apresentar perda de memória. Hoje sabe-se que existem diversos tipos de demências com quadros clínicos iniciais distintos. Qual das alternativas a seguir é caracterizada pela abertura do quadro demencial com alucinações visuais, parkinsonismo e distúrbio do sono REM?

- a) Demência frontotemporal.
- b) Demência vascular.
- c) Demência por corpúsculos de Lewy.**
- d) Hidrocefalia de pressão normal.
- e) Demência na Doença de Parkinson

18) Paciente feminina, com 80 anos, usando várias medicações, aonde se queixa de tremor em mãos, bilateral, mais ao repouso e bradicinesia, associado a obstipação intestinal crônica há 6 meses. Relata ter coxoartrose a direita, usando AINH para dor quase que diariamente nas últimas 3 semanas. Tem HAS com bom controle. Nega AVC ou IAM anterior. Refere também dor epigástrica e náuseas, com inapetência nos últimos 10 dias. Medicações: enalapril, atenolol, AAS, amitriptilina, diclofenaco sódico, dipirona, cinarizina, carbonato de cálcio (receitado pelo balconista de farmácia), metoclopramida, colágeno não hidrolisado tipo II. Quais as medicações você suspenderia nesta paciente devido as iatrogenias que vem tendo?

- a) Carbonato de cálcio e amitriptilina
- b) AAS, amitriptilina, diclofenaco, metoclopramida
- c) Carbonato de cálcio, AAS, diclofenaco, cinarizina, metoclopramida e amitriptilina**
- d) Diclofenaco, cinarizina, amitriptilina e AAS.
- e) Cinarizina, diclofenaco, amitriptilina e carbonato de cálcio.

19) Um paciente idoso com Pneumonia apresenta certas peculiaridades que são

incomuns em outras faixas etárias, que seriam:

- a) Ausência de febre, confusão mental e maior incidência de dor torácica.
- b) Confusão mental, tosse com pouca expectoração e febre frequente.
- c) Maior incidência de taquicardia, taquipneia e diminuição das atividades de vida diária.**
- d) Ausência de febre, hemograma com leucocitose com desvio a esquerda em todos os casos e raio X de tórax mostrando padrão alveolar de condensação.
- e) Taquipnéia frequente, delirium, presença de tosse com muita expectoração e dor torácica ventilatório dependente.

20) Paciente 70 anos, teve AVC isquêmico há 90 dias, aonde desde o internamento vem tendo quadro de confusão mental, choro fácil, repete assuntos, desorientação no tempo e espaço, não reconhece sua casa e sua esposa em certos momentos. Nega queixas cognitivas anteriormente. Qual possível hipótese diagnóstica para esse quadro?

- a) Doença de Alzheimer
- b) Demência Vascular**
- c) Comprometimento cognitivo leve
- d) Transtorno depressivo maior
- e) Demência por Corpos de Lewy

P2

Prova 2 T24 geriatria

- 1- Paciente com tontura rotacional associado a náusea e vômitos há 8h(episódio agudo), em repouso melhora e piora ao movimento, sem zumbido, sem perda auditiva associada:
 - a) labirintite – tto betaistina e ondasetrona (errada)
 - b) causa central (errada)
 - c) manobra de dix hallpike lá seria positivo (correta)
 - d) RVO seria positivo
 - e) ?
- 2- paciente DRC, usando AINE longa data, PA fora do limite porem era idoso FRÁGIL(então ele tem limite diferente – 145/90) -> idoso frágil ou com condições que comprometam a expectativa de vida, baixar a PA até o máximo tolerado;

R: suspender AINE pela DRC aumentar o enalapril;

- 3- idoso com DM em uso de metofrmina e glibenclamida, controle tava ok mas ele tinha muito sintoma de hipoglicemia, pedia como manejar:

R: Retirar glibenclamida

- 4- Paciente idoso com CURB2 por pneumonia, pedia como manejar:

R: Avaliar internação do paciente e usar ceftriaxona IV;

- 5- Diagnostico de osteoporose -> T-score < -2,5
- 6- Síndrome da fragilidade -> R: 3 critérios podemos fazer diagnostico
- 7- ICfEp tratamento -> apenas usamos diuretico(diminuir congestao) e ISGLT2, associado a controle de comorbidades para o tratamento;
- 8- Questao de vertigem -> R: hipotensao ortostatica comprovada diferença > 20mmHg;
- 9- Tratamento de dor moderada no idoso, não lembro resposta
- 10- Tratamento de IU no idoso -> tto não farmacologico sempre vem primeiro, era repetida;
- 11- Dor no idoso em cuidados paliativos -> uso de opioide forte e cuidar os efeitos colaterais, como constipação;
- 12- Sobre dor no idoso de novo, não lembro resposta
- 13- Demencia fronto temporal, pedia qual não era sintoma classico, era algo de alteração precoce de memoria
- 14- Queda no idoso, marcar incorreta -> falava que POMA era apenas equilibrio, mas é equilibrio e marcha
- 15- Uso de laxantes no idoso, não lembro resposta
- 16- A resposta correta era a que explicava bem certinho a fisiopatologia da osteoporose, das metaloproteinasas etc
- 17- Novamente osteoporose – não anotei porque era repetida das provas antigas
- 18- ICfEr em idoso com IAM prévio, qual medicmaneto associa -> BB, carvedilol
- 19- Uso de laxantes no idoso, novamente não lembro resposta
- 20- Quadro de hiperparatireoidismo no idoso -> comum tem o apatico

PROVA DE GERIATRIA – P2 – TXXI

Q.1 (0.50) - Sobre o tratamento farmacológico da dor crônica no idoso, marque V (verdadeiro) ou F (falso):

1. Os anti-inflamatórios são agentes eficazes na dor nociceptiva, mas devem ser utilizados apenas por curtos períodos.
2. Os relaxantes musculares podem ser úteis em situações específicas, como a fibromialgia e a dor pós-AVE, mas são pouco tolerados pelas pessoas idosas em razão de seus efeitos anticolinérgicos.
3. Os coxibes (como o celecoxibe), considerando-se os AINEs, são os mais indicados para os idosos, devido ao menor risco de sangramento gastrointestinal e de efeitos cardiovasculares.
4. A carbamazepina ainda é o tratamento de escolha para a neuralgia do trigêmeo, apesar de não ser o anticonvulsivante mais seguro para idosos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- a) F – F – V – V
- b) V – F – V – V
- c) V – V – F – F
- d) V – V – F – V**
- e) F – V – V – V

Q.2 (0.50) - Paciente do sexo feminino, 70 anos, hipertensa, má aderente ao tratamento, usando nifedipina e hidroclorotiazida, procura o ambulatório com queixas de dispneia aos médios esforços. Ao exame físico no momento, chamaram atenção apenas a PA de 160x95mmHg e discretas crepitações

bibasais pulmonares. O exame era um ecocardiograma que mostrava FE do VE de 38%. Sobre esse caso, assinale a alternativa correta:

- a) O uso de um diurético de alça seria mandatório, além da troca do bloqueador de canal de cálcio por um IECA.**
- b) Associar um betabloqueador como o carvedilol ao tratamento.
- c) Uma ótima opção terapêutica seria diltiazem, potente vasodilatador para controle da pressão, associado a furosemida.
- d) Deve-se controlar adequadamente a PA, e uma boa opção seria o início de um BRA associado a um IECA no esquema de tratamento.
- e) Suspender o bloqueador de canal de cálcio, passar espirolactona e digital.

Q.3 (0.50) - Paciente masculino, 80 anos, trazido por familiares que relatam quadro de tosse produtiva há uma semana e há dois dias sonolência diurna e períodos de agitação e delirium durante a noite. Chega ao pronto socorro sonolento, descorado +, desidratado ++, acianótico, afebril, PA 110 x 70mmHg, FC 101, FR 28, estertores crepitantes bibasais e no terço médio do HTE. Considerando-se a hipótese de PAC, qual análise de risco corresponde à conduta mais adequada para esse caso?

- a) Apresenta CURB-65 de 2 e, portanto, pode ser tratado no domicílio com terapia via oral ou sistema de Home Care, sendo o moxifloxacino o mais indicado para seu tratamento**

- b) Apresenta CURB-65 de 3 e, portanto, deve ser internado para tratamento, com consideração para internação em UTI de acordo com evolução e exames complementares.
- c) Apresenta CURB-65 de 1 com terapia via oral ou endovenosa de Levofloxacino.
- d) Apresenta CURB-65 de 2 e o antibiótico de eleição para o caso seria amoxicilina + clavulanato.
- e) Apresenta CURB-65 de 3 e, portanto, deve ser internado temporariamente em pronto-socorro por pelo menos 48 horas e avaliação de alta com terapia via oral após esse período.

Q.4 (0.50) - Paciente idosa, 83 anos vem ao consultório levado pela filha, com queixas déficit cognitivo e fraqueza muscular. Nega quedas ou outras queixas. Tem como exames laboratoriais TSH 7,8 e t4 livre normal, Colesterol total e frações normais, ANTI-TPO elevado. Diante do caso é correto dizer:

- a) A paciente apresenta Hipotireoidismo subclínico e conforme os exames apresentados devemos tratar.**
- b) O diagnóstico é de Tireoidite de Hashimoto, onde temos que esperar, pois a paciente não tem dislipidemia.
- c) O diagnóstico é de Hipotireoidismo Subclínico, onde não devemos tratar ainda, pois a paciente tem o TSH menor que 10.
- d) É um caso de Hipotireoidismo clínico e devemos iniciar Levotiroxina em dose padrão
- e) É um caso de Hipotireoidismo clínico devido a Tireoidite de Hashimoto, onde é necessário iniciar o tratamento.

Q.5 (0.50) - O diagnóstico da síndrome de IC é realizado por meio de história clínica e de exame físico detalhados. Sobre os achados semiológicos da IC, Assinale a alternativa correta.

- a) A ortopneia tem elevada especificidade para o diagnóstico da IC, sendo apresentada precocemente.
- b) A dispneia aos esforços é facilmente identificada em idosos e possui elevada especificidade para o diagnóstico da IC.
- c) O edema de tornozelo é um achado de alta especificidade para o diagnóstico de IC no idoso.
- d) Tosse seca geralmente ao deitar tem uma frequência elevada em pacientes idosos com ICC.

e) Distúrbios neuropsiquiátricos e sarcopenia podem atrasar o diagnóstico.

Q.6 (0.50) - Paciente idosa, 74 anos, vem ao consultório relatando um descontrole pressórico. Na MRPA os níveis tem chegado a 170.90. Paciente refere que não tem queixas clínicas. Está em uso de Valsartana e hidroclorotiazida em doses máximas. Tem exames laboratoriais que traz no consultório mostra glicemia jejum 156 Glicada 7,9, RFG 55 e potássio um pouco baixo. Não usa nenhuma medicação para DM. Qual alternativa correta para a paciente em questão:

- a) Associar um bloqueador de canal de cálcio, passar dieta e exercícios para controle pressórico e glicêmico e repositor de K.

b) Associar espirolactona, uma sulfoniuréia ao tratamento, junto com a dieta e exercícios.

c) Associar um bloqueador de canal de cálcio, suspender o diurético e passar um inibidor da SGLT-2.

d) Passar medidas somente não farmacológicas e repositor de K devido a hipocalemia.

e) Orientar quanto a dieta correta, prática de atividade física, suspender diurético e usar insulina.

Q.7 (0.50) - O transtorno depressivo no idoso causa um impacto significativo na vida do paciente, sendo que o seu diagnóstico muitas vezes é negligenciado e subtratado. Sendo assim é correto dizer:

a) Sentimentos de culpa e menos valia são menos comuns em depressão de início tardio.

b) A escolaridade e a doença cerebrovascular não são fatores de risco para depressão no idoso.

c) Os homens são os que tem mais sintomas e maior possibilidade de apresentação atípica.

d) A depressão subsindromica não preenche os critérios para depressão maior e não causa o mesmo tipo de incapacidade.

e) Na depressão de início tardio, o fator genético é de suma importância, e por isso deve ser investigado.

Q.8 (0.50) - As tonturas no idoso tem como o desafio o preciso diagnóstico, pois há mais de 60 enfermidades causadoras de

distúrbios de equilíbrio. Sendo assim é correto afirmar:

a) A quantidade de comorbidades não interfere na maior incidência de tonturas.

b) A vertigem de origem periférica tem um desequilíbrio importante com duração rápida.

c) A vertigem posicional paroxística benigna tem vertigem, náuseas, zumbido e nistagmo.

d) O envelhecimento leva a diminuição da sensibilidade proprioceptiva, do reflexo de aquileu e aumento da oscilação postural.

e) A vertigem ocorre exclusivamente em causas periféricas de tonturas.

Q.9 (0.50) - Quanto ao diagnóstico da síndrome de fragilidade, analise as alternativas a seguir e marque V (verdadeiro) ou F (falso).

- Alguns exames laboratoriais podem confirmar ou descartar essa condição.

- O melhor critério para se definir o idoso frágil é a Avaliação Geriátrica Ampla.

- Na prática clínica, utiliza-se a dosagem de interleucina 6 e 2 (IL-6 e IL-2) e fator de necrose tumoral para identificação de marcadores biológicos associados à fragilidade.

- O diagnóstico da síndrome de fragilidade é clínico.

a) V — V — F — F

b) F — F — V — V

c) V — F — V — F

d) V — V — V — F

e) F — V — F — V

Q.10 (0.50) - Assinale a alternativa correta sobre o antidepressivo capaz de prolongar o intervalo QT e causar hiponatremia:

- a) Nortriptilina
- b) Citalopram**
- c) Sertralina
- d) Duloxetina
- e) Venlafaxina

Q.11 (0.50) - Homem, 82 anos, professor universitário aposentado, viúvo, comparece no ambulatório de geriatria para avaliação geral, acompanhado de seu filho. É portador de hipertensão arterial e faz tratamento para depressão desde que a sua esposa faleceu, há cerca de dois anos. Não apresenta queixas específicas, refere que tem estado relativamente bem, exceto uma sensação de cansaço, descrita também como falta de energia, o que atribui ser “da idade”. Ao ser questionado, o filho se mostra preocupado com o fato de que seu pai vem perdendo peso progressivamente, associado à diminuição de apetite. Há seis meses, tropeçou num pequeno degrau em casa e caiu da própria altura; teve um trauma leve na coxa direita, mas desde então, passou a caminhar mais lentamente, a se apoiar nos objetos e nas paredes, alegando medo de outra queda. Além do mais, tem evitado sair de casa e deixou de fazer aula de pilates. Faz uso de enalapril, fluoxetina e se automedica com complexo vitamínico, para “sentir-se mais forte”. peso – 58,3kg; altura – 1,67m; IMC – 20,9kg/m²; perda de 4kg no último ano; bom estado geral; pressão arterial: 120/75mmHg (sentado) e 115/70mmHg (em pé); FC: 80, R. O exame segmentar do

paciente não apresentou alterações relevantes, assim como o neurológico não apresentou déficits focais. A AGA do paciente revelou: função sensorial satisfatória; cognição sem alterações dignas de nota; boa capacidade funcional para as ABVDS e AIVDS, necessitando apenas de auxílio para caminhar. tem critérios diagnósticos de depressão, com diminuição de interesse e humor deprimido, além de redução de apetite. Risco nutricional, de acordo com o uso de instrumento Miniavaliação nutricional (MAN). Como conduta foram solicitados exames gerais, cujos resultados foram dentro da normalidade. Diante do caso clínico, qual a conduta correta?

- a) Encaminhado a fisioterapia para exercícios de treino da marcha, fortalecimento e equilíbrio; dieta hiperproteica e trocado fluoxetina por mirtazapina.**
- b) Trocado fluoxetina por mirtazapina e encaminhado a fisioterapia para treino da marcha.
- c) Trocado fluoxetina por mirtazapina e dieta hiperproteica.
- d) Encaminhado a fisioterapia para exercícios de treino da marcha, fortalecimento e equilíbrio; trocado fluoxetina por sertralina.
- e) Mantido a fluoxetina, encaminhado a fisioterapia para exercícios para fortalecimento, equilíbrio e dieta hiperproteica.

Q.12 (0.50) - São medicações ou medidas de escolha para os cuidados nas últimas 48 horas de vida, EXCETO

- a) Benzodiazepínicos, como o midazolam, quando há indicação de sedação paliativa
- b) Analgésicos opioides, para controle da dispneia e da dor
- c) AAS e estatinas, em pacientes com alto risco cardiovascular.**
- d) Suspender a dieta por via enteral ou parenteral.
- e) Anticolinérgicos, como atropina e escopolamina, para controle de secreções.

Q.13 (0.50) - Sobre o hipertireoidismo no idoso é incorreto afirmar:

- a) No caso de um TSH baixo, repetir o exame em 1 a 3 meses, com t4 livre, t3 e ultrassom de tireoide.
- b) A droga de escolha para o tratamento é o metimazol.
- c) A maioria dos pacientes chegam ao eutireoidismo após 3 semanas, após uso da medicação.**
- d) Na doença de graves com hipertireoidismo subclínico, com TSH entre 0,1 e 0,4 mUI/ml, em idosos com mais de 65 anos, com fatores de risco cardiovascular ou comorbidades, deve se usar medicamento antitireoidiano.
- e) O hipertireoidismo está associado a aumento da remodelagem óssea, aumenta a incidência de fraturas, sendo que o hipertireoidismo subclínico tem repercussões semelhantes na mulher pós-menopausa.

Q.14 (0.50) - N.M., 74 anos, parda, queixa-se de perdas urinárias há cerca de cinco anos. Refere que apresenta escapes de

urina quando tosse ou espirra e que se preocupa em sempre ir imediatamente ao banheiro quando percebe o desejo de urinar, para evitar as perdas. Além disso tem urgência miccional, nictúria, sem outros sintomas. Aderiu ao uso de absorventes desde que veio molhada da igreja há dois anos, e desde então deixou de frequentar o seu grupo de oração. Evita ficar com a bexiga cheia, pois não consegue segurar por muito tempo. Diz que tem vontade de urinar e tem que ir logo, pois se não perde urina. Tem antecedentes de hipertensão arterial sistêmica, hipotireoidismo, diabetes, asma e depressão. Faz uso regular de: duloxetina 60mg; Losartana 50mg; HCTZ 25mg; Levotiroxina 50mcg e dapaglifozina. Marque a alternativa correta:

- a) Caso de Incontinência urinária de esforço; pedir parcial de urina e ecografia pélvica.
- b) Incontinência urinária mista, onde está indicado somente uso de medicações antimuscarínicas e/ou da mirabegrona.
- c) O estudo urodinâmico seria imprescindível neste paciente.
- d) Paciente tem Incontinência urinária mista; pedir exames laboratoriais como glicemia jejum, eletrólitos, ureia, creatinina, parcial de urina e ecografia pélvica.**
- e) Estamos diante de um caso de IU de urgência, onde o uso de oxibutinina ou darifenacina melhoraria o quadro.

Q.15 (0.50) - Sobre as quedas no paciente idoso, é incorreto dizer:

- a) O exame dos pés e dos calçados que o paciente usa são fundamentais para evitar quedas.
- b) A ptofobia é o medo de cair novamente, onde faz com que o paciente se movimente cada vez menos.
- c) A suplementação de b12 e cálcio ajudam no tratamento preventivo de quedas.**
- d) As medicações com maior potencial de risco para quedas são os hipnóticos sedativos.
- e) Como, onde e quando a queda ocorreu são perguntas essenciais para direcionar a investigação dos fatores envolvidos e/ou desencadeantes da queda.

Q.16 (0.50) - Hipertensão arterial no idoso é muito frequente, com características próprias dessa faixa etária:

I - Nos idosos, há especial preocupação com a aferição da PA, pois o envelhecimento está frequentemente associado à disfunção barorreflexa e, conseqüentemente, à maior possibilidade de hipotensão postural e pós-prandial, o que acontece em razão do inadequado aumento da FC com a queda do débito cardíaco.

II – Nos pacientes idosos, a medida da PA deve ser sempre realizada com o paciente de pé, em todas as consultas, para avaliar a presença de hipotensão ortostática, que, quando presente, determina que se considere a PA aferida com o paciente sentado como a medida padrão.

III – A manobra de Osler deve ser utilizada quando há suspeita de pseudo-hipertensão

e consiste na palpação da artéria radial enquanto o cuff está sendo insuflado para assegurar que a onda de pulso realmente desapareça.

IV - Pacientes com idade avançada, acima de 80 anos, devem ter o tratamento criterioso, não seguindo as metas exigidas pelas diretrizes.

Assinale a correta:

- a) Apenas I e II
- b) Apenas II e III
- c) Apenas I e III
- d) Todas estão corretas.**
- e) Apenas I, II e IV

Q.17 (0.50) - Sra. de 74 anos, tem doença de Alzheimer há 7 anos, com períodos de disfagia para líquidos nas ultimas semanas. Teve um engasgo importante com chá há 3 dias. Há 1 dia vem tendo quadro de tosse produtiva, sem expectoração, agitação psicomotora com insônia, sem febre e com dispneia associado. Exames físico: PA 115/80, FR 30, confusa. Tórax: mv crepitantes em base de pulmão direito. Diante do caso é verdadeiro afirmar:

- a) Paciente precisa ser internado em ambiente hospitalar, onde usaremos uma quinolona respiratória.
- b) O tratamento deverá ocorrer em ambiente domiciliar, com aporte de oxigênio e prescrição de ceftriaxona + macrolídeo.
- c) Este paciente deverá se submeter a sonda nasoenteral para alimentação, oxigênio e uso de ceftriaxona + azitromicina.

d) Paciente será internado, com uso de oxigênio e antibioticoterapia com uso de piperacilina\tazobactan.

e) Os principais germes envolvido neste caso seriam o S.Pneumoniae e Hemophilus influenzae.

Q.18 (0.50) - A dispneia é um sintoma comum em pacientes terminais. Nos pacientes que apresentam quadro de dispneia grave, a opção ideal de tratamento é:

- a) fenobarbital e clonazepam
- b) tramadol e quetiapina.
- c) morfina e tramadol
- d) fenobarbital e midazolam.
- e) morfina e midazolam.**

Q.19 (0.50) - Paciente de 73 anos, com queixas de dificuldade para dormir, com sensação de queimação nas pernas quando está na cama. Diz que precisa levantar para melhorar, associado a ansiedade. Diante do caso, o que podemos considerar como verdadeiro:

- a) É muito frequente em pacientes com Doença de Parkinson e Insuficiência renal crônica.**
- b) O neurotransmissor envolvido na patologia é a serotonina.
- c) Durante a investigação da SPI, devem-se solicitar exames de sangue para verificar níveis de ferro, ferritina, ureia, creatinina, TSH e vitamina B12.
- d) Essa alteração não é comum em pacientes com demência.
- e) A gabapentina é a primeira opção de tratamento.

Q.20 (0.50) - Quanto à conduta sugerida para um paciente idoso de 80 anos, com DM2, em uso de metformina e glicazida, com bom controle glicêmico, internado eletivamente para a realização de uma colecistectomia, assinale a alternativa correta:

- a) Suspende as medicações antes do procedimento e introduzir insulina regular de acordo com o controle glicêmico.**
- b) Suspende a metformina apenas pelo risco de acidose láctica, mantendo a gliclazida.
- c) Trocar a metformina e a gliclazida por um inibidor da DPP4, pelo baixo risco de hipoglicemia
- d) Manter a metformina e a gliclazida
- e) Fazer somente insulina nph durante o internamento e controle dos picos glicêmicos com insulina regular.

COMPILADO DE PROVAS – P2

GERIATRIA

QUESTÕES

1) Sobre o tratamento farmacológico da dor crônica no idoso, marque V (verdadeiro) ou F (falso):

1.Os anti-inflamatórios são agentes eficazes na dor nociceptiva, mas devem ser utilizados apenas por curtos períodos.

2.Os relaxantes musculares podem ser úteis em situações específicas, como a fibromialgia e a dor pós-AVE, mas são pouco tolerados pelas pessoas idosas em razão de seus efeitos anticolinérgicos.

3.Os coxibes (como o celecoxibe), considerando-se os AINEs, são os mais indicados para os idosos, devido ao menor risco de sangramento gastrointestinal e de efeitos cardiovasculares.

4.A carbamazepina ainda é o tratamento de escolha para a neuralgia do trigêmeo, apesar de não ser o anticonvulsivante mais seguro para idosos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- a) F – F – V – V
- b) V – F – V – V
- c) V – V – F – F
- d) **V – V – F – V**

e) F – V – V – V

2) Paciente do sexo feminino, 70 anos, hipertensa, má aderente ao tratamento, usando nifedipina e hidroclorotiazida, procura o ambulatório com queixas de dispnéia aos médios esforços. Ao exame físico no momento, chamaram atenção apenas a PA de 160x95mmHg e discretas crepitações bibasais pulmonares. O exame era um ecocardiograma que mostrava FE do VE de 38%. Sobre esse caso, assinale a alternativa correta:

- a) **O uso de um diurético de alça seria mandatório, além da troca do bloqueador de canal de cálcio por um IECA.**
- b) Associar um betabloqueador como o carvedilol ao tratamento.
- c) Uma ótima opção terapêutica seria diltiazem, potente vasodilatador para controle da pressão, associado a furosemida.
- d) Deve-se controlar adequadamente a PA, e uma boa opção seria o início de um BRA associado a um IECA no esquema de tratamento.

e) Suspender o bloqueador de canal de cálcio, passar espirolactona e digital.

3) Paciente masculino, 80 anos, trazido por familiares que relatam quadro de tosse produtiva há uma semana e há dois dias sonolência diurna e períodos de agitação e delirium durante a noite. Chega ao pronto socorro sonolento, descorado +, desidratado ++, acianótico, afebril, PA 110 x 70mmHg, FC 101, FR 28, estertores crepitantes bibasais e no terço médio do HTE. Considerando-se a hipótese de PAC, qual análise de risco corresponde à conduta mais adequada para esse caso?

a) Apresenta CURB-65 de 2 e, portanto, pode ser tratado no domicílio com terapia via oral ou sistema de Home Care, sendo o moxifloxacino o mais indicado para seu tratamento

b) Apresenta CURB-65 de 3 e, portanto, deve ser internado para tratamento, com consideração para internação em UTI de acordo com evolução e exames complementares.

c) Apresenta CURB-65 de 1 com terapia via oral ou endovenosa de Levofloxacino.

d) Apresenta CURB-65 de 2 e o antibiótico de eleição para o caso seria amoxicilina + clavulanato.

e) Apresenta CURB-65 de 3 e, portanto, deve ser internado temporariamente em pronto-socorro por pelo menos 48 horas e avaliação de alta com terapia via oral após esse período.

4) Paciente idosa, 74 anos, com sobrepeso, vem ao consultório relatando um descontrole pressórico. Na MRPA os níveis tem chegado a 170.90. Paciente refere fraqueza muscular e câimbras. Está

em uso de Valsartana e hidroclorotiazida em doses máximas. Tem exames laboratoriais que traz no consultório mostra glicemia jejum 156 Glicada 7,9, RFG 55 e potássio baixo, com valor 2,9 Não usa nenhuma medicação para DM. Qual alternativa correta para a paciente em questão:

a) Associar um bloqueador de canal de cálcio, suspender o diurético e passar dapaglifozina.

b) Passar medidas não farmacológicas e repositor de K devido a hipocalemia.

c) Orientar quanto a dieta correta, prática de atividade física, suspender diurético e usar insulina.

d) Associar espirolactona, uma sulfoniuréia ao tratamento, junto com a dieta e exercícios.

e) Associar um bloqueador de canal de cálcio, passar dieta e exercícios para controle pressórico e glicêmico e repositor de K.

5) Paciente idosa, 83 anos vem ao consultório levado pela filha, com queixas déficit cognitivo e fraqueza muscular. Nega quedas ou outras queixas. Tem como exames laboratoriais TSH 7,8 e t4 livre normal, Colesterol total e frações normais, ANTI-TPO elevado. Diante do caso é correto dizer:

a) A paciente apresenta Hipotireoidismo subclínico e conforme os exames apresentados devemos tratar.

b) O diagnóstico é de Tireoidite de Hashimoto, onde temos que esperar, pois a paciente não tem dislipidemia.

c) O diagnóstico é de Hipotireoidismo Subclínico, onde não devemos tratar

- ainda, pois a paciente tem o TSH menor que 10.
- d) É um caso de Hipotireoidismo clínico e devemos iniciar Levotiroxina em dose padrão
- e) É um caso de Hipotireoidismo clínico devido a Tireoidite de Hashimoto, onde é necessário iniciar o tratamento.
- 6) O diagnóstico da síndrome de IC é realizado por meio de história clínica e de exame físico detalhados. Sobre os achados semiológicos da IC, Assinale a alternativa correta.
- a) A ortopneia tem elevada especificidade para o diagnóstico da IC, sendo apresentada precocemente.
- b) A dispneia aos esforços é facilmente identificada em idosos e possui elevada especificidade para o diagnóstico da IC.
- c) O edema de tornozelo é um achado de alta especificidade para o diagnóstico de IC no idoso.
- d) Tosse seca geralmente ao deitar tem uma frequência elevada em pacientes idosos com ICC.
- e) Distúrbios neuropsiquiátricos e sarcopenia podem atrasar o diagnóstico.**
- 7) A fragilidade aumenta o risco de complicações aguda e crônicas, aumentando a prevalência de mortalidade do paciente idoso. Assim é de suma importância agirmos precocemente no seu tratamento que se baseia:
- a) Uso de dieta mais rica em aminoácidos e proteínas, exercícios resistidos e multicomponentes, diminuir a polifarmácia.**
- b) Atuar na polifarmácia e estimular exercícios aeróbicos.
- c) Reposição de testosterona intramuscular, exercícios físicos resistidos e de equilíbrio.
- d) Promover mudança ambiental para evitar quedas, reposição de vitamina D e cálcio e testosterona gel.
- e) Em acompanhamento interdisciplinar, com prescrição de suplementos como a creatina e indicação de hidroginástica.
- 8) Paciente idosa, 74 anos, vem ao consultório relatando um descontrole pressórico. Na MRPA os níveis tem chegado a 170.90. Paciente refere que não tem queixas clínicas. Está em uso de Valsartana e hidroclorotiazida em doses máximas. Tem exames laboratoriais que traz no consultório mostra glicemia jejum 156 Glicada 7,9, RFG 55 e potássio um pouco baixo. Não usa nenhuma medicação para DM. Qual alternativa correta para a paciente em questão:
- a) Associar um bloqueador de canal de cálcio, passar dieta e exercícios para controle pressórico e glicêmico e repositor de K.
- b) Associar espirolactona, uma sulfoniuréia ao tratamento, junto com a dieta e exercícios.
- c) Associar um bloqueador de canal de cálcio, suspender o diurético e passar um inibidor da SGLT-2.**
- d) Passar medidas somente não farmacológicas e repositor de K devido a hipocalemia.
- e) Orientar quanto a dieta correta, prática de atividade física, suspender diurético e usar insulina.

9) As tonturas no idoso tem como o desafio o preciso diagnóstico, pois há mais de 60 enfermidades causadoras de distúrbios de equilíbrio. Sendo assim é correto afirmar:

- a) A quantidade de comorbidades não interfere na maior incidência de tonturas.
- b) A vertigem de origem periférica tem um desequilíbrio importante com duração rápida.
- c) A vertigem posicional paroxística benigna tem vertigem, náuseas, zumbido e nistagmo.
- d) O envelhecimento leva a diminuição da sensibilidade proprioceptiva, do reflexo de aquileu e aumento da oscilação postural.**
- e) A vertigem ocorre exclusivamente em causas periféricas de tonturas.

10) Quanto ao diagnóstico da síndrome de fragilidade, analise as alternativas a seguir e marque V (verdadeiro) ou F (falso).

- Alguns exames laboratoriais podem confirmar ou descartar essa condição.
- O melhor critério para se definir o idoso frágil é a Avaliação Geriátrica Ampla.
- Na prática clínica, utiliza-se a dosagem de interleucina 6 e 2 (IL-6 e IL-2) e fator de necrose tumoral para identificação de marcadores biológicos associados à fragilidade.
- O diagnóstico da síndrome de fragilidade é clínico.

- a) V — V — F — F
- b) F — F — V — V
- c) V — F — V — F
- d) V — V — V — F
- e) F — V — F — V**

11) A dor crônica é uma condição comum em pacientes idosos, especialmente em instituições de longa permanência para idosos (ILPI). A respeito da dor crônica nessa população, qual das alternativas abaixo é verdadeira?

- a) A prevalência de dor crônica em idosos é menor em instituições de longa permanência, devido ao monitoramento constante.
- b) Em idosos, a dor é exclusivamente causada por alterações neurológicas.
- c) Pacientes idosos não possuem alterações na percepção de dor com o avanço da idade.
- d) A dor crônica pode ser subtratada em idosos, levando a limitações funcionais e comprometimento das atividades de vida diária (AVDs).**
- e) A dor crônica em idosos é rara, com prevalência abaixo de 10% em todas as faixas etárias.

12) São medicações ou medidas de escolha para os cuidados nas últimas 48 horas de vida, EXCETO

- a) Benzodiazepínicos, como o midazolam, quando há indicação de sedação paliativa
- b) Analgésicos opioides, para controle da dispneia e da dor
- c) AAS e estatinas, em pacientes com alto risco cardiovascular.**
- d) Suspender a dieta por via enteral ou parenteral.
- e) Anticolinérgicos, como atropina e escopolamina, para controle de secreções.

13) Sobre o hipertireoidismo no idoso é incorreto afirmar:

a) No caso de um TSH baixo, repetir o exame em 1 a 3 meses, com t4 livre, t3 e ultrassom de tireoide.

b) A droga de escolha para o tratamento é o metimazol.

c) A maioria dos pacientes chegam ao eutireoidismo após 3 semanas, após uso da medicação.

d) Na doença de graves com hipertireoidismo subclínico, com TSH entre 0,1 e 0,4 mUI/ml, em idosos com mais de 65 anos, com fatores de risco cardiovascular ou comorbidades, deve se usar medicamento antitireoidiano.

e) O hipertireoidismo esta associado a aumento da remodelagem óssea, aumenta a incidência de fraturas, sendo que o hipertireodismo subclínico tem repercussões semelhantes na mulher pós-menopausa.

14) Quanto ao diagnóstico da síndrome de fragilidade, analise as alternativas a seguir e marque V (verdadeiro) ou F (falso).

1. Alguns exames laboratoriais podem confirmar ou descartar essa condição.

2. O melhor critério para se definir o idoso frágil é a Avaliação Geriátrica Ampla.

3. Na prática clínica, utiliza-se a dosagem de interleucina 6 e 2 (IL-6 e IL-2) e fator de necrose tumoral para identificação de marcadores biológicos associados à fragilidade

4. Os marcadores de fragilidade são perda de peso, fraqueza muscular, exaustão, marcha lentificada e sedentarismo.

a) V — V — F — F

b) V — F — V — F

c) F — V — F — V

d) F — F — V — V

e) V — V — V — F

15) N.M., 74 anos, parda, queixa-se de perdas urinárias há cerca de cinco anos. Refere que apresenta escapes de urina quando tosse ou espirra e que se preocupa em sempre ir imediatamente ao banheiro quando percebe o desejo de urinar, para evitar as perdas. Além disso tem urgência miccional, nictúria, sem outros sintomas. Aderiu ao uso de absorventes desde que veio molhada da igreja há dois anos, e desde então deixou de frequentar o seu grupo de oração. Evita ficar com a bexiga cheia, pois não consegue segurar por muito tempo. Diz que tem vontade de urinar e tem que ir logo, pois se não perde urina. Tem antecedentes de hipertensão arterial sistêmica, hipotireoidismo, diabetes, asma e depressão. Faz uso regular de: duloxetine 60mg; Losartana 50mg; HCTZ 25mg; Levotiroxina 50mcg e dapaglifozina. Marque a alternativa correta:

a) Caso de Incontinência urinária de esforço; pedir parcial de urina e ecografia pélvica.

b) Incontinência urinária mista, onde esta indicado somente uso de medicações antimuscarínicas e/ou da mirabegrona.

c) O estudo urodinâmico seria imprescindível neste paciente.

d) Paciente tem Incontinência urinária mista; pedir exames laboratoriais como glicemia jejum, eletrólitos, ureia, creatinina, parcial de urina e ecografia pélvica.

e) Estamos diante de um caso de IU de urgência, onde o uso de oxibutinina ou darifenacina melhoraria o quadro.

16) Sobre as quedas no paciente idoso, é incorreto dizer:

- a) O exame dos pés e dos calçados que o paciente usa são fundamentais para evitar quedas.
- b) A ptofobia é o medo de cair novamente, onde faz com que o paciente se movimente cada vez menos.
- c) A suplementação de b12 e cálcio ajudam no tratamento preventivo de quedas.**
- d) As medicações com maior potencial de risco para quedas são os hipnóticos sedativos.
- e) Como, onde e quando a queda ocorreu são perguntas essenciais para direcionar a investigação dos fatores envolvidos e/ou desencadeantes da queda.

17) Hipertensão arterial no idoso é muito frequente, com características próprias dessa faixa etária:

I- Nos idosos, há especial preocupação com a aferição da PA, pois o envelhecimento está frequentemente associado à disfunção barorreflexa e, conseqüentemente, à maior possibilidade de hipotensão postural e pós-prandial, o que acontece em razão do inadequado aumento da FC com a queda do débito cardíaco.

II – Nos pacientes idosos, a medida da PA deve ser sempre realizada com o paciente de pé, em todas as consultas, para avaliar a presença de hipotensão ortostática, que, quando presente, determina que se considere a PA aferida com o paciente sentado como a medida padrão.

III – A manobra de Osler deve ser utilizada quando há suspeita de pseudo-hipertensão e consiste na palpação da artéria radial

enquanto o cuff está sendo insuflado para assegurar que a onda de pulso realmente desapareça.

IV - Pacientes com idade avançada, acima de 80 anos, devem ter o tratamento criterioso, não seguindo as metas exigidas pelas diretrizes.

Assinale a correta:

- a) Apenas I e II
- b) Apenas II e III
- c) Apenas I e III
- d) Todas estão corretas.**
- e) Apenas I, II e IV

18) Sobre as quedas no paciente idoso, é incorreto dizer:

- a) A mensuração da pressão deitado e depois em pé é de grande utilidade na investigação de quedas.
- b) A maioria das quedas no idoso ocorrem fora do domicílio devido a calçadas mal adaptadas e irregulares, e sem histórico de quedas anteriores.**
- c) Como, onde e quando a queda ocorreu são perguntas essenciais para direcionar a investigação dos fatores envolvidos e/ou desencadeantes da queda.
- d) As medicações com maior potencial de risco para quedas são os hipnóticos sedativos.
- e) A ptofobia é o medo de cair novamente, onde faz com que o paciente se movimente cada vez menos, aumentando o risco de quedas.

19) Sra. de 74 anos, tem doença de Alzheimer há 7 anos, com períodos de disfagia para líquidos nas últimas semanas. Teve um engasgo importante com chá há 3 dias. Há

1 dia vem tendo quadro de tosse produtiva, sem expectoração, agitação psicomotora com insônia, sem febre e com dispneia associado. Exames físico: PA 115/80, FR 30, confusa. Tórax: mv crepitantes em base de pulmão direito. Diante do caso é verdadeiro afirmar:

- a) Paciente precisa ser internado em ambiente hospitalar, onde usaremos uma quinolona respiratória.
- b) O tratamento deverá ocorrer em ambiente domiciliar, com aporte de oxigênio e prescrição de ceftriaxona + macrolídeo.
- c) Este paciente deverá se submeter a sonda nasoenteral para alimentação, oxigênio e uso de ceftriaxona + azitromicina.
- d) Paciente será internado, com uso de oxigênio e antibioticoterapia com uso de piperacilina/tazobactam.**
- e) Os principais germes envolvido neste caso seriam o S.Pneumoniae e Hemophilus influenzae.

20) A dispneia é um sintoma comum em pacientes terminais. Nos pacientes que apresentam quadro de dispneia grave, a opção ideal de tratamento é:

- a) fenobarbital e clonazepam
- b) tramadol e quetiapina.
- c) morfina e tramadol
- d) fenobarbital e midazolam.
- e) morfina e midazolam.**

21) Sra. de 74 anos, tem doença de Alzheimer há 7 anos, com períodos de disfagia para líquidos nas últimas semanas. Teve um engasgo importante com chá há 3 dias. Há 1 dia vem tendo quadro de tosse produtiva, sem expectoração, agitação psicomotora com insônia, sem febre e com dispneia associado. Exames físico: PA 115/80, FR

30, confusa. Tórax: mv crepitantes em base de pulmão direito. Diante do caso é verdadeiro afirmar:

- a) Paciente será internado, com uso de oxigênio e antibioticoterapia com uso de amoxicilina + clavulanato.
- b) Paciente precisa ser internado em ambiente hospitalar, onde usaremos uma quinolona respiratória.
- c) Este paciente deverá se submeter a sonda nasoenteral para alimentação, oxigênio e uso de ceftriaxona + clindamicina.**
- d) Os principais germes envolvido neste caso seriam o S.Pneumoniae e Hemophilus influenzae.
- e) O tratamento deverá ocorrer em ambiente domiciliar, com aporte de oxigênio e prescrição de ceftriaxona + macrolídeo.

22) Quanto à conduta sugerida para um paciente idoso de 80 anos, com DM2, em uso de metformina e glicazida, com bom controle glicêmico, internado eletivamente para a realização de uma colecistectomia, assinale a alternativa correta:

- a) Suspender as medicações antes do procedimento e introduzir insulina regular de acordo com o controle glicêmico.**
- b) Suspender a metformina apenas pelo risco de acidose láctica, mantendo a gliclazida.
- c) Trocar a metformina e a gliclazida por um inibidor da DPP4, pelo baixo risco de hipoglicemia
- d) Manter a metformina e a gliclazida,
- e) Fazer somente insulina nph durante o internamento e controle dos picos glicêmicos com insulina regular.

23) A Obstipação Intestinal é um sintoma de incidência de 50% em casas de repouso, podendo ter causas orgânicas ou funcionais. Sendo assim é falso afirmar:

- a) O uso de anticolinérgicos e antiinflamatórios são causas de obstipação.
- b) O Fecaloma é uma complicação da obstipação intestinal, podendo ter o paciente a diarreia paradoxal.
- c) Os critérios de Roma para obstipação intestinal evidencia que o paciente precisa de um quadro de evolução de há 30 dias nos últimos 6 meses.**
- d) As antraquinonas como o Sene, podem causar Melanosis coli.
- e) O domperidone e a bromoprida são adjuvantes no tratamento da obstipação.

24) Sobre a Hipertensão Arterial no Idoso é incorreto afirmar:

- a) Para afastar a Hipertensão do Jaleco Branco, devemos pedir ao paciente um MAPA ou uma Medida Residencial da Pressão Arterial.
- b) Paciente com 68 anos, obesa, com intolerância a glicose; as medicações mais adequadas seriam um tiazídico, um betabloqueador ou IECA.**
- c) Na Hipertensão Renovascular poderemos ter um sopro abdominal em lojas renais e resistência a terapia medicamentosa.
- d) Pacientes com HAS e com disfunção ventricular de origem diastólica, podem ter a indicação de Betabloqueadores.
- e) Os betabloqueadores teriam uma boa indicação em pacientes coronariopatas.

25) P.S., 86 anos, chega ao PS com tosse com catarro amarelo, dispnéia ao repouso, sem febre há 2 dias. Paciente é acamado

em uso de sonda nasoenteral, que segundo a família relata que o paciente teve regurgitação de dieta com engasgos e tosse, antes de começar o quadro pulmonar. No exame físico apresentava dispneico, sat O2 88%, afebril. Riscos difusos e estertores em base pulmonar direita. Com isso qual seria o melhor tratamento para este paciente?

- a) Tratar em casa e usar Amoxicilina + Clavulanico.
- b) Tratar em casa usando ceftriaxona intramuscular.
- c) Internar e usar Ceftriaxona + clindamicina**
- d) Internar e usar Levofloxacino.
- e) Internar e usar cefalosporina de 1a geração.

26) Paciente do sexo feminino, 69 anos, traz ao consultório exame de Densitometria Óssea mostrando resultado de Osteoporose. Exames de sangue normais. Paciente sem queixa clínica. Nega fraturas anteriores. Qual seria o seu tratamento:

- a) Raloxifeno e Carbonato de Cálcio 500mg
- b) Bifosfonato
- c) Teriparatida
- d) Bifosfonato e Colecalciferol 50.000ui 1x semana por 60 dias
- e) Bifosfonato e Cálcio Citrato Malato 500mg 2x ao dia.**

27) A patologia tireoidiana mais comum no idoso é o hipotireoidismo, sendo a causa mais comum a Tireoidite de Hashimoto. Assim, é incorreto afirmar:

- a) A principal manifestação neuropática é a síndrome do túnel do carpo.
- b) A alteração da glicose é a principal alteração metabólica.**

- c) O tabagismo pode ser um fator desencadeador de Tireoidite de Hashimoto.
- d) Pode haver alteração cardíaca como a insuficiência cardíaca e o derrame pericárdico.
- e) A levotiroxina deve ser usada sempre em jejum, começando com doses pequenas.

28) O idoso com diabetes mellitus e incontinência urinaria de urgência, qual a droga devemos evitar para o tratamento do quadro glicêmico e não piora da incontinência urinaria?

- a) Biguanidas
- b) Glitazonas
- c) Sulfoniuréias
- d) Inibidores da DPP4

e) Inibidores da SGLT2

29) Sra de 76 anos refere há meses polaciuria, nictúria e dizendo que quando sente vontade de urinar, não consegue chegar a tempo ao banheiro, tendo assim perdas de urina. Paciente tem como comorbidades DM II e DPOC. Qual seria o tratamento de escolha para essa paciente e que tipo de alteração urinária pode apresentar?

- a) Duloxetina e infecção urinária.
- b) Tolterodina e bexiga hiperativa.**
- c) Fisioterapia uroginecológica e incontinência urinária mista.
- d) Solifenacina e prolapso vesical
- e) Cirurgia tipo Sling e hiperreflexia do detrusor.

30) Idoso de 68 anos, comparece ao ambulatório de geriatria com queixas de tonturas tipo vertigem há 2 dias, que duram

algumas horas, acompanhado de hipoacusia e zumbido bilateral. Nega vômitos. Antes desse quadro relata que tinha tonturas ao levantar da cama e da cadeira, com sensação de fraqueza geral há meses. Paciente tem como comorbidades DM II e HAS, usando medicações com bom controle. Baseado nessas queixas, quais os possíveis diagnósticos de paciente?

- a) Hipotensão Ortostática e Vertigem Posicional Paroxística Benigna.
- b) Doença de Menière e Neurite Vestibular
- c) Insuficiência Vertebro Basilar e Vertigem Paroxística Benigna
- d) Doença de Menière e Hipotensão Ortostática**
- e) Neurite Vestibular e Hipotensão Ortostática

31) Paciente com 77 anos, com crises hipertensivas frequentes nos últimos meses, chegando a PA 220/110mmHg. Foi atendido no PS de sua cidade, aonde foi aumentado a dose máxima de anlodipino. Além disso, usa olmesartana, hidroclorotiazida e espirolactona. Paciente já teve IAM há 2 anos. Nega DM. Hoje vem ao consultório com PA de 170/90 e com várias medidas residências de PA alteradas. Diante do caso, qual seria a próxima droga a ser escolhida para a associação?

- a) Clonidina
- b) Furosemida
- c) IECA
- d) Metildopa
- e) Anlodipino**

32) Um paciente idoso com Pneumonia apresenta certas peculiaridades que são

incomuns em outras faixas etárias, que seriam:

- a) Ausência de febre, confusão mental e maior incidência de dor torácica.
- b) Confusão mental, tosse com pouca expectoração e febre frequente.
- c) Maior incidência de taquicardia, taquipneia e diminuição das atividades de vida diária**
- d) Ausência de febre, hemograma com leucocitose com desvio a esquerda em todos os casos e raio X de tórax mostrando padrão alveolar de condensação.
- e) Taquipnéia frequente, delirium, presença de tosse com muita expectoração e dor torácica ventilatório dependente.

33) Idosa de 72 anos, com DM e HAS, vem em consulta com queixa de tontura. Refere que tem tonturas sempre que está sentada e fica em pé rapidamente. Também quando faz caminhadas mais extenuantes que o habitual, nesse caso associado a náuseas e desconforto epigástrico (nega dor), nega que sinta o corpo girar ou os objetos girarem. Ao exame físico, sem alteração no exame neurológico, manobra de Dixhallpike negativa, avaliação da PA em decúbito e ortostase, a paciente apresenta queda da PAS de 15mmHg (alterado se > 20) e à ausculta cardíaca, tem sopro aórtico sistólico 4+/6. Medicamentos de uso contínuo enalapril, hidroclorotiazida, espironolactona, metoprolol, AAS, sinvastatina, metformina, dapagliflozina. Sobre o caso acima, assinale a alternativa CORRETA:

R: Lembrar que é uma paciente que tem uma tontura, não parece ser de origem vestibular – sem alterações dos canais, parece ser uma tontura que ela tem

quando levanta, uma tontura também quando ela se esforça mais (lembrar disso aí na prova). Flunarizina funciona para esse tipo de tontura – não Lembrar que o estado volêmico desse paciente muda no dia a dia desses pacientes, ela podia ter uma tontura dias atras, agora não tem mais, será que agora ela está tão desidratada quanto estava antes, será que ela está tomando certo os diuréticos está tomando agora e antes não estava tomando.

34) Paciente de 57 anos, vem em primeira consulta com o geriatra pois quer ter um envelhecimento saudável. Queixa-se de lombalgia há cerca de 2 anos após ter tentado levantar objeto pesado em casa. História pregressa de histerectomia e anexectomia bilateral aos 32 anos de idade, HAS, DM e etilismo. Nega ter fraturas prévias, mas relata que a mãe teve fratura de quadril ao tropeçar na rua. Ao exame físico da coluna, paciente apresenta leve escoliose e importante cifose. FRAX score de fratura de quadril 2,0% e por osteoporose 6,3%. Sobre o caso acima, assinale a alternativa CORRETA:

R: Uma senhora 57 anos, que por muito tempo ficou sem exposição ao estrogênio, não fez TRH e tem fatores de risco para desenvolver Osteoporose, dor lombar que não era para ter, nódulo dela contraindica TRH. Lembrar que o FRAX para gente tratar o de quadril tem que ser maior que 5% e osteoporose maior que 20%. Lembrar que a gente tem o T-score e o Z-score, lembrar o que e cada um e qual agt usa para o diagnóstico.

35) Paciente de 74 anos, homem, vem em consulta encaminhada ao geriatra pelo oncologista devido à quadro de fratura de coluna vertebral identificada em tomografias para investigação de metástases de CA de próstata após ter iniciado com dor lombar há alguns meses. Paciente refere apenas fraqueza após ter iniciado terapia antiandrogênica há cerca de 7 anos para controle do CA de próstata, com melhora importante ao realizar academia e corridas regularmente. História pregressa de HAS, hérnia hiatal volumosa e doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) sintomática. Nega tabagismo e etilismo. Em uso de enalapril, omeprazol e dipirona dipirona com bom controle da dor. Traz densitometria de 3 anos atrás com T score de -2 e PSA total de 0,08 (baixa probabilidade de recidiva do CA de próstata). Com base no caso acima, assinale a alternativa CORRETA:

R: **Importante lembrar que é um paciente que teve privação androgênica – homem com privação androgênica tem muito osteoporose. Lembrar que temos idades para ser realizado a densitometria – mulheres acima de 65 anos, homens acima de 70 anos. Sempre que acharmos que tem um fator de risco que pode indicar osteoporose fazer também a densitometria. Lembrar que as terapias anabólicas, sempre devem ser seguidas com uma antirreabsortivas com bifosfonatos – isso sempre deve ser feito. Lembrar que algumas medicações só servem para mulheres não podem ser usadas em homens – tipo Romosozumabe Lembrar que todos os pacientes que forem tratar osteoporose tem que usar vitamina D e**

cálcio. – Garantir uma ingesta adequada, mas saber que isso não é o suficiente. Ca de próstata não é um câncer que mata brevemente ainda mais o paciente que não tem recidiva, então vamos ter benefício de tratar esses pacientes. Benefícios do tratamento da osteoporose a partir de 2 anos. (um pouco mais rápido com o ácido não sei das quantas) Lembrar que tem algumas medicações que não podemos usar em pacientes que tem hernia hiatal e DRGE como alendronato, risedronato, porque tem risco de fazer lesão no esôfago.

36) Sobre a incontinência urinária, assinale a alternativa CORRETA:

R: **Lembrar que existe diagnostico de incontinência funcional – dificuldade de chegar ao banheiro. Lembrar que vamos estimular o tônus adrenérgico, e desestimular o tônus parassimpático (no caso) – certeza que trocou esse parassimpático por ter falado no caso – lembrar do efeito das medicações. Lembrar que o tto não farmacológico funciona, principalmente o treinamento vesical.**

37) Paciente feminina de 63 anos, vem em 1ª consulta com geriatra. Refere CA de mama estágio clínico IV, já em 4ª linha de tratamento por refratariedade e que o oncologista quer incluí-la em um protocolo de tratamento de uma nova medicação que teve benefício em estudos de fase 3 e que o oncologista nunca falou que ela tem uma doença incurável. Refere não aceitar que está passando por esse quadro e que acredita que Deus a está castigando, por

vezes chora ao pensar nisso. Relata que vem deixando de fazer as atividades que realizava devido a fraqueza e dor de moderada intensidade. A dor não teve melhora com codeína, por isso está indo com frequência ao pronto-socorro para receber morfina EV com melhora do quadro algico. Sobre o caso acima, assinale a alternativa CORRETA

R: **O que vocês fariam: aumentar o opioide, porque ela está com dor e está prejudicando-a. Ela está perdendo funcionalidade importante se atentar a isso, escalar a analgesia desta paciente, ela está com opioide fraco via oral usando continuamente sem melhora e trazendo prejuízo funcional (aumentar o opioide) Lembrar que ela está com sofrimento espiritual e lembrar que esta paciente pode estar tendo dor por outros motivos. Sempre vamos tentar tratar a dor com medicações como morfina, analgésicos simples, AINE e fazer tratamentos adjuvantes. No caso ela parece ter muitas tristezas daria para começar antidepressivos também. Algumas quimioterapias fazem neuropatia e a pregabalina e gabapentina não funcionam muito bem para isso. Vai ter que começar medicações adjuvantes – demoram 4 a 8 semanas para começar o efeito – pcts de muito baixa sobrevida não são indicados. Lembrar que atividade física, alimentação saudável ajuda muito esses pacientes. Todos os pacientes oncológicos que fazem atividade física juntamente com quimioterapia, eles têm desfechos melhores – ajudam nos sintomas neuropsiquiátricos por exemplo.**

38) Sobre os cuidados paliativos, assinale a alternativa CORRETA:

R: **Lembrar que cuidado paliativo não é só para paciente oncológico Intubação não vai beneficiar nenhum paciente nem gastrotomia. Hidratação não é para ser feito de rotina só em últimos casos. Não realizar RCP em Ca terminal com a família insistindo – nem fazer teatro. (falar para a família que pct já foi a óbito). Lembrar que podemos usar o protocolo SPIKE para falar com a família e paciente.**

Provas de Geriatria

2º BIMESTRE

PROVA 02 – TXXI

- 1- Sobre o tratamento farmacológico da dor crônica no idoso, marque V (verdadeiro) ou F (falso):
1. Os anti-inflamatórios são agentes eficazes na dor nociceptiva, mas devem ser utilizados apenas por curtos períodos.
2. Os relaxantes musculares podem ser úteis em situações específicas, como a fibromialgia e a dor pós-AVE, mas são pouco tolerados pelas pessoas idosas em razão de seus efeitos anticolinérgicos.
3. Os coxibes (como o celecoxibe), considerando-se os AINEs, são os mais indicados para os idosos, devido ao menor risco de sangramento gastrointestinal e de efeitos cardiovasculares.
4. A carbamazepina ainda é o tratamento de escolha para a neuralgia do trigêmeo, apesar de não ser o anticonvulsivante mais seguro para idosos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- a) F– F– V– V
- b) V– F– V– V
- c) V– V– F– F
- d) V– V– F– V
- e) F– V– V– V

- 2- Paciente do sexo feminino, 70 anos, hipertensa, má aderente ao tratamento, usando nifedipina e hidroclorotiazida, procura o ambulatório com queixas de dispneia aos médios esforços. Ao exame físico no momento, chamaram atenção apenas a PA de 160x95mmHg e discretas crepitações bi basais pulmonares. O exame era um ecocardiograma que

mostrava FE do VE de 38%. Sobre esse caso, assinale a alternativa correta:

- a) O uso de um diurético de alça seria mandatório, além da troca do bloqueador de canal de cálcio por um IECA.
 - b) Associar um betabloqueador como o carvedilol ao tratamento.
 - c) Uma ótima opção terapêutica seria diltiazem, potente vasodilatador para controle da pressão, associado a furosemida.
 - d) Deve-se controlar adequadamente a PA, e uma boa opção seria o início de um BRA associado a um IECA no esquema de tratamento.
 - e) Suspender o bloqueador de canal de cálcio, passar espirolactona e digital.
- 3- Paciente masculino, 80 anos, trazido por familiares que relatam quadro de tosse produtiva há uma semana e há dois dias sonolência diurna e períodos de agitação e delirium durante a noite. Chega ao pronto socorro sono lento, descorado +, desidratado ++, acianótico, afebril, PA 110 x 70mmHg, FC 101, FR 28, estertores crepitantes bi basais e no terço médio do HTE. Considerando-se a hipótese de PAC, qual análise de risco corresponde à conduta mais adequada para esse caso?
 - a) Apresenta CURB-65 de 2 e, portanto, pode ser tratado no domicílio com terapia via oral ou sistema de Home Care, sendo o moxifloxacino o mais indicado para seu tratamento
 - b) Apresenta CURB-65 de 3 e, portanto, deve ser internado para tratamento, com consideração para internação em UTI de acordo com evolução e exames complementares.

- c) Apresenta CURB-65 de 1 com terapia via oral ou endovenosa de Levofloxacino.
- d) Apresenta CURB-65 de 2 e o antibiótico de eleição para o caso seria amoxicilina + clavulanato.
- e) Apresenta CURB-65 de 3 e, portanto, deve ser internado temporariamente em pronto-socorro por pelo menos 48 horas e avaliação de alta com terapia via oral após esse período.

4- Paciente idosa, 83 anos vem ao consultório levado pela filha, com queixas déficit cognitivo e fraqueza muscular. Nega quedas ou outras queixas. Tem como exames laboratoriais TSH 7,8 e t4 livre normal, Colesterol total e frações normais, ANTI-TPO elevado. Diante do caso é correto dizer:

- a) **A paciente apresenta Hipotireoidismo subclínico e conforme os exames apresentados devemos tratar.**
- b) O diagnóstico é de Tireoidite de Hashimoto, onde temos que esperar, pois a paciente não tem dislipidemia.
- c) O diagnóstico é de Hipotireoidismo Subclínico, onde não devemos tratar ainda, pois a paciente tem o TSH menor que 10.
- d) É um caso de Hipotireoidismo clínico e devemos iniciar Levotiroxina em dose padrão
- e) É um caso de Hipotireoidismo clínico devido a Tireoidite de Hashimoto, onde é necessário iniciar o tratamento.

5- O diagnóstico da síndrome de IC é realizado por meio de história clínica e de exame físico detalhados. Sobre os achados semiológicos da IC, Assinale a alternativa correta.

- a) A ortopneia tem elevada especificidade para o diagnóstico da IC, sendo apresentada precocemente.
- b) A dispneia aos esforços é facilmente identificada em idosos e possui elevada especificidade para o diagnóstico da IC.

- c) O edema de tornozelo é um achado de alta especificidade para o diagnóstico de IC no idoso.
- d) Tosse seca geralmente ao deitar tem uma frequência elevada em pacientes idosos com ICC.

e) Distúrbios neuropsiquiátricos e sarcopenia podem atrasar o diagnóstico.

6- Paciente idosa, 74 anos, vem ao consultório relatando um descontrole pressórico. Na MRPA os níveis têm chegado a 170.90. Paciente refere que não tem queixas clínicas. Está em uso de Valsartana e hidroclorotiazida em doses máximas. Tem exames laboratoriais que traz no consultório mostra glicemia jejum 156 Glicada 7,9, RFG 55 e potássio um pouco baixo. Não usa nenhuma medicação para DM. Qual alternativa correta para a paciente em questão:

- a) Associar um bloqueador de canal de cálcio, passar dieta e exercícios para controle pressórico e glicêmico e repositor de K.
- b) Associar espirolactona, uma sulfoniuréia ao tratamento, junto com a dieta e exercícios.

c) Associar um bloqueador de canal de cálcio, suspender o diurético e passar um inibidor da SGLT-2.

- d) Passar medidas somente não farmacológicas e repositor de K devido a hipocalemia.
- e) Orientar quanto a dieta correta, prática de atividade física, suspender diurético e usar insulina.

7- O transtorno depressivo no idoso causa um impacto significativo na vida do paciente, sendo que o seu diagnóstico muitas vezes é negligenciado e subtratado. Sendo assim é correto dizer:

a) Sentimento de culpa e menos valia são menos comuns em depressão de início tardio.

- b) A escolaridade e a doença cerebrovascular não são fatores de risco para depressão no idoso.
- c) Os homens são os que tem mais sintomas e maior possibilidade de apresentação atípica.
- d) A depressão sub sindrômica não preenche os critérios para depressão maior e não causa o mesmo tipo de incapacidade.
- e) Na depressão de início tardio, o fator genético é de suma importância, e por isso deve ser investigado.

8- As tonturas no idoso tem como o desafio o preciso diagnóstico, pois há mais de 60 enfermidades causadoras de distúrbios de equilíbrio. Sendo assim é correto afirmar:

- a) A quantidade de comorbidades não interfere na maior incidência de tonturas.
- b) A vertigem de origem periférica tem um desequilíbrio importante com duração rápida.
- c) A vertigem posicional paroxística benigna tem vertigem, náuseas, zumbido e nistagmo.

d) O envelhecimento leva a diminuição da sensibilidade proprioceptiva, do reflexo de aquileu e aumento da oscilação postural.

- e) A vertigem ocorrem exclusivamente em causas periféricas de tonturas.

9- Quanto ao diagnóstico da síndrome de fragilidade, analise as alternativas a seguir e marque V (verdadeiro) ou F (falso).

1. Alguns exames laboratoriais podem confirmar ou descartar essa condição.
2. O melhor critério para se definir o idoso frágil é a Avaliação Geriátrica Ampla.
3. Na prática clínica, utiliza-se a dosagem de interleucina 6 e 2 (IL-6 e IL-2) e fator de necrose tumoral para identificação de marcadores biológicos associados à fragilidade.
4. O diagnóstico da síndrome de fragilidade é clínico.

- a) V, V, F, F

b) F, F, V, V

c) V, F, V, F

d) V, V, V, F

e) F, V, F, V

10- Assinale a alternativa correta sobre o antidepressivo capaz de prolongar o intervalo QT e causar hiponatremia:

a) Nortriptilina

b) Citalopram

c) Sertralina

d) Duloxetina

e) Venlafaxina

11- Homem, 82 anos, professor universitário aposentado, viúvo, comparece no ambulatório de geriatria para avaliação geral, acompanhado de seu filho. É portador de hipertensão arterial e faz tratamento para depressão desde que a sua esposa faleceu, há cerca de dois anos. Não apresenta queixas específicas, refere que tem estado relativamente bem, exceto uma sensação de cansaço, descrita também como falta de energia, o que atribui ser “da idade”. Ao ser questionado, o filho se mostra preocupado com o fato de que seu pai vem perdendo peso progressivamente, associado à diminuição de apetite. Há seis meses, tropeçou num pequeno degrau em casa e caiu da própria altura; teve um trauma leve na coxa direita, mas desde então, passou a caminhar mais lentamente, a se apoiar nos objetos e nas paredes, alegando medo de outra queda. Além do mais, tem evitado sair de casa e deixou de fazer aula de pilates. Faz uso de enalapril, fluoxetina e se automedica com complexo vitamínico, para “sentir-se mais forte”.

- peso– 58,3kg;

- altura– 1,67m;

- IMC– 20,9kg/m²;

- perda de 4kg no último ano;

- bom estado geral;

- pressão arterial: 120/75mmHg (sentado) e 115/70mmHg (em pé);
- FC: 80, R.
- O exame segmentar do paciente não apresentou alterações relevantes, assim como o neurológico não apresentou déficits focais.

A AGA do paciente revelou:

- função sensorial satisfatória;
- cognição sem alterações dignas de nota;
- boa capacidade funcional para as ABVDS e AIVDS, necessitando apenas de auxílio para caminhar.
- tem critérios diagnósticos de depressão, com diminuição de interesse e humor deprimido, além de redução de apetite.
- Risco nutricional, de acordo com o uso de instrumento Mini avaliação nutricional (MAN)
- Como conduta foram solicitados exames gerais, cujos resultados foram dentro da normalidade.

Diante do caso clínico, qual a conduta correta?

- a) Encaminhado a fisioterapia para exercícios de treino da marcha, fortalecimento e equilíbrio; dieta hiperproteica e trocado fluoxetina por mirtazapina.
- b) Troca do fluoxetina por mirtazapina e encaminhado a fisioterapia para treino da marcha.
- c) Trocado fluoxetina por mirtazapina e dieta hiperproteica.
- d) Encaminhado a fisioterapia para exercícios de treino da marcha, fortalecimento e equilíbrio; trocado fluoxetina por sertralina.
- e) Mantido a fluoxetina, encaminhado a fisioterapia para exercícios para fortalecimento, equilíbrio e dieta hiperproteica.

12- São medicações ou medidas de escolha para os cuidados nas últimas 48 horas de vida, EXCETO

- a) Benzodiazepínicos, como o midazolam, quando há indicação de sedação paliativa
- b) Analgésicos opioides, para controle da dispneia e da dor

c) AAS e estatinas, em pacientes com alto risco cardiovascular.

- d) Suspender a dieta por via enteral ou parenteral.
- e) Anticolinérgicos, como atropina e escopolamina, para controle de secreções.

13- Sobre o hipertireoidismo no idoso é incorreto afirmar:

- a) No caso de um TSH baixo, repetir o exame em 1 a 3 meses, com t4 livre, t3 e ultrassom de tireoide.
- b) A droga de escolha para o tratamento é o metimazol.

c) A maioria dos pacientes chegam ao eutireoidismo após 3 semanas, após uso da medicação.

- d) Na doença de graves com hipertireoidismo subclínico, com TSH entre 0,1 e 0,4 mUI/ml, em idosos com mais de 65 anos, com fatores de risco cardiovascular ou comorbidades, deve se usar medicação antitireoidiana.
- e) O hipertireoidismo está associado a aumento da remodelagem óssea, aumenta a incidência de fraturas, sendo que o hipertireoidismo subclínico tem repercussões semelhantes na mulher pós-menopausa.

14- N.M., 74 anos, parda, queixa-se de perdas urinárias há cerca de cinco anos. Refere que apresenta escapes de urina quando tosse ou espirra e que se preocupa em sempre ir imediatamente ao banheiro quando percebe o desejo de urinar, para evitar as perdas. Além disso tem urgência miccional, nictúria, sem outros sintomas. Aderiu ao uso de absorventes desde que veio molhada da igreja há dois anos, e desde então deixou de frequentar o seu grupo de oração. Evita ficar com a bexiga cheia, pois não consegue segurar por muito tempo. Diz que tem vontade de urinar e tem que ir logo, pois se não perde urina. Tem antecedentes de hipertensão

arterial sistêmica, hipotireoidismo, diabetes, asma e depressão. Faz uso regular de: duloxetina 60mg; Losartana 50mg; HCTZ 25mg; Levo tiroxina 50mcg e dapaglifozina. Marque a alternativa correta:

- a) Caso de Incontinência urinária de esforço; pedir parcial de urina e ecografia pélvica.
- b) Incontinência urinária mista, onde está indicado somente uso de medicações antimuscarínicas e/ou da mirabegrona.
- c) O estudo urodinâmico seria imprescindível neste paciente.
- d) Paciente tem Incontinência urinária mista; pedir exames laboratoriais como glicemia jejum, eletrólitos, ureia, creatinina, parcial de urina e ecografia pélvica.**
- e) Estamos diante de um caso de IU de urgência, onde o uso de oxibutinina ou da rifenacina melhoraria o quadro.

15- Sobre as quedas no paciente idoso, é incorreto dizer:

- a) O exame do pés e dos calçados que o paciente usa são fundamentais para evitar quedas.
- b) A ptofobia é o medo de cair novamente, onde faz com que o paciente se movimente cada vez menos.
- c) A suplementação de b12 e cálcio ajudam no tratamento preventivo de quedas.**
- d) As medicações com maior potencial de risco para quedas são os hipnóticos sedativos.
- e) Como, onde e quando a queda ocorreu são perguntas essenciais para direcionar a investigação dos fatores envolvidos e/ou desencadeantes da queda.

16- Hipertensão arterial no idoso é muito frequente, com características próprias dessa faixa etária:

- I. Nos idosos, há especial preocupação com a aferição da PA, pois o envelhecimento está frequentemente associado à disfunção barorreflexa e,

consequentemente, à maior possibilidade de hipotensão postural e pós-prandial, o que acontece em razão do inadequado aumento da FC com a queda do débito cardíaco.

- II. Nos pacientes idosos, a medida da PA deve ser sempre realizada com o paciente de pé, em todas as consultas, para avaliar a presença de hipotensão ortostática, que, quando presente, determina que se considere a PA aferida com o paciente sentado como a medida padrão.
- III. A manobra de Osler deve ser utilizada quando há suspeita de pseudo-hipertensão e consiste na palpação da artéria radial enquanto o cuff está sendo insuflado para assegurar que a onda de pulso realmente desapareça.
- IV. Pacientes com idade avançada, acima de 80 anos, devem ter o tratamento criterioso, não seguindo as metas exigidas pelas diretrizes.

Assinale a correta:

- a) Apenas I e II
- b) Apenas II e III
- c) Apenas I e III
- d) Todas estão corretas.**
- e) Apenas I, II e IV

17- Sra. de 74 anos, tem doença de Alzheimer há 7 anos, com períodos de disfagia para líquidos nas últimas semanas. Teve um engasgo importante com chá há 3 dias. Há 1 dia vem tendo quadro de tosse produtiva, sem expectoração, agitação psicomotora com insônia, sem febre e com dispneia associado. Exames físico: PA 115/80, FR 30, confusa. Tórax: mv crepitantes em base de pulmão direito. Diante do caso é verdadeiro afirmar:

- a) Paciente precisa ser internado em ambiente hospitalar, onde usaremos uma quinolona respiratória.
- b) O tratamento deverá ocorrer em ambiente domiciliar, com aporte de oxigênio e prescrição de ceftriaxona + macrolídeo.

- c) Este paciente deverá se submeter a sonda nasoenteral para alimentação, oxigênio e uso de ceftriaxona + azitromicina.
- d) Paciente será internado, com uso de oxigênio e antibioticoterapia com uso de piperacilina\tazobactam.
- e) Os principais germes envolvido neste caso seriam o S.Pneumoniae e Hemophilus influenzae.

18- A dispneia é um sintoma comum em pacientes terminais. Nos pacientes que apresentam quadro de dispneia grave, a opção ideal de tratamento é:

- a) fenobarbital e clonazepam
- b) tramadol e quetiapina.
- c) morfina e tramadol
- d) fenobarbital e midazolam.
- e) morfina e midazolam.

19- Paciente de 73 anos, com queixas de dificuldade para dormir, com sensação de queimação nas pernas quando está na cama. Diz que precisa levantar-se para melhorar, associado a ansiedade. Diante do caso, o que podemos considerar como verdadeiro:

- a) É muito frequente em pacientes com Doença de Parkinson e Insuficiência renal crônica.
- b) O neurotransmissor envolvido na patologia é a serotonina.
- c) Durante a investigação da SPI, devem se solicitar exames de sangue para verificar níveis de ferro, ferritina, ureia, creatinina, TSH e vitamina B12.
- d) Essa alteração não é comum em pacientes com demência.
- e) A gabapentina é a primeira opção de tratamento.

20- Quanto à conduta sugerida para um paciente idoso de 80 anos, com DM2, em uso de metformina e glicazida, com bom controle glicêmico, internado eletivamente para a realização de uma

colecistectomia, assinale a alternativa correta:

- a) Suspender as medicações antes do procedimento e introduzir insulina regular de acordo com o controle glicêmico.
- b) Suspender a metformina apenas pelo risco de acidose láctica, mantendo a gliclazida.
- c) Trocar a metformina e a gliclazida por um inibidor da DPP4, pelo baixo risco de hipoglicemia
- d) Manter a metformina e a gliclazida,
- e) Fazer somente insulina NPH durante o internamento e controle dos picos glicêmicos com insulina regular.

OUTRAS QUESTÕES

- 21- Sra. Balbina, 75 anos, autônoma e independente, comparece a consulta ambulatorial de rotina sem queixas espontâneas, ao exame observa perda ponderal de 5 quilos no último ano, que segundo a paciente foi involuntária, quando questionado sobre o hábito intestinal é relato que tem ficado até 4 dias sem evacuar e que o uso dos laxativos orais não modifica muito com quadro. Descreve certo tenesmo, revisando o prontuário percebe-se que há um ano a senhora Balbina possuía o ritmo intestinal diário sem esforço preocupatório. Então qual é a alternativa correta?
- a) Trata-se possivelmente de quadro benigno, já que não há impacto significativo na funcionalidade do paciente, recomenda-se apenas acompanhamento.
 - b) São indicados ajustes na dieta e uso regular e combinados laxativos orais com diferentes mecanismos de ação.
 - c) Deve-se realizar toque retal e solicitar pesquisa anual de sangue oculto nas fezes

d) Deve-se solicitar colonoscopia, considerando a funcionalidade da paciente e a presença dos sinais de alerta.

e) Prescrever fleets enema semanal para melhorar o funcionamento do intestino

22- Assinale a alternativa que apresenta apenas exames laboratoriais indicados para investigação da constipação crônica no idoso;

a) Hemograma, glicemia, creatinina, cálcio séricos.

b) Ácido úrico, ácido fólico, hemograma e tsh.

c) Vitamina D, PTH, cloretos, fósforo e glicemia.

d) Osmolaridade, cálcio, ureia, lítio e TGO.

e) Ferro sérico, hemograma, pesquisa de sangue oculto nas fezes, fosfatase alcalina.

23- M.A.N, 73 anos refere diarreia, astenia, náuseas e vômitos há 8 horas. Nega enterorragia e fezes com muco ou pus. No exame físico mostra-se desidratada +2/4, hipotensa 90/60 e confusa. Tirando o quadro patológico, a fácil desidratação dessa paciente pode ser explicada, devido a:

a) Aumento da massa gorda e diminuição da massa magra.

b) Diminuição de glândulas sudoríparas e setáceas.

c) Diminuição do fluxo sanguíneo renal.

d) Menor produção de renina.

e) Diminuição de água corpórea, devido a menor massa celular.

24- Idosa, 75 anos, (independente) compare a consulta ambulatorial de rotina, com queixas de emagrecimento de 5kg nos últimos 3 meses, sem alteração do apetite. Questionado sobre o hábito intestinal relata constipação intestinal nos últimos meses, ficando até 5 dias sem evacuar, onde tem desconforto abdominal. Usa sene sem melhora até

agora. Nega outros sintomas. Exame físico: normal. Qual seria conduta mais adequada a esta paciente:

a) É uma queixa benigna, pois altera a sua funcionalidade e a paciente não relata queixa espontânea. Somente mudança na dieta e exercícios já são suficientes.

b) Trocar o laxante sene por um formador de bolo fecal como psyllium.

c) Pedir colonoscopia para averiguar melhor o quadro.

d) Solicitar pesquisa de sangue oculto nas fezes anual.

e) Associar ao sene, um laxante osmótico como a lactulose.

25- Em relação a tontura no idoso, assinale a alternativa correta:

a) Tanto a vertigem de origem central como periférica são acompanhadas de sintomas neurológicos.

b) O tratamento medicamentoso é a primeira indicação para a VPPB.

c) Os antivertiginosos devem ser usados de maneira contínua para o tratamento da vertigem

d) A VPPB tem como característica a vertigem quando o paciente deita ou se vira na cama

e) O desequilíbrio pode ser tratado com Flunarizina, independente da causa.

26- Em relação ao tratamento farmacológico de tontura, assinale a alternativa incorreta.

a) Fármacos sedativos do labirinto podem ser úteis na fase aguda.

b) Os ansiolíticos e o Dimenidrato aumentam o risco de quedas.

c) O uso prolongado de bloqueadores dos canais de cálcio se associa ao parkinsonismo.

d) Na hipotensão ortostática podemos indicar meias elásticas e aumento de oferta hídrica

e) A Betaístina deve ser usada como primeira indicação nas tonturas de origem psiquiátrica.

27- Em relação ao tratamento farmacológico de tontura no idoso, assinale a alternativa incorreta:

- a) Bloqueadores de canais de cálcio são úteis na fase aguda e não devem ser usados por tempo prolongado, pois retardam o processo fisiológico de compensação labiríntica.
- b) Antieméticos como o dimenidrato devem ser evitados nos casos de náuseas associado a vertigens, pois podem levar a quedas.

c) O tratamento medicamentoso é a primeira indicação para a VPPB.

- d) O uso prolongado de cinarizina e flunarizina pode levar a parkinsonismo.
- e) Ansiolíticos como o Diazepam podem ser usados no quadro agudo.

28- Idoso de 85 anos, sexo masculino, queixa-se de tonturas diárias ao se levantar. O quadro iniciou há 2 meses e foi descrito como sensação de fraqueza e, às vezes, giro ou escurecimento visual. Paciente é diabético, hipertenso, cardiopata com uma revascularização miocárdica. Paciente fica a maioria do tempo deitado, com medo de ter tonturas. Apresenta quedas de repetição com uma fratura de fêmur há 1 ano. Qual o diagnóstico provável:

- a) Tontura de origem medicamentosa.
- b) Hipotensão ortostática devido a polineuropatia diabética.
- c) Pré-síncope.
- d) Disautonomia.
- e) VPPB

29- Paciente de 80 anos, vem ao PS com queixas de tosse produtiva sem expectoração, associado: do estado geral e apatia há 6 dias. No exame físico apresenta estertores em base esquerda, c

aumentado a esquerda. Tem como comorbidades HAS e DM II com bom controle. Nega febre ... sintomas. Diante da patologia acima, é correto afirmar:

- a) O exame principal a ser pedido nesse paciente é a cultura do escarro.
- b) Como o paciente não tem febre, pode descartar quadro pneumônico.
- c) Caso clínico compatível com Pneumonia, o antibiótico de escolha é a azitromicina.
- d) Paciente com Pneumonia, onde será pedido hemocultura e cultura do escarro.

e) O tratamento empírico pode ser baseado no uso de quinolona respiratória.

30- P.S., 91 anos, acamado, sequelado de AVC, teve broncoaspiração no domicílio, aonde após 24 horas teve quadro de tosse com catarro amarelo esverdeado, queda do estado geral, com sonolência e confusão mental. Paciente chega ao PS com PA 100/60, roncos e estertores difusos a ausculta e Sat O₂ 91%. Diante do quadro pneumônico, qual antibioticoterapia seria instituída?

- a) Levofloxacino
- b) Ceftriaxona + levofloxacino
- c) Ceftriaxona + metronidazol
- d) Cefalotina + azitromicina
- e) Amoxicilina + clavulanato

31- Paciente de 80 anos vem ao PS com queixas de tosse seca e dispnéia ao repouso e aos mínimos esforços há 3 dias, associado a queda do estado geral e apatia. Tem tido edema de MMII há 7 dias, principalmente final da tarde. No exame físico apresenta estertores em bases, mais pronunciado a esquerda, com FTV aumentado a esquerda. Edema de MMII bilateralmente ++/4 com cavidade positiva e presença de varizes. Tem como comorbidades HAS e DM II com bom controle. Nega febre ou outros sintomas. Diante da patologia acima, é correto afirmar:

- a) Trata-se de uma ICC descompensada, aonde a presença do edema de MMII e a dispneia ajuda fechar o diagnóstico.
- b) A realização de exames laboratoriais como o hemograma, PCR e BNP sérico podem ser de muita ajuda para concluir o diagnóstico.**
- c) Caso for um quadro de Pneumonia, o antibiótico de escolha é a cefalosporina de 1ª geração.
- d) A solicitação unicamente de um Ecocardiograma transesofágico seria a melhor opção para ajudar no diagnóstico.
- e) Como o paciente está dispneico e com edema, um tiazídico, poderia de imediato tratar este tipo de paciente, mesmo antes dos exames solicitados.

32- Apesar das elevadas taxas de mortalidade resultantes de pneumonia na velhice, a idade, por si só, não contraindica a instituição de medidas agressivas para o tratamento, pois as pneumonias são doenças potencialmente curáveis, mesmo nos indivíduos frágeis e com múltiplas doenças crônicas. Entretanto, a fragilidade, a multimorbidade e o prejuízo funcional são fatores preditivos de pior prognóstico. Assinale a alternativa correta que descreva duas condições relacionadas à pneumonia de repetição em pacientes idosos:

- a) Disfagia com microaspirações e imobilidade.**
- b) Uso prévio de antibióticos e obesidade.
- c) Hospitalização recente e hipertensão arterial.
- d) Refluxo gastroesofágico e uso de sondas para alimentação.
- e) Incapacidade funcional e vacinação anual contra vírus influenza

33- P.S., 76 anos, chega ao PS com delirium, tosse com catarro amarelo, dispnéia ao repouso e que piora aos esforços, sem febre. Tem como patologias HAS, DPOC e DM II. Diante do Rx de tórax, se vê uma

condensação em base de pulmão direito. Com isso qual seria o melhor tratamento para este paciente e qual bactéria seria a mais provável?

- a) Levofloxacino e Streptococcus pneumoniae.**
- b) Cefalexina e Moraxella catarrhalis.
- c) Levofloxacino e Legionella.
- d) Azitromicina e Anaerobios.
- e) Clindamicina e Streptococcus pneumoniae

34- Diabético vêm ao consultório para controle da sua glicemia, já está em uso de Metformina e ... em doses máximas. Os exames atuais mostram: Hb glicada 8,0: Glicemia jejum 179, Glicemia pós prandial 198. Qual hipoglicemiante abaixo seria a melhor opção para ser associado a esse paciente?

- a) Sulfonilureia
- b) Inibidores da SGLT-2**
- c) Acarbose
- d) Insulina glargina.
- e) Metiglinidas

35- No Diabetes Mellitus do paciente idoso é incorreto afirmar:

- a) A meta de Hemoglobina Glicada em pacientes frágeis e com doenças degenerativas é de 8,0 a 8,5.
- b) A metformina tem como inconveniente em idosos a maior incidência de eventos adversos gastrointestinais.
- c) Em idosos robustos a HB GLI pode ficar em torno de 7,0 a 7,5
- d) A Glibenclamida é uma medicação segura para pacientes idosos com diabetes descompensado.**
- e) A Empaglifozina leva a glicosúria e diminuição do peso.

36- Paciente idoso, 71 anos, independente para suas atividades de vida diária; coronariopata, hipertenso e diabético vem ao consultório para controle da sua glicemia. Já está em uso de Metformina

850 mg 3x dia e Sitagliptina 100 mg por dia. Os exames atuais mostram: Hb glicada 8,0; Glicemia jejum 179; Glicemia pós prandial 230. Qual hipoglicemiante abaixo seria a melhor opção para ser associado a esse paciente?

- a) Sulfonilureia
- b) Insulina NPH
- c) Acarbose
- d) Inibidores da SGLT-2**
- e) Metiglinidas

37- No Diabetes Mellitus do paciente idoso é incorreto afirmar:

- a) A meta de Hemoglobina Glicada em pacientes frágeis é de 8,0 a 8,5.
- b) A metformina tem como inconveniente em idosos a maior incidência de eventos adversos gastrointestinais. O uso de formulações de ação lenta de droga, diminui esses efeitos colaterais.
- c) Os idosos tem os mesmos sintomas que os pacientes jovens, como poliúria, polifagia e emagrecimento.**
- d) Em idosos robustos a HB GLI pode ficar em torno de 7,0 a 7,5.
- e) A empaglifazona leva a glicosúria e diminuição do peso.

38- Assinale a alternativa que contém os sinais e sintomas comuns de hipertireoidismo entre os indivíduos

- a) Tremor e intolerância ao calor.
- b) Fibrilação atrial e perda de peso**
- c) Ansiedade e osteoporose
- d) Hiperfagia e oftalmopatia
- e) Disfagia e pele úmida

39- Sobre hipotireoidismo no idoso é incorreto afirmar:

- a) Uma das causas de hipotireoidismo é uso de medicações como a amiodarona.
- b) A principal causa de hipotireoidismo no idoso é a doença autoimune.
- c) O tratamento excessivo com levotiroxina pode elevar a mortalidade em idosos.

d) No hipotireoidismo subclínico, o tratamento deve ser feito quando o paciente tem sintomas como aumento de peso e alopecia

- e) Sempre iniciar com doses menores a levotiroxina, sendo que em cardiopatas a dose pode ser 12,5mcg/dia

40- Paciente de 80 anos comparece ao ambulatório de geriatria, com queixas de perda de peso de 6 kg em dias, fraqueza muscular e astenia. No retorno da consulta, traz como únicos exames alterados TSH 0,02 e T4 livre 4,6. Seria incorreto afirmar neste caso:

- a) O paciente idoso apresenta o chamado hipertireoidismo apático.
- b) O bócio multinodular tóxico é a causa mais comum de hipertireoidismo no idoso.**
- c) A fibrilação atrial pode ser a primeira manifestação dessa doença.
- d) O tratamento final na maioria das vezes é o iodo radioativo.
- e) Os tremores são menos frequentes nos idosos.

41- A droga de escolha no tratamento do hipotireoidismo no idoso é a levotiroxina, sendo assim, é incorreto dizer:

- a) Começar com doses pequenas e aumentar gradualmente, principalmente em pacientes cardiopatas.
- b) Pacientes acima de 80 anos com TSH entre 5 a 10 e sem anticorpos presentes não devemos tratar.
- c) O alvo terapêutico para o TSH deve ser de 2 a 3 mIU/L.
- d) TSH maior ou igual a 10, somente devemos tratar se houver sintomas e com anti-tpo positivo.**
- e) O hipotireoidismo subclínico caracteriza-se por TSH elevado e T4 livre normal.

42- Analise as afirmativas sobre a Osteoporose.

- I. São fatores de risco para osteoporose a artrite reumatoide, uso crônico de corticoides e o tabagismo.
- II. Homens não entram na investigação para osteoporose, pois a incidência é bem menor do que nas mulheres
- III. Os bisfosfonatos tem como efeitos colaterais sintomas dispépticos, úlcera esofágica e osteonecrose de mandíbula.
- IV. O cálcio de melhor absorção no idoso e com poucos efeitos colaterais é o carbonato de cálcio.

Quais estão corretas?

- a) I e III
- b) I, II e III
- c) III e IV
- d) I, II e IV
- e) I e II

43- Paciente do sexo feminino, traz ao consultório exame de densitometria óssea mostrando os seguintes resultados: colo do fêmur -3,1/ fêmur total -2,8. Coluna vertebral L1-L4 -L2. Exames de sangue normais. Tem histórico de obstipação intestinal crônica. Qual seria o diagnóstico e tratamento:

- a) Osteopenia, usar Raloxifeno e Carbonato de Cálcio 500 mg + Vitamina D 400 UI 2X ao dia.
- b) Osteoporose, usar alendronato sódico semanal e Carbonato de cálcio 500 mg 2x ao dia.

c) Osteoporose, usar risedronato sódico, cálcio citrato malato associado a vitamina D.

- d) Osteopenia, usar Risedronato sódico, cálcio citrato malato e denosumabe.
- e) Osteopenia, usar denosumab e vitamina D.

44- Paciente 69 anos, sexo feminino, vem ao consultório com queixas de cefaleia occipital, tonturas e mal-estar. Tem como comorbidades diabetes mellitus, incontinência urinária de urgência e asma brônquica. Ao exame físico PA

190/110mmhg, afebril, Pulso 76. Tórax: Hiperfonese de 2ª bulha em foco aórtico. Abdômen: sem visceromegalias, sem sopros presentes. Membros: pulsos presentes e normais, ausência de edema. Está em uso de Enalapril e hidroclorotiazida em doses máximas. Diante desse quadro clínico, o que podemos tomar como melhor conduta neste caso?

- a) Adicionar metildopa.
- b) A associação de losartana poderia ajudar na baixa da pressão e na proteção renal por causa do diabetes.
- c) Associar um bloqueador de canal de cálcio.
- d) Introduzir um diurético de alça para potencializar ação diurética e anti-hipertensiva.
- e) Passar hidralazina, pois é um quadro de hipertensão estágio 3.

45- Analise as afirmativas considerando a avaliação da PA em idosos:

- I. Nos idosos, há especial preocupação com a aferição da PA, pois o envelhecimento está frequentemente associado à disfunção barorreflexa e, consequentemente, à maior possibilidade de hipotensão postural e pós-prandial.
- II. Nos pacientes idosos, a medida da PA deve ser sempre realizada também com o paciente de pé, de preferência em todas as consultas ou quando queixas de tonturas, para avaliar a presença de hipotensão ortostática.
- III. Medir sempre em ambos os braços na primeira consulta, se houver uma diferença maior de 20mmhg de sistólica, deve se buscar causas vasculares para essa alteração.
- IV. Variabilidade diária dos níveis de pressão é menos frequente no idoso.

Estão corretas:

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II e III

d) I, II e III

46- Paciente, 77 anos, sexo feminino, vem ao consultório com queixas de cefaleia occipital, tonturas e mal-estar. Tem como comorbidades diabetes mellitus, incontinência urinária de urgência e asma brônquica. Ao exame físico PA 170/100 mmHg, afebril, pulso 76, Tórax: hiperfonese de 2ª bulha em foco aórtico. Abdome: sem visceromegalias, sem sopros presentes, Membros: pulsos presentes e normais, ausência de edema. Está em uso de Losartana e hidroclorotiazida em doses máximas. Diante desse quadro clínico, o que podemos tomar como melhor conduta neste caso?

- a) Adicionar um betabloqueador ao tratamento.
- b) A associação de um IECA poderia ajudar na baixa da pressão e na proteção renal por causa do diabetes.
- c) Como é uma mulher, poderemos usar como droga de escolha um anti-hipertensivo de ação central, como a metildopa.

d) Associar um bloqueador de canal de cálcio.

- e) Introduzir um diurético de alça para potencializar ação diurética e anti-hipertensiva.

47- Na HAS do idoso, há um aumento da mortalidade e morbidade por doenças cardiovasculares, independentemente da idade. Assim, é verdadeiro afirmar:

- a) Naqueles idosos frágeis a pressão arterial deve ser como alvo 120/80.
- b) Nos idosos existem com mais frequência a HAS do jaleco branco e a hipotensão ortostática.
- c) Os betabloqueadores podem ser usados em pacientes com insuficiência arterial.
- d) Os anti-hipertensivos de ação central podem ser usados como medicação de primeira escolha em alguns casos.

- e) O hiperaldosteronismo leva a HAS, hipercalemia e hiponatremia.

48- Paciente do sexo feminino, 70 anos, hipertensa, usando anlodipino irregularmente e má aderente ao tratamento, procura o ambulatório sem queixas para mostrar exame solicitado por outro médico e, na ocasião, apresentava dispneia aos grandes esforços. Ao exame físico no momento, chamaram atenção apenas a PA de 170x95mmHg. O exame era um ecocardiograma que mostrava FE do VE de 40%. Sobre esse caso, assinale a alternativa correta.

a) Deve-se controlar adequadamente a PA, e uma boa opção seria o início de um iECA.

- b) Uma ótima opção terapêutica seria diltiazem, potente vasodilatador.
- c) Um β -bloqueador não teria qualquer benefício nesse caso, já que não há qualquer evidência de doença isquêmica cardíaca.
- d) Um diurético tem evidência de melhorar sintomas como a dispneia e aumentar a sobrevivência, e, por isso, deve ser utilizado nesse caso, nesse momento.
- e) Uso do digital seria mandatório neste caso.

49- Paciente idoso de 77 anos chega ao PS com queixas de dispneia ao repouso e aos mínimos esforços, dispneia paroxística noturna, edema de MMII há 5 dias. Nega febre ou outros sintomas. Tem como comorbidades HAS de difícil controle e DPOC. Nos exames laboratoriais mostrou anemia hipocromica e hiponatremia. Restante normais. Exames físicos: dispneico, sat O₂ 89%. Tórax: brnf sem sopros, taquicardico em ritmo de galope, estertoração em bases. Abdome: sp. Edema +++/4 em MMII. Diante do caso, assinale a correta:

- a) É um caso provável de ICC, aonde a causa dessa descompensação é somente a HAS de longa data.

- b) Caso provável de ICC descompensado, onde é mandatório o uso de betabloqueadores e diuréticos no internamento.
- c) O paciente se encontra na Classe Funcional III da NYHA, aonde vai precisar de diuréticos de alça para melhora da congestão.
- d) O uso de digitálicos na ICC tem como indicação todas as classes funcionais, para melhora da bomba cardíaca.
- e) A hiponatremia é comum em pacientes com ICC.

50- A incontinência urinária é um dos gigantes da geriatria, levando a uma repercussão negativa na qualidade de vida do idoso. Sobre esse sintoma, considere as seguintes afirmativas:

- 1. A incontinência urinária pode ser transitória, como no caso de uma infecção urinária.
- 2. Na incontinência urinária de urgência a suspensão de um IECA que vem sendo usado, pode ajudar a diminuir ou cessar o sintoma.
- 3. A incontinência por transbordamento é caracterizada por perda urinária intensa após longo período de resistência ao ato miccional.
- 4. A oxibutinina usada no tratamento de bexiga hiperativa pode causar xerostomia, obstipação e piora de função cognitiva.
- 5. A fisioterapia uroginecológica é uma opção de tratamento louvável para a incontinência urinária de esforço.

Assinale a alternativa correta:

- a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 2, 4 e 5 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1 e 5 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 4 e 5 são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.

51- Sobre o principal binômio terapêutico da síndrome de fragilidade, o exercício físico e a nutrição... alternativas a seguir.

- I. A abordagem multiprofissional é parte essencial do tratamento.
- II. Os exercícios físicos devem ser estimulados em todas as consultas médicas e multiprofissionais e podem ser de natureza aeróbica ou resistida ser de natureza aeróbica ou resistida.
- III. Em idosos com desnutrição, a otimização nutricional faz-se essencialmente por orientação alimentar, considerando aspectos ambientais e culturais da ingesta.
- IV. O uso de suplementos pode ser necessário em muitas situações no tratamento da fragilidade e deve ser considerado individualmente.

Quais estão corretas?

- a) Apenas a I e a II.
- b) Apenas a I, a II e a III.
- c) Apenas a I, a III e a IV.
- d) Apenas a II, a III e a IV.

52- A Síndrome de Fragilidade é uma patologia que aumenta a mortalidade e leva a sérias complicações no decorrer dos anos.

Assim é falso afirmar:

- a) Tem como fisiopatologia a sarcopenia, a diminuição de hormônios como GH, estrogênio e testosterona e disfunção imunológica como aumento IL-1, IL-6 e fator de necrose tumoral.
- b) Existe um fenótipo para fragilidade, onde pacientes são mais propensos a ter esse tipo de patologia.
- c) O aumento do cortisol somente ocorre na vigência de doenças agudas como a Pneumonia, onde temos assim uma perda acelerada de massa muscular.
- d) O SARCF + Circunferência da panturrilha é um importante método de avaliação de fragilidade.

- e) A dosagem de enzimas musculares como a aldolase deve ser rotina na avaliação da fragilidade.

53- A Síndrome de Fragilidade leva a uma cascata de complicações como imobilidade, infecções e quedas. É de suma importância o reconhecimento dessa enfermidade durante o processo de envelhecimento. O médico geriatra tem como fazer esse diagnóstico usando que critérios?

- a) Presença na queixa clínica de cansaço físico e perda de peso acentuada.
- b) Quedas frequentes nos últimos 6 meses e sarcopenia.
- c) AVDs comprometidas e fraturas anteriores.
- d) Diminuição da força muscular, fadiga e cansaço ao andar.
- e) Teste cronometrado ao andar alterado e albumina diminuída.

54- Para idosos frágeis temos como base de tratamento:

- a) Fortalecimento muscular com exercícios contra resistência, exercícios para o equilíbrio e dieta com bom aporte de aminoácidos.
- b) Hidroginástica, pilates e dieta rica em aminoácidos.
- c) Fortalecimento muscular e hidroginástica.
- d) Dieta com bom aporte proteico e caminhada.
- e) Uso de testosterona, vitamina D e cálcio.

55- Quedas no idoso é um fator de preocupação para essa faixa etária, pelas complicações e aumento da mortalidade nessa faixa etária. Sobre esse assunto, analise os itens abaixo:

- I. Pisos escorregadios, brinquedos soltos pela casa e tapetes são armadilhas arquitetônicas para quedas.
- II. Polifarmácia não é causa de quedas.
- III. Podem levar a depressão, hospitalização e imobilidade.

- IV. O medo de novas quedas faz o paciente ter pouca mobilidade e causar novas quedas.
- V. A vitamina D não entra na investigação de quedas.

Estão corretos:

- a) I, II, IV
- b) II, III e IV
- c) I, II e IV
- d) I, III e IV
- e) II, IV e V

56- As quedas são a terceira causa de morte em idosos. Sobre esse assunto, analise os itens abaixo:

- I. Piso escorregadios e tapetes são armadilhas arquitetônicas para quedas.
- II. A iatrogenia não é causa de quedas.
- III. Podem levar a depressão, hospitalização e imobilidade.
- IV. Com a queda pode haver repercussão na parte cognitiva do paciente.
- V. A vitamina D e o cálcio sérico não entram na investigação de quedas.

Estão INCORRETOS:

- a) I e IV.
- b) II e V.
- c) IV e V.
- d) III e IV.
- e) II, III e IV.

57- Diante de um paciente idoso com quedas frequentes há 30 dias, com quadros súbitos de lipotimia, palidez cutânea, sudorese fria e sem relação com mudança de decúbito; que exame poderia ser fundamental pedir?

- a) Enzimas cardíacas
- b) Rx de tórax
- c) Holter de 24h
- d) Albumina sérica
- e) Gasometria arterial

58- A úlcera de pressão é uma das consequências da síndrome de imobilismo, aonde temos uma interrupção da irrigação sanguínea em

determinada área, motivada por uma pressão aumentada local. Assim, podemos afirmar como incorreto:

- a) O uso de colchões especiais com pressão reduzida e a mudança de decúbito cada 2 horas são alternativas importantes para a prevenção de escaras.
- b) O alginato de cálcio é muito usado em feridas muito secretivas e infectadas.
- c) Fatores de risco para úlceras de decúbito são imobilismo, idade avançada, desnutrição e incontinência urinária.
- d) O hidrogel tem indicação em feridas com tecido necrótico e com esfacelos.
- e) Na escara de decúbito com necrose e muita exsudação o curativo mais usado é o hidropolímero

59- Em cuidados paliativos, a importância do cuidado e do amparo no final da vida, junto ao paciente e seus familiares é a base dessa atividade. Desta forma, é incorreto dizer:

- a) O Midazolam é a droga de escolha para sedação.
- b) Na sialorreia usamos colírio de atropina em cavidade oral.
- c) Em pacientes com difícil acesso a hipodermoclise é uma via de infusão segura.
- d) No final de vida em pacientes que caminham para o óbito a dieta é suspensa, para dar mais conforto ao paciente.
- e) Pela hipodermoclise pode se fazer hidratação e sem restrição a qualquer medicação, por isso ...mais usada no paliativismo.

60- Na Síndrome Da Fragilidade temos como alterações hormonais, exceto:

- a) Diminuição de Vit. D
- b) Diminuição de testosterona
- c) Diminuição do GH
- d) Aumento de interleucinas 6 e 1
- e) Aumento de eritropoietina

61- Quais desses abaixo fazem parte dos critérios que levam ao diagnóstico de fragilidade no idoso:

- a) Emagrecimento de 10kg ou mais nos últimos 12 meses.
- b) Quedas frequentes e fadiga referida.
- c) Tonturas, quedas e lentificação da marcha.
- d) Força de preensão palmar diminuída e diminuição da testosterona.
- e) Emagrecimento, exaustão física e lentificação da marcha.

62- A espirometria forçada é o padrão-ouro para o diagnóstico da DPOC, qual o valor que confirma este diagnóstico?

- a) VEF1/CVF menor que 70% 10 minutos após inalação de 400mcg de Salbutamol spray
- b) VEF1/CVF menor que 50% 15 minutos após inalação de 400mcg de Salbutamol spray
- c) VEF1/CVF menor que 70% 20 minutos após inalação de 200mcg de Salbutamol spray
- d) VEF1/CVF menor que 50% 20 minutos após inalação de 200mcg de Salbutamol spray
- e) VEF1/CVF menor que 70% 20 minutos após inalação de 400mcg de Salbutamol spray

63- Assinale a incorreta:

- a) A vacinação anual para influenza reduz a evolução para infecção grave e a mortalidade dos pacientes com DPOC em cerca de 50%.
- b) A vacinação antipneumocócica é recomendada para pacientes com DPOC maiores que 65 anos, pois diminui a incidência de pneumonia comunitária.
- c) A corticoterapia sistêmica deve ser evitada nos pacientes com DPOC estável, em razão dos efeitos adversos observados e da ausência de benefícios.
- d) Algumas indicações para internação hospitalar no DPOC: aumento da

dispneia, alteração do comportamento ou sonolência, problemas socioeconômicos, hipoxemia refratária, hipercapnia com acidose, incapacidade para dormir, alimentar-se ou deambular.

e) Na classificação da gravidade funcional do DPOC, classificamos o estágio III ou moderado com $VEF1/CVF < 50\%$, dispneia acentuada, diminuição da capacidade na realização de exercício, fadiga, exacerbações e diminuição da qualidade de vida.

64- Assinale a incorreta:

- a) Nos diagnósticos diferenciais de DPOC podemos incluir: asma, ICC, bronquiectasia, sequela de tuberculose, bronquiolite obliterante e pan-bronquiolite difusa.
- b) Nos fatores de risco da DPOC podemos incluir: tabagismo, exposição a partículas inaláveis, infecções e fator genético.
- c) No fator de risco genético a deficiência de alfa-1-antitripsina é a mais conhecida.
- d) Nas manifestações clínicas da DPOC a tosse crônica é o mais comum, podendo preceder a dispneia e a obstrução do fluxo aéreo; porém não podemos esquecer que os sintomas dependem do estágio da doença.

e) Na bronquite crônica apresenta a destruição e alargamento dos espaços aéreos distais ao bronquíolo terminal sem fibrose evidente enquanto que no enfisema pulmonar evidenciamos para o diagnóstico tosse produtiva, 3 meses ao ano por 2 anos consecutivos.

65- Sobre a incontinência urinária (IU) marque V ou F:

- () A prevalência da IU é de extrema variabilidade nos estudos disponíveis;
- () Apesar de frequente, a IU é subestimada;
- () Na IU a qualidade de vida não é influenciada pelos aspectos ocupacionais.
- () Disfunções intestinais podem constituir fatores promotores de IU.

- a) V, F, V, V
- b) V, F, F, F
- c) F, F, F, V
- d) V, F, F, V
- e) V, V, F, V

66- Em relação a Diabetes no idoso, assinale a alternativa falsa:

- a) A disfunção da célula beta com menor produção de insulina, que no idoso é processo que ocorre em virtude do envelhecimento da maior deposição de beta amiloide.
- b) A resistência insulínica, também frequentemente presente no idoso em função das mudanças corporais que ocorrem com o envelhecimento como a diminuição de massa magra, aumento de massa gorda preferencialmente na região abdominal e diminuição da atividade física.
- c) O diabetes em idosos está relacionado a um risco maior de morte prematura, a maior associação com outras comorbidades e principalmente com as grandes síndromes geriátricas.
- d) No músculo estão presentes receptores de glicose, denominados GLUTs, que carregam a glicose do sangue para dentro da célula e mantém a glicemia normal.
- e) O aumento da glicose também é responsável por diminuir a resistência da ação dos receptores de insulina e consequentemente aumentar a expressão dos GLUTs.

67- Em relação a diarreia no idoso, assinale a alternativa incorreta:

- a) A diarreia crônica alta caracteriza-se por grande volume de fezes com poucas evacuações, dor abdominal, restos alimentares nas fezes, relação com os horários das refeições e manutenção das fezes na superfície da água.
- b) A diarreia crônica baixa caracteriza-se por várias evacuações durante o dia, precedidas de dor em cólica, volume

pequeno, sem restos alimentares e por vezes com muco e ou sangue vivo.

- c) Diarreia crônica mista ou inespecífica caracteriza-se quando não se distingue de alta com baixa.
- d) Idosos mantêm regras básicas dos adultos jovens seguindo os principais preceitos: como a confirmação do diagnóstico do quadro agudo; descartar sinais de alerta (sangramento, vômitos incoercíveis, emagrecimento e curso prolongado); investigar possíveis locais de contágio; suporte clínico com início de terapia de reposição volêmica; firmar diagnóstico precoce de complicações e prevenir recidivas.

e) Diarreia crônica Alta está relacionada com os cólons enquanto a baixa está relacionada com o intestino delgado.

68- Sobre infecção Urinária no idoso marque V ou F:

() Muito comum na população idosa, sendo que em pacientes com mais de 80 anos ocorre mais internação em mulheres que em homens.

() A atrofia vaginal, DM tipo 1 e higiene perineal inadequada compõem fatores de risco para infecção urinária em mulheres na pós menopausa.

() O uso de sonda vesical de demora aumenta a probabilidade de ITU.

() São fatores predisponentes> incontinência urinária, uso de fraldas geriátricas, obstrução uretral, baixa ingestão de líquidos.

() Indicações absolutas para internamento em casos de pielonefrite em idoso é anormalidade do trato urinário.

() A infecção do TGU é muito comum na população idosa e existem vários patógenos que podem causar ela, sendo o mais comum o Klebsiella sp.

() Para o diagnóstico de ITU há vários sintomas e sinais sendo o mais ocorrente a Febre >38°C.

() Os principais agentes de ITU em idosos são. E. coli e S. saprophyticus.

Marque a correta:

- a) V, V, F, V, V, V, F, V

b) V, V, V, V, F, V, V, V

c) F, F, V, V, V, V, F, F

d) V, V, F, V, F, F, V, V

e) V, V, V, V, F, F, F, V

69- Sobre bacteriúria assintomática (BA) e ITU no idoso marque V ou F:

() Patógeno mais comum na bacteriúria assintomática é E. coli, seguido por Klebsiella e Proteus.

() O diagnóstico da BA nos homens é dado através de apenas 1 cultura urinária >= 100000UFC/ml

() É indicação relativa para internamento da pielonefrite aguda: idade acima de 60 anos, imunodepressão, anormalidade no TGU, condições sociais e leucograma.

() Não é recomendado o rastreamento em pacientes assintomáticos, mesmo sendo diabéticos, neuropatas ou idosos.

() O diagnóstico de BA nas mulheres é dado através de 2 culturas urinárias >= 100000 UFC/ml

() Sendo está uma condição assintomática não há nenhuma condição em que se indique seu tratamento nos idosos.

() A ITU não é uma condição frequente entre os gerontes, e possui um aumento progressivo com o avançar da idade, tendo uma maior incidência entre a mulheres.

A alternativa com a sequência correta é:

a) V, V, F, V, V, V, F

b) V, V, V, V, F, V, V

c) F, F, V, V, V, V, F

d) V, V, F, V, F, F, V

e) V, V, V, V, V, F, F

70- Em relação a Tuberculose no idoso, assinale s incorreta:

a) A doença é o resultado de recrudescência de infecção longamente inativa, pois os idosos são os únicos que experimentaram a mais extensa exposição nas suas vidas.

b) A tuberculose pulmonar dos idosos na maioria das situações se mostra de forma atípica.

c) Os idosos estão mais predispostos à reinfecção, tanto endógena como

exógena, no entanto a reinfecção endógena é a mais frequente.

- d) A doença é mais facilmente transmitida em ambientes fechados e com exposição prolongada. Identificou-se a moradia nas instituições para idosos como importante fonte de contágio da doença.
- e) O tratamento da tuberculose no idoso é específico, diferente do adulto-jovem, pois o esquema medicamentos terapêutico tem relação com a idade do paciente e seu peso.

71- A manobra que, quando positiva, confirma o diagnóstico de vertigem posicional paroxística benigna (VPPB) é:

- a) manobra de Romberg
- b) tilt test
- c) manobra posicional de Dix-Hallpike
- d) teste get up and go
- e) escala de mobilidade e equilíbrio Tinetti

72- Mulher, 75 anos, portadora de demência tipo Alzheimer em uso de donepezila 5 mg, diabética em uso de insulina NPH e vildagliptina 100 mg/dia, cardiopata em uso de carvedilol 12,5mg/dia e hipertensa em uso de losartan 100 mg/dia, é admitida com icterícia e colúria. USG abdominal mostra aumento do volume hepático sem dilatação de vias biliares e com presença de ascite. A conduta imediata é a suspensão de

- a) losartana.
- b) carvedilol.
- c) vildagliptina.
- d) donepezila.

73- A vertigem é a sensação que o paciente tem de estar girando em torno do ambiente ou vice-versa. Mais raramente, há a sensação de movimento em balsa no plano horizontal, de movimento ascendente e descendente ou ilusão de rotação horária ou anti-horária no plano frontal. Assinale a alternativa INCORRETA acerca da vertigem.

- a) Pode ser acompanhada de outros sintomas, como náuseas, vômitos, tinnitus e hipoacusia.
- b) Na vertigem periférica, a lesão se encontra no labirinto e/ou nervo vestibular, até sua entrada no núcleo vestibular.
- c) A vertigem é provocada por disfunção do aparelho vestibular e se manifesta como uma ilusão de movimento, geralmente do tipo rotatório.
- d) A vertigem periférica pode estar associada a tinnitus e hipoacusia e o corpo costuma pender para o lado contralateral da lesão vestibular durante a queda.

74- São considerados critérios diagnósticos para Diabetes Mellito (valores em mg/dL):

- a) glicemia > 140 e < 200 após teste de tolerância à glicose.
- b) glicemia em jejum > 100 e ou igual a 126.
- c) glicemia casual >140.
- d) glicemia >140 após 75 g de glicose.

75- A tontura é uma queixa comum entre idosos e tem etiologia multifatorial. Sobre a tontura, assinale a alternativa correta.

- a) A farmacocinética das drogas sistêmicas não interfere no curso das tonturas que têm causa otológica.
- b) A vertigem posicional paroxística benigna é autolimitada, dura três meses e a manobra de Epley é eficaz para a recuperação.
- c) Qualquer tontura do idoso deve ser investigada com TAC e RNM, porque tem componente central.
- d) Os antivertiginosos devem ser usados continuamente, por serem vasodilatadores cerebrais e evitarem a esclerose cerebral.
- e) Tanto a vertigem central quanto a periférica são acompanhadas de intensos sintomas neurológicos.

76- Quanto à doença de Diabetes Mellitus na pessoa idosa, considere as seguintes assertivas:

- I. Os sintomas neuroglicopênicos não são mais relevantes nas pessoas idosas do que nos jovens.
- II. Na pessoa idosa, a glicosúria ocorre com valores mais elevados que em indivíduos jovens, exceto quando o idoso está em uso de diurético.
- III. Na pessoa idosa, os sintomas adrenérgicos muitas vezes não são percebidos e podem ser mascarados por drogas.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) **Apenas III.**
- d) Apenas I e II.
- e) Apenas II e III.

77- A metformina é contraindicada nos pacientes idosos diabéticos que apresentem:

- a) baixo peso corporal, depressão e insuficiência cardíaca.
- b) **tendência ao desenvolvimento de acidose láctica, portadores de insuficiências cardíaca, renal, respiratória e hepática.**
- c) obesidade, estresse cirúrgico, sepse.
- d) infecções graves de repetição, baixo peso corporal, tendência ao desenvolvimento de acidose láctica.
- e) infecções graves, baixo peso corporal, insuficiência renal

78- A diabetes mellitus tipo 2 está presente em cerca de 15-20% nos indivíduos maiores de 60 anos, e, entre medicamentos orais, utilizados no tratamento de tal doença, encontram-se as sulfonilureias, que podem apresentar como efeitos colaterais:

- a) cefaleia, redução do peso corporal, hipoglicemia, fotossensibilidade, anemia transitória.
- b) **distúrbios gastrointestinais, aumento do peso corporal, fotossensibilidade, hipoglicemia, púrpura.**

- c) aumento do peso corporal, derrame pleural, alteração nas transaminases, distúrbios gastrointestinais.
- d) anemia transitória, fotossensibilidade, hipoglicemia, aumento do peso corporal, alterações nas transaminases.
- e) edema, derrame pleural, anemia transitória, hipoglicemia, aumento do peso corporal.

79- O teste do levantar-se e caminhar cronometrado (Timed Up and Go) identifica idoso com alto risco para quedas, quando o tempo para execução do teste for superior a:

- a) 10 segundos.
- b) 12 segundos.
- c) 15 segundos.
- d) 18 segundos.
- e) **20 segundos.**

80- Os tipos de incontinência urinária que, mais frequentemente, acometem pacientes com demência da doença de Alzheimer estágio grave são:

- a) **urgência e funcional.**
- b) transbordamento e esforço.
- c) esforço e funcional.
- d) urgência e transbordamento.
- e) esforço e urgência.

81- A meta terapêutica da hemoglobina glicada para idoso diabético com expectativa de vida menor que cinco anos, segundo novo posicionamento publicado pela Sociedade Brasileira de Diabetes, em 2014, deve situar-se entre

- a) 6,0% e 7,0%
- b) 6,5% e 7,5%
- c) 7,0% e 8,0%
- d) **7,5% e 8,5%**
- e) 8,0% e 9,0%

82- A tontura é uma queixa comum entre idosos e tem etiologia multifatorial. Sobre a tontura, assinale a alternativa correta.

- a) A farmacocinética das drogas sistêmicas não interfere no curso das tonturas a causa é primariamente funcional otológica.
- b) neurite vestibular raramente causa sintomas de tontura em idosos.
- c) tontura no idoso deve ser investigada com tomografia de crânio porque tem comprometimento do sistema nervoso central.
- d) a síndrome de Ménière está diretamente relacionada a posições e movimentos do pescoço.

e) A vertigem posicional paroxística benigna é autolimitada e a manobra de Epley é eficaz para a recuperação do paciente.

83- Paciente de 63 anos de idade tem diabetes há cerca de 20 anos e há 8 anos, aproximadamente, está em insulino terapia. Atualmente, faz uso de insulina NPH humana, aplicando 28 U por volta das 8 horas e 20 U por volta das 22 horas. Ele faz automonitoramento com a dosagem de glicemia capilar duas vezes por dia, sempre antes de utilizar a insulina. Tem notado que a glicemia capilar da noite tem ficado em torno de 130 mg/dL, mas a glicemia capilar da manhã quase sempre está acima de 250 mg/dL. Além disso, frequentemente, ele tem acordado durante a madrugada com tremores, sudorese e fome. A melhor conduta para esse paciente é:

- a) visando evitar a hipoglicemia de rebote, deve ser iniciada uma dose de insulina regular de 0,1 U/Kg antes do jantar
- b) a dose da insulina da noite pode ser aumentada em 4 U, uma vez que a glicemia capilar da manhã está acima do desejável
- c) orientar o paciente a manter a dose de insulina e colocar o despertador para as 2 horas da madrugada para se alimentar, visando evitar os picos de hipoglicemia

d) a dose de insulina da noite pode ser reduzida, uma vez que é provável que

esteja havendo hipoglicemia durante a madrugada, com hiperglicemia reacional em seguida.

84- Paciente de 77 anos de idade vem à consulta, por apresentar quadro de tontura e algumas quedas, há 6 meses. Ela descreve que o sintoma aparece quando ela está caminhando e, às vezes sentada. Nega hipoacusia, zumbidos, disartria ou disfagia. Ao exame físico, PA = 130 x 70 mmHg, sentada e em pé, ausência de diplopia e ataxia. Exame cardiovascular: ausência de sopros carotídeos, bulhas cardíacas rítmicas e normofonéticas, sem sopros. A causa mais provável da tontura é:

- a) o uso de betabloqueadores, metildopa ou nifedipina
- b) pré-síncope secundária a um quadro de estenose aórtica
- c) o comprometimento da propriocepção e visão, secundários à idade
- d) síndrome de Ménière, se a paciente apresentar plenitude aural associada.

85- S.F. 82 anos, refere dispneia aos moderados esforços, nictúria, anorexia e edema de MMII, que piora no final da tarde há 5 dias. Nega precordialgia ou febre. Paciente relata também como comorbidades incontinência urinária de urgência, HAS, DM II e artrose de joelho. Na ISDA apresenta dor em joelho direito, em uso de medicação contínua e obstipação intestinal crônica.

- Antecedentes pessoais: colecistectomia há 10 anos

- Familiares: pai e mãe diabéticos.

- Medicamentos: captopril 25mg 12/12, AAS infantil, ibuprofeno 600mg 1xdia, metformina 850mg 1xdia

- Exame físico: PA 180/100, FC 100bpm, Tórax:

BRNF sem sopros, MV com estertores finas

bolhas em bases. Abdome: SP. Membros: edema de MMII inelástico, indolor 2+/4.

Qual seria a conduta mais adequada para o caso?

- a) Pedir exames laboratoriais, ECG, ecocardiograma; aumentar a dose do captopril para 3x ao dia e passar um diurético como a hidroclorotiazida 25mg/dia.
- b) Pedir exames laboratoriais, ECG, Rx de tórax e ecocardiograma; suspender ibuprofeno, aumentar a dose do captopril para 3x dia, e associar um diurético como furosemida 40mg.**
- c) Pedir Rx de tórax, suspender o ibuprofeno, aumentar a dose do captopril para 3x dia e não passar diuréticos, pois aumentaria a incontinência urinária de urgência do paciente.
- d) ECG, Rx de tórax ou ecocardiograma; aumentar a dose do captopril para 3x dia e associar um betabloqueador como o carvedilol 3,125mg 2x dia. ???? (HAS + ICC?)
- e) Pedir BNP sérico, ECG, Rx de tórax, suspender ibuprofeno, aumentar a dose de captopril para 3x dia e associar nitrato mais um diurético como furosemida 40mg.

86- Sobre o hipertireoidismo na terceira idade é verdadeiro afirmar:

- a) o Bócio multinodular tóxico é a principal causa de tireotoxicose no idoso.
- b) O tratamento deve ser realizado em todos os pacientes com hipertireoidismo subclínico.**
- c) No quadro clínico há presença de exoftalmia característica e pele úmida.
- d) O tratamento do hipertireoidismo é sempre com iodo radioativo.
- e) Após o tratamento com iodo radioativo o paciente continua usando as drogas antitireoidianas.

87- A Sra X, 84 anos, vem ao consultório para controle do seu DM. Nos exames de rotina, apresenta TSH 6,8 e T4 livre normal. Assim, qual seria a nossa melhor conduta frente ao caso de hipotireoidismo subclínico:

- a) Tratar com levotiroxina e repetir o exame em 40 dias.
- b) Não tratar com levotiroxina e repetir o exame do TSH, mais anti-TPO em 40 dias.**
- c) Caso o paciente apresente anti-TPO positivo e sem sintomas, mesmo assim não será feito o tratamento.
- d) Somente é feito o tratamento com levotiroxina com TSH acima de 15.
- e) Começar o tratamento com doses já elevadas de 50mcg de levotiroxina e repetir exame em 30 a 40 dias.

88- U.T, 69 anos, vem no ambulatório em tratamento por ICC há 3 anos, com queixas de dispneia aos médios esforços, ortopneia, fadiga. Ecocardiograma mostra IC sistólica com FE baixa. ECG: IAM anterior em parede anterior. Nega edema de MMII e hemoptise. Antecedentes pessoais: IAM há 4 anos com colocação de stent. Familiares: Pai teve AVC. Em uso de Losartana 50mg 12/12h, Furosemida 40mg/dia, AAS infantil e sinvastatina 40mg/dia. Ao exame físico: PA 150/90, FC 82bpm, Torax: BRNF sem sopros, MV + S/RA, FTV normal. Abdome: sp. MMII: sem edemas, presença de varizes. Qual seria o melhor tratamento para este paciente:

- a) Aumentar a dose de furosemida
- b) Associar carvedilol e espironolactona**
- c) Associar espironolactona
- d) Associar digital e carvedilol
- e) Trocar losartana por IECA e associar espironolactona.

89- Senhor Antônio de 93 anos é um paciente de uma instituição de longa permanência há 10 anos, desde que recebeu alta hospitalar após um acidente vascular cerebral que o deixou afásico, hemiplégico à direita e com gastrotomia. Com o passar dos anos sofreu outras injúrias isquêmicas, evoluindo para comprometimento cognitivo e dependência funcional grave. Tem como antecedentes HAS, DM, Dislipidemia, DAC

(revascularização miocárdica há 12 anos) e hipotireoidismo. Está internado neste momento com uma úlcera de pressão grau IV infectada. O exame físico apresenta, além da sequela do AVC, redução da amplitude de movimento das articulações dos joelhos, quadris e cotovelos. Tendo em vista o quadro descrito, qual é a alternativa correta?

- a) O paciente apresenta síndrome de fragilidade e necessidade de suporte nutricional hiper proteico e hipercalórico além de fisioterapia intensiva.
- b) O paciente apresenta síndrome da imobilidade e necessita de reabilitação fisioterápica e fonoterápica.
- c) O paciente apresenta síndrome da fragilidade e necessita de reabilitação fisioterápica e fonoterápica.
- d) O paciente apresenta sarcopenia, necessitando de suplementação nutricional hiperproteica e atividade física.
- e) O paciente apresenta síndrome da imobilidade e necessita de medidas de conforto e tratamento para as complicações, como úlcera de pressão.

90- Em relação ao idoso hipertenso, todas as afirmativas estão corretas, EXCETO:

- a) Seu débito cardíaco em geral é normal ou elevado, com resistência periférica aumentada;
- b) Sua pressão sistólica em geral é aumentada pela perda da elasticidade e distensibilidade dos vasos;
- c) O aumento de pressão diastólica ocorre por aumento da resistência periférica;
- d) O uso de anti-hipertensivos é indicado se PA sistólica for ≥ 160 mmHg e/ou PA diastólica ≥ 100 mmHg.
- e) Na urgência hipertensiva não há risco imediato de vida ou de dano agudo a órgãos-alvo, e o controle da PA deve ser feito com medicações orais em até 24 horas.

91- Em relação aos princípios gerais do tratamento anti-hipertensivo no idoso. Assinale a alternativa correta:

- a) Considerar que alterações hemodinâmicas decorrentes do envelhecimento podem afetar a distribuição, metabolização, eliminação, efeito e ação dos fármacos e conhecer interações medicamentosas mais comuns.
- b) Avaliar comorbidades que contraindiquem o uso de um fármaco específico.
- c) Escolher a medicação que permita menor número possível de tomadas diárias
- d) Iniciar em doses baixas e aumentar gradativamente e se possível, aguardar 1 mês antes de aumentar dose ou associar outro fármaco.
- e) Considerar as condições socioeconômicas e cognitivas do paciente e instruí-lo e/ou seus familiares sobre a doença, a importância do tratamento, a PA alvo e os possíveis efeitos colaterais dos fármacos.
- f) Todas as alternativas acima estão corretas.

92- P.S., 76 anos, acamado, sequelado de AVC há 4 anos, usando sonda nasointestinal; chega ao PS trazido pela família, com história de tosse com catarro, tiragem intercostal, e queda do estado geral. Família relata que o paciente broncoaspirou durante a dieta há 2 dias, com cianose de extremidades. No exame físico apresenta-se emagrecido, dispneico, afebril, com MV presente e com estertoração em base de pulmão direito. Diante do RX de tórax se vê uma condensação em base de pulmão direito. Com isso, qual seria o melhor tratamento empírico para este paciente?

- a) Cefalosporina de 2ª Geração
- b) Cefalosporina de 1ª Geração + Macrolídeo
- c) Levofloxacino

d) Cefalosporina de 3ª Geração + Metronidazol

e) **Clindamicina + Macrolídeo**

93- Paciente de 82 anos interna por fratura de fêmur, e após 3º dia de internamento, começa com confusão mental, tosse seca e taquicardia, sem febre ou dor torácica. Após os exames complementares chegou-se ao diagnóstico de Pneumonia. Quais seriam as drogas de eleição para este paciente?

a) Cefalosporina de 2ª Geração

b) Quinolona ou Cefalosporina de 2ª Geração

c) Macrolídeo

d) **Cefalosporina de 3ª Geração + Aminoglicosídeo ou Cefalosporina de 4ª Geração + Aminoglicosídeo**

e) Cefalosporina de 4ª Geração + Aminoglicosídeo ou Cefalosporina de 3ª Geração + Metronidazol

94- Mulher, 58 anos, comparece ao serviço de saúde para avaliação ginecológica anual de rotina. Não tem queixas atuais. Tem parentes próximos que apresentam vitiligo. Dos diversos exames laboratoriais coletados o único alterado foi o TSH = 7,8 um/l. O que dever ser feito?

a) Tratar com levotiroxina 1,5 mcg/kg de peso

b) Tratar com T3 50mcg/dia

c) **Repetir a dosagem de TSH em três meses**

d) Solicitar a ultrassonografia da tireoide

95- Homem de 83 anos, institucionalizado, tem poliúria e febre há cinco dias. Desde o dia anterior está coma alteração da consciência e já está há 24 horas sem urinar. Usa regularmente Metformina e Glibenclamida por diabetes tipo 2. Ao exame físico apresenta-se desidratado 4+/4, corado, eupneico, FC 120 bpm, PA 90.60 mmHg, FR 20irpm, T.Ax 38,5C, Glasgow 10. Exames laboratoriais: Glicose 600 mg/dl, creatinina 2,2 mg/dl, uréia 100mg/dl, sódio 156 mEq/l, potássio 3,2

mEq/l, Hemograma – leucocitose com neutrofilia e 12% de bastonetes. Urina leucócitos > 100/campo, hemácias em número normal e leuco-esterase positiva. Assinale a alternativa que contém os diagnósticos corretos e o tratamento adequado.

a) Sepses de foco urinário, diabetes descompensado, estimular a ingestão hídrica e administrar insulina.

b) **Estado hiperglicêmico hiperosmolar, sepse de foco urinário e insuficiência renal aguda, antibioticoterapia, hidratação intravenosa e insulina regular em infusão contínua**

96- Idoso queixa-se de tonturas tipo vertigem ao levantar e abaixar a cabeça. Quando se vira na cama piora o quadro. Nega náuseas ou vômitos. Nega zumbidos. Já usou Cinarizina 25mg3x dia por 5 anos, onde teve melhora, mas agora não faz mais efeito. Relata um tremor em mão direita ao repouso que atrapalha na sua vida diária. Tem como comorbidades esquizofrenia e hipertensão arterial. Usa Metildopa 500mg 2x dia e Haloperidol 5mg dia. Exame físico: PA 170x90 e tremor parkinsoniano em mão direita e roda dentada positiva no membro superior direito. VPPB – vertigem ao movimentar a cabeça. Diagnostico: DIX HALPIKE. Tto: EPLEY.

a) Qual a conduta frente ao caso de tonturas?

Manobra de Epley. Suspender Cinarizina + acrescentar Betaistina + Ginkgo Biloba.

b) Quais seriam as causas desse tremor?
Cinarizina, haloperidol ou metildopa.

c) Qual a conduta na hipertensão arterial?
Retirar metildopa + acrescentar IECA ou BRA (Losartana)

97- Sobre a síncope nos pacientes idosos, marque a correta:

- a) Infecções virais e retenção hídrica nunca tem relação com a fisiopatologia da síncope.
- b) O tratamento farmacológico de comorbidades do paciente idoso, como doença arterial coronariana, DPOC, ICC, HAS, não é fator adicional ao risco de síncope.
- c) A capacidade de manutenção da consciência independe da oferta de oxigênio e substrato metabólico ao cérebro.
- d) O diagnóstico diferencial da síncope com lipotimia e queda, sem perda da consciência, convulsões, embora não seja importante, é sempre fácil.
- e) O diagnóstico etiológico da síncope tem relação com o tratamento.

98- Paciente de 67 anos de idade faz uso regular de hidroclorotiazida 25 mg pela manhã, para controle de hipertensão arterial. É portadora de asma, mas não apresenta sintomas, desde que mantenha o uso regular de budesonida/ formoterol inalatório (200/6 mcg duas vezes por dia). Há cerca de 3 meses, em função de um quadro depressivo, foi-lhe prescrito amitriptilina 25 mg à noite. Nesse período, houve uma melhora notável dos sintomas depressivos já ao final do primeiro mês de tratamento. No entanto, no último mês tem sentido “tonteira” quando se levanta da cama ou do sofá, o que motivou sua vinda à consulta atual. Tem usado com frequência um medicamento que a vizinha lhe receitou para a dor relacionada à osteoartrose dos joelhos e, além disso, como tem notado constipação intestinal, tem usado, diariamente, um laxativo. Sobre esse caso, é possível afirmar que:

- a) A prescrição de um anti-histamínico não sedativo seria uma boa opção para o tratamento da vertigem dessa paciente
- b) A dose de amitriptilina pode ser aumentada para 50 mg por dia, uma vez

que o quadro depressivo ainda não está plenamente controlado

- c) A “tonteira” pode ser a interpretação da paciente de algum sintoma relacionado à asma, devendo ser aumentada a dose dos medicamentos inalatórios
- d) A paciente pode estar apresentando hipotensão postural; nesse caso, o médico deve observar a associação do diurético tiazídico com o antidepressivo tricíclico

99- Em relação a síncope em idosos, marque a INCORRETA:

- a) Hipotensão ortostática e Hipersensibilidade do seio carotídeo podem ser causas.
- b) Isquemia miocárdica não tem relação com síncope, pois interfere apenas no sistema cardíaco.
- c) Causas metabólicas e psiquiátricas também podem ser causas.
- d) Síncope em idosos asilados estão associados a hipotensão induzida por drogas como nitratos, betabloqueadores e vasodilatadores.
- e) Doenças com fluxo sanguíneo cerebral normal ou aumentado podem levar à diminuição ou perda da consciência, variando da sonolência ao coma; porém com menos frequência, são causadoras de síncope, devido principalmente a hipoxemia (por anemia ou distúrbios de hematose) ou hipoglicemia.

100- Paciente vem apresentando há 2 horas quadro súbito de vertigens de forte intensidade, com quedas, náuseas, vômitos e zumbido. Nega diminuição de força muscular ou parestesias. Qual seria o provável diagnóstico?

- a) Vertigem Posicional Paroxística Aguda
- b) Vertigem associada a Depressão
- c) Insuficiência Vertebro basilar
- d) Vertigem de origem metabólica
- e) Doença de Menière

101- Na Vertigem Posicional Paroxística Benigna temos um tipo de tontura muito incapacitante no idoso, podendo levar a quedas e fraturas. Sobre essa patologia é INCORRETO dizer:

- a) **Vertigem posicional associada a diplopia e fraqueza muscular.**
- b) O tratamento se baseia na Manobra de Epley e/ou Betaistina.
- c) O paciente tem tonturas que duram segundos a minutos e é a tontura mais frequente no idoso.
- d) A cinarizina e flunarizina podem ser usadas como arsenal terapêutico.
- e) Pode haver náuseas associado ao quadro.

102- Qual o grupo de medicamentos que não causa hipotensão ortostática e tonturas no idoso?

- a) Antidepressivos tricíclicos.
- b) **Antidepressivos inibidores da recaptação da serotonina.**
- c) Diuréticos tiazídicos.
- d) Bloqueadores dos canais de cálcio derivados da dihidropiridina.
- e) Nitratos.

103- As quedas são a terceira causa de morte em idosos. Sobre esse assunto, analise os itens abaixo:

- I. Idosos caem mais por causa dos déficits visual e auditivo.
- II. Pisos escorregadios e tapetes são armadilhas arquitetônicas para quedas.
- III. Podem levar a fraturas, hospitalização e imobilidade.
- IV. Idosos da comunidade caem mais que idosos em ILPI.
- V. Com a queda pode haver repercussão na parte cognitiva do paciente.

Estão INCORRETOS:

- a) II e IV.
- b) **I e IV.**
- c) I e II.
- d) II e V.
- e) IV e V.

104- Paciente de 89 anos refere obstipação intestinal crônica há 10 anos, já usou lactopurga com melhora, mas tem reclamado de cólicas que o remédio causa. Tem como comorbidades Hipotireoidismo, Diabetes Mellitus e Depressão Maior. Trouxe exames para consulta que fez há 30 dias. TSH: 9,8; ureia 32; Cr 1,4; Sódio 136; potássio 4,6; glicemia jejum 78; HbA1c 5,6%; glicemia pós 90. Medicamentos em uso: Vildagliptina 100mg/dia, Glicazida 60mg/dia, AAS 100mg/dia, Enalapril 10mg 2x dia, Nortriptilina 50mg dia, Levotiroxina 75mcg.

- a) Diante do caso o que você faria para a Obstipação desse paciente?

Correção do hipotireoidismo, suspender lactopurga, usar laxante formador de bolo fecal muvinlax.

- b) As medicações estão corretas? Você faria alguma correção ou não?

Aumentaria a Levotiroxina 125mcg + Suspenderia glicazida, tricíclico (escitalopram).

- c) Quais seriam as possíveis causas de obstipação intestinal nesse paciente?

Hipotireoidismo, DM, tricíclico

105- Paciente de 58 anos, vem com outros exames e diz ao médico que quer fazer “exames da tireoide”. Resultados: TSH 7,05 (referência 0,5 a 5,0); T4l 1,10 (referência 0,6 a 1,5); anticorpo anti tireoperoxidase elevado. A respeito desse caso, pode afirmar:

- a) é impossível excluir hipotireoidismo nessa paciente somente com esses exames e deve-se, portanto, solicitar dosagem de T3 sérico.
- b) Como a paciente não tem sintomas, não há necessidade de tratamento.
- c) A paciente apresenta hipotireoidismo subclínico e não tem necessidade de tratar.

- d) é necessário solicitar hemoglobina glicada, perfil lipídico, creatinofosfoquinase e prolactina, devido a associação de aumento do TSH com alterações desses exames.

e) A paciente apresenta um quadro de hipotireoidismo subclínico, devendo iniciar o uso de levotiroxina.

106- Paciente de 60 anos de idade, em uma consulta de retorno com o seu geriatra, trouxe uma ultrassonografia da tireoide, apresentando um nódulo em lobo esquerdo medindo 0,8 cm de diâmetro, com as seguintes características: hipoeogenicidade, microcalcificações, margem irregular e hipervascularização intranodular. O TSH estava normal. A conduta correta para o caso é:

- a) indicar radioiodoterapia
- b) solicitar punção aspirativa com agulha fina
- c) indicar remoção cirúrgica da glândula tireoide
- d) seguir com ultrassonografia da tireoide a cada 6 meses

107- Paciente com Hipertensão de difícil controle, com histórico de litíase urinária de repetição e fraqueza muscular nos últimos 3 meses. Paciente vinha com excelente controle, mas houve uma piora do quadro hipertensivo nesses últimos 90 dias. Qual seria a causa dessa provável descompensação?

- a) Hipertensão renovascular.
- b) Doença de Cushing.
- c) Feocromocitoma.
- d) Hipertireoidismo.
- e) Hiperparatireoidismo

108- Paciente do sexo masculino, traz ao consultório exame de Densitometria Óssea mostrando resultado de Osteoporose. Exames de sangue normais, exceto vitamina D de 12 (valor de

referência é de 30). Paciente sem queixa clínica. Nega fraturas anteriores. Qual será o tratamento:

- a) Raloxifeno e Carbonato de Cálcio 500mg + Vitamina D 400UI 2x ao dia. (não é mulher)
- b) Colecalciferol 1000 UI por dia, Bifosfonato e Carbonato de Cálcio 500mg 2x ao dia. (dose errada)
- c) Bifosfonato, Carbonato de Cálcio 500mg + Vitamina D 400UI 1x ao dia e uso de testosterona.
- d) Calcitonina intranasal e Colecalciferol 50.000UI 1x por semana por 60 dias.
- e) Colecalciferol 50.000UI 1x por semana por 60 dias, Bifosfonato e Carbonato de Cálcio 500mg 2x ao dia.

109- Homem de 72 anos, caucasiano, apresenta fratura espontânea de fêmur. É tabagista ativo (50 anos/maço) e apresenta DPOC com episódios frequentes de exacerbação e uso de corticosteroides por via sistêmica. Tem avaliação urológica recente com dosagem de PSA normal, IMC= 24 kg/m², estável há dez anos. O hemograma, cálcio, fósforo, sódio, potássio e função renal são normais. Seu diagnóstico clínico mais provável é:

- a) Osteoporose – com uso de corticoide sistêmico e IMC 24 kg/m² fatores agravantes.
- b) Hiperparatireoidismo
- c) Hipoparatireoidismo
- d) Osteoporose – com uso de corticoide sistêmico como fator agravante e IMC 24 kg/m² fator protetor.

110- Qual medicamento não causa osteoporose no idoso?

- a) Corticoide
- b) Anticonvulsivante
- c) Metotrexate
- d) Ramipril
- e) Imunossupressores

111- Os fármacos utilizados para o tratamento da osteoporose que atuam na reabsorção óssea são os bifosfonatos. Quanto ao uso desses medicamentos, é CORRETO afirmar que:

- a) os efeitos farmacológicos dos bifosfonatos cessam rapidamente após a interrupção do uso dos mesmos
- b) reações como febre, mialgias e artralgias são comuns no início do tratamento com bifosfonatos de uso oral
- c) se os pacientes não estiverem recebendo reposição adequada de cálcio e vitamina D, eles podem desenvolver hiperparatireoidismo secundário
- d) são medicações seguras após 5 anos de uso; assim, deve-se mantê-las, por haver redução importante do risco de fraturas com seu uso a longo prazo

112- Sobre a vacinação de idosos, é CORRETO afirmar:

- a) Os indivíduos imunodeprimidos, esplenectomizados e asilados devem tomar a vacina antipneumocócica a cada 10 anos.
- b) O idoso que apresentar reações adversas à vacina da gripe após 7 dias deve ser internado.
- c) Os doentes pulmonares não devem ser vacinados, porque pode haver o agravamento da doença básica.
- d) A vacina dupla contra difteria e tétano deve ser tomada em dose única.
- e) A vacina contra influenza é anual, segura e deve ser adiada se o idoso mostra uma síndrome gripal em curso.

113- Paciente de 82 anos interna para realizar Colectomia, após 3o dia de internamento, começa com confusão mental, tosse seca e taquicardia, sem febre ou dor torácica. Após os exames complementares chegou-se ao diagnóstico de Pneumonia. Quais seriam as drogas de eleição para este paciente?

- a) Cefalosporina de 2a Geração.

b) Clindamicina ou Cefalosporina de 3a Geração.

c) Quinolona

d) Cefalosporina de 1a Geração + Aminoglicosídeo

e) Cefalosporina de 4a Geração + Aminoglicosídeo

114- Paciente de 70 anos de idade apresenta-se no ambulatório com tosse há 5 dias, febre de até 39°C e dispneia. Ao exame físico, encontra-se um pouco confuso, FR = 36 ipm, PA = 120 x 70 mmHg. À ausculta respiratória, crepitação em terço médio do hemitórax esquerdo. A conduta mais adequada, nesse caso, é:

- a) prescrição de sintomáticos, solicitação de raio X de tórax PA e perfil e orientação de retorno com o exame em mãos para decisão da conduta
- b) encaminhamento para tratamento hospitalar como pneumonia grave adquirida na comunidade
- c) prescrição de amoxicilina+clavulanato por 10 dias e reavaliação em 7 dias
- d) prescrição de levofloxacino por 7 dias e reavaliação em 3 dias

115- Um paciente com noventa e cinco anos de idade, com demência de Alzheimer na fase grave, recebe atendimentos domiciliares regulares há mais de cinco anos e encontra-se acamado, com síndrome de fragilidade, osteoporose, doença do refluxo gastroesofágico e diabetes melito tipo 2. Faz uso de ácido acetilsalicílico 100 mg por dia, alendronato sódico 70 mg por semana, carbonato de cálcio 500 mg por dia, sinvastatina 10 mg por dia e aspartato de L-arginina 250 mg/dia. Na consulta anterior, a família reiterou a vontade de não mais levá-lo ao hospital se caso complicasse a doença, pois da última vez que isso ocorreu ele ficou internado na unidade de terapia intensiva por quase trinta dias. Após um episódio de engasgo

importante, começou no dia seguinte com episódios de tosse produtiva amarelada e febre, onde o médico é chamado a residente e confirma o diagnóstico clínico de pneumonia. Não há sinais de hipoxemia evidentes. Qual a conduta mais adequada diante do caso?

- a) Internar o paciente em UTI, pois o mesmo apresenta várias comorbidades. O antibiótico de escolha seria o cefepime.

b) Tratar em domicílio e usar dois antibióticos: moxifloxacino e metronidazol.

- c) Internar o paciente na enfermaria devido as várias comorbidades e usar ceftriaxona.
d) Tratar em domicílio o caso, usando uma quinolona respiratória associado a um macrolídeo.
e) Chamar atendimento de Home Care e usar ceftriaxona endovenosa.

116- Um paciente com 74 anos chega ao pronto atendimento com febre, confusão mental, agitação e taquicardia. O quadro clínico é compatível com:

1. alucinação.
2. demência.
3. delirium.
4. pneumonia aguda.

Estão corretos os itens:

- a) 1 e 2 apenas.
b) 2 e 3 apenas.
c) 1, 3 e 4 apenas.
d) 1 e 2 apenas.
e) 1, 2, 3 e 4

117- Quanto ao acompanhamento do tratamento da tuberculose pulmonar, pode-se afirmar que:

- a) nos casos de abandono do tratamento, deverá ser feita nova avaliação por meio de baciloscopia, cultura, identificação e teste de sensibilidade, aguardando-se o resultado desses exames para a escolha do esquema

b) caso o paciente tenha escarro negativo no final do tratamento, mas uma evolução clínica radiológica ainda insatisfatória, pode-se prolongar o tratamento por mais três meses

- c) a cultura para micobactérias com identificação e teste de sensibilidade deverá ser solicitada se, após o primeiro mês, a baciloscopia do paciente continuar sendo positiva
d) é considerado falência no tratamento, quando a baciloscopia continua positiva, mesmo com poucos bacilos, no quinto ou sexto mês de tratamento

118- Diante de um paciente de 65 anos de idade, com quadro de Tuberculose pulmonar é correto afirmar:

- I. A maioria dos casos é por reativação do Complexo Primário de Ranke.
- II. O uso de métodos invasivos para a elucidação diagnóstica não deve ser descartado para o paciente, caso o exame de escarro seja negativo.
- III. Presença de cavernas em ápices pulmonares tem incidência menor no idoso.
- IV. Os idosos tem maior incidência de hepatotoxicidade com o uso das drogas.

Assinale a alternativa correta:

- a) I e II estão corretas.
b) II e III estão corretas.
c) Todas estão corretas.
d) I e IV estão corretas
e) I, II e III estão corretas.

119- São sintomas/sinais do idoso com insuficiência cardíaca, EXCETO:

- a) Síncope
b) Alterações do sono
c) Tremores
d) Confusão mental
e) Tosse

120- Sr. João Pedro, 82 anos, ex-professor de matemática e viúvo há 2 anos. Vinha em primeira consulta

apresentando quadro de labilidade emocional esporádica, tristeza e apatia, com melhora importante do quadro depressivo após a introdução de um antidepressivo (Escitalopram 10 mg 1x ao dia). Neste retorno relata que sua disposição voltou ao normal e está até passeando mais – sic. E que está feliz também pois seu cardiologista o elogiou pelo bom controle do tratamento cardíaco. HMP: HAS, Insuficiência Cardíaca, Hiperplasia Prostática Benigna e Depressão. Medicamentos em uso: Losartan, Carvedilol, Furosemida, Aldactone, AAS, Combodart e Escitalopram. Exames laboratoriais: CT:262 HDL: 33 LDL: 182 TGC: 145 GJ: 116 E demais dentro da normalidade. Avaliando o quadro clínico do paciente e os exames laboratoriais atuais, podemos concluir:

- a) Que o paciente agora vem apresentando hipercolesterolemia e deve ser aplicado o Escore de Framingham para avaliar o risco cardíaco.
- b) Deve ser iniciado o uso de estatina e um hipoglicemiante oral.
- c) Deve ser iniciado tratamento para hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia.
- d) Dever ser iniciado o tratamento para hipercolesterolemia, orientação alimentar e aplicar o Escore de Framingham.**
- e) Deve ser iniciado o tratamento com estatina, orientação alimentar e não é necessário aplicar o Escore de Framingham.

121- Paciente idoso com ICC apresenta maior hospitalizações e maior mortalidade que os pacientes jovens, com isso podemos afirmar, EXCETO:

- a) As manifestações da ICC no idoso são atípicas, com sintomas inespecíficos como delirium e anorexia.
- b) A Ivabradina pode ser indicada para pacientes com classe funcional I a IV com fibrilação atrial.**

- c) A digoxina pode ser usada em pacientes com ICC diastólica com Fibrilação atrial associada.
- d) o antagonista da aldosterona é indicada para todos os pacientes sintomáticos.
- e) os estertores finos em bases pulmonares pode ocorrer também em idosos por tempo prolongado no leito e inatividade física.

122- Paciente de 70 anos de idade sofreu, há 2 anos, um infarto agudo do miocárdio (IAM) e, como consequência, evoluiu com insuficiência cardíaca congestiva (ICC). Estava com um bom controle dos sintomas, mas há um mês se queixa de dispneia aos moderados esforços (consegue caminhar no plano e arrumar a casa). Não se lembra de ter tido episódios de dor torácica nesse período. No momento, usa enalapril 10 mg de 12/12h, hidroclorotiazida 25 mg/dia, AAS 200 mg/dia. Ao exame físico, apresenta aumento de peso de 3 kg em 30 dias, bulhas cardíacas com sopro sistólico em foco mitral, frequência cardíaca de 88 bpm, pressão arterial de 160/100 mmHg, edema (+2/+4) em membros inferiores e ausculta pulmonar normal. A conduta farmacológica mais adequada para esse caso é:

- a) associar hidralazina-isossorbida 3 vezes ao dia
- b) introduzir carvedilol, na dose de 3,125 mg, 2 vezes por dia
- c) aumentar a dose de hidroclorotiazida para atingir o peso seco**
- d) substituir o enalapril por um antagonista dos receptores de angiotensina II

123- A respeito do diagnóstico e manejo da insuficiência cardíaca, é CORRETO afirmar:

- a) o ecocardiograma é indispensável para o diagnóstico de insuficiência cardíaca

- b) a investigação da etiologia da insuficiência cardíaca é dispensável, pois o tratamento deve ser sintomático
- c) a digoxina é um medicamento indicado na maior parte dos casos, pois está associado à redução da mortalidade entre pacientes com a doença

d) os inibidores da enzima conversora de angiotensina são medicamentos de primeira escolha, pois seu uso está associado à redução da mortalidade entre pacientes com a doença

124- Nas descompensações cardíacas em pacientes com insuficiência cardíaca sistólica, os betabloqueadores devem ter a dose:

- a) aumentada rapidamente
- b) diminuída
- c) suspensa
- d) mantida

125- Assinale a alternativa errada em relação à dislipidemia no idoso:

- a) Somente pacientes com boa saúde que, na ausência de um evento coronariano, tem um prognóstico bom de sobrevida longa com boa qualidade de vida devem ser considerados para o tratamento de dislipidemia.
- b) Muitas situações não haverá indicação para um tratamento. Como por exemplo pacientes com doenças concomitantes severas como quadros demenciais, neoplasia maligna, doença cerebrovascular severa, insuficiência cardíaca severa e pacientes terminais.
- c) A correção dos fatores de risco é justificada para pessoas com expectativa razoável de vida.
- d) O bom estado geral da saúde do paciente favorece a intervenção no fator de risco e considerações práticas, tais como motivação do paciente, situação econômica, dieta e afecções clínicas coexistentes, devem ser levadas em

consideração na decisão sobre o tratamento.

- e) Independente da idade e comorbidades, todos os pacientes idosos devem ser tratados quando apresentarem dislipidemia.

126- A dislipidemia é um dos fatores de risco cardiovascular mais importantes. Considere um paciente de 64 anos, sexo feminino, com infarto do miocárdio há 3 meses, atualmente com LDL de 149 mg/dL. O seu cardiologista orientou que seria mais seguro manter níveis de LDL abaixo de 100 mg/dL, inclusive tentando obter valores próximos a 70 mg/dL. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela em há maior chance de êxito:

- a) Ciprofibrato 100 mg por via oral.
- b) Pravastatina 20 mg por via oral.
- c) Rosuvastatina 10 mg por via oral.
- d) Fluvastatina 40 mg por via oral.
- e) Ezetimibe.

127- Um homem de 88 anos, hipertenso, parkinsoniano, e portador de marca-passo cardíaco há 8 anos, evolui com dispneia progressiva há duas semanas. Nega dor precordial. No momento tem dispneia quando fala. Ao exame físico apresenta: mucosas coradas, sem cianose, estase jugular a 45 graus, discretos estertores crepitantes nas bases pulmonares e alguns roncos bilaterais, ritmo cardíaco regular com sopro sistólico em foco mitral, pressão arterial = 130x70 mmHg e frequência cardíaca = 100 bpm. Quais os exames complementares de maior relevância na investigação da dispneia deste paciente?

- a) Dosagem do BNP e ecocardiograma.
- b) Dosagem do hemograma e radiografia do tórax.
- c) BNP sérico e teste ergométrico.
- d) Dosagem do dímero D e angiotomografia do tórax.
- e) Holter e Tomografia de coronárias.

128- Sr. RM, 76 anos, chega ao PS com queixas de tonturas, dispneia aos repouso e aos esforços há 2 dias. Nega dispneia paroxística noturna, febre, ortopneia ou edema de mmii. Paciente tem como diagnóstico pelo seu cardiologista FA há 2 anos, segundo a filha que o acompanha. Medicamentos em uso: varfarina 5mg ½ cp ao dia; atenolol 50mg/dia, enalapril 20mg/dia e omeprazol 20mg/dia. No exame físico mostra discretamente dispneico, taquicárdico, FC 125bpm, FR 30irpm, PA 130/80mmHg, afebril e com o restante do exame normal. Hemograma normal, uréia 40, clearance de creatinina 65, Na 135, K 4,0, TAP com INR 2,5. ECG: Fibrilação Atrial. Qual a melhor conduta para esse paciente:

- a) Aumentar a dose de varfarina, devido o TAP não estar de acordo com os valores normais da anticoagulação, prescrever diurético como furosemida e diminuir a FC com amiodarona.
- b) Prescrever diurético como furosemida e diminuir a FC com amiodarona
- c) Aumentar a dose de varfarina, introduzir digital e hidroclorotiazida como diurético.
- d) Diminuir a dose de varfarina, reverter a FA para sinusal usando amiodarona ou propafenona e prescrever diurético como furosemida.
- e) Prescrever diurético como furosemida e tentar reverter a fibrilação atrial e sinusal com cardioversão elétrica pois o paciente mesmo com medicação está descompensado.

129- Paciente idosa de 79 anos, com Diabetes Mellitus, vem perdendo peso nos últimos meses. Refere que se alimenta bem. Refere também tem fadiga e câimbras pelo corpo. Como queixas adicionais tem referido diminuição de memória recente há 7 meses que vem piorando. Esquece aonde guarda objetos, já deixou a panela queimar varias vezes,

repete assuntos e segundo o marido se perdeu um dia perto de sua casa. Sua mãe teve Doença de Alzheimer com 82 anos. Nega outras comorbidades. Tem curso superior, foi pedagoga. Medicações: Glifage 850mg 3x dia, Saxagliptina 5mg, Glimeperida 6mg/dia, Empaglifazona 25mg/dia. Exames atuais: glicemia jejum 382; glicemia pós 472; HbA1c 11; Cr 1,8; ureia 54; TSH 2,3; hemograma normal.

- a) Para o diabetes da paciente o que você faria como conduta?

Insulinoterapia a noite 6 a 8u glargina ou nph.
Manter antidiabeticos orais.

- b) No caso do distúrbio cognitivo, que testes de memória você faria para essa paciente?

MEEM + teste do relógio + teste de fluência verbal, lista de palavras, mooca.

- c) Quais os exames que pediria para investigar o déficit cognitivo?

RNM de crânio, b12, ácido fólico, tap, tgo, tgp, tsh, eletrólitos e função renal, vdrl ftaabs

130- Assinale a alternativa correta em relação ao envelhecimento e a sua relação com o Diabetes Mellitus.

- a) Quando iniciam com Diabetes Mellitus os idosos necessitam de terapia com insulina.
- b) Em situações de stress, os idosos desencadeiam quadro de diabetes que não reverte quando a situação estressante desaparece.
- c) A capacidade de a insulina estimular a captação de glicose diminui com a idade e geralmente se manifesta como hipoglicemia pós-prandial, mas com níveis de glicose e insulina de jejum normal.

d) Algumas alterações fisiológicas imitam doenças quando podem ser uma parte normal do envelhecimento; assim, a Diabetes mellitus pode “aparecer” e “desaparecer” em idosos.

- e) A perda de reserva fisiológica de glicogênio hepático é o fator determinante para o aumento da prevalência de diabetes com o avançar da idade.

131- Assinale a opção que apresenta uma consequência indesejada da metformina no idoso:

- a) Aumento do risco cardiovascular.
b) Sintomas gastrointestinais.
c) Hipoglicemia.
d) Retenção hídrica.
e) Ganho de peso.

132- Paciente de 67 anos de idade, portador de diabetes mellitus tipo 2 desde os 50 anos de idade, aproximadamente. Atualmente, faz uso de metformina apenas e, na última consulta, como não havia um controle glicêmico adequado, optou-se por aumentar a dose da medicação de 850 mg/dia para 1700 mg/dia. Para avaliar o impacto desta intervenção, está indicado o seguinte exame complementar:

- a) hemoglobina glicosilada, que deve ser realizada em 30 dias
b) hemoglobina glicosilada, que deve ser realizada em cerca de 90 dias
c) insulina basal, que deve ser realizada, mensalmente, nos primeiros meses
d) glicemia de jejum, que deve ser realizada, semanalmente, durante o primeiro mês, após o ajuste da dose

133- Uma mulher de 65 anos, assintomática, obesa e diabética há 6 anos, vai ao médico mostrar seus exames laboratoriais. Apresenta glicemia de jejum = 258 mg/dl e Hb glicada A1c = 8,2%. A paciente faz uso de glimepirida 2 mg/dia e metformina 850 mg 2x/dia. Qual a melhor abordagem terapêutica para esta paciente?

- a) Acrescentar sitagliptina e aumentar dose da glimepirida.

- b) Introduzir insulina, manter metformina e aumentar dose da glimepirida.
c) Introduzir insulina, manter metformina e suspender glimepirida.
d) Internar a paciente para insulinização plena.

e) Acrescentar sitagliptina e aumentar dose da metformina.

134- Sr. 80 anos, com diagnóstico de Depressão Maior, pela escala de Yesavage, relata que tem Diabetes Mellitus Tipo II, em uso de Metformina 850mg 2x ao dia, com razoável controle. Relata dor em queimação em membros inferiores, mais precisamente em pés de maneira simétrica. No exame de Eletroneuromiografia mostrou Polineuropatia Diabética. Diante do caso depressivo e de dor, qual seria o melhor medicamento em questão:

- a) Diazepam
b) Fluoxetina
c) Duloxetina
d) Trazodona
e) Sertralina

135- Paciente de 67 anos de idade é hipertensa, diabética e faz uso de hidroclorotiazida 25 mg, enalapril 20 mg e espironolactona 25 mg, todos pela manhã. Além disso, é medicada com metformina 850 mg, 3 vezes por dia e sinvastatina 40 mg à noite. A taxa de filtração glomerular calculada a partir do MDRD é de 40 mL/min (taxa de filtração glomerular está baixa = insuficiência renal). Considerando o valor encontrado, a medicação que deve ter sua dose reduzida é:

- a) Enalapril
b) Metformina
c) espironolactona
d) hidroclorotiazida

136- A hipertensão arterial sistêmica é considerada:

- a) síndrome, cuja prevalência na população urbana no Brasil varia de 22 a 43%
- b) entidade nosológica caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial ($\geq 140 \times 90$ mmHg)
- c) **fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e déficits cognitivos, como doença de Alzheimer, demência vascular e senil**
- d) patologia, cujas complicações mais comuns são insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e doença renal crônica

137- Paciente idosa chega ao consultório médico, com queixas de cefaleia occipital, tonturas e mal-estar. Nega dor precordial ou dispneia. Tem HAS em tratamento usando ENALAPRIL, ANLODIPINO e HIDROCLOROTIAZIDA todos em dosagem máxima. Como comorbidades tem somente Osteoporose. Ao exame físico: PA 180.90mmhg e restante normal. Exames laboratoriais normais. Qual seria o próximo medicamento a ser associado a essa paciente para controle da pressão arterial?

- a) **Nebivolol.**
- b) Metildopa.
- c) Furosemida.
- d) Nifedipina.
- e) Valsartana.

138- A incontinência urinária é um sinal e sintoma de um problema médico que impacta a qualidade de vida do idoso. Sobre esse sintoma, considere as seguintes afirmativas:

- I. Bacteriúria assintomática, vaginite atrófica e infecção urinária são causas de incontinência.
- II. Clonidina, salbutamol e aminofilina podem causar incontinência urinária transitória.
- III. A incontinência por transbordamento é caracterizada por perda urinária intensa

após longo período de resistência ao ato miccional.

- IV. A oxibutinina usada no tratamento de bexiga hiperativa pode causar xerostomia, obstipação e piora da função cognitiva.
- V. A incontinência urinária funcional pode estar presente em idosos com déficit cognitivo, dificuldade de locomoção, hospitalizados.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas I e V são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
- d) **Somente as afirmativas IV e V são verdadeiras.**
- e) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.

139- Um homem de 76 anos de idade, geralmente com boa saúde, começou a notar problemas há cinco meses os quais estão piorando. Apresenta dificuldade para levantar-se de poltronas baixas e dos vasos sanitários. O que mais provavelmente apresenta esse paciente?

- a) **Fraqueza muscular proximal.**
- b) Disautonomia.
- c) Disdiadococinesia.
- d) Fraqueza muscular distal.
- e) Apraxia de marcha.

140- A prevalência e a incidência de idosos frágeis foram demonstradas em vários estudos, sobretudo em idosos residentes em ILPI. São considerados critérios de Fragilidade, segundo Fried et AL:

- a) Déficit cognitivo e baixo nível de atividade física.
- b) **Perda de peso não intencional e fadiga.**
- c) Perda de peso 4,5kg em 6 meses e instabilidade postural.
- d) Incontinências e sarcopenia.

- e) Redução da velocidade da marcha e albumina sérica abaixo de 2,0g/dl.

141- Com o envelhecimento temos um processo de perda de massa magra e aumento de massa gorda. Assim, é INCORRETO afirmar:

- a) Há uma maior perda de fibras do tipo I, de contração rápida.
- b) A diminuição de massa muscular é chamada de sarcopenia.
- c) A sarcopenia pode levar a quedas no paciente idoso.
- d) O sistema muscular é o que mais sofre com o processo de envelhecimento.
- e) O aumento do tecido gorduroso pode interferir no processo farmacodinâmico de certas drogas.

142- Uma senhora de 80 anos acamada há 2 anos, começou a desenvolver Úlcera por Pressão. O médico que avaliou a ferida descreveu dessa maneira: Presença de lesão ulcerada grau III, medindo 6 cm com bordas hiperemiadas, sem tecido necrótico e com secreção amarelada em grande quantidade, com odor fétido. Diante dessa lesão, qual o tratamento curativo a ser realizado:

- a) Ácidos graxos essenciais.
- b) Alginato de Cálcio.
- c) Hidrocoloide.
- d) Hidrogel.
- e) Colagenase pomada.

143- Paciente de 74 anos de idade foi diagnosticado, há 1 ano, com um câncer de pulmão metastático, cujas possibilidades terapêuticas foram esgotadas há 3 meses. Em consulta domiciliar apresenta-se restrito ao leito devido à caquexia, com baixa ingestão hídrica, mas usando fraldas descartáveis e urinando normalmente. Está sem defecar regularmente há alguns dias. Sua prescrição inclui metoclopramida 10 mg 8/8 horas, codeína + paracetamol 30 + 500

mg 8/8 horas, omeprazol 40 mg pela manhã em jejum e clonazepam 2 mg às 22 horas. Está consciente, e, perguntado sobre como se pode ajudá-lo, responde que a dor está bem controlada, mas as náuseas persistem, que a barriga está muito inchada por não defecar e que isso o tem incomodado bastante, especialmente porque tem a sensação de que há ocupação retal mesmo após defecar. A melhor medida a ser tomada, considerando o desejo do paciente e seu manejo adequado, é:

- a) suspender a codeína+paracetamol e iniciar metadona
- b) manter a codeína+paracetamol e introduzir o óleo mineral
- c) suspender a codeína+paracetamol e prescrever naltrexona
- d) manter a codeína+paracetamol e realizar toque retal para investigar a presença de fecaloma

144- Paciente feminina de 72 anos de idade encontra-se no domicílio, restrita ao leito, com diagnóstico de câncer de colo de útero sem possibilidade terapêutica. Apresenta dor de forte intensidade (8 na escala de dor), síndrome da anorexia-caquexia e constipação. Além de orientações alimentares e aumento da ingestão hídrica, o melhor esquema medicamentoso para essa paciente é:

- a) opioides fortes, anti-inflamatórios, gabapentina, prednisona e laxativos
- b) anti-inflamatórios não hormonais e amitriptilina
- c) opioides fortes, imipramina e laxativos
- d) dipirona, nortriptilina e laxativos

145- Paciente de 82 anos, vem ao PS com tosse com catarro com expectoração amarelada, chiado no peito, queda do estado geral, sem dor torácica ou dispneia há 3 dias. Nega febre. Refere nesses dias confusão mental associado, alteração do ciclo sono vigília. Paciente é diabética, em

uso de medicações: glimeperida e metformina. Paciente foi tabagista por 30 anos, 1 maço/dia. Nega HAS.

EF: PA 160.90, HGT 320

REG, confusa, desidratada, eupneica.

Tórax: BRNF2T taquicardia sem sopros. MV diminuído em base esquerda, sem estertores, com sibilos difusos. FTV aumentado em base esquerda.

Abdômen: Sem visceromegalias, ruídos normais, indolor.

Neurológico: desorientada, agitada, sem sinais localizatórios e sinais meníngeos.

- a) Quais os diagnósticos dessa paciente?

Diabetes tipo 2. PNM, DPOC.

- b) Quais exames a serem pedidos?

RX tórax, HMG, glicemia de jejum e HbA1c.

- c) Quais as medicações a serem prescritas, pois a paciente ficará internada no hospital. Faça uma prescrição hospitalar:

Dieta pastosa assistida para DM, hidratação com SF sódio e potássio, haloperidol IM 01 amp pode repetir a cada 30 min se paciente não acalmar. Ranitidina EV a cada 12h. Suspende medicação da DM e deixa insulina regular se precisar, heparina SC 12 em 12h. Captopril 25mg SL, se necessário. Inalação com berotec e atrovent. Antibiótico, ceftriaxona com azitromicina EV ou levofloxacino ou moxifloxacino EV isolado. CTC prednisolona 1mg/kg a cada 6h ou hidrocortisona, controlar glicemia e avaliar confusão mental. FST respiratória. Higiene oral com capacol e mudança de decúbito.

- 146- Paciente, sexo feminino, 73 anos, refere obstipação intestinal há mais de 10 anos, sem outras queixas clínicas. Como comorbidades: HAS, DM II, obesidade leve

e osteoartrite de coluna lombar. Usando como medicações: enalapril 10 mg, metformina 850 mg, tramadol 50 mg e amitriptilina 25 mg. Diante do quadro, qual seria a melhor conduta?

- a) trocar o enalapril por outro anti-hipertensivo devido a ser obstipante, atividade física regular e bisacodil dose única a noite.
- b) Suspender somente o tramadol, atividade física regular, orientação nutricional quanto a fibras e fenolftaleína como laxante.
- c) Atividade física regular, orientação nutricional quanto a fibras, suspender tramadol e amitriptilina e usar o plantago ovata.
- d) Atividade física regular, orientação nutricional quanto a fibras, suspender amitriptilina e prescrever cáscara sagrada
- e) Orientação nutricional quanto a fibras, trocar metformina por acarbose e prescrever ... enema a cada 7 dias.

- 147- Em idosos, é fundamental prevenir a iatrogenia, uma vez que, nessa faixa etária, há uma vulnerabilidade aumentada quanto às reações adversas às drogas e a determinadas situações. Nessa fase da vida, é comum a:

- a) Iatrogenia decorrente de polifarmácia, da interação medicamentosa e do desconhecimento das alterações farmacocinéticas associadas ao envelhecimento.
- b) Iatrogenia do silêncio, associada ao desconhecimento de técnicas de comunicação de más notícias.
- c) Iatrogenia da palavra, que decorre da dificuldade de ouvir adequadamente o paciente e sua família.
- d) Iatrogenia do excesso de intervenções reabilitadoras na qual o déficit de "equipe interdisciplinar" pode trazer consequências desfavoráveis ao paciente.

148- Devemos ficar atentos as principais alterações farmacológicas e farmacodinâmicas das drogas do Idoso, pois com isso evitaremos possíveis iatrogenias, sendo com isso correto dizer:

- a) No geronte temos maior intoxicação por drogas hidrofílicas, como o fenobarbital.
- b) Temos um prejuízo na absorção de certos medicamentos no idoso devido a sua hipocloridria, sendo um dos exemplos o ferro e salicilato.**
- c) A digoxina é um dos medicamentos que não sofre alteração na absorção devido ao Ph mais alto no geronte.
- d) Tanto o processo de oxidação como conjugação hepática estão reduzidos no paciente idoso.
- e) A creatinina é fidedigna não avaliação renal do idoso.

149- Um número significativo de idosos é vítima de síndromes semelhantes, independentemente de doenças específicas, denominadas os 5 "Is" ou gigantes da geriatria. Descritas inicialmente por Isaac, os 5 "Is" foram acrescidos de duas novas síndromes que atuam diretamente na saúde do idoso, totalizando, agora, os 7 "Is" da geriatria. As duas novas entidades são:

- a) Incapacidade comunicativa e iatrogenia.
- b) Incapacidade comunicativa e insuficiência familiar.**
- c) Insuficiência familiar e imobilidade.
- d) Iatrogenia e imobilidade.

150- O teste recomendado pelo Ministério da Saúde, a ser aplicado pela Atenção Básica, para avaliação do desempenho do idoso na realização das atividades básicas de vida diária é:

- a) Escala de Barthel
- b) Escala de Katz**
- c) MiniCog
- d) Miniexame do estado mental
- e) Escala de Lawton

151- Idosa em uso de Varfarina devido a FA crônica, apresentou há 2 dias hematoma de parede abdominal e vaginal. Exame físico normal, exceto a presença de hematoma de parede. Seus exames laboratoriais de entrada mostraram-se normais, exceto um TAP com INR de 10. Qual a melhor conduta frente ao caso?

- a) suspender a varfarina e usar inicialmente vitamina K endovenosa e se necessário plasma fresco congelado.
- b) Suspender a varfarina e fazer controle do TAP INR até voltarem ao normal.
- c) Suspender a varfarina, fazer concentrado de plaquetas e controlar TAP INR.
- d) Diminuir a dose de varfarina e usar vitamina k endovenosa.
- e) Diminuir a dose de varfarina pela metade e fazer plasma fresco congelado.

152- A.T., 72 anos, queixa-se de obstipação intestinal há 40 dias, com fezes em cíbalos, esforço evacuatório, ficando até 4 dias sem evacuar, aonde usa laxante receitado pelo balconista de farmácia, com melhora parcial. Paciente nega dor abdominal, enterorragia ou febre. Não relata perda de peso. Paciente foi tabagista crônico por 30 anos, nega etilismo. Nega diabetes. Como comorbidades é depressivo e usa nortriptilina 50mg/dia. Tem HAS, com bom controle em uso de enalapril 10mg/dia. Exame físico normal. Qual é a melhor conduta sobre esse paciente?

- a) pedir exames laboratoriais como TSH, cálcio, urina I. Não pedir colonoscopia ainda, pois vamos esperar os exames laboratoriais. Manter a nortriptilina.
- b) Pedir exames laboratoriais como hemograma, TSH, cálcio, pesquisa de sangue oculto nas fezes e Rx simples de abdome. Suspender nortriptilina e passar ISRS.**
- c) Pedir colonoscopia e Rx simples de abdome.

- d) Solicitar hemograma, ureia, creatinina, cálcio, TSH, colonoscopia. Suspende nortriptilina e usar um ISRS.
- e) Pedir hemograma, ureia, creatinina, cálcio, glicemia de jejum, TSH e colonoscopia. Trocar a nortriptilina e enalapril, por ISRS e losartana

153- M.P.S. 67 anos, refere quadro de apatia, insônia, fraqueza geral, desânimo, ansiedade principalmente no período da manhã há 6 meses. Foi diagnosticado Depressão maior e iniciado Mirtazapina 30mg, sendo que após 40 dias teve melhora parcial dos sintomas. Aumentado dose da medicação para 45mg e pedido para retornar em 40 dias. Paciente volta com melhora da insônia, mas ainda com alguns sintomas depressivos e de ansiedade. Diante do quadro, poderemos seguir qual conduta?

- a) associar lítio
- b) eletroconvulsoterapia
- c) associar ISRS
- d) introduzir um benzodiazepínico
- e) Trocar a medicação por ISRS

154- A.T.R, 78 anos, sexo masculino, em tratamento com sertralina para Depressão maior há 60 dias, com melhora importante dos sintomas de anedonia, desânimo, ansiedade. Entretanto, refere dificuldades para iniciar o sono e sono entrecortado. Apresenta muitos cochilos durante o dia. Tem como comorbidades HPB, obesidade, HAS e dislipidemia. Analisando o caso, qual seria a melhor medicação para esse paciente?

- a) benzodiazepínico como o Lexotam
- b) amitriptilina ao deitar-se
- c) mirtazapina associada ao deitar-se
- d) trazodona ao deitar-se
- e) zolpidem em dose baixa.

155- A obstipação intestinal é um sintoma de incidência de 50% em casas de repouso, podendo ter de causar

orgânicas ou funcionais. Sendo assim é falso afirmar:

- a) o uso de anticolinérgicos e anti-inflamatórios são causas de obstipação.
- b) O fecaloma é uma complicação da obstipação intestinal, podendo ter o paciente a diarreia paradoxal.
- c) Sais de magnésio é uma opção boa em pacientes idosos, sendo isento de efeitos colaterais.
- d) As antraquinonas como o Sene, podem causar Melanosis coli.
- e) O domperidone e a bromoprida são adjuvantes no tratamento da obstipação.

156- Paciente com DPOC diagnosticado há 5 anos, comparece ao PS com piora quantidade de secreção pulmonar, com expectoração amarelada há 3 dias, sem dispneia ou ortopneia. Nega febre. No Rx de tórax mostra-se somente enfisema pulmonar. Pedido de exames laboratoriais que mostrou hemograma com leucocitose discreta e com desvio a esquerda. Demais exames normais. Qual seria sua prescrição?

- a) quinolona respiratória como Levofloxacino por 10 dias e hidratação.
- b) Quinolona como ciprofloxacim por 10 dias e hidratação
- c) Macrolídeo como a azitromicina por 10 dias e hidratação
- d) Associação de levofloxacino e azitromicina e hidratação
- e) Cefalexina por 10 dias.

157- Paciente com depressão grave vem ao consultório geriátrico com queixas de anedonia, melancolia, fraqueza geral, desânimo e vontade de ficar somente na cama. Está em uso de venlafaxina e mirtazapina em doses máximas há 6 meses, com pouca melhora. Frente ao caso qual seria a sua conduta mais provável?

- a) eletroconvulsoterapia

- b) Trocar a venlafaxina e colocar um tricíclico como a Nortriptilina
- c) Associar a lamotrigina
- d) Associar ISRS
- e) Trocar a venlafaxina por um antipsicótico atípico como a quetiapina.

158- Pacientes idosos com ICC, apresentam maior hospitalização e maior mortalidade do que pacientes jovens, com isso podemos afirmar, exceto:

- a) O antagonista da aldosterona é indicado para todos os pacientes sintomáticos.
- b) As manifestações de IC no paciente idoso são atípicas muitas vezes, com sintomas inespecíficos como anorexia e delirium.
- c) Os estertores finos em bases pulmonares podem ocorrer também em idosos por tempo prolongado no leito e com inatividade física.

d) A Ivabradina pode ser indicada para pacientes Classe Funcional I a IV e com Fibrilação Atrial.

- e) A digoxina pode ser usada em pacientes com IC diastólica quando associada com Fibrilação Atrial.

159- Paciente de 68 anos de idade vem à consulta para mostrar exames solicitados em um outro serviço de saúde. Apesar de estar assintomática, ela havia dito ao médico que gostaria de fazer “exames da tireoide”, pois tem irmãs com doenças tireoidianas. Os resultados foram os seguintes: TSH 7,05 mUI/L (valor de referência: 0,50 a 5,00 mUI/L); T4 livre 1,10 ng/dL (valor de referência: 0,60 a 1,50 ng/dL); anticorpo anti-tireoperoxidase elevado. A respeito desse caso, pode-se afirmar que:

- a) Como a paciente não tem sintomas, não há necessidade de usar levotiroxina.
- b) É necessário solicitar hemograma, perfil lipídico, creatinofosfoquinase e prolactina, devido à associação de aumento de TSH com alterações nesses exames.

- c) É impossível excluir hipotireoidismo nessa paciente somente com esses exames, deve-se, portanto, solicitar a dosagem de T3 sérico.

- d) A paciente apresenta hipotireoidismo subclínico e não há necessidade de utilização de levotiroxina no momento.

e) A paciente apresenta um quadro de hipotireoidismo subclínico por Tireoidite de Hashimoto, devendo ser iniciado o uso de levotiroxina.

160- Idosa com dor em joelho esquerdo, com crepitação e discreto edema. Fez RX do joelho que mostrou Osteoartrite. Paciente refere também instabilidade na articulação com algumas quedas. Quais as condutas que seriam mais adequadas a essa paciente?

- a) Fisioterapia e joelheira
- b) Artroplastia total e fisioterapia
- c) Hidroxicloroquina, Ácido Hialurônico e fisioterapia

d) Ácido hialurônico, joelheira e fisioterapia motora

- e) Glicosamina + Condroitina e fisioterapia

161- O manejo da dor crônica com antidepressivos tricíclicos é muito comum. Qual das condições dolorosas abaixo demonstrou benefício no uso do antidepressivo tricíclico, porém não comprovado efeito analgésico?

- a) Neuralgia pós-herpética.
- b) Neuropatia diabética.
- c) Cefaleia tensional.
- d) Enxaqueca.

e) Dor lombar crônica.

162- No estudo da geriatria, são considerados os gigantes da geriatria ou grandes “I”. Essas situações devem obrigatoriamente ser pesquisadas na abordagem geriátrica. Quais das situações clínicas correspondem a dois desses grandes “I”?

- a) Imobilidade e incompetência istmo-cervical
- b) Insuficiência cardíaca e iatrogenia
- c) Insuficiência renal e insuficiência cerebral
- d) Incontinência fecal e infarto do miocárdio
- e) Incontinência urinária e instabilidade postural

163- No tratamento medicamentoso da constipação intestinal crônica do idoso, na suspeita de obstrução intestinal, são formalmente contraindicados:

- a) laxantes e sais osmóticos.
- b) lubrificantes.
- c) laxantes formadores de massa.
- d) laxantes emolientes ou amolecedores de fezes.
- e) laxante estimulante ou de contato.

164- Com relação ao envelhecimento renal, é correto afirmar que ocorre:

- a) diminuição do limiar de excreção renal de glicose.
- b) aumento da concentração plasmática de aldosterona.
- c) aumento da capacidade tubular distal de reabsorver sódio.
- d) aumento da síntese de 1,25(OH)₂ vitamina D.
- e) diminuição da atividade da renina plasmática.

165- Paciente de 62 anos de idade, vem ao ambulatório com queixa de constipação presente há vários anos. Tem evacuado apenas uma ou duas vezes por semana, quase sempre com muito esforço, e, de vez em quando, fica com a sensação de que não conseguiu evacuar tudo. Ocasionalmente usa laxantes, que aliviam um pouco os sintomas, mas deixam as fezes amolecidas, o que também a incomoda. Não tem história familiar de problemas semelhantes. Nega sangramento nas fezes e perda de peso. Fora a constipação, tem boa saúde: tem HAS controlada, faz caminhadas diárias e

tem uma dieta rica em verduras, frutas, pães e carne (branca e vermelha). Fez alguns exames laboratoriais 6 meses atrás, incluindo uma pesquisa de sangue oculto nas fezes, com resultado negativo. O exame do abdome é normal e o toque retal não encontra alterações. Diante do quadro, a conduta mais adequada é:

- a) solicitar colonoscopia
- b) contraindicar as caminhadas
- c) prescrever supositórios de glicerina
- d) orientar o aumento da ingestão de líquidos

166- Paciente de 60 anos de idade procura seu geriatra queixando-se de que está sem evacuar há 3 dias. Iniciou sintomas há 2 anos, sendo que, nos últimos 3 meses, está evacuando duas vezes por semana. Relata eliminação de gases, e que, na maioria das vezes, faz esforço para evacuar e apresenta sensação de esvaziamento incompleto. Nega alteração na cor ou consistência das fezes, nega dor abdominal ou mudança da forma ou frequência das evacuações. É hipertensa há 10 anos e faz uso de atenolol 100 mg e enalapril 20 mg. Sem alterações no exame físico. O diagnóstico, mais provável, e o plano terapêutico mais adequado são, respectivamente:

- a) constipação intestinal primária; orientar a paciente sobre as variações individuais do trânsito intestinal, prescrever dieta rica em fibra e líquidos, atividade física e reeducação intestinal
- b) constipação intestinal secundária ao uso de medicação; trocar anti-hipertensivo e prescrever um laxante emoliente e dieta rica em fibras e líquidos
- c) síndrome do cólon irritable; detectar eventos de vida que estão associados com os momentos de constipação
- d) constipação intestinal crônica; solicitar colonoscopia para exclusão de doenças anorretais e do cólon

167- Obstipação intestinal é uma das queixas mais frequentes em Geriatria, com uso de inapropriados de laxantes por essa faixa etária. Com isso podemos afirmar:

- a) Os laxativos osmóticos como sais de magnésio e sódio são os de primeira escolha para o idoso.
- b) As antraquinonas com Sene e Cáscara Sagrada, por serem fitoterápicos, praticamente são isentos de efeitos colaterais.
- c) O hipertireoidismo é um exemplo de causa de obstipação intestinal
- d) O fecaloma é uma complicação da obstipação intestinal, sendo caracterizado por fezes em cíbalos e enterorragia.

e) Os laxativos formadores de bolo fecal, como Psílio, devem ser evitados em pacientes acamados e com Megacólon

168- Paciente do sexo feminino, traz ao consultório exame de densitometria óssea mostrando os seguintes resultados: colo do fêmur -3,1/ fêmur total -2,8. Coluna vertebral L1-L4 -L2. Exames de sangue normais. Tem histórico de obstipação intestinal crônica. Qual seria o diagnóstico e tratamento:

- a) Osteopenia, usar Raloxifeno e Carbonato de Cálcio 500 mg + Vitamina D 400 UI 2X ao dia.
- b) Osteoporose, usar alendronato sódico semanal e Carbonato de cálcio 500 mg 2x ao dia.
- c) Osteoporose, usar bifosfonato, cálcio citrato malato associado a vitamina D.
- d) Osteopenia, usar Risedronato sódico, cálcio citrato malato e denosumabe.
- e) Osteopenia, usar denosumab e vitamina D.

169- Paciente de 73 anos, com obstipação intestinal há 7 dias, com dor em hipogástrio tipo cólica, fraca intensidade e sem irradiação. À dor

melhora com antiespasmódico e sem fator de piora. Nega outros sintomas associados. Comorbidades: DM, artrose de joelhos e doença de parkinson. Exame físico: crepitação de joelhos, joelhos em varo, parkinsonismo. Medicamentos: levodopa, metformina e codeína. Diante do caso é ERRADO AFIRMAR:

- a) A codeína e a doença de Parkinson são fatores para obstipação neste paciente
- b) Pouca mobilidade desse paciente devido à sua artrose e levodopa são causas de obstipação

c) Como conduta o mais acertado seria dieta rica em fibras, hidratação e um laxante como antraquinona

- d) Um toque retal seria de fundamental importância
- e) Uma colonoscopia ou um enema opaco seriam exames de imagem a serem pedidos

170- Mulher, 76 anos, cardiopata isquêmica, hipertensa e diabética, há 4 meses apresentou AVEI, com seqüela motora em dimídio direito, permanecendo cadeirante. Evoluiu há 2 meses com alteração do humor, chorosa, irritada, desejando morrer, alegando não servir para mais nada. Sente muita dor nas pernas e na coluna. A opção terapêutica para essa paciente é

- a) Clomipramina.
- b) Fluoxetina.
- c) Duloxetina.
- d) Trazodona

171- A dor é uma experiência sensorial desagradável, multicausal, de intensidade variável, que requer diagnóstico e tratamento. Sobre a dor, assinale a alternativa correta.

- a) A analgesia nunca deve ser feita com opioides associados a anti-inflamatórios não hormonais.
- b) Os idosos não respondem a medidas não farmacológicas para alívio da dor.

c) Antidepressivos tricíclicos, neurolépticos e anti-histamínicos são medicações coadjuvantes no tratamento da dor.

- d) A persistência da dor requer o aumento progressivo da dosagem do anti-inflamatório.
- e) A potência analgésica e a tóxica de cada anti-inflamatório caminham paralelas; melhor intercalar diferentes tipos de AINES.

172- Assinale a alternativa que apresenta corretamente opioides para tratamento de dor de intensidade leve a moderada no indivíduo idoso.

- a) Morfina e nalbufina.
- b) Cetorolaco e fentanila.
- c) Tramadol e codeína.
- d) Oxycodona e metadona.
- e) Meperidina e dipirona.

173- Qual a arritmia cardíaca mais frequente em pacientes idosos admitidos em serviços de emergência?

- a) Taquicardia sinusal
- b) Bloqueio atrioventricular de primeiro grau
- c) Fibrilação atrial
- d) Bradicardia sinusal

174- Num paciente idoso, com quadro infeccioso de qualquer natureza, temos que ficar atentos para não ter atraso no diagnóstico. Sendo assim, o que é verdadeiro afirmar:

- a) A febre e os sintomas de septicemia estão presentes na maioria dos casos
- b) A ausência de febre em certos casos, devido a imuno senescência
- c) A ausência de febre, devido a diminuição da água corporal
- d) Sintomas atípicos, como confusão mental
- e) As questões B e D estão corretas

175- Paciente idoso com fibrilação atrial, facilmente pode evoluir para quadro de edema agudo de pulmão, em comparação ao jovem, devido à:

- a) deposição de gordura e colágeno no nó sinusal
- b) devido ao aumento da espessura do VE
- c) devido à maior participação da contração atrial com a idade e diminuição da complacência do VE
- d) Diminuição da função sistólica no repouso
- e) calcificação das valvas mitral e aórtica

176- Paciente masculino de 80 anos de idade, portador de demência vascular, crises epiléticas secundárias ao acidente vascular cerebral, hipertensão arterial e diabetes mellitus, residente de Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Foi encaminhado à unidade de urgência com quadro de redução do nível de consciência, hipotensão, taquicardia e piora das escórias renais. Exame de sangue mostra leucocitose com desvio para a esquerda e aumento do lactato. Vinha evoluindo há 4 dias com períodos de desorientação e agitação, queixa de disúria e urina fétida. Cuidador nega febre. Possui história prévia de crise convulsiva com uso de quinolonas. O EAS (Elementos e sedimentos anormais ou Exame de Urina Tipo I) solicitado mostra nitrito positivo, leucócitos aumentados e presença de numerosas bactérias. Entre os antibióticos apresentados abaixo, aquele mais indicado para esse paciente, incluindo a forma de administração, é:

- a) ciprofloxacino intravenoso até resultado do antibiograma
- b) levofloxacino via oral 1 x dia por 7 dias
- c) sulfametoxazol/trimetoprima intravenoso até resultado do antibiograma
- d) ceftazidima intravenosa até resultado do antibiograma
- e) amoxicilina + ácido clavulânico via oral por 7 dias

177- Idosa de 72 anos vem ao consultório médico referindo inapetência há 40 dias. Diz que perdeu 5kg no período.

Relato associado náuseas e diarreia intermitente. Tem tremor em mão direita há 6 meses, que vem aumentando, associado a bradicinesia. Nega sintomas depressivos ou qualquer outro sintoma associado. Paciente tem diabetes mellitus com excelente controle, hipertensão arterial e labirintopatia. Usa como medicamentos: metformina, enalapril, metoclopramida, cinarizina, AAS infantil.

- Exame físico: tremor parkinsoniano em mão direita, roda dentada positiva, fâcies de máscara
- Exames laboratoriais normais
- Descarta causa orgânica, e diante da anamnese referida, quais medicamentos poderiam levar a esses sintomas iatrogênicos?

- a) Metformina, enalapril e metoclopramida
- b) Metformina e cinarizina
- c) Enalapril, AAS e metformina
- d) Cinarizina, metoclopramida e Metformina**
- e) AAS, enalapril

178- Paciente 70 anos, sexo feminino, com queixas de melancolia, irritabilidade, mal-estar, tonturas, desânimo e diminuição do vocabulário há 90 dias. Foi num médico generalista há 60 dias que passou dose máxima de citalopram, com razoável melhora. Mantém ainda quadro de desânimo e tristeza em certos dias, querendo ficar somente em casa e não sair. Paciente tem como comorbidades HAS, Obesidade, DM II e Neuropatia Diabética. Diante de tudo isso, qual seria a melhor conduta para a paciente:

- a) Associar outro ISRS.**
- b) Trocar o citalopram pelo escitalopram.
- c) Associar mirtazapina.
- d) Trocar o citalopram pela duloxetina.
- e) Trocar o citalopram pela bupropiona.

179- Paciente feminina, 78 anos, portadora de HAS, DMII e osteoporose, sofreu duas quedas da própria altura no último ano, sendo a última há 1 mês, em casa, após tropeçar no tapete levando a trauma em região frontal. Na avaliação

geriátrica ampla apresenta Teste get up and go de 30 seg, escala yesavage 9, MEEM=25. Nesse caso, o fator que é o maior PREDITOR de futuras quedas para essa idosa é:

- a) Osteoporose
- b) Minimental
- c) A hipertensão
- d) A idade
- e) O teste get up and go**

OBSTIPAÇÃO INTESTINAL

Questões:

- 68)## (P1: T20) 09) Sra. Balbina, 75 anos, autônoma e independente, comparece a consulta ambulatorial de rotina sem queixas espontâneas, ao exame observa perda ponderal de 5 quilos no último ano, que segundo a paciente foi involuntária, quando questionado sobre o hábito intestinal é relato que tem ficado até 4 dias sem evacuar e que o uso dos laxativos orais não modifica muito com quadro. Descreve certo tenesmo, revisando o prontuário percebe-se que há um ano a senhora Balbina possuía o ritmo intestinal diário sem esforço preocupatório. Então qual é a alternativa correta?
- a) Trata-se possivelmente de quadro benigno, já que não há impacto significativo na funcionalidade do paciente, recomenda-se apenas acompanhamento.
 - b) São indicados ajustes na dieta e uso regular e combinados laxativos orais com diferentes mecanismos de ação.
 - c) Deve-se realizar toque retal e solicitar pesquisa anual de sangue oculto nas fezes mais nada
 - d) Prescrever fleets enema semanal para melhorar o funcionamento do intestino
 - e) ???? ele pulou essa alternativa que seria a correta
- 69)## (P1: T18) 04) Assinale a alternativa que apresenta apenas exames laboratoriais indicados para investigação da constipação crônica no idoso;
- a) Hemograma, glicemia, creatinina, cálcio séricos.
 - b) Ácido úrico, ácido fólico, hemograma e tsh.
 - c) Vitamina D, PTH, cloretos, fósforo e glicemia.
 - d) Osmolaridade, cálcio, ureia, lítio e tgo.
 - e) Ferro sérico, hemograma, pesquisa de sangue oculto nas fezes, fosfatase alcalina.
- 70)## (P1: T18) 16) M.A.N, 73 anos refere diarreia, astenia, náuseas e vômitos há 8 horas. Nega enterorragia e fezes com muco ou pus. No exame físico mostra-se desidratada +2/4, hipotensa 90/60 e confusa. Tirando o quadro patológico, a fácil desidratação dessa paciente pode ser explicada, devido a:
- a) Aumento da massa gorda e diminuição da massa magra.
 - b) Diminuição de glândulas sudoríparas e setáceas.
 - c) Diminuição do fluxo sanguíneo renal.
 - d) Menor produção de renina.
 - e) Diminuição de água corpórea, devido a menor massa celular.
- 71)## (P1: T18) 17) Idosa, 75 anos, (independente) compare a consulta ambulatorial de rotina, com queixas de emagrecimento de 5kg nos últimos 3 meses, sem alteração do apetite. Questionado sobre o hábito intestinal relata constipação intestinal nos últimos meses, ficando até 5 dias sem evacuar, aonde tem desconforto abdominal. Usa sene sem melhora até agora. Nega outros sintomas. Exame físico: normal. Qual seria conduta mais adequada a esta paciente:
- a) É uma queixa benigna, pois altera a sua funcionalidade e a paciente não relata queixa espontânea. Somente mudança na dieta e exercícios já são suficientes.
 - b) Trocar o laxante sene por um formador de bolo fecal como psyllium.
 - c) Pedir colonoscopia para averiguar melhor o quadro.
 - d) Solicitar pesquisa de sangue oculto nas fezes anual.
 - e) Associar ao sene, um laxante osmótico como a lactulose.

Questões comentadas:

72)## (P1: T20) 09) Sra. Balbina, 75 anos, autônoma e independente, comparece a consulta ambulatorial de rotina sem queixas espontâneas, ao exame observa **perda ponderal de 5 kg** no último ano, que segundo a paciente foi **involuntária**. Quando questionado sobre o hábito intestinal é relato que tem ficado **até 4 dias sem evacuar** e que o **uso dos laxativos orais não modifica muito com quadro**. Descreve certo **tenesmo**, revisando o prontuário percebe-se que há um ano a senhora Balbina possuía o **ritmo intestinal diário sem esforço preocupatório**. Então qual é a alternativa correta?

[O que aconteceu é uma pessoa que tinha um hábito intestinal normal e que mudou a pouco tempo o seu hábito intestinal, e associado a isso um sinal de alarme que é emagrecimento]

- a) Trata-se possivelmente de quadro benigno, já que não há impacto significativo na funcionalidade do paciente, recomenda-se ~~apenas acompanhamento~~.
 - ↪ Não, porque todo paciente que tem uma **mudança do hábito intestinal** e que **tem emagrecimento** a gente **tem que investigar**
- b) São indicados ajustes na dieta e uso regular e combinados laxativos orais com diferentes mecanismos de ação.
 - ↪ Não. Seria se fosse uma obstipação de caráter funcional, que faz muitos anos que tem essa obstipação, aí sim poderia fazer essa resposta. Mas é um paciente que teve uma mudança recente no hábito intestinal
- c) Deve-se realizar toque retal e solicitar pesquisa anual de sangue oculto nas fezes mais nada
 - ↪ Não, porque, aqui você vai ter que fazer um exame um pouco mais invasivo, que seria a colonoscopia, porque é um paciente que não é tão idoso assim, 75 anos, é um paciente que funcionalmente o paciente está bem, e tem sinais de alerta que é o emagrecimento
- d) Prescrever fleets enema semanal para melhorar o funcionamento do intestino
 - ↪ Não, isso só vai tratar os sintomas, vai tratar a causa do problema
- e) ???? ele pulou essa alternativa que seria a correta

73)## (P1: T18) 17) Idosa, 75 anos, (independente) comparece a consulta ambulatorial de rotina, com queixas de **emagrecimento de 5kg nos últimos 3 meses**, sem alteração do apetite. Questionado sobre o hábito intestinal **relata constipação intestinal nos últimos meses**, ficando até **5 dias sem evacuar**, aonde tem desconforto abdominal. Usa sene sem melhora até agora. Nega outros sintomas. Exame físico: normal. Qual seria conduta mais adequada a esta paciente:

- a) É uma queixa benigna, pois altera a sua funcionalidade e a paciente não relata queixa espontânea. Somente mudança na dieta e exercícios já são suficientes.
- b) Trocar o laxante sene por um formador de bolo fecal como psyllium.
- c) Pedir colonoscopia para averiguar melhor o quadro.**
 - ↪ Vai ter que fazer um exame um pouco mais invasivo, que seria a colonoscopia, porque é um paciente que não é tão idoso assim, 75 anos, é um paciente que funcionalmente o paciente está bem, e tem sinais de alerta que é o emagrecimento
- d) Solicitar pesquisa de sangue oculto nas fezes anual.
- e) Associar ao sene, um laxante osmótico como a lactulose.

74)## (P1: T18) 04) Assinale a alternativa que apresenta apenas exames **laboratoriais indicados para investigação da constipação crônica** no idoso;

- a) Hemograma, glicemia, creatinina, cálcio séricos.**
- b) Ácido úrico, ~~ácido fólico~~, hemograma e tsh.
- c) ~~Vitamina D~~, PTH, cloretos, ~~fósforo~~ e glicemia.

- d) ~~Osmolaridade~~, cálcio, ureia, ~~lítio e tgo.~~
e) ~~Ferro sérico~~, hemograma, pesquisa de sangue oculto nas fezes, ~~fosfatase alcalina~~.

↪ **Laboratoriais:**

- Hemograma
- Glicemia jejum
- TSH
- Ureia
- Creatinina
- Sódio
- Potássio
- Cálcio
- Magnésio
- Pesquisa de sangue oculto nas fezes (lembrar que sangue oculto nas fezes pode dar falso positivo se não fizer dieta corretamente ou se tiver hemorroida, fissura → sangra e dá falso positivo)

OSTEOPOROSE

76) ## (P2: T20) Paciente do sexo feminino, traz ao consultório exame de Densitometria Óssea mostrando os seguintes resultados: colo do fêmur -3,1/fêmur total -2,8. Coluna vertebral L1-L4 -1,2. Exames de sangue normais. Tem histórico de obstipação intestinal crônica. Qual seria o diagnóstico e tratamento:

- a) Osteopenia; usar Raloxifeno e Carbonato de Cálcio 500mg + Vitamina D 400UI 2X ao dia.
- b) Osteoporose; usar Alendronato sódico semanal e Carbonato de cálcio 500mg 2x ao dia.
- c) Osteoporose; usar Bifosfonato, cálcio citrato malato associado a vitamina D.
- d) Osteopenia; usar Bifosfonato, cálcio citrato malato e Denosumabe.
- e) Osteopenia; usar cálcio citrato malato e vitamina D.

77) ## (P2: T20) Analise as afirmativas sobre a Osteoporose.

- I. São fatores de risco para osteoporose a artrite reumatoide, uso crônico de corticoides e o tabagismo.
- II. Homens não entram na investigação para osteoporose, pois a incidência é bem menor do que nas mulheres
- III. Os bisfosfonatos tem como efeitos colaterais sintomas dispépticos, úlcera esofágica e osteonecrose de mandíbula.
- IV. O cálcio de melhor absorção no idoso e com poucos efeitos colaterais é o carbonato de cálcio.

Quais estão corretas?

- a) I e III
- b) I, II e III
- c) III e IV
- d) I, II e IV
- e) I e II

78) ## (P2: T17) Paciente do sexo feminino, traz ao consultório exame de densitometria óssea mostrando os seguintes resultados: colo do fêmur -3,1/ fêmur total -2,8. Coluna vertebral L1-L4 -1,2. Exames de sangue normais. Tem histórico de obstipação intestinal crônica. Qual seria o diagnóstico e tratamento:

- a) Osteopenia, usar Raloxifeno e Carbonato de Cálcio 500 mg + Vitamina D 400 UI 2X ao dia.
- b) Osteoporose, usar alendronato sódico semanal e Carbonato de cálcio 500 mg 2x ao dia.
- c) Osteoporose, usar risedronato sódico, cálcio citrato malato associado a vitamina D.**
- d) Osteopenia, usar Risedronato sódico, cálcio citrato malato e denosumabe.
- e) Osteopenia, usar denosumab e vitamina D.

DIABETES MELLITUS

Questões:

- 79) ## (P2: T20) Diabético vêm ao consultório para controle da sua glicemia, já está em uso de Metformina e ... em doses máximas. Os exames atuais mostram: Hb glicada 8,0; Glicemia jejum 179, Glicemia pós prandial 198. Qual hipoglicemiante abaixo seria a melhor opção para ser associado a esse paciente?
- a) Sulfonilureia
 - b) Inibidores da SGLT-2
 - c) Acarbose
 - d) Insulina glargina.
 - e) Metiglinidas
- 80) ## (P2: T20) No Diabetes Mellitus do paciente idoso é incorreto afirmar:
- a) A meta de Hemoglobina Glicada em pacientes frágeis e com doenças degenerativas é de 8,0 a 8,5.
 - b) A metformina tem como inconveniente em idosos a maior incidência de eventos adversos gastrointestinais.
 - c) Em idosos robustos a HB GLI pode ficar em torno de 7,0 a 7,5
 - d) A Glibenclamida é uma medicação segura para pacientes idosos com diabetes descompensado.
 - e) A Empaglifozina leva a glicosúria e diminuição do peso.
- 81) ## (P2: T17) Paciente idoso, 71 anos, independente para suas atividades de vida diária; coroniopata, hipertenso e diabético vem ao consultório para controle da sua glicemia. Já está em uso de Metformina 850 mg 3x dia e Sitagliptina 100 mg por dia. Os exames atuais mostram: Hb glicada 8,0; Glicemia jejum 179; Glicemia pós prandial 230. Qual hipoglicemiante abaixo seria a melhor opção para ser associado a esse paciente?
- a) Sulfonilureia
 - b) Insulina NPH
 - c) Acarbose
 - d) Inibidores da SGLT-2
 - e) Metiglinidas
- 82) ## (P2: T17) No Diabetes Mellitus do paciente idoso é incorreto afirmar:
- a) A meta de Hemoglobina Glicada em pacientes frágeis é de 8,0 a 8,5.
 - b) A metformina tem como inconveniente em idosos a maior incidência de eventos adversos gastrointestinais. O uso de formulações de ação lenta de droga, diminui esses efeitos colaterais.
 - c) Os idosos tem os mesmos sintomas que os pacientes jovens, como poliúria, polifagia e emagrecimento.
 - d) Em idosos robustos a HB GLI pode ficar em torno de 7,0 a 7,5.
 - e) A empaglifazona leva a glicosúria e diminuição do peso.

RESUMO MEDICAMENTOS

↪ Sulfoniluréias

↪ Medicamentos:

- 1ª Geração: Clorpropamida
- 2ª Geração: Glibenclamida, **Glipizida**, Gliclazida.
- 3ª Geração: **Glimepirida**.

↪ Ação:

- Estimula a **liberação de insulina** pelo pâncreas

↪ Colateral:

- Aumento de peso (principal)
- **Glibenclamida** (2ª G) e **Clorpropamida** (1ª G)
 - **Não são boas opções para idosos**
 - Causam:
 - ↳ **Intenso esforço pancreático**
 - Aumenta demais a secreção de insulina pelo pâncreas. Ou seja, leva a uma falência pancreática muito mais rápido.
 - ↳ **Hipoglicemia severa prolongada**
 - A superdose aguda, bem como o tratamento com elevadas doses de **glibenclamida** a longo prazo podem levar a **hipoglicemia severa prolongada**, com risco de vida

↪ Metiglinidas

↪ Medicamentos:

- **Nateglinida** e **Repaglinida**.

↪ Ação:

- Diminuem a **hiperglicemia pós-prandial**
 - Indicados para hiperglicemia pós-prandial
 - Usadas antes das refeições.
- Estimula a secreção de insulina
- **MENOR risco de hipoglicemia no idoso**

↪ Colateral:

- Aumento de peso
- Dor muscular
- Distúrbios gastrointestinais
- Cefaleia

↪ Biguanidas

↪ Medicamentos:

- **Metformina**

↪ Ação:

- Reduz a **produção hepática de glicose** e a **resistência periférica à insulina**.
- Boa indicação para **diabéticos obesos**.
- **ÚNICO com redução significativa de complicações macrovasculares**, diminuindo a mortalidade.

↪ Contra-indicações:

- IR
- Insuficiência Hepática
- Insuficiência Cardíaca.
 - IC grave tem aumento de ácido láctico que é aumentado pela metformina.

↪ Colateral:

- Diminuição do peso
- **Distúrbios do TGI** (diarreia, náusea e vômito)
 - **O uso de formulações de ação lenta de droga, diminui esses efeitos colaterais**
- Inapetência.

↪ Acarbose

↪ Ação:

- Inibição competitiva e temporária da atividade enzimática de α -glicosidase
 - ↳ Diminuindo a **absorção da glicose**
- Utilizada para diminuir a **glicemia pós-prandial**

↪ Colateral:

- Flatulência
- Intolerância gástrica
- Diarreia
- Dor abdominal.
- **É pouco utilizada no idoso**

↳ Inibidores da SGLT-2

↳ Medicamentos:

- **Empagliflozina**
- **Dapagliflozina**
- **Canagliflozina**

↳ Ação:

- Inibidores do cotransportador de sódio-glicose-2
 - A ausência do SGLT2, bloqueia a reabsorção da glicose filtrada no túbulo proximal. Assim, o excesso de glicose é expelido na urina (**glicosúria**), reduzindo a glicemia e hemoglobina glicada
- Redução da **glicemia** e **HB glicada**
- Boa indicação em **pacientes intolerantes a metformina**
- **Diminuição do risco cardiovascular**

↳ Colateral:

- Deve-se **evitar** em pacientes com **fragilidade e infecções urogenitais**.
- **Perda de peso**
- Efeito hipotensor

↳ Insulina

- Utilizada em situações de:
 - Não controle clínico
 - Estresse
 - Infecções importantes
 - Traumas
 - Cetoacidose
 - Coma hiperosmolar
 - Controle pós-IAM
- **Uso do hipoglicemiante oral deve ser mantido**

↳ Medicamentos:

- **Longa duração (Insulina Ultralenta)**
 - ↳ 1 a 2 doses
 - **Glargina**
 - **Detemir**
- **Ação intermediária (Insulina Lenta)**
 - ↳ 3 doses
 - **NPH**
- **Ação Rápida**
 - **Regular**
- **Ação Ultrarrápida**
 - **Asparte**
 - **Lispro**
 - **Glulisina**
- Usar esquemas simples inicialmente
 - Inicialmente noturno, com doses baixas e de aumento gradativo
- Para **associação** há a preferência para os **análogos a insulina**, como a **Glargina** e o **Detemir**

↳ Indicações:

- **Glicemia > 300 mg/dL**
- **Hb glicada > 9%**
- **Não controle com duas ou mais drogas orais**
- Rápida perda de peso
- Infecções que necessitem de hospitalização
- Internados para procedimento cirúrgico

Questões comentadas:

83)## (P2: T20) Diabético vêm ao consultório para controle da sua glicemia, já está em uso de **Metformina** e ... em doses máximas. Os exames atuais mostram: **Hb glicada 8,0: Glicemia jejum 179, Glicemia pós prandial 198**. Qual hipoglicemiante abaixo seria a **melhor opção** para ser **associado** a esse paciente?

↳ Diagnóstico de DM:

- Glicemia de jejum: ≥ 126 em duas aferições.
- HbA1c (Hemoglobina glicada) $\geq 6,5\%$
- TOTG: ≥ 200 após 2h.
- Casual: ≥ 200 e COM Sintomas de diabetes

↳ Pré-DM:

- Glicemia de jejum entre 100 e 125mg/dL
- Glicemia entre 140 e 199mg/dL após 2h em TOTG
- HbA1c entre 5,7-6,4%

a) Sulfonilureia

↳ **Glibenclamida** (2ª G) e **Clorpropamida** (1ª G)

- **Não são boas opções para idosos**, pois causam:
 - **Intenso esforço pancreático**
 - **Hipoglicemia severa prolongada**

b) Inibidores da SGLT-2

- ↳ Melhor opção para ser associado, pois o paciente já em uso de **Metformina** e **Hb glicada 8,0**
 - Inibidores da SGLT-2
 - **↓ glicemia e HB glicada**
 - Boa indicação em **pacientes intolerantes a metformina**

c) Acarbose

- ↳ Utilizada para diminuir a **glicemia pós-prandial**.
 - **É pouco utilizada no idoso**

d) Insulina Glargina.

- ↳ Não tem indicação
 - Indicações (para o caso)
 - Glicemia > 300 mg/dL
 - Hb glicada $> 9\%$
 - Não controle com duas ou mais drogas orais

e) Metiglinidas

- ↳ Indicado para casos de **hiperglicemia pós-prandial**
 - Pacientes com valores acima de 200mg/dL são sugestivos de diabetes
 - Problema do paciente não é a glicemia pós prandial (198)

85)## (P2: T17) Paciente idoso, 71 anos, independente para suas atividades de vida diária; coroniopata, hipertenso e diabético vêm ao consultório para controle da sua glicemia. Já está em uso de **Metformina 850 mg 3x dia** e **Sitagliptina 100 mg por dia**. Os exames atuais mostram: **Hb glicada 8,0**; **Glicemia jejum 179**; **Glicemia pós prandial 230**. Qual hipoglicemiante abaixo seria a **melhor opção** para ser **associado** a esse paciente?

- a) Sulfonilureia
- b) Insulina NPH
- c) Acarbose

d) Inibidores da SGLT-2

↳ Medicamentos:

- **Empagliflozina**
- **Dapagliflozina**
- Canagliflozina
- ↓ **glicemia** e **HB glicada**
- Boa indicação em **pacientes intolerantes a metformina**

- e) Metiglinidas

86)## (P2: T20) No Diabetes Mellitus do paciente idoso é INCORRETO afirmar:

- a) A **meta de Hemoglobina Glicada** em pacientes frágeis e com doenças degenerativas é de **8,0 a 8,5**.

↳ **Meta de HB GLI de 8,0 a 8,5%**

- Essa é a meta de tratamento para idosos com:
 - Fragilidade
 - Expectativa de vida limitada
 - História de hipoglicemia grave
 - Presença de comorbidades (como: Demência, Doença cerebrovascular)

- b) A metformina tem como inconveniente em idosos a maior incidência de eventos adversos gastrointestinais.

↳ **Biguanidas**

- Medicamentos:
 - **Metformina**
- Ação:
 - Reduz a **produção hepática de glicose** e a **resistência periférica à insulina**.
 - Boa indicação para **diabéticos obesos**.
 - **ÚNICO** com **redução significativa de complicações macrovasculares**
- Colateral:
 - Diminuição do peso
 - **Distúrbios do TGI (diarreia, náusea e vômito)**
 - ↳ **O uso de formulações de ação lenta de droga, diminui esses efeitos colaterais**
 - Inapetência.

- c) Em **idosos robustos** a **HB GLI** pode ficar em torno de **7,0 a 7,5**

↳ **Diagnóstico de DM:**

- Glicemia de jejum: ≥ 126 em duas aferições.
- HbA1c (Hemoglobina glicada) $\geq 6,5\%$
 - Tratamento individualizado
 - ↳ Bom senso: 90 anos não tem porque deixar glicada abaixo de 7
- TOTG: ≥ 200 após 2h.

- Casual: ≥ 200 e COM Sintomas de diabetes

d) A Glibenclamida é uma medicação segura para pacientes idosos com diabetes descompensado.

↳ **Sulfoniluréis: Glibenclamida** (2ª G) e **Clorpropamida** (1ª G)

- **Não são boas opções para idosos**, pois causam:
- **Intenso esforço pancreático**
 - Aumenta demais a secreção de insulina pelo pâncreas. Ou seja, leva a uma falência pancreática muito mais rápido.
- **Hipoglicemia severa prolongada**
 - A superdose aguda, bem como o tratamento com elevadas doses de **glibenclamida** a longo prazo podem levar a **hipoglicemia severa prolongada**, com risco de vida

e) A Empaglifozina leva a glicosúria e diminuição do peso.

↳ **Inibidores da SGLT-2**

- Medicamentos:
 - **Empagliflozina**
 - **Dapagliflozina**
 - **Canagliflozina**
- Ação:
 - Inibidores do cotransportador de sódio-glicose-2
 - ↳ A ausência do SGLT2, bloqueia a reabsorção da glicose filtrada no túbulo proximal. Assim, o **excesso de glicose é expelido na urina (glicosúria)**, reduzindo a glicemia e hemoglobina glicada
 - Redução da **glicemia** e **HB glicada**
 - Boa indicação em **pacientes intolerantes a metformina**
 - **Diminuição do risco cardiovascular**
- Colateral:
 - Deve-se **evitar** em pacientes com **fragilidade** e **infecções urogenitais**.
 - **Perda de peso**
 - Efeito hipotensor

87) ## (P2: T17) No Diabetes Mellitus do paciente idoso é INCORRETO afirmar:

- a) A meta de **Hemoglobina Glicada** em **pacientes frágeis** é de **8,0 a 8,5**.
- b) A **metformina** tem como inconveniente em idosos a **maior incidência de eventos adversos gastrointestinais**. **O uso de formulações de ação lenta de droga, diminui esses efeitos colaterais**.

c) Os idosos tem os mesmos sintomas que os pacientes jovens, como poliúria, polifagia e emagrecimento.

↳ **Características peculiares dos idosos Diabéticos:**

- **Idosos tem MENOS polidipsia, poliúria pode estar ausente.**
- Mialgias (amiotrofia diabética), fadiga, adinamia, confusão mental e incontinência urinária.
- Visão borrada
- Infecções fúngicas e bacterianas.
- Maior facilidade a desidratação.
- Glicosúria somente é detectada acima de 220mg\dl.
- Aumento do risco de queda

d) Em **idosos robustos** a **HB GLI** pode ficar em torno de **7,0 a 7,5**.

e) A **Empaglifazina** leva a **glicosúria** e **diminuição do peso**.

PNEUMONIA

Questões:

- 88)## (P2: T20) Paciente de 80 anos, vem ao PS com queixas de tosse produtiva sem expectoração, associado: do estado geral e apatia há 6 dias. No exame físico apresenta estertores em base esquerda, c aumentado a esquerda. Tem como comorbidades HAS e DM II com bom controle. Nega febre ... sintomas. Diante da patologia acima, é correto afirmar:
- a) O exame principal a ser pedido nesse paciente é a cultura do escarro.
 - b) Como o paciente não tem febre, pode descartar quadro pneumônico.
 - c) Caso clínico compatível com Pneumonia, o antibiótico de escolha é a azitromicina.
 - d) Paciente com Pneumonia, onde será pedido hemocultura e cultura do escarro.
 - e) O tratamento empírico pode ser basear no uso de quinolona respiratória.
- 89)## (P2: T20) P.S., 91 anos, acamado, sequelado de AVC, teve broncoaspiração no domicílio, aonde após 24 horas teve quadro de tosse com catarro amarelo esverdeado, queda do estado geral, com sonolência e confusão mental. Paciente chega ao PS com PA 100.60, roncos e estertores difusos a ausculta e Sat O2 91%. Diante do quadro pneumônico, qual antibioticoterapia seria instituída?
- a) Levofloxacino
 - b) Ceftriaxona + levofloxacino
 - c) Ceftriaxona + metronidazol
 - d) Cefalotina + azitromicina
 - e) Amoxicilina + clavulanato
- 90)## (P2: T17) Paciente de 80 anos vem ao OS com queixas de tosse seca e dispneia ao repouso e aos mínimos esforços há 3 dias, associado a queda do estado geral e apatia. Tem tido edema de MMII há 7 dias, principalmente final da tarde. No exame físico apresenta estertoração em bases, mais pronunciado a esquerda, com FTV aumentado a esquerda. Edema de MMII bilateralmente ++/4 com cacifu positivo e presença de varizes. Tem como comorbidades HAS e DM II com bom controle. Nega febre ou outros sintomas. Diante da patologia acima, é correto afirmar:
- a) Trata-se de uma ICC descompensada, aonde a presença do edema de MMII e a dispneia ajuda fechar o diagnóstico.
 - b) A realização de exames laboratoriais como o hemograma, PCR e BNP sérico podem ser de muita ajuda para concluir o diagnóstico.
 - c) Caso for um quadro de Pneumonia, o antibiótico de escolha é a cefalosporina de 1ª geração.
 - d) A solicitação unicamente de um Ecocardiograma transesofágico seria a melhor opção para ajudar no diagnóstico.
 - e) Como o paciente está dispneico e com edema, um tiazídico, poderia de imediato tratar este tipo de paciente, mesmo antes dos exames solicitados.
- 91)## (P2: T17) Apesar das elevadas taxas de mortalidade resultantes de pneumonia na velhice, a idade, por si só, não contraindica a instituição de medidas agressivas para o tratamento, pois as pneumonias são doenças potencialmente curáveis, mesmo nos indivíduos frágeis e com múltiplas doenças crônicas. Entretanto, a fragilidade, a multimorbidade e o prejuízo funcional são fatores preditivos de pior prognóstico. Assinale a alternativa correta que descreva duas condições relacionadas à pneumonia de repetição em pacientes idosos:

- a) Disfagia com microaspirações e imobilidade.
- b) Uso prévio de antibióticos e obesidade.
- c) Hospitalização recente e hipertensão arterial.
- d) Refluxo gastroesofágico e uso de sondas para alimentação.
- e) Incapacidade funcional e vacinação anual contra vírus influenza

92)## (P2: T17) P.S., 76 anos, chega ao PS com delirium, tosse com catarro amarelo, dispnéia ao repouso e que piora aos esforços, sem febre. Tem como patologias HAS, DPOC e DM II. Diante do Rx de tórax, se vê uma condensação em base de pulmão direito. Com isso qual seria o melhor tratamento para este paciente e qual bactéria seria a mais provável?

- a) Levofloxacino e *Streptococcus pneumoniae*.
- b) Cefalexina e *Moraxella catarrhalis*.
- c) Levofloxacino e *Legionella*.
- d) Azitromicina e Anaeróbios.
- e) Clindamicina e *Streptococcus pneumoniae*

Questões comentadas:

93)## (P2: T20) Paciente de 80 anos, vem ao PS com queixas de **tosse produtiva sem expectoração**, associado: do estado geral e **apatia** há 6 dias. No exame físico apresenta **estertores** em base esquerda, c aumentado a esquerda. Tem como comorbidades HAS e DM II com bom controle. Nega febre ... sintomas. Diante da patologia acima, é correto afirmar:

a) O exame principal a ser pedido nesse paciente é a ~~cultura do escarro~~.

↳ Exame principal a ser pedido → **Radiografia simples de tórax**

↳ Exame do escarro

- Casos de resistência ao ATB

- Não é requisitado normalmente, sendo uma exceção para casos de resistência ao tratamento com antibiótico

b) Como o paciente não tem febre, pode ~~descartar~~ quadro pneumônico.

↳ Há uma **MENOR incidência de febre e de tosse com expectoração**

- “Idoso não faz febre”

↳ Quadro clínico:

- Taquipneia
- Taquicardia
- Delirium
- Diminuição das atividades de vida diária
- Inapetência
- Síncope
- Quedas
- Incontinência
- Alteração da consciência
- O principal padrão de dor é abdominal e em ombro quando apical, não costumando haver dor torácica

↳ Exame físico:

- Há menores achados, mas pode haver:
 - **Estertores crepitantes, roncocal sibilos**, com **MV diminuído**.
- Ausculta:
 - **Frêmito tóraco-vocal** estará **aumentado** na presença de **consolidações**

c) Caso clínico compatível com Pneumonia, o antibiótico de escolha é a azitromicina.

↳ Tratamento ambulatorial

- **β-lactâmicos + Macrolídeo**
 - Amoxicilina e ácido clavulânico + macrolídeo (Aзитromicina)
 - ↳ Em casos com comorbidades e uso prévio de ATB.
 - Cefuroxima, Cefprozil ou Ceftriaxona IM + Macrolídeo
- **Quinolonas respiratórias** (Monoterapia)
 - Levofloxacino
 - Moxifloxacino
 - Gemifloxacino

d) Paciente com Pneumonia, onde será pedido hemocultura e cultura do escarro.

↳ **Hemoculturas** → Em casos graves

↳ **Cultura do escarro** → Não é requisitado normalmente, sendo uma exceção para casos de resistência ao tratamento com antibiótico

e) O tratamento empírico pode ser baseado no uso de quinolona respiratória.↳ Tratamento ambulatorial

- **β-lactâmicos + Macrolídeo**
 - Amoxicilina e ácido clavulânico + macrolídeo (Azitromicina)
 - ↳ Em casos com comorbidades e uso prévio de ATB.
 - Cefuroxima, Cefprozil ou Ceftriaxona IM + Macrolídeo
- **Quinolonas respiratórias** (Monoterapia)
 - Levofloxacino
 - Moxifloxacino
 - Gemifloxacino

94) ## (P2: T20) P.S., 91 anos, **acamado**, sequelado de AVC, teve **broncoaspiração no domicílio**, aonde após 24 horas teve quadro de **tosse com catarro amarelo esverdeado, queda do estado geral, com sonolência e confusão mental**. Paciente chega ao PS com PA 100/60, roncospas e **estertores difusos** a ausculta e Sat O₂ 91%. Diante do quadro pneumônico, qual antibioticoterapia seria instituída?

↳ CURB-65 = 3 ou +

- Confusão mental
- PA 100/60
- 91 anos

a) Levofloxacino

b) Ceftriaxona + Levofloxacino

c) Ceftriaxona + Metronidazol

↳ **Metronidazol** devido a **broncoaspiração**

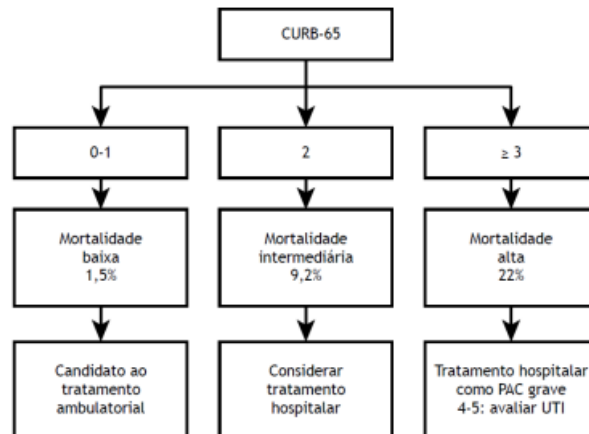
↳ PAC a ser internado SEM necessidade de UTI

- **Tratamento empírico:**
 - Ceftriaxona ou Ampicilina + Sulbactam + Macrolídeo.
 - Cefotaxima + Macrolídeo.
 - Quinolonas respiratórias IV.
- **Suspeita de Pseudomonas:**
 - Piperacilina/Tazobactam
 - Meropenem
 - Polimixina B
- **Suspeita aspiração:**
 - Metronidazol ou Clindamicina associado
 - Piperacilina/Tazobactam.

d) Cefalotina + azitromicina

e) Amoxicilina + clavulanato

C: Confusão mental
U: Uréia >50 mg/dL
R: Fr. Respiratória >30 resp./min
B: Pressão sanguínea (Sist. <90; Dias. <60 mmHg)
65: ≥65 anos



95)## (P2: T17) Apesar das elevadas taxas de mortalidade resultantes de pneumonia na velhice, a **idade, por si só, não contraindica a instituição de medidas agressivas para o tratamento**, pois as pneumonias são doenças potencialmente curáveis, mesmo nos indivíduos frágeis e com múltiplas doenças crônicas. Entretanto, **a fragilidade, a multimorbidade e o prejuízo funcional são fatores preditivos de pior prognóstico**. Assinale a alternativa correta que descreva **duas condições relacionadas à pneumonia de repetição** em pacientes idosos:

a) Disfagia com microaspirações e imobilidade.

- b) Uso prévio de antibióticos e obesidade.
- c) Hospitalização recente e hipertensão arterial.
- d) Refluxo gastroesofágico e uso de sondas para alimentação.
- e) Incapacidade funcional e vacinação anual contra vírus influenza

↳ **Fatores predisponentes:**

- **Extrínsecos:**
 - Influenza
 - Asilos
 - Hospitais
- **Intrínsecos:**

▪ Desnutrição ▪ DM ▪ ICC ▪ Coronariopatia ▪ IR ▪ DPOC ▪ Hepatopatias ▪ Coronariopatias ▪ Anemias	▪ Doenças neurológicas ▪ Depressão ▪ Delirium ▪ Disfagia ▪ Convulsões ▪ Alcoolismo ▪ Imobilização ▪ Sondas nasogástricas ▪ Sondas gástricas.
--	--

↳ **Patogenia:**

- O **principal mecanismo no idoso** é a **colonização da orofaringe e aspiração de microrganismos**
 - **Aspirações são mais comuns** em indivíduos com **disfagias** por demência, AVC e Parkinson, doenças esofágicas, uso de sondas enterais e diminuição da consciência por patologias, sedativos e álcool.
- Mas também pode ocorrer através da:
 - Inalação de aerossóis infectados, disseminação hematogênica, inoculação direta em procedimentos de drenagem pleural sem medidas corretas de higiene ou contiguidade como em abscesso hepático.
- O **local mais comum** de infecção é a **base do pulmão direito**
- **Pré-requisitos da colonização:** Todos são fatores que influenciam a colonização por **GRAM NEGATIVOS e ANAERÓBIOS**

▪ Doenças crônicas ▪ Diminuição da capacidade funcional ▪ Fragilidade ▪ Desnutrição ▪ Uso de antiácidos ▪ ILPs	▪ Hospitalização frequente ▪ Redução da saliva (por tricíclicos, anti-parkinsonianos, diuréticos, neurolépticos, antieméticos e anti-hipertensivos) ▪ Doenças periodontais ▪ Higiene precária e uso de próteses.
---	--

96)## (P2: T17) P.S., 76 anos, chega ao PS com **delirium, tosse com catarro amarelo, dispnéia ao repouso** e que **piora aos esforços, sem febre**. Tem como patologias HAS, DPOC e DM II. Diante do Rx de tórax, se vê uma **condensação em base de pulmão direito**. Com isso qual seria o melhor tratamento para este paciente e qual bactéria seria a mais provável?

a) Levofloxacino e Streptococcus pneumoniae.

↳ Tratamento ambulatorial

- **β-lactâmicos + Macrolídeo**
 - Amoxicilina e ácido clavulânico + macrolídeo (Azitromicina)
 - ↳ Em casos com comorbidades e uso prévio de ATB.
 - Cefuroxima, Cefprozil ou Ceftriaxona IM + Macrolídeo
- **Quinolonas respiratórias** (Monoterapia)
 - **Levofloxacino**
 - Moxifloxacino
 - Gemifloxacino

↳ Etiologia

- Germes mais comuns na pneumonia do idoso. Gram negativos, bactérias atípicas
- PAC (Pneumonia adquirida na comunidade)
 - **S. Pneumoniae** (principal)
 - *M. Pneumoniae*
 - *Legionella*
 - *Hemophilus influenzae*
 - *C.pneumoniae*
 - *Moraxella catarrhalis*

b) Cefalexina e Moraxella catarrhalis.

↳ β-lactâmicos + Macrolídeo

c) Levofloxacino e Legionella.

↳ Streptococcus pneumoniae → Mais provável

d) Azitromicina e Anaerobios.

↳ β-lactâmicos + Macrolídeo

e) Clindamicina e Streptococcus pneumoniae

↳ Clindamicina = Suspeita de aspiração (Anaeróbios)

HIPERTENSÃO ARTERIAL

Questões:

97)## (P2: T20) Paciente 69 anos, sexo feminino, vem ao consultório com queixas de cefaleia occipital, tonturas e mal-estar. Tem como comorbidades diabetes mellitus, incontinência urinária de urgência e asma brônquica. Ao exame físico PA 190/110mmHg, afebril, Pulso 76. Tórax: Hiperfoneses de 2ª bulha em foco aórtico. Abdômen: sem visceromegalias, sem sopros presentes. Membros: pulsos presentes e normais, ausência de edema. Está em uso de Enalapril e hidroclorotiazida em doses máximas. Diante desse quadro clínico, o que podemos tomar como melhor conduta neste caso?

- a) Adicionar metildopa.
- b) A associação de losartana poderia ajudar na baixa da pressão e na proteção renal por causa do diabetes.
- c) Associar um bloqueador de canal de cálcio.
- d) Introduzir um diurético de alça para potencializar ação diurética e anti-hipertensiva.
- e) Passar hidralazina, pois é um quadro de hipertensão estágio 3.

98)## (P2: T20) Analise as afirmativas considerando a avaliação da PA em idosos:

- I. Nos idosos, há especial preocupação com a aferição da PA, pois o envelhecimento está frequentemente associado à disfunção barorreflexa e, conseqüentemente, à maior possibilidade de hipotensão postural e pós-prandial.
- II. Nos pacientes idosos, a medida da PA deve ser sempre realizada também com o paciente de pé, de preferência em todas as consultas ou quando queixas de tonturas, para avaliar a presença de hipotensão ortostática.
- III. Medir sempre em ambos os braços na primeira consulta, se houver uma diferença maior de 20mmHg de sistólica, deve-se buscar causas vasculares para essa alteração.
- IV. Variabilidade diária dos níveis de pressão é menos frequente no idoso.

Estão corretas:

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II e III
- d) I, II e III

99)## (P2: T17) Paciente, 77 anos, sexo feminino, vem ao consultório com queixas de cefaléia occipital, tonturas e mal estar. Tem como comorbidades diabetes mellitus, incontinência urinária de urgência e asma brônquica. Ao exame físico PA 170/100 mmHg, afebril, pulso 76, Tórax: hiperfoneses de 2ª bulha em foco aórtico. Abdome: sem visceromegalias, sem sopros presentes, Membros: pulsos presentes e normais, ausência de edema. Está em uso de Losartana e hidroclorotiazida em doses máximas. Diante desse quadro clínico, o que podemos tomar como melhor conduta neste caso?

- a) Adicionar um betabloqueador ao tratamento.
- b) A associação de um IECA poderia ajudar na baixa da pressão e na proteção renal por causa do diabetes.
- c) Como é uma mulher, poderemos usar como droga de escolha um anti-hipertensivo de ação central, como a metildopa.
- d) Associar um bloqueador de canal de cálcio.
- e) Introduzir um diurético de alça para potencializar ação diurética e anti-hipertensiva.

- 100) ## (P2: T17) Na HAS do idoso, há um aumento da mortalidade e morbidade por doenças cardiovasculares, independente da idade. Assim, é verdadeiro afirmar:
- a) Naqueles idosos frágeis a pressão arterial deve ser como alvo 120/80.
 - b) Nos idosos existem com mais frequência a HAS do jaleco branco e a hipotensão ortostática.
 - c) Os betabloqueadores podem ser usados em pacientes com insuficiência arterial.
 - d) Os anti-hipertensivos de ação central podem ser usados como medicação de primeira escolha em alguns casos.
 - e) O hiperaldosteronismo leva a HAS, hipercalemia e hiponatremia.

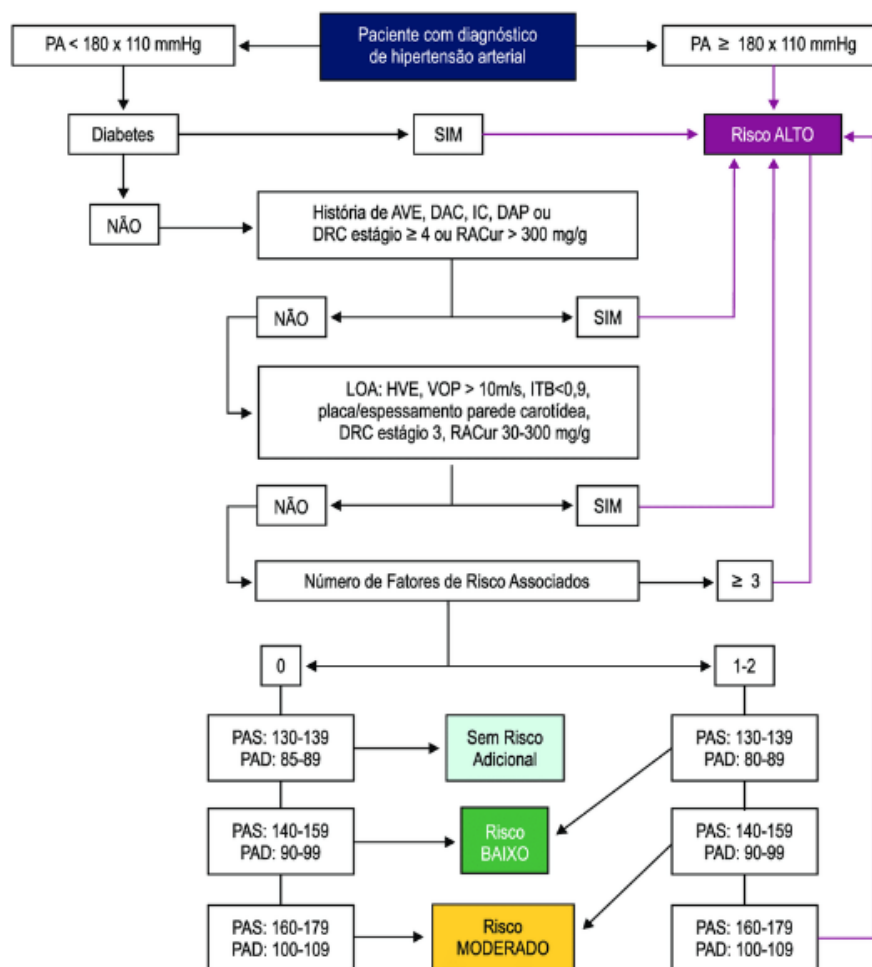
FLUXOGRAMAS E TABELAS

Quadro 3.4 – Classificação da pressão arterial de acordo com a medição no consultório a partir de 18 anos de idade

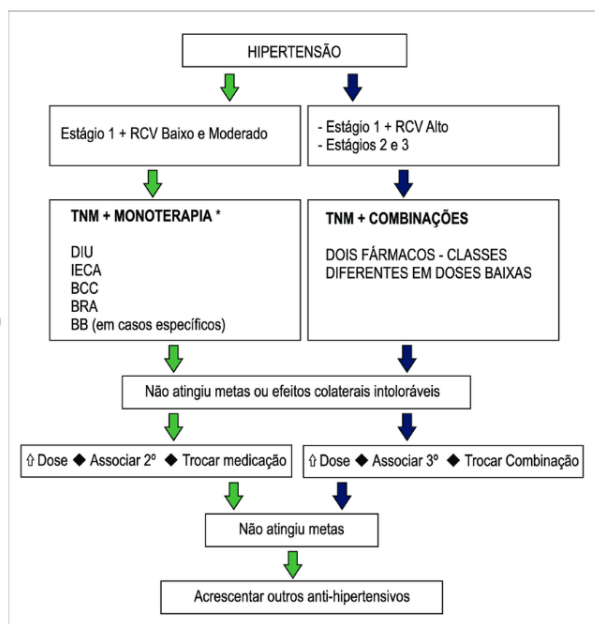
Classificação*	PAS (mmHg)		PAD (mmHg)
PA ótima	< 120	e	< 80
PA normal	120-129	e/ou	80-84
Pré-hipertensão	130-139	e/ou	85-89
HA Estágio 1	140-159	e/ou	90-99
HA Estágio 2	160-179	e/ou	100-109
HA Estágio 3	≥ 180	e/ou	≥ 110

HA: hipertensão arterial; PA: pressão arterial; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica. *A classificação é definida de acordo com a PA no consultório e pelo nível mais elevado de PA, sistólica ou diastólica. **A HA sistólica isolada, caracterizada pela PAS ≥ 140 mmHg e PAD < 90 mmHg, é classificada em 1, 2 ou 3, de acordo com os valores da PAS nos intervalos indicados. ***A HA diastólica isolada, caracterizada pela PAS < 140 mmHg e PAD ≥ 90 mmHg, é classificada em 1, 2 ou 3, de acordo com os valores da PAD nos intervalos indicados.

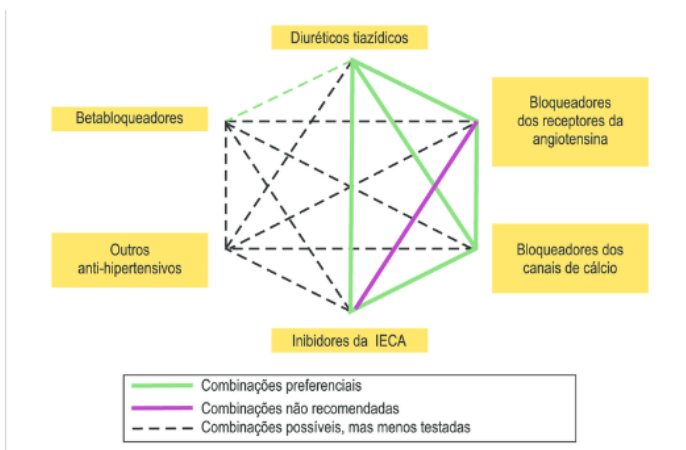
Avaliação do Risco Cardiovascular Adicional no Hipertenso



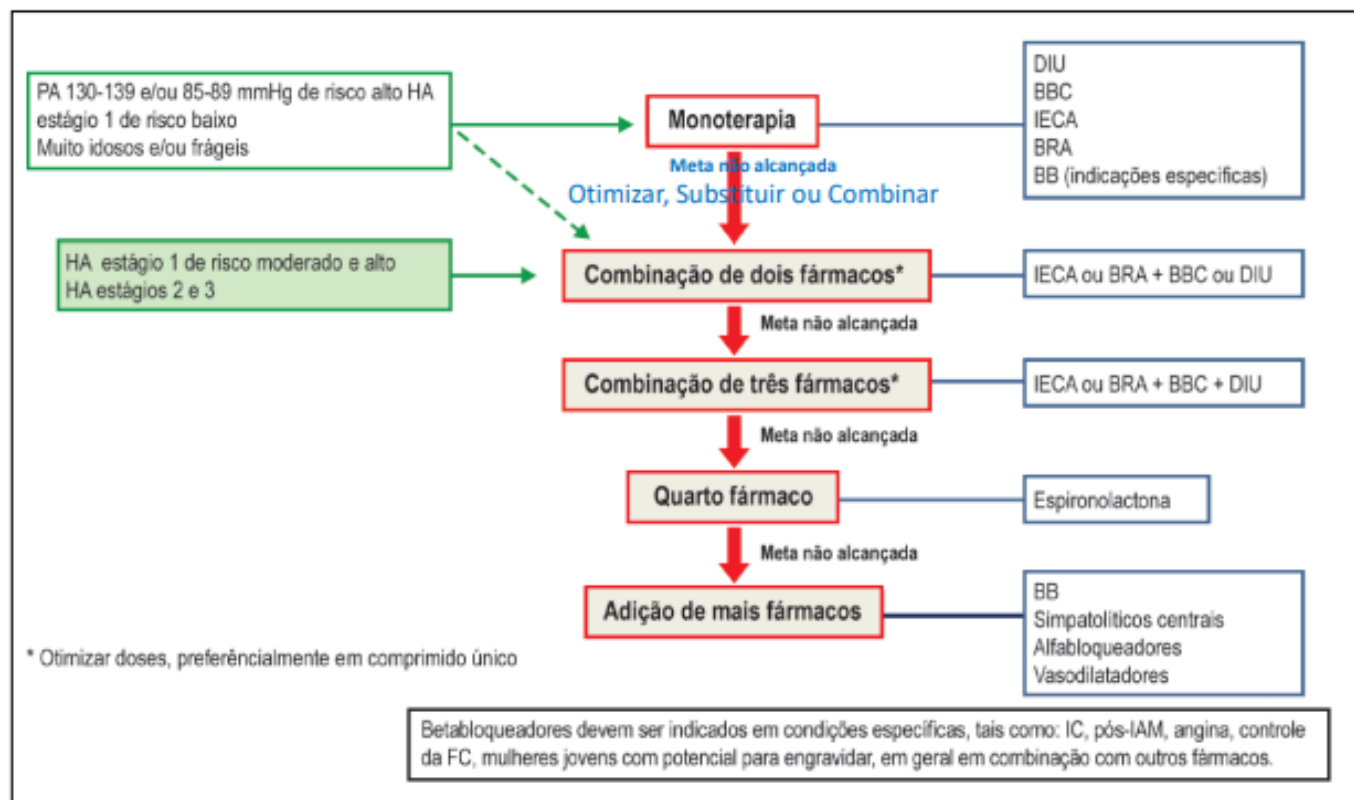
Fluxograma de classificação de risco CV adicional no paciente hipertenso. PA: pressão arterial; AVE: acidente vascular encefálico; DAC: doença arterial coronariana; IC: insuficiência cardíaca; DAP: doença arterial periférica; DRC: doença renal crônica; RACur: relação albumina/creatinina urinária; LOA: lesão de órgão-alvo; HVE: hipertrofia ventricular esquerda; VOP: velocidade da onda de pulso; ITB: índice tornozelo-braquial; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica. Fatores de risco: sexo masculino, idade > 55 anos (homem) ou > 65 anos (mulher), história familiar, tabagismo, dislipidemia, obesidade e resistência à insulina.



Fluxograma para o tratamento da hipertensão. RCV: risco cardiovascular; TNM: tratamento não medicamentoso; DIU: diuréticos; IECA: inibidores da enzima de conversão da angiotensina; BCC: bloqueador dos canais de cálcio; BRA: bloqueador do receptor de angiotensina; BB: betabloqueadores.



— Esquema preferencial de associações de medicamentos, de acordo com mecanismos de ação e sinergia. Adaptado de Journal of Hypertension 2007, 25:1751-1762



Questões comentadas:

101) ## (P2: T20) Paciente 69 anos, sexo feminino, vem ao consultório com queixas de **cefaleia occipital, tonturas e mal-estar**. Tem como comorbidades **diabetes mellitus**, incontinência urinária de urgência e asma brônquica. Ao exame físico **PA 190/110mmHg**, afebril, Pulso 76. Tórax: **Hiperfonese de 2ª bulha em foco aórtico**. Abdômen: sem visceromegalias, sem sopros presentes. Membros: pulsos presentes e normais, ausência de edema. Está em uso de **Enalapril** [IECA] e **hidroclorotiazida** [DIU] em doses máximas. Diante desse quadro clínico, o que podemos tomar como melhor conduta neste caso?

↳ **PA 190/110mmHg** = HA Estágio 3 = Alto risco

↳ **Hiperfonese de 2ª bulha no foco aórtico** = **Crise hipertensiva**

a) Adicionar metildopa.

↳ Agentes de Ação Central

- **Metildopa, Clonidina**

- Discreta diminuição na **resistência vascular periférica** e no **DC**, redução de **renina** e diminuição da **atividade simpática**

b) A associação de losartana poderia ajudar na baixa da pressão e na proteção renal por causa do diabetes.

↳ IECA ou BRA → **NUNCA os dois juntos**

- IECA (Inibidores da ECA)

- **Captopril, Enalapril**, Ramipril, Lisinopril

- Reações adversas: **tosse seca**, alteração do paladar

- Medicamentos que **bloqueiam a ECA**

- ↳ Não ocorre aumento da Angio II

- BRA (Bloqueadores dos Receptores da Angiotensina II)

- **Losartana**, Candesartan, Omersartan, Valsartan, Telmisartan

- ↳ Não aumentam o nível de Bradicininina (não causa tosse)

- Bloqueiam os receptores AT1 da angiotensina II

- ↳ **Dilatação arteriolar e venosa e bloqueio da secreção de aldosterona** (Ação farmacológica similares aos IECAs)

c) Associar um bloqueador de canal de cálcio.

↳ A **combinação de três fármacos** é usada quando a monoterapia ou a utilização de dois fármacos não atinge as expectativas, nesse caso a combinação é **IECA ou BRA + BBC + DIU**.

↳ Beta-Bloqueador

- **Atenolol, Carvedilol, Propranolol**, Bisoprolol, Nebivolol, **Metoprolol**, Labetalol

- Menos seletivo é o metoprolol.

- Diminuição do **débito cardíaco** e das **catecolaminas**

d) Introduzir um diurético de alça para potencializar ação diurética e anti-hipertensiva.

↳ Diuréticos

- **Hidroclorotiazida, Furosemida**, Indapamida, Clortalidona, **Espironolactona**.

- **Depleção de volume**, depois a uma diminuição da **resistência periférica**

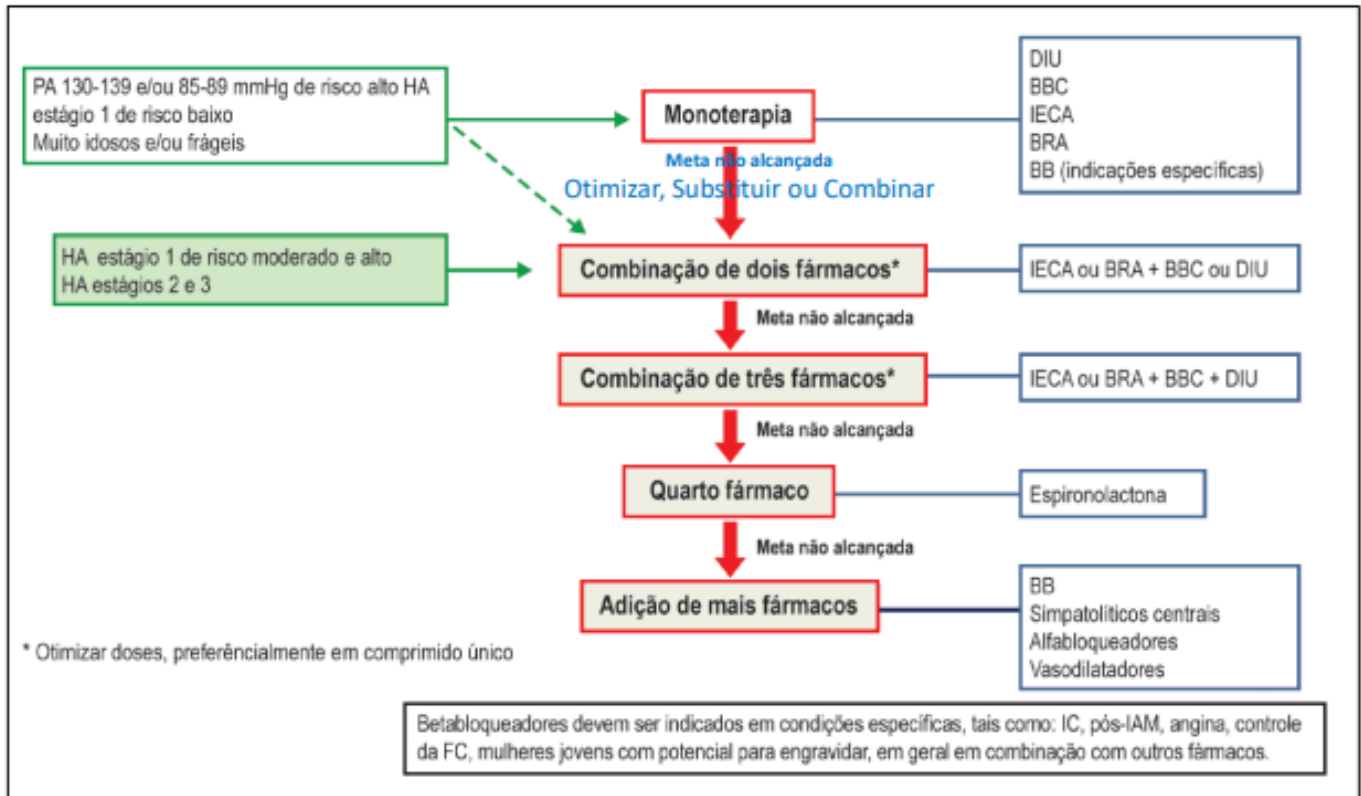
e) Passar hidralazina, pois é um quadro de hipertensão estágio 3.

↳ Vasodilatadores Diretos

- **Hidralazina e Minoxidil**

- Difícil controle ou não tolerou outros medicamentos.

- Redução da **resistência vascular periférica**



102) ## (P2: T17) Paciente, 77 anos, sexo feminino, vem ao consultório com queixas de cefaléia occipital, tonturas e mal estar. Tem como comorbidades diabetes mellitus, incontinência urinária de urgência e asma brônquica. Ao exame físico **PA 170/100 mmHg**, afebril, pulso 76, Tórax: hiperfonese de 2ª bulha em foco aórtico. Abdome: sem visceromegalias, sem sopros presentes, Membros: pulsos presentes e normais, ausência de edema. Está em uso de **Losartana** e **hidroclorotiazida** em doses máximas. Diante desse quadro clínico, o que podemos tomar como melhor conduta neste caso?

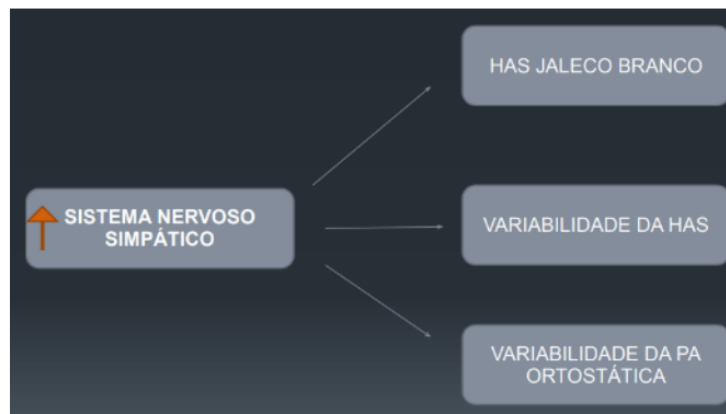
- Adicionar um betabloqueador ao tratamento.
- A associação de um IECA poderia ajudar na baixa da pressão e na proteção renal por causa do diabetes.
- Como é uma mulher, poderemos usar como droga de escolha um anti-hipertensivo de ação central, como a metildopa.
- Associar um bloqueador de canal de cálcio.**
- Introduzir um diurético de alça para potencializar ação diurética e anti-hipertensiva.

103) ## (P2: T20) Analise as afirmativas considerando a avaliação da PA em idosos:

I. (V) Nos idosos, há especial preocupação com a aferição da PA, pois o envelhecimento está frequentemente associado à **disfunção barorreflexa** e, conseqüentemente, à **maior possibilidade de hipotensão postural e pós-prandial**.

↳ Fisiopatologia

- Com o processo de envelhecimento há:
 - Ruptura e perda das fibras de elastina
 - Alterações na deposição de cálcio e colágeno
 - PAD aumenta até a 6ª década de vida, passando por uma lenta e progressiva queda após. Entretanto, a PAS passa por aumento progressivo durante o envelhecimento.
 - A ação vasodilatadora mediada por receptores β -adrenérgicos também é diminuída, e o endotélio aterosclerótico produz endotelina, tromboxano e angiotensina II, causando vasoconstrição.
 - Os **barorreceptores têm sua sensibilidade diminuída**, havendo **aumento do sistema nervoso simpático, aumento da PA e da FC**
 - ↳ Aumento do SN simpático: Comum no paciente idoso, nem sempre está associado a hipertensão, podendo ser **HAS por jaleco branco**, variabilidade de HAS ou variabilidade da PA ortostática.



II. (V) Nos pacientes idosos, a medida da PA deve ser **sempre** realizada também com o **paciente de pé**, de preferência em **todas as consultas** ou quando **queixas de tonturas**, para **avaliar a presença de hipotensão ortostática**.

↳ Achados da avaliação clínica:

- Hipotensão ortostática:
 - A **medida da PA** em **posição supina** (decúbito dorsal) e **ortostática** (em pé) deve ser realizada **pelo menos na primeira avaliação** e em **todas as avaliações de idosos diabéticos**, em uso de anti-hipertensivos, etilistas e com disautonomia (doenças degenerativas).
 - ↳ Caso a **PAS caia 20mmHg** ou **PAD 10mmHg** é considerada **hipotensão ortostática**.
 - Hipertensão do Jaleco Branco:
 - ↳ Para ser afastada pode ser medida em **outro dia no consultório**, em **MRPA** (residencial) ou em **MAPA** (pequeno aparelho eletrônico automático que realiza várias medições ao longo do dia)

III. (V) Medir **sempre em ambos os braços na primeira consulta**, se houver uma **diferença maior de 20 mmHg de sistólica**, deve se **buscar causas vasculares** para essa alteração.

↳ Avaliação clínica:

- Primeira avaliação:
 - Medição em **ambos os braços**, com os braços na altura do coração.
 - ↳ Em caso de diferença na PA deve ser **utilizado o maior valor**
 - ↳ Se **variação maior que 20mmHg na PAS** ou **10mmHg na PAD** devem ser **investigadas doenças arteriais**, como coarctação de aorta (subclávia esquerda).
- Consultas subsequentes:
 - **Três medidas**, sendo a média das duas últimas considerada a PA do indivíduo.
 - ↳ Na **prática** são feitas **duas medidas**, uma no início e outra ao término da consulta

IV. (F) Variabilidade diária dos níveis de pressão é menos frequente no idoso.

↳ **Variabilidade diária** dos níveis de pressão é **MAIS frequente** no idoso

Estão corretas:

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II e III

d) I, II e III

104) ## (P2: T17) Na HAS do idoso, há um aumento da mortalidade e morbidade por doenças cardiovasculares, independentemente da idade. Assim, é verdadeiro afirmar:

a) Naqueles idosos frágeis a pressão arterial deve ser como alvo 120/80.

↳ Em pacientes idosos com **mais de 80 anos podem ser tolerados PAS de até 150 mmHg**.

↳ Em **idosos ≥ 80 anos o limite para início da terapia** farmacológica **aumenta para uma PAS ≥ 160 mmHg**, evitando iatrogenias.

b) Nos idosos existem com mais frequência a HAS do jaleco branco e a hipotensão ortostática.

↳ Hipertensão do Jaleco Branco:

- Para ser afastada pode ser medida em **outro dia no consultório**, em **MRPA** (residencial) ou em **MAPA** (pequeno aparelho eletrônico automático que realiza várias medições ao longo do dia)

c) Os betabloqueadores podem ser usados em pacientes com insuficiência arterial.

d) Os anti-hipertensivos de ação central podem ser usados como medicação de primeira escolha em alguns casos.

e) O hiperaldosteronismo leva a HAS, **hipercalemia** e **hiponatremia**.

↳ Hiperaldosteronismo

- Leva a:
 - HAS
 - **HIPERnatremia**
 - **HIPOcalemia** (HIPOpotassemia)
- Níveis elevados de aldosterona podem **provocar hipertensão arterial** e **níveis baixos de potássio**.
 - Níveis baixos de potássio podem provocar fraqueza, formigamento, espasmos musculares e períodos de paralisia temporária.
- **Aldosterona** faz com que os rins
 - **Retenham mais sódio**
 - **Excretem mais potássio**

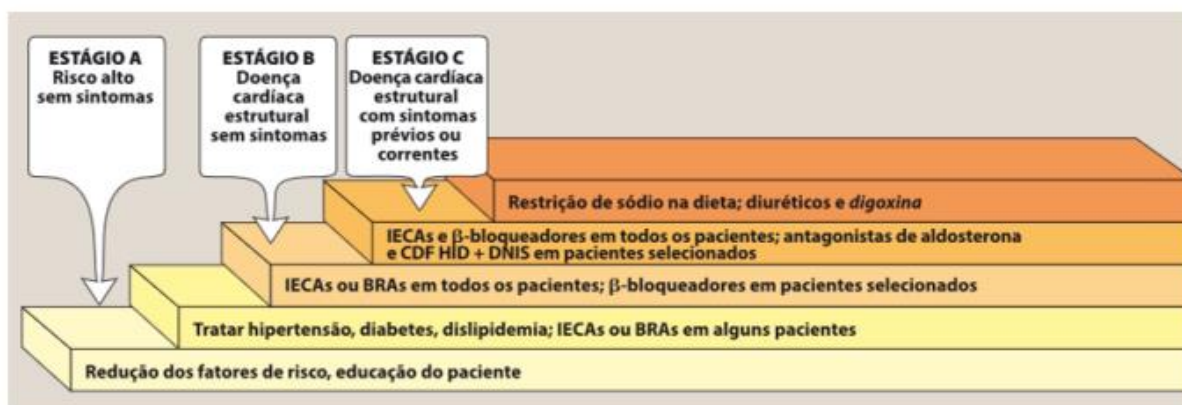
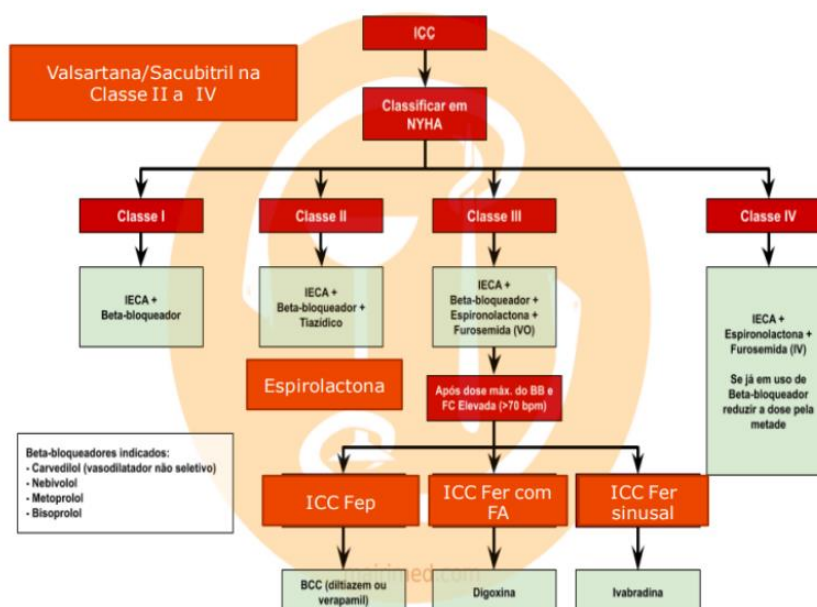
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

Questões:

- 105) ## (P2: T20) Paciente do sexo feminino, 70 anos, hipertensa, usando anlodipino irregularmente e má aderente ao tratamento, procura o ambulatório sem queixas para mostrar exame solicitado por outro médico e, na ocasião, apresentava dispneia aos grandes esforços. Ao exame físico no momento, chamaram atenção apenas a PA de 170x95mmHg. O exame era um ecocardiograma que mostrava FE do VE de 40%. Sobre esse caso, assinale a alternativa correta.
- a) Deve-se controlar adequadamente a PA, e uma boa opção seria o início de um iECA.
 - b) Uma ótima opção terapêutica seria diltiazem, potente vasodilatador.
 - c) Um β -bloqueador não teria qualquer benefício nesse caso, já que não há qualquer evidência de doença isquêmica cardíaca.
 - d) Um diurético tem evidência de melhorar sintomas como a dispneia e aumentar a sobrevida, e, por isso, deve ser utilizado nesse caso, nesse momento.
 - e) Uso do digital seria mandatório neste caso.
- 106) ## (P2: T17) Paciente idoso de 77 anos chega ao PS com queixas de dispneia ao repouso e aos mínimos esforços, dispneia paroxística noturna, edema de MMII há 5 dias. Nega febre ou outros sintomas. Tem como comorbidades HAS de difícil controle e DPOC. Nos exames laboratoriais mostrou anemia hipocromica e hiponatremia. Restante normais. Exames físicos: dispneico, sat O₂ 89%. Tórax: brnf sem sopros, taquicardico em ritmo de galope, estertoração em bases. Abdome: sp. Edema +++/4 em MMII. Diante do caso, assinale a correta:
- a) É um caso provável de ICC, aonde a causa dessa descompensação é somente a HAS de longa data.
 - b) Caso provável de ICC descompensado, aonde é mandatório o uso de betabloqueadores e diuréticos no internamento.
 - c) O paciente se encontra na Classe Funcional III da NYHA, aonde vai precisar de diuréticos de alça para melhora da congestão.
 - d) O uso de digitálicos na ICC tem como indicação todas as classes funcionais, para melhora da bomba cardíaca.
 - e) A hiponatremia é comum em pacientes com ICC.
- 107) ## (P2: T17) Paciente de 80 anos vem ao OS com queixas de tosse seca e dispneia ao repouso e aos mínimos esforços há 3 dias, associado a queda do estado geral e apatia. Tem tido edema de MMII há 7 dias, principalmente final da tarde. No exame físico apresenta estertoração em bases, mais pronunciado a esquerda, com FTV aumentado a esquerda. Edema de MMII bilateralmente ++/4 com cacifu positivo e presença de varizes. Tem como comorbidades HAS e DM II com bom controle. Nega febre ou outros sintomas. Diante da patologia acima, é correto afirmar:
- a) Trata-se de uma ICC descompensada, aonde a presença do edema de MMII e a dispneia ajuda fechar o diagnóstico.
 - b) A realização de exames laboratoriais como o hemograma, PCR e BNP sérico podem ser de muita ajuda para concluir o diagnóstico.
 - c) Caso for um quadro de Pneumonia, o antibiótico de escolha é a cefalosporina de 1ª geração.
 - d) A solicitação unicamente de um Ecocardiograma transesofágico seria a melhor opção para ajudar no diagnóstico.
 - e) Como o paciente está dispneico e com edema, um tiazídico, poderia de imediato tratar este tipo de paciente, mesmo antes dos exames solicitados.

FLUXOGRAMAS E TABELAS

Classe funcional	Definição	Descrição geral	Mortalidade
I	Paciente com doença cardíaca, mas sem limitação para atividades habituais	Assintomático	5%
II	Sintomas com atividades habituais e limitação leve	Dispneia aos moderados esforços	10%
III	Sintomas com atividades menos intensas que habituais e limitação importante	Dispneia aos pequenos esforços	30%
IV	Sintomas com qualquer atividade e ao repouso	Dispneia em repouso	50-60%



Questões comentadas:

108) ## (P2: T20) Paciente do sexo feminino, 70 anos, **hipertensa**, usando **anlodipino** [BBC] **irregularmente** e **má aderente ao tratamento**, procura o ambulatório sem queixas para mostrar exame solicitado por outro médico e, na ocasião, apresentava **dispneia aos grandes esforços** [NYHA 1]. Ao exame físico no momento, chamaram atenção apenas a **PA de 170x95mmHg**. O exame era um ecocardiograma que mostrava **FE do VE de 40%** [Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFER)]. Sobre esse caso, assinale a alternativa correta.

- ↳ Dispneia aos **grandes esforços** → **NYHA 1**
- ↳ **FE do VE de 40%** → Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFER)
- ↳ **PA de 170x95mmHg** → HÁ Estágio 2, Moderado risco

a) Deve-se controlar adequadamente a PA, e uma boa opção seria o início de um iECA.

↳ **NYHA 1** → iECA + BB

b) Uma ótima opção terapêutica seria diltiazem, potente vasodilatador.

↳ **Bloqueadores de Canais De Cálcio**

- **Anlodipino**, Lercanidipino, Lacidipino, **Felodipino**, **Nifedipino**, Nitrendipino, Levanlodipino, **Verapamil**, **Diltiazem** e Manidipino.
- Redução da resistência vascular periférica .
- **Verapamil** e **Diltiazem** → Efeito **bradicardizante** e **antiarrítmico**
 - **Diltiazem** → **Vasodilatador** e depressor da função cardíaca
 - ↳ Usa em **NYHA 3**, após dose max do BB e FC elevada (≥ 70) se **ICC FEP** (Ejeção Preservada)

c) Um β -bloqueador ~~não teria qualquer benefício~~ nesse caso, já que ~~não~~ há qualquer evidência de doença isquêmica cardíaca.

↳ Há evidências de doença isquêmica cardíaca

- Dispneia aos grandes esforços
- Ecocardiograma que mostrava FE do VE de 40%

d) Um diurético tem evidência de melhorar sintomas como a dispneia e aumentar a sobrevida, e, por isso, deve ser utilizado nesse caso, ~~nesse momento~~.

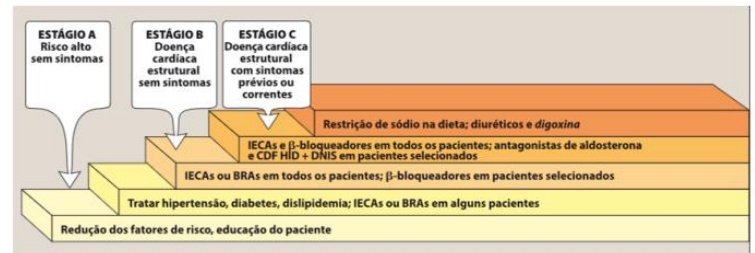
↳ **Diuréticos:**

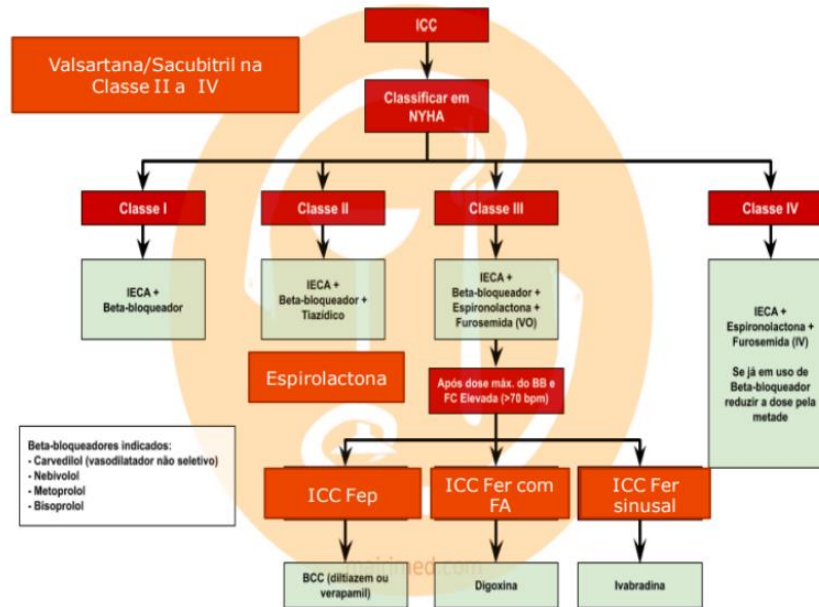
- **Tiazídicos (Hidroclorotiazida):**
 - Em congestão leve
 - ↳ Usa a partir do **NYHA 2**
- **De alça (Furosemida)**
 - Em anasarca (EV).
 - ↳ Usa a partir do **NYHA 3**
- Melhoram os sintomas e reduzem as hospitalizações.
- As classes podem ser associadas, mas devendo manter cuidado com hipotensão e hipocalemia.
- Para os estáveis e sem congestão é necessária a retirada progressiva

e) Uso do digitálicos seria mandatório neste caso.

↳ **Digitálicos (Digoxina)**

- Indicada quando **houver FA** ou **não responderam adequadamente ao tratamento otimizado**





109) ## (P2: T17) Paciente idoso de 77 anos chega ao PS com queixas de **dispneia ao repouso** [NYHA 4] e aos mínimos esforços, **dispneia paroxística noturna**, **edema de MMII** há 5 dias. Nega febre ou outros sintomas. Tem como comorbidades **HAS de difícil controle** e **DPOC**. Nos exames laboratoriais mostrou **anemia** hipocromica e **hiponatremia**. Restante normais. Exames físicos: **dispneico**, **sat O2 89%**. Tórax: brnf sem sopros, **taquicardico em ritmo de galope**, **estertoração em bases**. Abdome: sp. **Edema +++/4** em MMII. Diante do caso, assinale a correta:

a) É um caso provável de ICC, aonde a causa dessa descompensação é ~~somente~~ a HAS de longa data.

↳ Causas de descompensação da ICC

- Redução inapropriada da terapia.
- Embolia pulmonar.
- Arritmias.
- Infecção sistêmica.
- Retenção de sódio ou medicamentos cardíacos supressores.
- Excessos físicos, emocionais ou ambientais.
- Desenvolvimento de comorbidades.
- Infarto agudo do miocárdio.
- Ruptura/ perfuração de valva cardíaca (endocardite).
- Miocardite aguda.
- IC.

b) Caso provável de ICC descompensado, aonde é mandatório [??] o uso de betabloqueadores e diuréticos no internamento.

↳ Não sei se é mandatório o uso

↳ NYHA 4

- IECA+ Espironolactona + Furosemida (IV)
- Se já em uso de Beta-bloqueador reduzir a dose pela metade
 - BB precisa SEMPRE associar com os antagonistas da SRAA (IECA ou BRA).

c) O paciente se encontra na ~~Classe Funcional III~~ da NYHA, aonde vai precisar de diuréticos de alça para melhora da congestão.

↳ NYHA 3 → Precisar de diuréticos de alça (Furosemida) para melhora da congestão

↳ Pact apresenta **dispneia ao repouso** → **Classe Funcional IV da NYHA**

↳ **Classificação: NYHA.**

- Classe I: Doença cardíaca **sem limitação** de atividade física.
- Classe II: **Leve limitação.** Atividade usual causa fadiga e dispneia.
- Classe III: **Assintomático somente ao repouso.**
- Classe IV: **Dispneia ao repouso**

Classe funcional	Definição	Descrição geral	Mortalidade
I	Paciente com doença cardíaca, mas sem limitação para atividades habituais	Assintomático	5%
II	Sintomas com atividades habituais e limitação leve	Dispneia aos moderados esforços	10%
III	Sintomas com atividades menos intensas que habituais e limitação importante	Dispneia aos pequenos esforços	30%
IV	Sintomas com qualquer atividade e ao repouso	Dispneia em repouso	50-60%

d) O uso de digitálicos na ICC tem como indicação todas as classes funcionais, para melhora da bomba cardíaca.

↳ **Digitálicos (Digoxina)**

- Indicada quando **houver FA** ou **não responderam adequadamente ao tratamento otimizado**

e) A hiponatremia é comum em pacientes com ICC.

↳ **Hiponatremia**

- A **hiponatremia é um dos distúrbios eletrolíticos mais frequentes na insuficiência cardíaca congestiva (ICC)** e que pode ser resultante tanto da própria evolução e progressão da doença quanto dos efeitos dos medicamentos utilizados para o seu controle, sendo assim, é um importante marcador a ser utilizada como preditor de mortalidade e prognóstico na ICC
- Representa um excesso relativo de água em relação ao sódio corporal.
 - Pode ser induzida por um aumento acentuado na ingestão de água (polidipsia primária) e/ou por excreção de água prejudicada devido, por exemplo, a insuficiência renal avançada ou liberação persistente de hormônio antidiurético (ADH)
 - As causas da hiponatremia em pacientes portadores de ICC podem ser classificadas em por diluição ou por depleção de sódio. A hiponatremia por diluição é a forma mais comum durante o início da ICC e se deve justamente pelo modelo clássico do estímulo do SRAA e pelos níveis elevados de ADH na presença do quadro de ICC que levam a uma maior expressão de aquaporina-2 nos ductos coletores desencadeando a retenção de água pelos rins diluindo assim o sódio plasmático, em contraponto, a hiponatremia por depleção é resultado do uso desregulado e exagerado de diuréticos tiazídicos e a alimentação com baixo teor de sal, porém, ambos são importantes mecanismos de hiponatremia na ICC

110) ## (P2: T17) Paciente de 80 anos vem ao OS com queixas de **tosse seca e dispneia ao repouso** [NYHA 4] e aos **mínimos esforços** há 3 dias, associado a **queda do estado geral e apatia**. Tem tido **edema de MMII** há 7 dias, principalmente final da tarde. No exame físico apresenta **estertoração em bases**, mais pronunciado a esquerda, com FTV aumentado a esquerda. **Edema** de MMII bilateralmente ++/4 com cacifu positivo e presença de varizes. Tem como comorbidades HAS e DM II com bom controle. **Nega febre** ou outros sintomas. Diante da patologia acima, é correto afirmar:

a) Trata-se de uma ICC descompensada, aonde a presença do edema de MMII e a dispneia ajuda fechar o diagnóstico.

↳ Edema de MMII e a dispneia → Achados inespecíficos

↳ **Insuficiência Cardíaca (IC) aguda descompensada**

- Representa uma condição médica comum e potencialmente letal, caracterizada por desencadear uma síndrome respiratória aguda
- A **ortopneia e dispneia paroxística noturna** são os **achados mais específicos** para diagnóstico de ICAD.
- Os pacientes podem evoluir com hipotensão ou valores de pressão convergentes com má-perfusão periférica, presença de B3 ou B4 e ritmo de galope pode ocorrer e novos sopros cardíacos podem ocorrer.
- Sinais de edema periférico como edema de membros inferiores e estase venosa jugular podem ocorrer.
- Ao exame físico:
 - Estertores crepitantes são frequentes e se ocupam todos os campos pulmonares sugerem congestão significativa, os pacientes podem apresentar sibilância por edema peribronquiolar simulando asma e outras causas de broncoespasmo.

b) A realização de exames laboratoriais como o hemograma, PCR e BNP sérico podem ser de muita ajuda para concluir o diagnóstico.

↳ **BNP sérico e NT-proBNP**

- Grande utilidade se tivermos dúvida diagnóstica.
- Também aumenta o ICFEP.
- Pode prever eventos cardiovasculares futuros.
- Estima prognóstico.
- Anemia, idade avançada, insuficiência renal e sexo feminino tem valores mais elevados.
- Acima de 400 pg/ml

c) Caso for um quadro de Pneumonia, o antibiótico de escolha é a cefalosporina de 1ª geração.

↳ **PAC ambulatorial**

- **Amoxicilina + Ácido clavulânico**

↳ **PAC Hospitalar**

- **Cefalosporinas de 3ª Geração (Ceftriaxona ou Cefotaxima) OU Ampicilina/Sulbactam + Macrolídeo (Azitromicina ou Claritromicina)**

d) A solicitação unicamente de um Ecocardiograma seria a melhor opção para ajudar no diagnóstico.

↳ Ressonância Magnética cardíaca → Mais preciso que o ecocardiograma

e) Como o paciente está dispneico e com edema, um ~~tiazídico~~ [de alça], poderia de imediato tratar este tipo de paciente, mesmo antes dos exames solicitados.

↳ **Diuréticos:**

- **Tiazídicos (Hidroclorotiazida):**

- Em congestão leve
 - ↳ Usa a partir do **NYHA 2**

- **De alça (Furosemida)**

- Em anasarca (EV).
 - ↳ Usa a partir do **NYHA 3**

DISTÚRBIOS DA TIREOIDE

Questões:

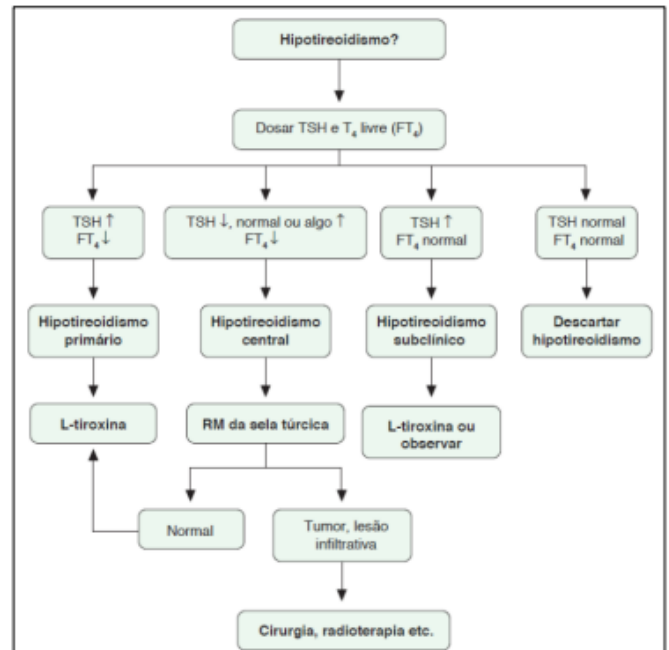
- 111) ## (P2: T20) Assinale a alternativa que contém os sinais e sintomas comuns de hipertireoidismo entre os indivíduos
- a) Tremor e intolerância ao calor.
 - b) Fibrilação atrial e perda de peso
 - c) Ansiedade e osteoporose
 - d) Hiperfagia e oftalmopatia
 - e) Disfagia e pele úmida
- 112) ## (P2: T20) Sobre hipotireoidismo no idoso é incorreto afirmar:
- a) Uma das causas de hipotireoidismo é uso de medicações como a amiodarona.
 - b) A principal causa de hipotireoidismo no idoso é a doença autoimune.
 - c) O tratamento excessivo com levotiroxina pode elevar a mortalidade em idosos.
 - d) No hipotireoidismo subclínico, o tratamento deve ser feito quando o paciente tem sintomas como aumento de peso e alopecia
 - e) Sempre iniciar com doses menores a levotiroxina, sendo que em cardiopatas a dose pode ser 12,5mcg/dia
- 113) ## (P2: T17) Paciente de 80 anos comparece ao ambulatório de geriatria, com queixas de perda de peso de 6 kg em dias, fraqueza muscular e astenia. No retorno da consulta, traz como únicos exames alterados TSH 0,02 e T4 livre 4,6. Seria incorreto afirmar neste caso:
- a) O paciente idoso apresenta o chamado hipertireoidismo apático.
 - b) O bócio multinodular tóxico é a causa mais comum de hipertireoidismo no idoso.
 - c) A fibrilação atrial pode ser a primeira manifestação dessa doença.
 - d) O tratamento final na maioria das vezes é o iodo radioativo.
 - e) Os tremores são menos frequentes nos idosos.
- 114) ## (P2: T17) A droga de escolha no tratamento do hipotireoidismo no idoso é a levotiroxina, sendo assim, é incorreto dizer:
- a) Começar com doses pequenas e aumentar gradualmente, principalmente em pacientes cardiopatas.
 - b) Pacientes acima de 80 anos com TSH entre 5 a 10 e sem anticorpos presentes não devemos tratar.
 - c) O alvo terapêutico para o TSH deve ser de 2 a 3 mIU/l.
 - d) TSH maior ou igual a 10, somente devemos tratar se houver sintomas e com anti-tpo positivo.
 - e) O hipotireoidismo subclínico caracteriza-se por TSH elevado e T4 livre normal.

Questões comentadas:

Hipotireoidismo

⇒ Diagnóstico:

- Valor de referência
 - TSH: 0,4 – 4,5
 - T4 livre (T4L): 0,7 – 0,8
- Falha na **Glândula tireoide** → Doença autoimune (Hashimoto)
 - Hipotireoidismo primário: **TSH elevado** com **T4L baixo**
 - Hipotireoidismo primário subclínico: **TSH elevado** com **T4L normal**.
- Falha na **Hipófise** – TSH (secundário) ou **Hipotálamo** - TRH (terciário)
 - Hipotireoidismo secundário ou terciário (central): **TSH normal** ou **baixo** e **T4L baixo**.



115) ## (P2: T20) Sobre hipotireoidismo no idoso é INCORRETO afirmar:

- Uma das causas de hipotireoidismo é uso de medicações como a amiodarona.
 - ↪ Drogas antitireoidianas: **amiodarona**, lítio, xaropes para tosse com iodo
- A principal causa de hipotireoidismo no idoso é a doença autoimune.
 - ↪ 50% dos casos de Tireoidite Auto-Imune = **Doença de Hashimoto**
 - ↪ **Etiologia:**
 - As principais causas são a tireoidite de Hashimoto, o uso de medicações e a tireoidectomia.
 - **Causas primárias:** → **TSH aumentado** e **T4L diminuído**
 - **Perda da função tireoidiana:**
 - ↳ **Tireoidite de Hashimoto** (mais comum)
 - ↳ Tireoidectomia parcial ou total e pós-radioiodoterapia por hipertireoidismo.
 - **Biossíntese defeituosa dos hormônios:**
 - ↳ Por medicações (amiodarona, lítio e perclorato)
 - **Amiodarona** possui 14- 20x mais iodo que a alimentação normal, podendo desenvolver hiper ou hipotireoidismo
 - ↳ Por deficiência ou excesso de iodo.
 - **Causas secundárias:** → **TSH normal** ou **baixo** e **T4L baixo**.
 - **Deficiência hipofisária de TSH:**
 - ↳ Hipofisite ou tumores hipofisários (adenoma de hipófise).
 - **Alterações hipotalâmicas:**
 - ↳ Deficiência de TRH e tumores hipotalâmicos
 - O tratamento excessivo com levotiroxina pode elevar a mortalidade em idosos.
 - ↪ Aumento da mortalidade cardiovascular

d) No hipotireoidismo subclínico, o tratamento deve ser feito quando o paciente tem sintomas como aumento de peso e alopecia

↳ **Hipotireoidismo subclínico:**

- **TSH elevado** com **T4L normal**.
 - Com hipotireoidismo subclínico sempre deve ser requisitado **anticorpos anti-tireoperoxidase**, pois a positividade destes anticorpos indica provável evolução para **hipotireoidismo franco**
- Difícilmente existem manifestações clínicas, principalmente neuropsiquiátricas.
- **Não há indicação de tratamento**, pois aumenta a mortalidade cardiovascular, tendo em vista que as alterações do hipotireoidismo subclínico são protetoras ao paciente.
 - Deve-se tratar somente o hipotireoidismo subclínico **se o TSH persistir acima de 10**
 - Estudos que mostram associação de hipotireoidismo subclínico com síndrome metabólica, ICC e insuficiência coronariana ocorre apenas em idosos com **TSH > 10**, sendo nestes casos a exceção ao tratamento
- Indicações de tratamento
 - TSH entre 5 a 10 **sem** Anticorpos presentes e sem sinais clínicos: **não tratar**.
 - TSH entre 5 a 10 **com** Anticorpos presentes e sem sinais clínicos: **tratar**.
 - **TSH > 10: tratar sempre**.

e) Sempre iniciar com doses menores a levotiroxina, sendo que em cardiopatas a dose pode ser 12,5mcg/dia

↳ **Tratamento hipotireoidismo clínico**

- Iniciar com **doses pequenas de 12,5-25mcg 1x/dia** com levotiroxina
- **Dose terapêutica** deve ser mantida em **75 a 100 mcg/dia** (20 a 30% menor que os jovens).
- Meta → Visando um **TSH de 2,5-3,5**.
- Deve ser **tomada em jejum**, aguardando 20- 30 minutos para se alimentar, além de **não ingerir junto de outros remédios** e não cortar o comprimido ao meio
- Medicamentos que alteram a absorção
 - ↓ Absorção de T4: Antiácidos, carbonato de Ca e Ferro.
 - ↑ Absorção de T4: IBP.
 - ↓ Secreção de TSH: Corticoides, Lítio e Amiodarona.

116) ## (P2: T17) A droga de escolha no tratamento do hipotireoidismo no idoso é a levotiroxina, sendo assim, é INCORRETO dizer:

a) Começar com doses pequenas e aumentar gradualmente, principalmente em pacientes cardiopatas.

↳ Iniciar com doses pequenas de 12,5-25mcg 1x/dia com levotiroxina

b) Pacientes acima de 80 anos com TSH entre 5 a 10 e sem anticorpos presentes não devemos tratar.

↳ **Indicações de tratamento**

- TSH entre 5 a 10 **SEM** Anticorpos presentes e sem sinais clínicos: **não tratar**.
- TSH entre 5 a 10 **com** Anticorpos presentes e sem sinais clínicos: **tratar**.
- **TSH > 10: tratar sempre**.

TABELA 71.2 Abordagem diagnóstica e terapêutica do hipotireoidismo no idoso.

Valores de TSH ^a	Idoso robusto		Idoso frágil	
	65 a 75 anos	> 75 anos	65 a 75 anos	> 75 anos
4 a 6 mU/ℓ	Observar/ tratar ^{b,c}	Observar	Observar	Observar
6 a 10 mU/ℓ	Observar/ tratar ^{b,c}	Observar/ tratar ^{b,c}	Observar	Observar
> 10 mU/ℓ	Tratar ^d	Tratar ^d / observar	Observar/ tratar ^b	Observar

c) O alvo terapêutico para o TSH deve ser de 2 a 3 mIU/l.

→ Meta → Visando um **TSH de 2,5-3,5**.

d) TSH maior ou igual a 10, somente devemos tratar se houver sintomas e com anti-tpo positivo.

→ **TSH > 10: tratar SEMPRE**

e) O hipotireoidismo subclínico caracteriza-se por TSH elevado e T4 livre normal.

→ Falha na **Glândula tireoide** → Doença autoimune (Hashimoto)

• **Hipotireoidismo primário**: **TSH elevado** com **T4L baixo**

• **Hipotireoidismo primário subclínico**: **TSH elevado** com **T4L normal**.

→ Falha na **Hipófise** – TSH (secundário) ou **Hipotálamo** - TRH (terciário)

• **Hipotireoidismo secundário ou terciário (central)**: **TSH normal** ou **baixo** e **T4L baixo**

↪ Hipertireoidismo

• Quando temos o **TSH baixo** e **hormônios tireoidianos elevados**.

• **Hipertireoidismo subclínico** pode ser dividido em:

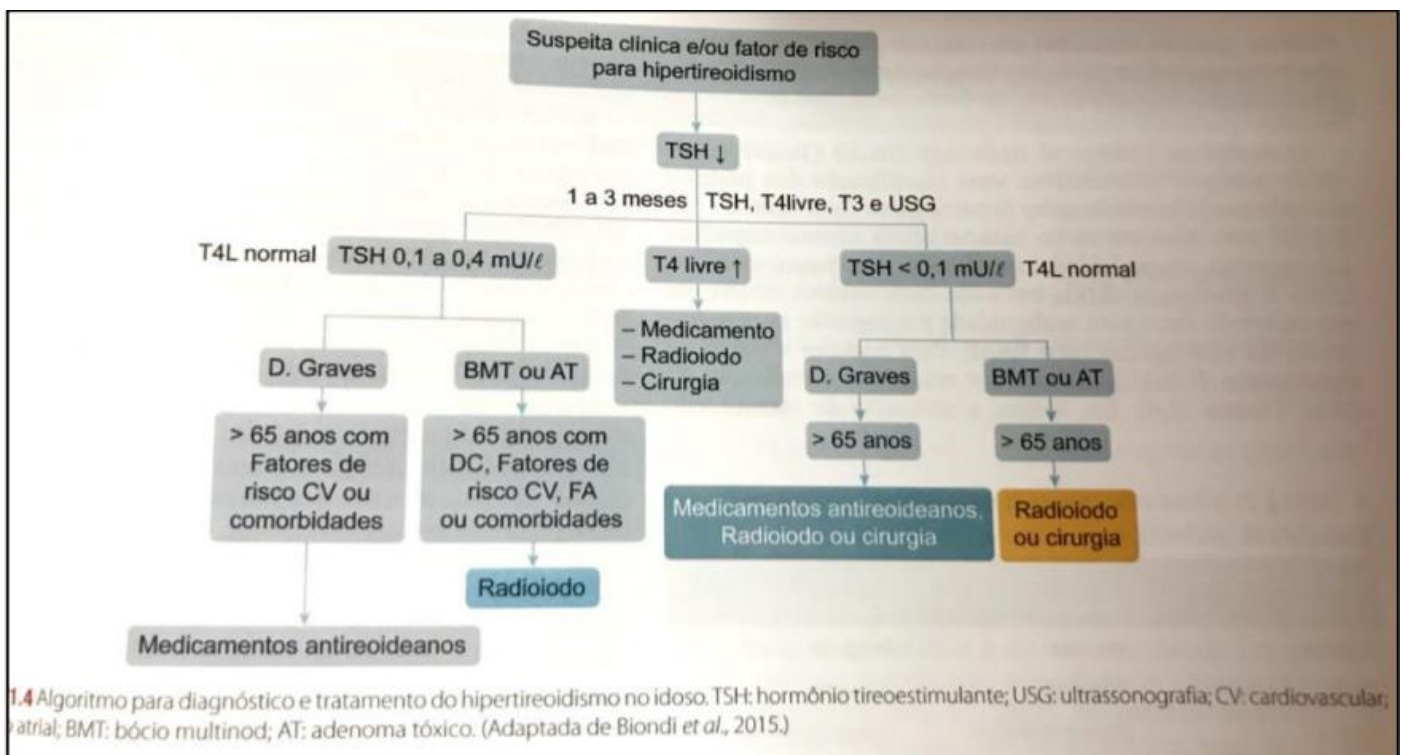
▪ TSH baixo, mas detectável 0,1 a 0,4 mIU/ml

▪ TSH suprimido menor 0,1 mIU/ml

▪ Ambos aumentam o risco de doença cardiovascular, principalmente se tratando de FA e IC

↳ TSH < 0,1 aumenta o risco de ICC, FA e aumento da mortalidade por DAC.

↳ Então, diferentemente do hipotireoidismo subclínico, o **hipertireoidismo necessita de tratamento**



117) ## (P2: T20) Assinale a alternativa que contém os sinais e sintomas comuns de HIPERTireoidismo entre os indivíduos

a) Tremor e intolerância ao calor.

↳ **HIPER** → MENOS manifestações hiperadrenérgicas como: **tremor**, nervosismo e **intolerância ao calor**

↳ **HIPO** → **Intolerância ao frio**;

b) Fibrilação atrial e perda de peso

↳ **HIPER** → MAIS manifestações cognitivas e risco de abrir o quadro com **FA**.

- 30% dos idosos tem hipertireoidismo apático, que envolve letargia, humor depressivo, declínio cognitivo, fraqueza muscular, **emagrecimento** e **fibrilação atrial**.

↳ **HIPO** → **Aumento de peso**

c) Ansiedade e osteoporose

↳ **HIPER** → Osteoporose

d) Hiperfagia e oftalmopatia

↳ **HIPER** → Ausência de exoftalmia quando comparado aos pacientes mais jovens

e) Disfagia e pele úmida

↳ **HIPER** → Pele **úmida**

↳ **HIPO** → Pele **seca**

118) ## (P2: T17) Paciente de 80 anos comparece ao ambulatório de geriatria, com queixas de **perda de peso** de 6 kg em dias, **fraqueza muscular** e **astenia**. No retorno da consulta, traz como únicos exames alterados **TSH 0,02 [baixo]** e **T4 livre 4,6 [elevado]**. Seria INCORRETO afirmar neste caso:

↳ Hipertireoidismo

– **TSH baixo** e **hormônios tireoidianos elevados**.

– **Perda de peso**

• Valor de referência

▪ TSH: 0,4 – 4,5

▪ T4 livre (T4L): 0,7 – 1,8

a) O paciente idoso apresenta o chamado **hipertireoidismo apático**.

↳ 30% dos idosos tem **hipertireoidismo apático**, que envolve:

- Letargia
- Humor depressivo
- Declínio cognitivo
- **Fraqueza muscular**
- **Emagrecimento**
- Fibrilação atrial.

b) O bócio multinodular tóxico é a causa mais comum de hipertireoidismo no idoso.

c) A **fibrilação atrial** pode ser a **primeira manifestação** dessa doença.

↳ **HIPER** → Mais manifestações cognitivas e risco de **abrir o quadro com FA**

d) O tratamento final na maioria das vezes é o iodo radioativo.

↳ **Iodo radioativo** → Tratamento curativo e definitivo

e) Os tremores são menos frequentes nos idosos.

↳ **HIPER** → MENOS manifestações hiperadrenérgicas como: **tremor**, nervosismo e **intolerância ao calor**

INCONTINÊNCIA URINÁRIA

Questões:

119) ## (P2: T20) A incontinência urinária é um dos Gigantes da Geriatria, levando a uma repercussão negativa na qualidade de vida do idoso. Sobre esse sintoma, considere as seguintes afirmativas:

- I. A incontinência urinária pode ser transitória, como no caso de uma infecção urinária.
- II. Na incontinência urinária de urgência não indicamos fisioterapia como adjuvante no tratamento.
- III. A incontinência por transbordamento é caracterizada por perda urinária intensa após longo período de resistência ao ato miccional.
- IV. Os antimuscarínicos usados no tratamento de bexiga hiperativa pode causar xerostomia, obstipação e piora da função cognitiva.
- V. A fisioterapia uroginecológica é uma opção de tratamento louvável para a Incontinência Urinária de Esforço.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 2, 4 e 5 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1 e 5 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 4 e 5 são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.

120) ## (P2: T17) A incontinência urinária é um dos gigantes da geriatria, levando a uma repercussão negativa na qualidade de vida do idoso. Sobre esse sintoma, considere as seguintes afirmativas:

1. A incontinência urinária pode ser transitória, como no caso de uma infecção urinária.
2. Na incontinência urinária de urgência a suspensão de um IECA que vem sendo usado, pode ajudar a diminuir ou cessar o sintoma.
3. A incontinência por transbordamento é caracterizada por perda urinária intensa após longo período de resistência ao ato miccional.
4. A oxibutinina usada no tratamento de bexiga hiperativa pode causar xerostomia, obstipação e piora de função cognitiva.
5. A fisioterapia uroginecológica é uma opção de tratamento louvável para a incontinência urinária de esforço.

Assinale a alternativa correta:

- a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 2, 4 e 5 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1 e 5 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 4 e 5 são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.

Questões comentadas:

121) ## (P2: T20) A incontinência urinária é um dos Gigantes da Geriatria, levando a uma repercussão negativa na qualidade vida do idoso. Sobre esse sintoma, considere as seguintes afirmativas:

I. (V) A incontinência urinária pode ser **transitória**, como no caso de uma **infecção urinária**.

→ Incontinência urinária transitória:

- Consiste na perda involuntária de urina, precipitada por insulto psicológico, medicamentoso ou orgânico, que cessa ou melhora após o controle do fator desencadeante.
- Causas → **DIURAMID**
 - **Delirium**
 - **Infecção**
 - **Uretrite**
 - **Restrição ao leito**
 - **Aumento de débito urinário** (ICC ou DM)
 - **Medicamentos** (diuréticos, anticolinérgicos, IECA, anti-parkinsonianos, opiáceos e sedativos)
 - **Impactação fecal**
 - **Distúrbios psíquicos** (depressão, delirium e ansiedade)

II. (F) Na incontinência urinária de **urgência** ~~não~~ **indicamos fisioterapia** como adjuvante no tratamento.

→ É indicado fisioterapia do assoalho pélvico

→ Incontinência urinária de urgência:

- **Causa mais frequente nos idosos**
- Ocorre partir de uma **bexiga hiperativa**
 - Havendo:
 - ↳ Urgência miccional
 - ↳ Polaciúria
 - ↳ Nictúria
 - ↳ Quase sempre incontinência urinária.
 - A bexiga hiperativa sofre **contrações vesicais involuntárias**, tendo **fatores neurológicos presentes ou ausentes**
 - ↳ Presentes → **Hiperreflexia do detrusor (bexiga neurogênica)**
 - ↳ Ausentes → **Instabilidade do detrusor**
- Tratamento:
 - **Conservador:**
 - ↳ **Acessórios para diurese e treinamento vesical.**
 - Paciente deve urinar em horários fixos, a cada 2 ou 3 horas, realizando contração do assoalho pélvico
 - **Outras medidas:**
 - ↳ Exercícios, **fisioterapia**, duloxetine (uso associado no tratamento da depressão, diminuindo contrações) e estrogênios em cremes (para vaginite atrófica)

III. (F) A incontinência **por transbordamento** é caracterizada por **perda urinária intensa** após **longo período de resistência ao ato miccional**.

→ Não é intensa → É pequena (gotejamento)

→ **Incontinência por transbordamento**

- É o **gotejamento de urina** da bexiga sobrecarregada.
- O **volume é normalmente pequeno**, mas pode ser constante, resultando em grandes perdas totais
 - Ocorrem perdas pequenas de urina, de maneira contínua, com jato fraco, hesitação, nictúria e sensação de esvaziamento incompleto.
- Relacionada a obstrução uretral (HPB, Ca. de próstata, constrição uretral, prolapso uterino ou prolapso vesical) ou hipoatividade do detrusor (por lesão medular, com urina por gotejamento).
- Com progressão da doença obstrutiva pode se desenvolver uma hiperatividade do detrusor

IV. (V) Os **antimuscarínicos** usados no tratamento de **bexiga hiperativa** pode causar xerostomia, obstipação e piora da função cognitiva.

→ **Tratamento Medicamentoso - Incontinência urinária de urgência (bexiga hiperativa):**

- **Inibem os receptores muscarínicos (Antimuscarínicos):**
 - **Oxibutinina** (1ª Escolha)
 - ↳ Efeitos colaterais:
 - **Xerostomia**.
 - Piora do glaucoma.
 - Confusão mental.
 - **Obstipação**.
 - Taquicardia.
 - **Déficit cognitivo**
 - Causam menos efeitos colaterais e tão bons quanto a oxibutinina:
 - ↳ **Tolterodina**.
 - ↳ **Solifenacina**
 - ↳ **Darifenacina**
- **Mirabegron**
 - **Agonista de receptores beta adrenérgicos.**
 - Diminui contrações da bexiga.
 - Sem efeitos anti-colinérgicos.
- **Toxina Botulínica** (em último caso).

V. (V) A **fisioterapia uroginecológica** é uma opção de tratamento louvável para a Incontinência Urinária de Esforço.

Assinale a alternativa correta.

- Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- Somente as afirmativas 2, 4 e 5 são verdadeiras.
- Somente as afirmativas 1 e 5 são verdadeiras.
- Somente as afirmativas 1, 4 e 5 são verdadeiras.**
- Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.

122) ## (P2: T17) A incontinência urinária é um dos gigantes da geriatria, levando a uma repercussão negativa na qualidade de vida do idoso. Sobre esse sintoma, considere as seguintes afirmativas:

I. (V) A incontinência urinária pode ser **transitória**, como no caso de uma **infecção urinária**.

↳ Causas → **DIURAMID**

- **Delirium**
- **Infecção**
- **Uretrite**
- **Restrição ao leito**
- **Aumento de débito urinário** (ICC ou DM)
- **Medicamentos** (diuréticos, anticolinérgicos, IECA, anti-parkinsonianos, opiáceos e sedativos)
- **Impactação fecal**
- **Distúrbios psíquicos** (depressão, delirium e ansiedade)

II. (F) Na incontinência urinária de **urgência** a **suspensão de um IECA** que vem sendo usado, pode ajudar a **diminuir ou cessar o sintoma**.

↳ Incontinência por medicamento é IU Transitória

- De urgência é por bexiga hiperativa (contrações vesicais involuntárias)

↳ Incontinência urinária transitória:

- Consiste na **perda involuntária** de urina, precipitada por insulto psicológico, **medicamentoso** ou orgânico, que cessa ou **melhora após o controle do fator desencadeante**.

• Causas → **DIURAMID**

- **Medicamentos** (diuréticos, **IECA**)

↳ Incontinência urinária de urgência:

- Causa mais frequente nos idosos
- Ocorre partir de uma **bexiga hiperativa**
 - A bexiga hiperativa sofre **contrações vesicais involuntárias**, tendo **fatores neurológicos presentes ou ausentes**
 - ↳ Presentes → **Hiperreflexia do detrusor (bexiga neurogênica)**
 - ↳ Ausentes → **Instabilidade do detrusor**

III. A incontinência por **transbordamento** é caracterizada por **perda urinária intensa** após **longo período de resistência ao ato miccional**.

↳ Incontinência por transbordamento

- É o **gotejamento de urina** da bexiga sobrecarregada.
- O **volume é normalmente pequeno**, mas pode ser constante, resultando em grandes perdas totais

IV. (V) A **oxibutinina** usada no tratamento de **bexiga hiperativa** pode causar xerostomia, obstipação e piora de função cognitiva.

↳ **Oxibutinina (Antimuscarínicos)** → 1ª Escolha

- Efeitos colaterais:
 - **Xerostomia.**
 - **Obstipação.**
 - Piora do glaucoma.
 - Taquicardia.
 - Confusão mental.
 - **Déficit cognitivo**

V. (V) A **fisioterapia uroginecológica** é uma opção de tratamento louvável para a incontinência urinária de esforço.

Assinale a alternativa correta:

- a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 2, 4 e 5 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1 e 5 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 4 e 5 são verdadeiras.**
- e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.

TONTURA

Questões:

- 125) ## (P2: T20) Em relação a tontura no idoso, assinale a alternativa correta:
- a) Tanto a vertigem de origem central como periférica são acompanhadas de sintomas neurológicos.
 - b) O tratamento medicamentoso é a primeira indicação para a VPPB.
 - c) Os antivertiginosos devem ser usados de maneira contínua para o tratamento da vertigem
 - d) A VPPB tem como característica a vertigem quando o paciente deita ou se vira na cama
 - e) O desequilíbrio pode ser tratado com Flunarizina, independente da causa.
- 126) ## (P2: T20) Em relação ao tratamento farmacológico de tontura, assinale a alternativa incorreta.
- a) Fármacos sedativos do labirinto podem ser úteis na fase aguda.
 - b) Os ansiolíticos e o Dimenidrato aumentam o risco de quedas.
 - c) O uso prolongado de bloqueadores dos canais de cálcio se associa ao parkinsonismo.
 - d) Na hipotensão ortostática podemos indicar meias elásticas e aumento de oferta hídrica
 - e) A Betaístina deve ser usada como primeira indicação nas tonturas de origem psiquiátrica.
- 127) ## (P2: T17) Em relação ao tratamento farmacológico de tontura no idoso, assinale a alternativa incorreta:
- a) Bloqueadores de canais de cálcio são úteis na fase aguda e não devem ser usados por tempo prolongado, pois retardam o processo fisiológico de compensação labiríntica.
 - b) Antieméticos como o dimenidrato devem ser evitados nos casos de náuseas associado a vertigens, pois podem levar a quedas.
 - c) O tratamento medicamentoso é a primeira indicação para a VPPB.
 - d) O uso prolongado de cinarizina e flunarizina pode levar a parkinsonismo.
 - e) Ansiolíticos como o Diazepam podem ser usados no quadro agudo.
- 128) ## (P2: T17) Idoso de 85 anos, sexo masculino, queixa-se de tonturas diárias ao se levantar. O quadro iniciou há 2 meses e foi descrito como sensação de fraqueza e, às vezes, giro ou escurecimento visual. Paciente é diabético, hipertenso, cardiopata com uma revascularização miocárdica. Paciente fica a maioria do tempo deitado, com medo de ter tonturas. Apresenta quedas de repetição com uma fratura de fêmur há 1 ano. Qual o diagnóstico provável:
- a) Tontura de origem medicamentosa.
 - b) Hipotensão ortostática devido a polineuropatia diabética.
 - c) Pré-síncope.
 - d) Disautonomia.
 - e) VPPB

Questões comentadas:

129) ## (P2: T20) Em relação a tontura no idoso, assinale a alternativa correta:

a) Tanto a **vertigem** de **origem central** como **periférica** são **acompanhadas de sintomas neurológicos**.

↳ **Sintomas neurológicos:**

- Periférica → Raros
- Central → Comuns

↳ **Classificação**

- **Pré-síncope** (sensação que vai apagar).
- **Vertigem** (sensação rotatória).
- **Desequilíbrio**.
- **Tontura inespecífica** - psiquiátrica.
- **Periféricas** (mais comum) ou **Centrais**:

Causas / Sintomas	Vertigem Periférica	Vertigem Central
Duração	Rápida	Longa
Intensidade	Grave	Moderada
Náuseas e vômitos	Graves	Moderados
Sintomas otológicos	Comuns	Raros
Sinais neurológicos	Raros	Comuns
Desequilíbrio	Leve	Intenso e progressivo
Ataxia	Rara	Comuns
Perda auditiva	Comum	Rara
Compensação	Rápida	Lenta
Relação com posição da cabeça	Comum	Rara
Chance de tontura rotatória	Alta	Rara

b) O tratamento **medicamentoso** é a **primeira indicação** para a **VPPB**.

↳ **VPPB** → Não tem indicação medicação

- A indicação é a **Manobra de Epley**

c) Os **antivertiginosos** ~~devem~~ ser usados de **maneira contínua** para o tratamento da vertigem

↳ Medicamentos devem ter seu **uso contínuo evitado**, pois podem causar **desequilíbrio do labirinto**

- Casos de recorrência devem ter utilizada a menor dose possível.

d) A **VPPB** tem como característica a vertigem quando o **paciente deita ou se vira na cama**

↳ **Vertigem posicional paroxística benigna (VPPB):**

- Causa mais comum de tontura em idoso, presente em 40% dos casos.
- A vertigem ocorre com a **movimentação da cabeça, melhorando** em cerca de um minuto, com presença de **nistagmo rotacional**.
- Ocorre **principalmente** quando paciente vai se **deitar**, se **virar na cama** e **algumas vezes** quando se **levanta**. Geralmente rápido

e) O **desequilíbrio** pode ser tratado com **Flunarizina**, independente da causa.

↳ **Desequilíbrio**

- Multifatorial
- Tratamento:
 - Rever medicações
 - Prática de atividade física
 - Fisioterapia, calçados adequados
 - Correção visual

130) ## (P2: T20) Em relação ao tratamento farmacológico de tontura, assinale a alternativa INCORRETA.

a) Fármacos **sedativos do labirinto** podem ser úteis na **fase aguda**.

b) Os **ansiolíticos** e o **Dimenidrato** (Dramin) aumentam o **risco de quedas**.

↳ Medicamentos para tontura ~~devem~~ causar **desequilíbrio do labirinto**

c) O uso prolongado de **bloqueadores dos canais de cálcio** se associa ao **parkinsonismo**.

↳ **Flunarizina** (Bloqueadores dos canais de cálcio)

- Problema é o **parkinsonismo**.
- **Bloqueadores de canais de cálcio** são úteis na **fase aguda** e **não** devem ser usados por tempo prolongado, pois **retardam** o processo fisiológico de **compensação labiríntica**

- d) Na **hipotensão ortostática** podemos indicar **meias elásticas** e **aumento de oferta hídrica**
- ↳ **Hipotensão ortostática**
 - Uma pré-síncope associada a hipotensão, onde ocorre **sequestro de sangue em MMII**
 - **Tratamento:**
 - **Meias elásticas** tipo meia calça
 - Flexões do pés
 - Elevação da cabeceira da cama
 - Fludrocortizona

e) A **Betaístina** deve ser usada como **primeira indicação nas tonturas de origem psiquiátrica.**

- ↳ **Tontura Inespecífica**
- Geralmente **causa psiquiátrica.**
- Sensação de cabeça pesada, vazia, fora do lugar, mal estar.
- Tontura insidiosa, indefinida, tipo flutuar que pode durar minutos ou horas.
- **Tratamento psiquiátrico**

131) ## (P2: T17) Em relação ao tratamento farmacológico de tontura no idoso, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) **Bloqueadores de canais de cálcio** são **úteis na fase aguda** e **não** devem ser usados por tempo prolongado, pois **retardam** o processo fisiológico de **compensação labiríntica.**
 - ↳ Medicamentos para tontura devem ter seu **uso contínuo evitado**, pois podem causar **desequilíbrio do labirinto**
- b) **Antieméticos** como o **dimenidrato** (Dramin) devem ser evitados nos casos de náuseas associado a vertigens, pois **podem levar a quedas.**
- c) **O tratamento medicamentoso é a primeira indicação para a VPPB.**
 - ↳ **VPPB** → Não tem indicação medicação
 - A indicação é a **Manobra de Epley**
- d) O uso prolongado de **cinarizina** e **flunarizina** pode **levar a parkinsonismo.**
 - ↳ **Cinarizina** e **Flunarizina** (Bloqueadores dos canais de cálcio)
 - Problema é o **parkinsonismo.**
- e) **Ansiolíticos** como o **Diazepam** podem ser usados no **quadro agudo.**
 - ↳ **Diazepam** → Doses baixas (2 a 7,5mg) diária

132) ## (P2: T17) Idoso de 85 anos, sexo masculino, queixa-se de **tonturas diárias ao se levantar.** O quadro iniciou há 2 meses e foi descrito como sensação de **fraqueza** e, às vezes, **giro** ou **escurecimento visual.** Paciente é **diabético**, hipertenso, cardiopata com uma revascularização miocárdica. Paciente fica a **maioria do tempo deitado, com medo de ter tonturas.** Apresenta **quedas de repetição** com uma fratura de fêmur há 1 ano. Qual o diagnóstico provável:

- a) Tontura de origem medicamentosa.
- b) **Hipotensão ortostática devido a polineuropatia diabética.**
- c) Pré-síncope.
- d) Disautonomia.
- e) VPPB

FRAGILIDADE NO IDOSO

Questões:

- 133) ## (P2: T20) Sobre o principal binômio terapêutico da síndrome de fragilidade, o exercício físico e a nutrição... alternativas a seguir.
- I. A abordagem multiprofissional é parte essencial do tratamento.
 - II. Os exercícios físicos devem ser estimulados em todas as consultas médicas e multiprofissionais e podem ser de natureza aeróbica ou resistida ou de natureza aeróbica ou resistida.
 - III. Em idosos com desnutrição, a otimização nutricional faz-se essencialmente por orientação alimentar, considerando aspectos ambientais e culturais da ingesta.
 - IV. O uso de suplementos pode ser necessário em muitas situações no tratamento da fragilidade e deve ser considerado individualmente.

Quais estão corretas?

- a) Apenas a I e a II.
 - b) Apenas a I, a II e a III.
 - c) Apenas a I, a III e a IV.
 - d) Apenas a II, a III e a IV.
- 134) ## (P2: T20) A Síndrome de Fragilidade é uma patologia que aumenta a mortalidade e leva a sérias complicações no decorrer dos anos. Assim é falso afirmar:
- a) Tem como fisiopatologia a sarcopenia, a diminuição de hormônios como GH, estrogênio e testosterona e disfunção imunológica como aumento IL-1, IL-6 e fator de necrose tumoral.
 - b) Existe um fenótipo para fragilidade, onde pacientes são mais propensos a ter esse tipo de patologia.
 - c) O aumento do cortisol somente ocorre na vigência de doenças agudas como a Pneumonia, onde temos assim uma perda acelerada de massa muscular.
 - d) O SARCF + Circunferência da panturrilha é um importante método de avaliação de fragilidade.
 - e) A dosagem de enzimas musculares como a aldolase deve ser rotina na avaliação da fragilidade.
- 135) ## (P2: T17) A Síndrome de Fragilidade leva a uma cascata de complicações como imobilidade, infecções e quedas. É de suma importância o reconhecimento dessa enfermidade durante o processo de envelhecimento. O médico geriatra tem como fazer esse diagnóstico usando que critérios?
- a) Presença na queixa clínica de cansaço físico e perda de peso acentuada.
 - b) Quedas frequentes nos últimos 6 meses e sarcopenia.
 - c) AVDs comprometidas e fraturas anteriores.
 - d) Diminuição da força muscular, fadiga e cansaço ao andar.
 - e) Teste cronometrado ao andar alterado e albumina diminuída.
- 136) ## (P2: T17) Para idosos frágeis temos como base de tratamento:
- a) Fortalecimento muscular com exercícios contra resistência, exercícios para o equilíbrio e dieta com bom aporte de aminoácidos.
 - b) Hidroginástica, pilates e dieta rica em aminoácidos.
 - c) Fortalecimento muscular e hidroginástica.
 - d) Dieta com bom aporte proteico e caminhada.
 - e) Uso de testosterona, vitamina D e cálcio.

Questões comentadas:

137) ## (P2: T20) Sobre o principal **binômio terapêutico** da síndrome de fragilidade, o exercício físico e a nutrição... alternativas a seguir.

- I. (V) A **abordagem multiprofissional** é parte **essencial** do tratamento.
- II. (F) Os **exercícios físicos** devem ser **estimulados** em todas as consultas médicas e multiprofissionais e podem ser de **natureza aeróbica ou resistida**.
 ➔ As melhores evidências de ganho de funcionalidade (como força, massa muscular e desempenho funcional) são relacionadas a **exercícios resistidos** e **multicomponentes** (Equilíbrio, flexibilidade)
- III. (V) Em idosos com **desnutrição**, a otimização nutricional faz-se essencialmente por orientação alimentar, considerando aspectos ambientais e culturais da ingesta.
- IV. (V) O **uso de suplementos** pode ser necessário em muitas situações no tratamento da fragilidade e deve ser considerado individualmente.

Quais estão corretas?

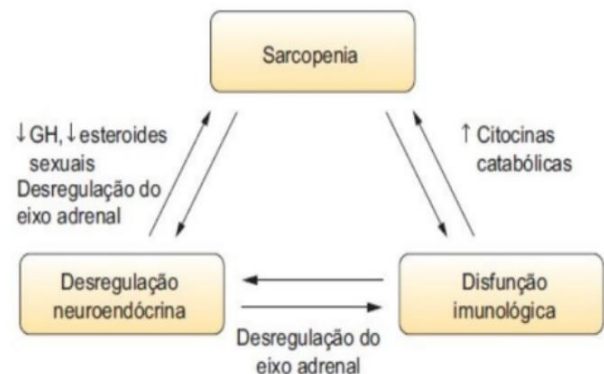
- a) Apenas a I e a II.
- b) Apenas a I, a II e a III.
- c) Apenas a I, a III e a IV.**
- d) Apenas a II, a III e a IV.

138) ## (P2: T20) A Síndrome de Fragilidade é uma patologia que aumenta a mortalidade e leva a sérias complicações no decorrer dos anos. Assim é FALSO afirmar:

- a) Tem como fisiopatologia a **sarcopenia**, a **diminuição de hormônios** como GH, estrogênio e testosterona e **disfunção imunológica** como aumento IL-1, IL-6 e fator de necrose tumoral.

➔ **Tríade**

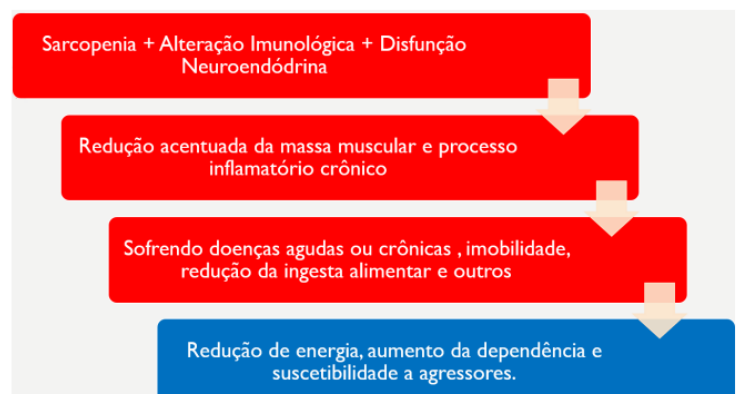
- Alterações neuromusculares (**sarcopenia**)
- Desregulação do sistema **neuroendócrino**
- Disfunção do sistema **imunológico**



- b) Existe um **fenótipo para fragilidade**, onde pacientes são mais propensos a ter esse tipo de patologia.

➔ **Fenótipo para fragilidade**

- Marcadores de Fragilidade:
 - Perda de peso;
 - Fraqueza muscular;
 - Sensação de exaustão;
 - Lentificação da marcha;
 - Baixo nível de atividade física.



c) O aumento do cortisol ~~somente ocorre na vigência de doenças agudas como a Pneumonia, onde temos assim uma perda acelerada de massa muscular.~~

↳ Aumento de cortisol faz parte da Desregulação do sistema **neuroendócrino** (Tríade), compondo o Ciclo da síndrome de fragilidade

- Desregulação do sistema **neuroendócrino** (Tríade)
 - A **redução** de **Testosterona**, **Estrogênio**, **Igf1** e **Gh**, contra o **aumento** de **IL6** e **Cortisol** resultam em **menor força muscular**

d) O **SARCF + Circunferência da panturrilha** é um importante método de avaliação de fragilidade.

↳ Avaliação geriátrica ampla:

- **Força de preensão palmar:**
 - Com dinamômetro, recomendado que seja feito na mão dominante enquanto o paciente permanece sentado em uma cadeira, mantendo cotovelo fletido a 90°
 - ↳ **Homens $\geq 27\text{kg}$**
 - ↳ **Mulheres $\geq 16\text{ kg}$.**
 - Valores **abaixo** indicam **fraqueza muscular**.
- **Time up and go test:**
 - Valores **superiores a 20 segundos para 3 metros** de caminhada indicam **idoso frágil**, com maior risco de quedas.
 - Entre **10 e 20 segundos** indicam **idoso pré-frágil**.
- **Teste de sentar e levantar:**
 - O paciente fica sentado em uma cadeira, com costas apoiadas e braços cruzados, considerando **tentativa única**.
 - Um **tempo superior a 15 segundos** indica o **idoso frágil**.
- **SARC-F + CC:**
 - Questionário associado a **circunferência da panturrilha**.
 - **Idosos sarcopênicos** apresentam **pontuação ≥ 11** .
 - É um teste de sugestão de **sarcopenia**
- **Índice de SOF:** Study of osteoporotic fractures.
 - Questionário com pontuação que classifica o idoso em **robusto**, **pré-frágil (1)** ou **frágil (2-3)**

e) A **dosagem de enzimas musculares** como a **aldolase** deve ser rotina na avaliação da fragilidade.

139) ## (P2: T17) A Síndrome de Fragilidade leva a uma **cascata de complicações** como imobilidade, infecções e quedas. É de suma importância o reconhecimento dessa enfermidade durante o processo de envelhecimento. O médico geriatra tem como fazer esse diagnóstico usando que critérios?

a) Presença na queixa clínica de cansaço físico e perda de peso acentuada.

↳ Um ou dois critérios → Pré-frágil

b) Quedas frequentes nos últimos 6 meses e sarcopenia.

c) AVDs comprometidas e fraturas anteriores.

d) Diminuição da força muscular, fadiga e cansaço ao andar.

↳ **Critérios diagnósticos**

- A presença de:
 - Três fatores → Frágil
 - Um ou dois → Pré-frágil
- Critérios
 - Redução da **força de preensão palmar**
 - Redução da **velocidade da marcha**
 - **Perda de peso** não intencional
 - Sensação de **exaustão**
 - **Atividade física baixa**

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS

Redução da força de preensão palmar	Abaixo do percentil 20 da população, corrigido por gênero e índice de massa corporal
Redução da velocidade de marcha	Abaixo do percentil 20 da população, em teste de caminhada de 4,6 m, corrigido por gênero e estatura
Perda de peso não intencional	Acima de 4,5 kg referidos ou 5% do peso corporal, se medido, no último ano
Sensação de exaustão	Autoreferida (questões do questionário CES-D)
Atividade física baixa	Abaixo do percentil 20 da população, em kcal/semana (Minnesota Leisure Time Activity Questionnaire, versão curta)

A presença de três critérios classifica um idoso como frágil, a presença de um ou dois, como pré-frágil, e a ausência de critérios, como não frágil. Adaptado de Fried et al., 2001.

e) Teste cronometrado ao andar alterado e albumina diminuída.

140) ## (P2: T17) Para idosos frágeis temos como base de tratamento:

a) Fortalecimento muscular com exercícios contra resistência, exercícios para o equilíbrio e dieta com bom aporte de aminoácidos.

b) Hidroginástica, pilates e dieta rica em aminoácidos.

c) Fortalecimento muscular e hidroginástica.

d) Dieta com bom aporte proteico e caminhada.

e) Uso de testosterona, vitamina D e cálcio.

QUEDAS

Questões:

141) ## (P2: T20) Quedas no idoso é um fator de preocupação para essa faixa etária, pelas complicações e aumento da mortalidade nessa faixa etária. Sobre esse assunto, analise os itens abaixo:

- I. Pisos escorregadios, brinquedos soltos pela casa e tapetes são armadilhas arquitetônicas para quedas.
- II. Polifarmácia não é causa de quedas.
- III. Podem levar a depressão, hospitalização e imobilidade.
- IV. O medo de novas quedas faz o paciente ter pouca mobilidade e causar novas quedas.
- V. A vitamina D não entra na investigação de quedas.

Estão corretos:

- a) I, II, IV
- b) II, III e IV
- c) I, II e IV
- d) I, III e IV
- e) II, IV V

142) ## (P2: T17) As quedas são a terceira causa de morte em idosos. Sobre esse assunto, analise os itens abaixo:

- I. Piso escorregadios e tapetes são armadilhas arquitetônicas para quedas.
- II. A iatrogenia não é causa de quedas.
- III. Podem levar a depressão, hospitalização e imobilidade.
- IV. Com a queda pode haver repercussão na parte cognitiva do paciente.
- V. A vitamina D e o cálcio sérico não entram na investigação de quedas.

Estão INCORRETOS:

- a) I e IV.
- b) II e V.
- c) IV e V.
- d) III e IV.
- e) II, III e IV.

143) ## (P2: T17) Diante de um paciente idoso com quedas frequentes há 30 dias, com quadros súbitos de lipotimia, palidez cutânea, sudorese fria e sem relação com mudança de decúbito; que exame poderia ser fundamental pedir?

- a) Enzimas cardíacas
- b) Rx de tórax
- c) Holter de 24h
- d) Albumina sérica
- e) Gasometria arterial

Questões comentadas:

144) ## (P2: T20) Quedas no idoso é um fator de preocupação para essa faixa etária, pelas complicações e aumento da mortalidade nessa faixa etária. Sobre esse assunto, analise os itens abaixo:

- I. (V) Pisos escorregadios, brinquedos soltos pela casa e tapetes são armadilhas arquitetônicas para quedas.
- II. (F) **Polifarmácia** ~~não~~ é causa de quedas.
→ **Polifarmácia**
 - A revisão criteriosa das medicações é elemento essencial, dada a prevalência de iatrogenia nessa população, além de **interações medicamentosas** interferindo diretamente nos **mecanismos de coordenação da marcha e do equilíbrio**.
 - Medicações com risco para quedas:
 - Hipnóticos sedativos
 - Antidepressivos
 - Antipsicóticos
 - Anticolinérgicos
 - Antiparkinsonianos
- III. (V) Podem levar a depressão, hospitalização e imobilidade.
- IV. (V) O medo de novas quedas faz o paciente ter pouca mobilidade e causar novas quedas.
- V. (F) A **vitamina D** ~~não~~ entra na **investigação de quedas**.
→ **Suplementação de vitamina D**
 - Parece estar associada à **prevenção de quedas** pela melhora da força muscular e do equilíbrio. Entretanto, existe um conflito de evidências se a suplementação **pode influenciar a incidência de quedas**
 - Estudos longitudinais apresentam que níveis de 25OHD **abaixo de 10ng/mL** são, de forma independente, **associados a quedas**

Estão corretos:

- a) I, II, IV
- b) II, III e IV
- c) I, II e IV
- d) I, III e IV**
- e) II, IV e V

145) ## (P2: T17) As quedas são a terceira causa de morte em idosos. Sobre esse assunto, analise os itens abaixo:

- I. Piso escorregadios e tapetes são armadilhas arquitetônicas para quedas.
- II. (F) A iatrogenia ~~não~~ é causa de quedas.
- III. Podem levar a depressão, hospitalização e imobilidade.
- IV. Com a queda pode haver repercussão na parte cognitiva do paciente.
- V. (F) A vitamina D e o cálcio sérico ~~não~~ entram na investigação de quedas.

Estão INCORRETOS:

- a) I e IV.
- b) II e V.**
- c) IV e V.
- d) III e IV.
- e) II, III e IV.

146) ## (P2: T17) Diante de um paciente idoso com **quedas frequentes** há 30 dias, com quadros súbitos de **lipotimia, palidez cutânea, sudorese fria** e sem relação com mudança de decúbito; que exame poderia ser fundamental pedir?

↳ Lipotimia → Paciente se sente prestes a desmaiar, mas não chega à perda de consciência

- a) Enzimas cardíacas
- b) Rx de tórax
- c) Holter de 24h**
- d) Albumina sérica
- e) Gasometria arterial

CUIDADOS PALIATIVOS

Questões:

- 147) ## (P2: T20) Em cuidados paliativos, a importância do cuidado e do amparo no final da vida, junto ao paciente e seus familiares é a base dessa atividade. Desta forma, é incorreto dizer:
- a) O Midazolam é a droga de escolha para sedação.
 - b) Na sialorreia usamos colírio de atropina em cavidade oral.
 - c) Em pacientes com difícil acesso a hipodermóclise é uma via de infusão segura.
 - d) No final de vida em pacientes que caminham para o óbito a dieta é suspensa, para dar mais conforto ao paciente.
 - e) Pela hipodermóclise pode se fazer hidratação e sem restrição a qualquer medicação, por isso ...mais usada no paliativismo.
- 148) ## (P2: T17) Em cuidados paliativos, a importância do cuidado e do amparo no final da vida, junto ao paciente e seus familiares é a base dessa atividade. Desta forma, é incorreto dizer:
- a) O midazolam é a droga de escolha para sedação.
 - b) Na sialorreia usamos colírio de atropina em cavidade oral.
 - c) Em pacientes com difícil acesso a hipodermóclise é uma via de infusão segura.
 - d) No final de vida em pacientes que caminham para o óbito a dieta é suspensa, para dar mais conforto ao paciente.
 - e) Pela hipodermóclise pode-se fazer hidratação e sem restrição a qualquer medicação.

Questões comentadas:

149) ## (P2: T20) Em cuidados paliativos, a importância do cuidado e do amparo no final da vida, junto ao paciente e seus familiares é a base dessa atividade. Desta forma, é INCORRETO dizer:

a) O Midazolam é a droga de escolha para sedação.

↳ Sedação

- Finalidade:
 - Tirar a consciência do final de vida em grande sofrimento.
- Medicamentos:
 - **Midazolam** → Droga de **escolha** para sedação
 - Propofol
 - Fenobarbital
 - Clorpromazina

b) Na sialorreia usamos colírio de atropina em cavidade oral.

↳ Sialorreia

- Paciente se torna incapaz de deglutir a saliva, não necessariamente havendo excesso na sua produção.
- **Colírio de atropina**
 - Mais utilizado para diminuição da sialorreia
 - Pingando 1-2gts 1-2x/dia na boca
 - Resseca a mucosa oral

c) Em pacientes com difícil acesso a hipodermóclise é uma via de infusão segura.

d) No final de vida em pacientes que caminham para o óbito a dieta é suspensa, para dar mais conforto ao paciente.

↳ Muitas vezes a alimentação artificial no final da vida traz mais malefícios do que benefícios

e) Pela hipodermóclise pode-se fazer hidratação e sem restrição a qualquer medicação, por isso ...mais usada no paliativismo.

↳ **Desvantagens**

- Limitação de eletrólitos e medicamentos

↳ Hipodermóclise

- Caracterizada pela **infusão** de líquidos no tecido subcutâneo, com administração gradual de soluções neste espaço, onde os fluidos são absorvidos pela corrente sanguínea através de uma combinação de difusão e perfusão dos tecidos.
- 70% dos pacientes em fase final da vida necessitarão de uma via alternativa para administração e esta via pode ser a mais adequada

150) ## (P2: T17) Em cuidados paliativos, a importância do cuidado e do amparo no final da vida, junto ao paciente e seus familiares é a base dessa atividade. Desta forma, é incorreto dizer:

a) O midazolam é a droga de escolha para sedação.

b) Na **sialorreia** usamos **colírio de atropina** em **cavidade oral**.

c) Em **pacientes com difícil acesso** a **hipodermóclise** é uma **via de infusão segura**.

d) No final de vida em pacientes que caminham para o óbito a **dieta é suspensa**, para dar mais conforto ao paciente.

e) Pela hipodermóclise pode-se fazer hidratação e sem restrição a qualquer medicação.

DOR

151)

QUESTÕES NÃO CLASSIFICAS - P2

- 152) ## (P2: T17) A úlcera de pressão é uma das consequências da síndrome de imobilismo, aonde temos uma interrupção da irrigação sanguínea em determinada área, motivada por uma pressão aumentada local. Assim, podemos afirmar como incorreto:
- a) O uso de colchões especiais com pressão reduzida e a mudança de decúbito cada 2 horas são alternativas importantes para a prevenção de escaras.
 - b) O alginato de cálcio é muito usado em feridas muito secretivas e infectadas.
 - c) Fatores de risco para úlceras de decúbito são imobilismo, idade avançada, desnutrição e incontinência urinária.
 - d) O hidrogel tem indicação em feridas com tecido necrótico e com esfacelos.
 - e) Na escara de decúbito com necrose e muita exsudação o curativo mais usado é o hidropolímero.**